

Questão 1 Classificação de risco Infectologia Quadro clínico

Com relação à dengue, é correto afirmar que

- A diferentemente de outras doenças, a gravidade não está relacionada a fatores de risco individuais.
- B a imunidade adquirida é permanente apenas para o primeiro sorotipo após a infecção, não ocorrendo após a segunda.
- C a maioria dos pacientes apresenta formas graves, hemorrágicas com choque e risco de morte.
- D o período de viremia geralmente se inicia um dia antes do aparecimento da febre.

4000120617

Questão 2 HIVAids

No cuidado das pessoas que vivem com HIV, a figura a seguir representa a mandala de



Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

- A intervenções comportamentais.
- B estratégia de tratamento eficaz.
- C prevenção combinada.
- D estratégia de combinação de tratamento.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000120609

Questão 3 Hanseníase tuberculoide

Homem de 35 anos apresenta, há 3 anos, uma única lesão no terço inferior da perna esquerda caracterizada por placa com centro hipocrômico, anestésica e bordas moderadamente elevadas (imagem a seguir). Baciloscopia: negativa; exame anatomopatológico: infiltrado inflamatório granulomatoso perineural e perianexial, com pesquisa de BAAR negativa; reação de Mitsuda: positiva. É correto afirmar que



- A não há evidências para diagnóstico de hanseníase, pois a baciloscopia foi negativa.
- B se trata de hanseníase indeterminada, pois apresenta uma única lesão cutânea.
- C o diagnóstico é de hanseníase tuberculoide, mesmo sem o achado do bacilo.
- D o diagnóstico é de hanseníase dimorfa, pois a reação de Mitsuda foi positiva.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120593](#)

Questão 4

Introdução **Sarampo** **Vigilância Epidemiológica**

O fato que justifica a epidemia de sarampo que está ocorrendo no Brasil é

- A a presença de indivíduos não vacinados suscetíveis pela baixa cobertura vacinal contra sarampo.
- B a falta de vacinas, responsável pela baixa cobertura vacinal, com consequente aumento de casos.
- C a baixa eficácia da vacina, responsável pelo aumento de indivíduos suscetíveis.
- D o aumento da virulência do RNA vírus, responsável pelo aumento da transmissão da doença.

4000120580

Questão 5

Esquema básico para tuberculose pulmonar **Infectologia** **Diagnóstico**

Homem de 43 anos, em consulta na UBS, refere tosse, sudorese noturna, inapetência e emagrecimento há 2 meses. Radiografia de tórax: infiltrado em ápice direito, baciloscopia direta: positiva para BAAR em duas amostras de escarro. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde do Brasil, a conduta correta é

- A aguardar resultado da cultura de escarro e teste de sensibilidade para introduzir tratamento e convocar contatos intradomiciliares para consulta e realização de prova tuberculínica.
- B notificar o caso para a vigilância epidemiológica, encaminhar para o nível secundário de assistência para introdução do tratamento e agendar consulta médica em 30 dias na UBS.
- C realizar testagem para HIV, introduzir esquema de tratamento com esquema RIPE (rifampicina-isoniazida-pirazinamida-etambutol) e notificar o caso para a vigilância epidemiológica.
- D agendar visita domiciliar, construir e mapa, convocar contatos intradomiciliares e solicitar provas de função hepática para o paciente, aguardando os resultados para introduzir esquema RIPE (rifampicina-isoniazida-pirazinamida-etambutol).

4000120571

Questão 6 Declaração de óbito DO Atestado de óbito

Homem de 66 anos estava consertando o telhado de sua própria residência quando veio a cair de uma altura de oito metros. Atendido pelo SAMU, foi levado ao hospital, sendo constatado traumatismo cranioencefálico, falecendo minutos após. A família informou que o paciente era portador de diabetes mellitus e hipertensão arterial. Com base nessas informações, é correto o seguinte preenchimento da Declaração de Óbito:

- A PARTE I; a) Traumatismo cranioencefálico; b) Queda de telhado; c) _____; d) _____; PARTE II; Hipertensão arterial; Diabetes mellitus
- B PARTE I; a) Traumatismo cranioencefálico; b) _____; c) _____; d) _____; PARTE II; Queda de telhado
- C PARTE I; a) Queda de telhado; b) Traumatismo cranioencefálico; c) _____; d) _____; PARTE II _____
- D Por se tratar de morte por causa não natural, não deverá ser emitido Atestado de Óbito, cabendo, ao Instituto Médico Legal, a emissão de laudo competente para esses casos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120560](https://www.4000120560.com.br)

Questão 7 Sigilo profissional Documentos médicos

Segundo o Código de Ética Médica, de 2019, é vedado ao médico

- A deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, mesmo quando houver indícios de morte violenta.
- B atestar óbito quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, exclusivamente, se o fizer em caso de necrópsia ou verificação médico-legal.
- C atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente.
- D deixar de prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120551](https://www.4000120551.com.br)

Questão 8 Política Nacional de Humanização

Está incluída dentre as diretrizes da Política Nacional de Humanização:

- A garantir a permanência hospitalar, evitando-se a desospitalização precoce e os riscos dos cuidados em domicílio.
- B respeitar a autonomia dos profissionais médicos, evitando-se o uso de protocolos clínicos.
- C garantir atendimento igualitário a toda demanda observando rigorosamente a ordem cronológica de chegada.
- D prover o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade dos usuários.

4000120545

Questão 9 Política Nacional de Promoção de Saúde

“Ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras)” é um dos objetivos específicos

- A da Política de Humanização do SUS.
- B da Política Nacional de Promoção da Saúde.
- C dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- D da Clínica Ampliada e Compartilhada.

4000120538

Questão 10 Planos e Seguros de Saúde Lei nº 9656/1998

O setor de saúde suplementar exibe diferentes modalidades de gestão e operação. A modalidade denominada “medicina de grupo” tem como característica:

- A a gestão do plano é feita por profissionais médicos vinculados às cooperativas, denominados cooperados.
- B os serviços podem ser prestados por unidades próprias, onde os profissionais de saúde são empregados da empresa de medicina de grupo, ou por meio de unidades credenciadas por esta.
- C são instituídas e administradas, por empresas ou por seus empregados, por meio de caixas de assistência, associações, sindicatos, fundações, sem finalidade lucrativa.
- D a principal organização que as representa é o Sistema Cooperativo Unimed.

4000120530

Questão 11 Regionalização do SUS

O Decreto nº 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, estabelece como centro coordenador do cuidado e ordenador das ações e dos serviços disponibilizados na Rede de Atenção à Saúde,

- A a atenção básica à saúde.
- B a secretaria municipal de saúde.
- C o serviço de atenção especializada de referência.
- D a central de regulação e oferta de serviços de saúde (CROSS).

4000120522

Questão 12 Lei nº 8142/1990

A Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do SUS, nos termos da Lei nº 8.142, de 28.12.1990, deve

- A se reunir a cada dois anos.
- B contar com a participação deliberativa de profissionais de saúde e consultiva dos demais segmentos sociais.
- C avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
- D ser convocada pelo Conselho Nacional de Saúde, ou, extraordinariamente, pelo Presidente da República.

4 000120516

Questão 13 Lei nº 8080/1990

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Essa afirmação integra o texto da

- A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948).
- B Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990).
- C Portaria nº 399/2006, que estabelece o “Pacto pela Saúde”.
- D Política Nacional de Humanização (Brasil, 2004).

4 000120510

Questão 14 Instituto Nacional de Previdência Social INPS

Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), com profundas mudanças na prestação de serviços de saúde no Brasil. Dentre outras características, o INPS dava ênfase à

- A atenção hospitalar privada, mediante contratos e convênios.
- B expansão de serviços ambulatoriais terceirizados e hospitalares próprios.
- C promoção de saúde e prevenção com o intuito de reduzir internações e despesas assistenciais.
- D descentralização da gestão para estados e municípios.

Essa questão possui comentário do professor no site [4 000120505](#)

Questão 15 Mortalidade Materna

Em relação ao coeficiente de mortalidade materna, é correto afirmar que

- A estima o risco dos nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida e reflete o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil.
- B seu cálculo é realizado a partir do número de óbitos maternos, por 100 mil nascidos vivos de mães residentes em determinado local, no ano considerado.
- C o conceito de morte materna na 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) refere-se à morte de uma mulher durante a gestação e o parto devido a causas relacionadas à gravidez e a causas acidentais ou incidentais.
- D taxas elevadas de mortalidade materna independem do planejamento familiar e da assistência pré-natal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120499](https://www.4000120499.com.br)

Questão 16 Mecanismos de Emergência e Reemergência de Doenças Infecciosas

Analisar as tabelas 1 e 2 e os dados sobre o sarampo no Brasil. É correto afirmar que

TABELA 1
CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO, POR ANO, SEGUNDO REGIÕES Brasil, 1991 a 2005

Região	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2003	2005
Brasil	45 532	2 396	972	53 664	908	1	2	6
Norte	4 665	239	141	231	—	—	—	—
Nordeste	11 364	366	195	4 547	969	—	—	—
Sudeste	10 893	1 002	346	45 503	359	1	—	2
Sul	11 140	558	253	1 770	39	—	2	4
Centro-Oeste	4 470	231	37	1 613	50	—	—	—

(Ministério da Saúde/VS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan))

Nota: Casos ocorridos em 2001, 2002 e 2003 foram importados da Europa e do Japão. Não houve casos em 2004. Dados sujeitos a revisão (atualizado em setembro/2006).

TABELA 2
SARAMPO: MONITORAMENTO DO SARAMPO – 2019

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL

MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL*		
Período de monitoramento: 05 de maio a 03 de agosto de 2019 (SE ¹ 19 a 31)		
Atualização 02.08.2019		
	Número	Estados
Casos notificados	4 226	Brasil
Casos confirmados	907	Brasil
Casos em investigação	2 740	Brasil
Casos descartados	579	Brasil
Óbitos	0	Brasil

(Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde)

* Dados preliminares e sujeitos à revisão.
¹ SE = Semana Epidemiológica.

Contra preços abusivos na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

- A para conter o avanço do sarampo, o Ministério da Saúde intensificou, em 2019, a vacinação com tríplice viral em crianças de seis a 11 meses de idade e a vacinação em adultos com 60 anos e mais.
- B até o momento, no Brasil, além dos surtos de sarampo nos estados de Amazonas, Roraima e Pará, os casos confirmados em 2019 estão distribuídos por todas as unidades federadas do país.
- C o surto de sarampo, que está ocorrendo no Brasil, desde 2018, está relacionado a casos importados de pessoas que viajaram para a Europa e para o Líbano, sem qualquer relação com os surtos que estão ocorrendo em países da América Latina.
- D no período de 1999 a 2005, o Brasil encontrava-se em processo de erradicação do sarampo, com progressiva redução do número de casos. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo pela OMS, declarando a região das Américas livre do sarampo.

4000120489

Questão 17 Mortalidade Infantil e Perinatal

Analisar a tabela a seguir. De acordo com essa tabela, é correto afirmar:

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS), POR ANO, SEGUNDO REGIÕES
Brasil, 1991, 1997, 2000 e 2004

Região	1991 ^(a)	1997 ^(b)	2000 ^(b)	2004 ^(c)
Brasil	45,2	31,9	26,8	22,6
Norte	42,3	32,2	28,7	25,5
Nordeste	71,2	50,4	41,4	33,9
Sudeste	31,6	23,1	18,0	14,9
Sul	25,9	17,5	17,0	15,0
Centro-Oeste	29,7	24,4	21,0	18,7

(Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM))

Notas:

(a) Taxas estimadas.

(b) Taxas combinando dados diretos do RJ, SP, RS e MS e indiretos para demais unidades da federação.

(c) Taxas combinando dados diretos do ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS e DF e indiretos para demais unidades da federação.

- A há consistente tendência de redução da mortalidade infantil em todas as regiões brasileiras, o que reflete a melhoria nas condições de vida, o declínio da fecundidade e o efeito de intervenções públicas nas áreas de saúde e saneamento, entre outros aspectos.
- B os dados refletem as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde da população infantil, e expressam as causas de mortes perinatais.
- C ainda que os valores médios continuem elevados, sobretudo na região nordeste, podemos observar uma significativa redução da mortalidade neonatal em relação à mortalidade tardia em todas as regiões do país e no Brasil como um todo, nesses anos em estudo.
- D ocorreu acentuado e contínuo declínio da mortalidade pós-neonatal para todas as regiões do país e para o Brasil como um todo, produzindo padrão homogêneo entre todas as regiões, nos anos de 2000 e 2004.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120466](https://www.4000120466.com.br)

Questão 18 Asma ocupacional x asma relacionada ao trabalho Asma ocupacional

“No Brasil, os casos de crises de asma brônquica que acometem indivíduos com asma preexistente são atribuídos a características hereditárias e pessoais e não estão incluídos na lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho”. Essa afirmação está

- A errada, pois podem ser considerados casos de asma relacionada ou agravada pelo trabalho e estão incluídos na lista.
- B correta, pois esse entendimento segue a compreensão majoritária na comunidade internacional.
- C errada, pois esse entendimento vai depender do tipo de crise apresentada e do tempo de exposição ao agente.
- D correta, pois esses casos demonstram a existência de predisposição individual e o trabalho isoladamente não desencadeia os quadros.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120455](https://www.4000120455.com.br)

Questão 19 Tipos de Estudos Epidemiológicos

Um estudo teve como objetivo avaliar a associação entre variáveis meteorológicas e poluição do ar com internações respiratórias em crianças. Para tanto, foram utilizados dados secundários das variáveis meteorológicas, de poluição atmosférica e das internações hospitalares durante o período de 2003 a 2013. Os dados meteorológicos foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados sobre a poluição atmosférica foram obtidas na plataforma Qualar da Companhia Ambiental de São Paulo. E, por fim, os dados epidemiológicos referentes às internações hospitalares foram obtidos de maneira pública pelos registros das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os resultados desse trabalho mostraram que existe relação entre temperatura média do ar, umidade relativa, precipitação e o poluente atmosférico MP10 com as internações por doenças respiratórias em crianças com até 9 anos de idade. De acordo o texto, o delineamento desse estudo é

- A de caso controle.
- B de coorte.
- C descritivo.
- D ecológico.

4000120446

Questão 20 Tipos de Estudos Epidemiológicos

Um estudo realizado em um hospital de grande porte avaliou: a prevalência de quedas; a distribuição das quedas por grau de dependência dos pacientes; a distribuição das quedas pelo motivo pelas quais originou (por exemplo: piso escorregadio, desorientação, diminuição da força muscular ou outra); a distribuição das quedas de acordo com a gravidade das suas consequências e a distribuição das quedas de acordo com o turno e local de ocorrência. Os dados foram coletados em relação aos anos de 2016, 2017 e 2018. De acordo com a descrição, o delineamento desse estudo é

- A de caso controle.
- B de coorte.
- C descritivo.
- D ecológico.

4000120438

Questão 21 Neurite Vestibular Síndromes Vestibulares Periféricas

Homem de 42 anos apresenta vertigem intensa de início súbito. Nega hipoacusia, zumbido ou plenitude auricular. AP: ausência de comorbidades. Exame físico: PA 120 x 80 mmHg, taquicardia leve, sudorese, palidez cutâneo-mucosa, nistagmo espontâneo horizontal para direita, que aumenta de velocidade ao olhar para direita e reduz com a fixação ocular; demais pares de nervos cranianos e provas cerebelares normais. A hipótese diagnóstica é

- A síndrome de Menière.
- B neurite vestibular.
- C vertigem posicional paroxística benigna.
- D labirintite.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120429](https://www.4000120429.com)

Questão 22 Analgesia Perioperatória Opioides Cirurgia

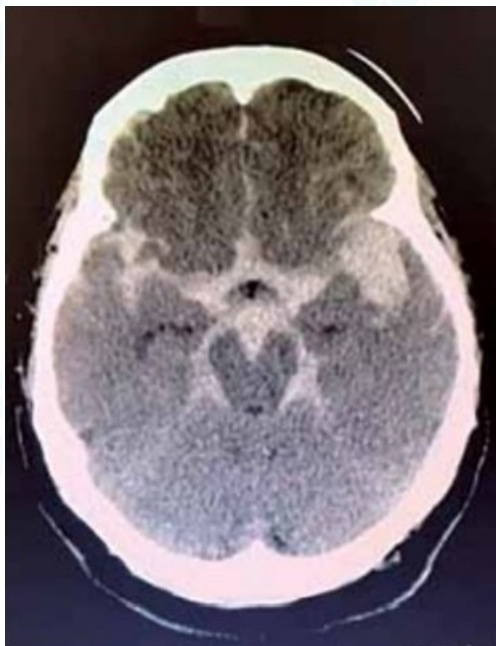
Homem de 80 anos foi submetido à cirurgia de urgência para fixação de fratura de fêmur sob anestesia geral venosa total. AP: insuficiência renal não dialítica (TFG 20 mL/min) e HAS não controlada. Ao despertar na sala de recuperação anestésica, apresentou quadro de intensa dor (escore 10, em escala de 0 a 10) no sítio cirúrgico. Assinale a alternativa correta.

- A Os analgésicos opioides estão contraindicados em dor aguda em decorrência da epidemia de overdoses e de mortes associada ao seu uso.
- B As dores ósseas respondem bem ao uso de antiinflamatórios, motivo pelo qual são a primeira escolha.
- C Morfina é considerada o opioide “padrão-ouro” e, por esse motivo, é a primeira escolha para tratar dores de forte intensidade.
- D Fentanil ou metadona são os analgésicos opioides de escolha, pois o paciente é nefropata.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120418](#)

Questão 23 Quadro Clínico Tomografia Computadorizada

Mulher de 53 anos foi encontrada por familiares caída e arresponsiva. AP: hipertensa e tabagista. Exame físico: comatosa (escala de coma de Glasgow 7), PA 180 x 100 mmHg, FC 70 bpm. TC de crânio (imagem a seguir). A hipótese diagnóstica é



- A acidente vascular cerebral intraparenquimatoso hipertensivo.
- B hemorragia subaracnoideia por ruptura de aneurisma cerebral.
- C trombose de seio cavernoso.
- D hematoma subdural agudo traumático.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120411](#)

Questão 24 Intubação traqueal

Criança de 3 meses foi submetida à cirurgia cardíaca para correção do defeito septal atrioventricular. A intubação e extubação orotraqueal ocorreram sem intercorrências. O tempo de intubação foi de três horas. Após a extubação, passou a apresentar choro baixo e fraco e leve estridor bifásico. Os sintomas mantiveram-se após uso de corticoide endovenoso. A hipótese diagnóstica é

- A estenose subglótica após intubação.
- B laringomalácia por malformação.
- C paralisia de prega vocal esquerda por comprometimento do nervo laringeo recorrente.
- D laringite aguda viral sazonal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120391](#)

Questão 25 Classificação Clínica CEAP Cirurgia

A respeito da classificação CEAP para insuficiência venosa crônica (IVC), assinale a alternativa correta.

- A Pacientes com classe clínica C2 são portadores de telangectasias ou veias reticulares.
- B A classificação fisiopatológica divide os pacientes com IVC em causas congênita, indeterminada/primária e conhecida/secundária.
- C Pacientes com classe clínica C4 apresentam alterações tróficas da pele como hiperpigmentação, eczema e lipodermatoesclerose.
- D Pacientes com classe clínica C5 apresentam úlcera em atividade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120379](#)

Questão 26 Tromboangiíte obliterante ou doença de Buerger Diagnóstico

Homem de 35 anos apresenta dor, hiperemia e endurecimento nos trajetos venosos superficiais, inicialmente nas pernas e atualmente em região lateral das coxas. Há 3 meses, ele apresenta necrose em pododáctilos e úlceras digitais de difícil cicatrização na mão direita. Exame físico: perfusão lentificada nos pés bilateralmente e na mão direita, úlceras com crostas necróticas e fundo pálido e ausência de pulsos distais nos MMII e de pulsos radial e ulnar no MSD, demais pulsos 4+/4, sem sopros, presença de tromboflebite superficial nos membros inferiores. AP: tabagista e hipertenso. A hipótese diagnóstica é

- A arterite de Takayasu.
- B tromboangiíte obliterante.
- C síndrome do anticorpo antifosfolípide.
- D doença aterosclerótica periférica.

4000120357

Questão 27 Estimativa da Superfície Corpórea Queimada e Circulação Cirurgia
Tratamento Definitivo das Áreas Queimadas

Homem de 20 anos sofreu queimaduras de 2º grau por escaldadura em 30% da superfície corporal. Para garantir que o paciente esteja bem hidratado, o principal parâmetro é

- A controle do débito urinário.
- B monitorização da frequência cardíaca.
- C monitorização da pressão venosa central.
- D avaliação do turgor e das mucosas.

Questão 28 **Respiração e Ventilação** **Trauma Abdominal Fechado**
Hierarquização do Atendimento e Avaliação Primária

Homem de 33 anos, vítima de acidente automobilístico (carro x moto), deu entrada ao pronto-socorro trazido pelo SAMU, em prancha rígida e colar cervical. Exame físico: confuso, abertura ocular ao chamado e localiza dor, FC 115 bpm, PA 120 x 55 mmHg, oximetria 89%, MV + diminuído e hipertimpânico à direita, abdome globoso, flácido e doloroso à palpação de hipocôndrio esquerdo. As condutas a serem adotadas nesse caso são:

- A intubação orotraqueal, drenagem de tórax, tomografia de abdome.
- B suplementação não invasiva de oxigênio, drenagem de tórax, tomografia de abdome.
- C suplementação não invasiva de oxigênio, toracocentese no 2º EIC, FAST.
- D intubação orotraqueal, toracocentese no 2º EIC, FAST.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000120340

Questão 29 **Complicações**

Homem de 65 anos, dá entrada na UTI com pancreatite aguda biliar. Evoluiu no quinto dia de internação com piora clínica. Exame físico: febril (38°C), PA 100 x 60 mmHg, FC 125 bpm, abdome globoso, doloroso e tenso à palpação de todo abdome. Exames laboratoriais: GB = 19000/ mm³; DHL = 450 U/L; TGO = 280 U/L; BT = 3,0 mg/dL (BD = 2,1 mg/dL); amilase = 1850 U/L; lipase = 3500 U/L. TC de abdome: imagem a seguir. Em relação ao caso, é correto afirmar que



- A a cirurgia, quando indicada, deve ser realizada o mais tardiamente possível, uma vez que a intervenção precoce é associada à elevada morbimortalidade.
- B a dieta parenteral é preferível à dieta enteral até que os níveis de amilase e lipase normalizem.
- C o uso de antibiótico profilático está associado à redução significativa da morbi-mortalidade.
- D a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica está indicada nos casos de pancreatite associada à icterícia.

4000120326

Questão 30 **Cirurgia** **Exames Diagnósticos e Tratamento**

Mulher de 44 anos, sem comorbidades, apresenta há 2 dias, dor em hipocôndrio direito, acompanhada de icterícia, colúria e acolia. Exame físico: BEG, ictérica (+/+), abdome doloroso à palpação de hipocôndrio direito, sem reação peritoneal.

Exames laboratoriais: Hb = 13,9 g/dL; Ht = 39%; GB = 6500/mm³; plaquetas = 250000/mm³; TGO = 77 U/L; TGP = 98 U/L; GGT = 445 U/L; FA = 221 U/L; BT = 3,5 mg/dL (BD = 2,8 mg/dL), amilase = 51 U/L. Ultrassonografia de abdome: vesícula biliar de paredes finas e lisas, com inúmeros cálculos no seu interior, discreta dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas com evidência de fator obstrutivo distal de, aproximadamente, 3 mm. A conduta mais adequada é

- A colangioressonância e colecistectomia videolaparoscópica.
- B antibioticoterapia e colecistectomia videolaparoscópica em um segundo momento.
- C colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e colecistectomia videolaparoscópica.
- D drenagem percutânea da via biliar e colecistectomia videolaparoscópica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120318](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 31 Inervação Cirurgia

Com relação à anatomia e às hérnias inguinais, é correto afirmar que

- A as hérnias diretas são mais frequentes que as hérnias indiretas.
- B as hérnias indiretas encontram-se no anel inguinal profundo, medialmente aos vasos epigástricos inferiores.
- C a vascularização da região inguinal provém dos vasos ilíacos internos.
- D os três principais nervos da região inguinal são: ilioinguinal, ílio-hipogástrico e o ramogenital do genitofemoral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120311](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 32 Conduta e Tratamento Cirurgia

Homem de 58 anos foi submetido à laparotomia exploradora em caráter de urgência por abdome agudo obstrutivo. No intraoperatório, foi evidenciada neoplasia obstrutiva de sigmoide e realizada sigmoidectomia a Hartmann. AP: hipertenso, diabético, obeso e tabagista. No 5º PO, evidenciou-se saída de grande quantidade de líquido sero-hemático pela ferida operatória. A hipótese diagnóstica é

- A fístula intestinal de alto débito.
- B eventração da parede abdominal.
- C infecção de ferida operatória.
- D evisceração.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120302](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 33 Epidemiologia e fisiopatologia

As estruturas anatômicas que entram em colisão em pacientes com a síndrome do impacto do ombro são

- A tubérculo maior do úmero e terço distal da clavícula.
- B terço distal da clavícula e tubérculo menor do úmero.
- C tubérculo menor do úmero e acrômio.
- D acrômio e tubérculo maior do úmero.

Questão 34 **Análise do líquido pleural** **Cirurgia** **Biópsia pleural**

Mulher de 64 anos apresenta dispneia aos grandes esforços e emagrecimento há 1 mês. Radiografia de tórax: velamento do 1/3 médio e inferior do hemitórax direito. Realizada toracocentese diagnóstica. Exames do líquido pleural: pH 7,28; DHL 890 U/L; glicose 85 mg/dL; proteína 4,2 g/dL; celularidade 90% de linfócitos; adenosina deaminase: normal e citopatológico negativo para neoplasia. Exames séricos: DHL 650 U/L; proteína 5,5 g/dL. Após a análise do derrame pleural, a conduta é

- A biópsia de pleura.
- B drenagem pleural fechada.
- C pleurodese.
- D observação.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000120279

Questão 35 **Anatomia do Mediastino** **Cirurgia**

Com relação à anatomia intratorácica normal, é correto afirmar que

- A a veia cava superior é formada pela veia braquiocéfálica esquerda e pela veia inominada.
- B a artéria torácica interna direita se origina da artéria subclávia direita.
- C as artérias subclávia e carótida comum esquerdas e a carótida comum direita são ramos da aorta.
- D a veia hemiáximo drena para a veia cava superior.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000120269

Questão 36 **Atresia de vias biliares** **Atresia da Via Biliar**

RN a termo, com 25 dias de vida, apresenta icterícia desde o início da segunda semana de vida, com piora progressiva. Há 3 dias passou a apresentar urina de cor escura e fezes esbranquiçadas. AP: pré-natal e parto sem intercorrências. Exame físico: peso e estatura adequados para a idade, BEG, icterício 4+/4, fígado palpável a 3 cm do RCD, com consistência normal. A hipótese diagnóstica e o exame mais adequado para a definição da etiologia são, respectivamente:

- A icterícia colestática; biópsia hepática percutânea guiada por ultrassonografia.
- B icterícia fisiológica do RN; dosagem de bilirrubinas séricas.
- C colestase; dosagem de bilirrubinas séricas.
- D colestase de causa intra-hepática; colangiorressonância magnética.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000120258

Questão 37 **Cirurgia** **Hérnia Inguinal**

Menino de 4 meses apresenta, há 2 semanas, abaulamento inguinal à direita que aparece quando chora e desaparece espontaneamente. Exame físico: abaulamento inguinal à direita, que reduz espontaneamente, sem sinais flogísticos; testículos tópicos. Com base na principal hipótese diagnóstica, a origem e o respectivo tratamento dessa doença são, respectivamente:

- A persistência do conduto peritoniovaginal; herniorrafia inguinal direita em caráter eletivo.
- B fraqueza da fáscia transversalis; herniorrafia inguinal direita em caráter eletivo.
- C persistência do conduto peritoniovaginal; tratamento expectante até completar 3 anos.
- D fraqueza da fáscia transversalis; tratamento expectante até completar 3 anos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120249](#)

Questão 38 **Investigação diagnóstica** **Apresentação clínica**

Mulher de 45 anos, cozinheira industrial, apresenta dores em flanco esquerdo, de forte intensidade, em cólica, irradiando para abdome anterior, acompanhada de náuseas e vômitos há 1 dia. Nega febre e queixas urinárias. AP: hipotireoidismo, HAS, DM tipo 2 e dislipidemia. AF: litíase urinária. Estabelecida a hipótese diagnóstica de litíase urinária,

- A o ultrassom de vias urinárias deve ser prontamente solicitado.
- B o raio X e ultrassom não devem ser solicitados, devido sua baixa sensibilidade e especificidade, estando indicada TC.
- C deve ser realizada a analgesia e solicitados os exames de imagem ambulatorialmente.
- D como a profissão da paciente é de risco para litíase, deve-se solicitar TC nesse momento.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120238](#)

Questão 39 **Traumatismo Urológico** **Cirurgia**

Homem de 58 anos, vítima de acidente de colisão carro contra muro. Exame físico: consciente, orientado, vias aéreas pervias e eupneico, FC 80 bpm, PA 140 x 70 mmHg, abdome flácido em andar superior, tenso e doloroso em hipogástrico, com massa palpável até cicatriz umbilical. A principal hipótese diagnóstica é

- A bexigoma associado a trauma de via urinária alta.
- B trauma vesical associado a possível fratura de bacia.
- C hematoma em retroperitônio.
- D trauma de uretra isolado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120229](#)

Questão 40 **Insuficiência mitral aguda** **Comunicação interventricular**

Ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo

As complicações do infarto agudo do miocárdio que podem necessitar de intervenção cirúrgica de urgência ou emergência são:

- A insuficiência valvar aórtica aguda, comunicação interventricular e aneurisma de ventrículo esquerdo.
- B trombose em átrio esquerdo, dissecação de aorta e insuficiência aguda de valvapulmonar.
- C aneurisma de ventrículo esquerdo, ruptura cardíaca e insuficiência aguda da valvapulmonar.
- D ruptura cardíaca, comunicação interventricular e insuficiência mitral aguda.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120222](#)

Questão 41 **Manifestações articulares** **Diagnóstico** **Artrite psoriásica**

Homem 57 anos apresenta lesões cutâneas generalizadas com diagnóstico de psoríase. Há cinco anos, queixa-se de dores articulares em ambas as mãos acompanhadas por edema, limitação dos movimentos e atualmente várias deformidades (imagem a seguir). Com base na história clínica e na imagem apresentada, é correto afirmar:



- A trata-se de artrite reumatoide associada à psoríase pelo predomínio de comprometimento das articulações interfalangianas e não metacarpofalangianas.
- B trata-se de provável caso de artrite associada ao depósito de ácido úrico, complicação comum durante o tratamento tópico da psoríase.
- C o diagnóstico de certeza é o de psoríase artropática, pois a presença de lesões cutâneas por si só define o diagnóstico.
- D o diagnóstico é de psoríase artropática com base na presença de lesões cutâneas e do comprometimento da articulação interfalângiana distal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120212](#)

Questão 42 **Histologia**

Homem de 41 anos, com valores de AST de 563 U/L e ALT 501 U/L, realizou biópsia hepática, cujo resultado foi presença de vacúolos claros no citoplasma dos hepatócitos e estruturas hialinas irregulares em alguns deles, além de neutrófilos e necrose de hepatócitos isolados. A etiologia mais provável para esse conjunto de alterações é

- A hepatite aguda pelo vírus A.
- B citotoxicidade por acetaminofen.
- C hepatite crônica pelo vírus B.
- D hepatite alcoólica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120199](#)

Questão 43 **Tratamento Farmacológico** **Endoscopia Digestiva Alta EDA**

Mulher de 52 anos apresenta queimação retroesternal e regurgitação há 5 anos, inicialmente cerca de 3 vezes na semana, e há 1 ano diariamente. O quadro é desencadeado minutos após a alimentação ou quando fica “estressada” e melhora com o uso de antiácidos, os quais utiliza sob demanda desde o início dos sintomas. Relata rouquidão recorrente há mais de 10 anos. AP: tabagismo ativo (20 anos-maço). Exame físico: IMC: 30,4 kg/m², sem demais alterações. Além de orientações dietéticas e comportamentais, a conduta inicial mais adequada é

- A prescrição de inibidor de bomba de prótons; pHmetria de 24 horas.
- B prescrição de inibidor de bomba de prótons; endoscopia digestiva alta.
- C manometria convencional; pHmetria de 24 horas.
- D manometria alta resolução; endoscopia digestiva alta.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120191](#)

Questão 44 Transfusão de Hemoderivados

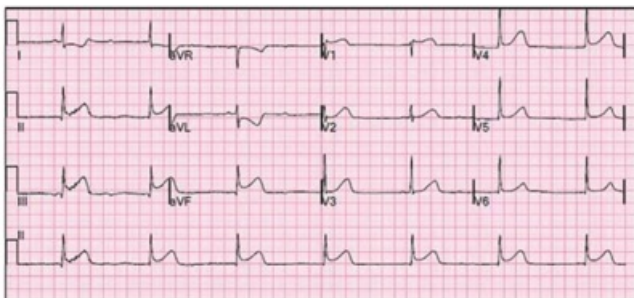
Homem de 52 anos, internado para tratamento de síndrome de abstinência alcoólica, apresentou hematêmese em grande quantidade e rebaixamento do nível de consciência. AP: etilista. Exame físico: descorado, icterico, FC 122 bpm, PA 65/45 mmHg, ginecomastia, ascite tensa, circulação colateral, edema de membros inferiores e melena ao toque retal. Hemograma: Hb 10 g/dL e plaquetas de 85000/mm³. A alternativa correta é:

- A recomenda-se que a endoscopia digestiva alta seja realizada em caráter de emergência, por se tratar de uma provável hemorragia digestiva varicosa.
- B o balão de Sengstaken-Blakemore pode ser usado nesse caso como uma terapia definitiva, devendo ser mantido por 48 horas.
- C a profilaxia com antibiótico e o uso de drogas vasoconstritoras, como o octreotida, devem ser iniciados após a endoscopia confirmar a presença de varizes esofágicas.
- D considerando a provável etiologia da hemorragia digestiva e o nível de hemoglobina, não há indicação de transfusão de hemácias nesse momento.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120181](#)

Questão 45 Diagnóstico eletrocardiográfico da parede do infarto Bradiarritmias e bloqueios atrioventriculares

Mulher de 80 anos apresenta dor torácica retroesternal em peso, contínua, de forte intensidade, sem fatores de melhora, acompanhada de fraqueza e turvação visual há 6 horas. AP: DM, AVC há 10 anos. Exame físico: REG, FR 14 irpm, FC 40 bpm, PA 80/60 mmHg, oximetria 95% em ar ambiente, bulhas rítmicas sem sopros, ausculta respiratória com som claro pulmonar. ECG da admissão (imagem a seguir). Assinale a alternativa correta.



- A O distúrbio do ritmo está relacionado à provável acometimento intranodal, associado a distúrbio transitório (2-3 dias) e que raramente necessita de marcapasso permanente.
- B A administração de nitrato, considerando a provável etiologia vasoespástica, pode reduzir a área de miocárdio atordado associado, contribuindo para reduzir a remodelação adversa a longo prazo.
- C A administração de prasugrel associado à rivaroxabana na admissão do paciente, considerando o alto risco de sangramento, é mais recomendada do que o tratamento com clopidogrel e enoxaparina.
- D A presença de complicações relacionadas à síndrome coronariana aguda, dentre elas, a insuficiência mitral aguda por disfunção da musculatura papilar, comumente, está relacionada à presença de sopro sistólico importante no foco mitral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120175](#)

Questão 46 Exame físico

Mulher de 60 anos apresenta dispneia aos esforços, com piora progressiva no último ano, atualmente aos esforços habituais. Nega febre. Exame físico: bulhas rítmicas, hiperfonese de B1 com sopro diastólico em ruflar em 5° EIC esquerdo linha hemiclavicular e estalido de abertura. ECG: ritmo sinusal, sobrecarga atrial esquerda. Raio X de tórax: aumento do tronco da artéria pulmonar. A etiologia mais provável é

- A degeneração senil.
- B cardiopatia congênita.
- C febre reumática.
- D endocardite infecciosa.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120165](#)

Questão 47 Critérios diagnósticos Tratamento medicamentoso

Homem de 40 anos sem comorbidades em avaliação de rotina na UBS. Exame físico: BEG, PA 130/80 mmHg, IMC 30 kg/m². Glicemia de jejum 148 (há 3 meses) e 156 (atual). Além de orientar mudança de estilo de vida com dieta e atividade física, a conduta é

- A reavaliar paciente em 3 meses e, se não tiver atingido controle da doença, introduzir metformina.
- B reavaliar paciente em 3 meses e, se não tiver atingido controle da doença, introduzir glibenclamida.
- C introduzir metformina.
- D introduzir glibenclamida.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120155](#)

Questão 48 Diagnóstico da síndrome de Cushing

Após a confirmação diagnóstica de síndrome de Cushing, o exame que deve ser realizado para investigação etiológica é

- A cortisolúria.
- B ACTH plasmático.
- C cortisol salivar a meia noite.
- D cortisol após 1 mg de dexametasona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120147](https://www.4000120147.com)

Questão 49 Manifestações Motoras

O tremor na doença de Parkinson

- A tem características simétricas desde o início do quadro.
- B tem frequência de 10-12 Hz.
- C melhora de intensidade durante o sono.
- D tem características assimétricas desde o início dos sintomas.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120137](https://www.4000120137.com)

Questão 50 Avaliação dos pacientes com monoartrite Artrite séptica Exames complementares

Homem de 70 anos, internado com pneumonia bacteriana, desenvolve artrite em joelho direito. AP: DM, HAS, DLP. A principal hipótese diagnóstica e sua respectiva conduta são:

- A artrite séptica; punção articular para esclarecer diagnóstico.
- B gota; colchicina e anti-inflamatório.
- C osteoartrite; analgesia, evitando-se uso de anti-inflamatórios.
- D gota; alopurinol e corticoide.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120128](https://www.4000120128.com)

Questão 51 Prognóstico Lúpus Eritematoso Sistêmico LES

No lúpus eritematoso sistêmico, são fatores de pior prognóstico:

- A acometimento renal e articular.
- B indivíduos negros e baixo nível socioeconômico.
- C alopecia e sexo masculino.
- D acometimento de sistema nervoso central e presença de anticorpo antinúcleo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120119](https://www.4000120119.com)

Questão 52 Quedas em idosos

Mulher de 81 anos relata tontura quando fica em pé e medo de cair. AP: HAS, incontinência urinária e osteoartrite de joelhos. Medicações em uso regular: captopril, anlodipino, hidroclorotiazida, paracetamol e oxibutinina. Exame físico: PA 120/70 mmHg (deitada), FC 76 bpm, pulso regular, levanta-se da cadeira sem utilizar apoio, teste time up and go 10 s. A conduta

mais adequada para avaliar o risco de queda dessa paciente é

- A mensurar pressão arterial sentada e em pé.
- B realizar tomografia de crânio.
- C avaliar equilíbrio com teste de Berg.
- D avaliar acuidade visual.

4000120112

Questão 53 Critérios Diagnósticos

Para o diagnóstico de delírium, segundo o algoritmo Confusion Assessment Method, são obrigatórias as seguintes características:

- A pensamento desorganizado ou incoerente e déficit de memória.
- B déficit de memória e dificuldade para manter a atenção.
- C agitação e modificação aguda do estado mental.
- D modificação aguda do estado mental e dificuldade para manter a atenção.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120105](https://www.4000120105.com.br)

Questão 54 Farmacológico Exacerbações Definição

A exacerbação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

- A define a gravidade e seu manejo terapêutico.
- B frequentemente é causada por pneumonia, embolia pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva.
- C deve ser tratada com corticosteroides por via sistêmica por um período mínimo de 10 dias, seguido de esquema de desmame.
- D não ocorre em paciente com obstrução leve (GOLD I).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120095](https://www.4000120095.com.br)

Questão 55 Infectologia Tratamento

Homem de 75 anos refere tosse com expectoração amarelada, febre de 39 °C e dispneia aos esforços há 2 dias. Exame físico: orientado, FR: 24 irpm, oximetria de 87%, ausculta respiratória com crepitações em base pulmonar direita. O tratamento deve ser

- A hospitalar com cefalosporina de 3ª geração e macrolídeo.
- B ambulatorial com macrolídeo.
- C ambulatorial com fluorquinolona.
- D hospitalar com betalactâmico e fluorquinolona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120087](https://www.4000120087.com.br)

Questão 56 Manejo da Nefropatia diabética Etiologia Diabetes mellitus DM

Em relação à doença renal do diabetes e seu tratamento, é correto afirmar que

- A é um processo multifatorial, que envolve associação entre lesão mecânica, disfunção celular e fibrose. A albuminúria não se correlaciona com o risco cardiovascular, sendo unicamente um marcador fisiopatológico.
- B o tratamento envolve redução de risco cardiovascular, controle glicêmico e pressórico e bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com o objetivo de reduzir a pressão intraglomerular.
- C não há relação entre a hemoglobina glicada e os desfechos microvasculares. A metformina não pode ser usada se houver alteração de função renal em qualquer grau e os inibidores do SGLT-2 restabelecem o feedback túbulo-glomerular com consequente redução da pressão intraglomerular.
- D o controle pressórico é fundamental, sendo importante o uso de medicações que bloqueiem o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O mecanismo de ação está na vasodilatação da arteríola aferente e vasoconstrição da arteríola eferente, culminando na redução da pressão intraglomerular.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120076](https://www.4000120076.com)

Questão 57 Encaminhamento ao Nefrologista

Em relação ao cuidado do paciente com doença renal crônica, é responsabilidade da atenção primária à saúde

- A suspeitar do diagnóstico e, quando da presença de fatores de risco, encaminhar o paciente para o serviço de referência especializado para confirmar o diagnóstico.
- B encaminhar os pacientes com necessidade de iniciar terapia renal substitutiva ao serviço especializado e os demais devem permanecer em seguimento na atenção primária.
- C classificar o risco das diferentes causas, fazer o estadiamento e encaminhar ao especialista pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 30-45 mL/min ou proteinúria > 1,0 g/24 horas.
- D encaminhar o paciente para o serviço especializado na confirmação do diagnóstico e evitar fazer ajustes na prescrição buscando não interferir nas prescrições especializadas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120069](https://www.4000120069.com)

Questão 58 Desfibrilação

Homem de 66 anos, em internação hospitalar por celulite de perna esquerda, encontrado arresposivo no leito. Convocado Time de Resposta Rápida, que diagnosticou parada cardiorrespiratória e iniciou manobras de RCP. O próximo passo a ser realizado é

- A garantir a via aérea avançada.
- B avaliar se há ritmo com indicação de desfibrilação.
- C iniciar epinefrina 1mg IV em bolus.
- D avaliar a última gasometria arterial para determinar a causa da parada cardiorrespiratória.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120058](https://www.4000120058.com)

Questão 59 Cetoacidose

Mulher de 20 anos está em tratamento para cetoacidose diabética desencadeada por infecção urinária. Recebe insulina endovenosa, hidratação e reposição de potássio. Está consciente, orientada e hemodinamicamente estável. A gasometria e os exames laboratoriais mostram: pH 7,32, bicarbonato 14 mEq/L, cloro 115 mEq/L, sódio 139 mEq/L, glicemia 150 mg/dL,

albumina: 4,0 g/dL. Os exames laboratoriais sugerem que a paciente

- A recebeu excesso de hidratação com cloreto de sódio.
- B permanece em cetoacidose diabética.
- C ainda está desidratada.
- D está em sepse de foco urinário.

4000120048

Questão 60 Tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada

Homem de 52 anos apresenta dispneia aos esforços há dois anos, progressiva, com melhora ao repouso. Há dois meses, iniciou inchaço nas pernas. AP: HAS não controlada há 15 anos. Exame físico: estase jugular 2+/4+, crepitações pulmonares em bases bilaterais e edema de membros inferiores. Rx de tórax: sinais de congestão pulmonar. Ecocardiograma: câmaras cardíacas com dimensões normais, aumento da espessura da parede do ventrículo esquerdo, fração de ejeção de 51%. Com o objetivo de aumentar a sobrevida e melhorar os sintomas, a melhor conduta é

- A inibidor da enzima conversora da angiotensina e betabloqueador.
- B controle da pressão arterial e introduzir diurético.
- C betabloqueador e ivabradina.
- D antagonistas dos canais de cálcio e associação sacubitril-valsartana.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120038](https://www.4000120038.com)

Questão 61 Tratamento cirúrgico

Mulher de 29 anos, nuligesta, apresenta aumento do fluxo menstrual com cólicas discretas. Método contraceptivo: condom. Exame ginecológico normal. Ultrassonografia transvaginal: mioma tipo 1 com 2 cm de diâmetro. A conduta é

- A miomectomia histeroscópica mais ablação do endométrio.
- B miomectomia histeroscópica.
- C histerectomia subtotal laparoscópica.
- D histerectomia total laparoscópica.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120029](https://www.4000120029.com)

Questão 62 Herpes na gestação

Primípara de 28 anos, 39 semanas de gestação, em trabalho de parto, apresenta ruptura da bolsa há 3 horas e refere história de lesões dolorosas na vulva há 4 dias. Exame físico: extensa placa eritematoedematosa, com exulcerações nos pequenos lábios (imagem a seguir). Exame citológico direto: células multinucleadas e núcleos com aspecto de vidro fosco. A conduta imediata é



- A cesariana e sorologia para herpes vírus.
- B parto vaginal e penicilina cristalina.
- C cesariana e aciclovir.
- D parto vaginal e ganciclovir.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120022](https://www.4000120022.com)

Questão 63 Interpretação e conduta frente as atipias citológicas Nomenclatura citológica brasileira

Mulher de 30 anos realizou exame ginecológico de rotina. Exame citológico do colo do útero: sugestivo de cervicite folicular. A conduta mais adequada é

- A realizar colposcopia.
- B tratar infecção por clamídia.
- C repetir exame citológico.
- D realizar ultrassonografia transvaginal.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000120000](https://www.4000120000.com)

Questão 64 Transtornos Somáticos Transtorno dos Sintomas Somáticos Diagnóstico da Depressão

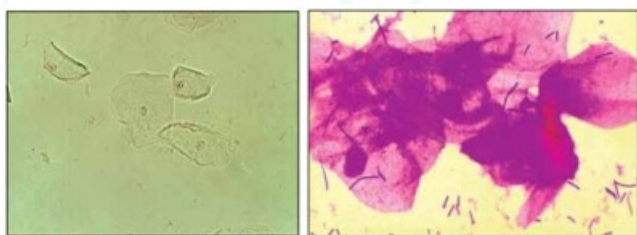
Mulher de 54 anos apresenta diminuição da concentração e rendimento no trabalho, desânimo, piora do sono e despertar matinal precoce, há dois meses, com piora há 15 dias. Os sintomas são piores pela manhã melhorando no período da tarde. Emagreceu 4 kg nesse período. Seus sintomas começaram logo após ter sofrido infarto do miocárdio. AP: menopausa aos 50 anos sem terapia hormonal. O diagnóstico e a conduta são:

- A depressão maior; inibidor preferencial de recaptura de serotonina.
- B distúrbio psicossomático; benzodiazepínicos.
- C transtorno de ajustamento; inibidor preferencial de recaptura de serotonina.
- D transtorno somatoforme; benzodiazepínicos.

400019994

Questão 65 Tipos de flora vaginal

Mulher de 32 anos apresenta corrimento vaginal persistente sem melhora após diversos tratamentos. Refere último tratamento há 40 dias, com creme vaginal que não sabe o nome, por sete dias. Nega mau odor genital e/ou prurido. Tem hábito de higienizar a região genital várias vezes ao dia com sabonetes perfumados. Exames microscópicos do conteúdo vaginal (imagens a seguir). O diagnóstico e a conduta são:



- A candidíase vaginal; isoconazol creme vaginal a 1% por 7 dias.
- B vaginose citolítica; banho de assento com chá de camomila frio.
- C vaginite descamativa inflamatória; clindamicina creme vaginal a 2% por 7 dias.
- D conteúdo vaginal fisiológico; adequar higiene genital.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 400019983

Questão 66 Regimes terapêuticos

Mulher de 59 anos, menopausa aos 53 anos, apresenta dor a relação sexual, ressecamento e ardência vaginal. Refere ondas de calor esporadicamente que não incomodam mais. Refere hipertrigliceridemia em tratamento. Mamografia BIRADS II. A conduta é

- A terapia estrogênica isolada transdérmica.
- B terapia estrogênica via vaginal.
- C terapia hormonal estroprogestativa oral.
- D lubrificante vaginal.

Essa questão possui comentário do professor no site 400019970

Questão 67 Histologia

O principal achado mamográfico do carcinoma in situ da mama é

- A nódulo espiculado, irregular e denso.
- B assimetria focal.
- C microcalcificações pleomórficas, numerosas e agrupadas.
- D distorção arquitetural.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119954](https://www.4000119954.com)

Questão 68 Diagnóstico diferencial Diagnóstico

Mulher de 25 anos, nuligesta, com disfunção menstrual desde a menarca, apresenta períodos de amenorreia de até 9 meses. Exame físico: PA 130x70 mmHg, estatura 1,50 m, peso 72 kg, acne ausente, índice de Ferriman--Gallwey (IFG) 10, acantosis nigricans presente na região cervical posterior. USG-TV: útero 52 cm³, espessura endometrial 6 mm, ovário direito 8,5 cm³, ovário esquerdo 7,0 cm³. A principal hipótese diagnóstica é

- A síndrome dos ovários policísticos, devendo-se afastar outras etiologias que cursam com disfunção menstrual e hiperandrogenismo.
- B síndrome dos ovários policísticos e como apresenta acantosis nigricans não é necessário afastar outras etiologias.
- C hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, pois a ultrassonografia é normal.
- D hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, devido ao valor de IFG.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119956](https://www.4000119956.com)

Questão 69 Células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas ASCUS Colposcopia

Mulher de 27 anos, G3P3A0C0, apresenta secreção vaginal amarronzada de forte odor e sinusorragia recorrente. Última citologia oncológica há 02 anos: ASC-US. Exame ginecológico: extensa ectopia cervical -2 friável, lesão grosseira acetorreagente às "6 horas". O próximo passo no seguimento dessa paciente é

- A nova citologia oncológica.
- B colposcopia com biópsia cervical.
- C cirurgia de alta frequência.
- D eletrocauterização de ectopia cervical.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119951](https://www.4000119951.com)

Questão 70 Tratamento

Mulher de 32 anos, G4P3A1C2, em uso de DIU de cobre como método contraceptivo, apresenta dor em baixo ventre de forte intensidade associada à febre. Exame físico: REG, T 39,2 °C, abdome doloroso e reativo, predominantemente à palpação de FIE, conteúdo vaginal anormal com secreção amarelada e espessa, em moderada quantidade, Whiff Test +, dor ao toque bimanual e à palpação, de regiões anexas, anexo esquerdo aumentado de tamanho (duas vezes), pouco móvel. A conduta inicial é

- A solicitação de exames laboratoriais e antibioticoterapia ambulatorial.
- B antibioticoterapia hospitalar e remoção do DIU.
- C solicitação de ultrassonografia transvaginal e antibioticoterapia hospitalar.
- D antibioticoterapia ambulatorial e remoção do DIU.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119946](#)

Questão 71 **Estadiamento** **Tratamento cirúrgico**

Mulher de 58 anos, G0P0, apresenta sangramento pós-menopausa recorrente há 7 meses. USG-TV: espessura endometrial 16 mm. Biópsia de endométrio à Pipelle: adenocarcinoma de endométrio do tipo endometriode, bem diferenciado grau I. RNM: envolvimento de menos de 50% do miométrio. A conduta inicial é

- A histerectomia total intrafascial e salpingooforectomia bilateral.
- B histerectomia total ampliada e linfadenectomia pélvica e paraórtica.
- C histerectomia total intrafascial e oomentectomia.
- D histerectomia total ampliada e salpingooforectomia bilateral.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119941](#)

Questão 72 **Tratamento** **Classificação**

Mulher de 67 anos, G4P4A0C0, menopausa aos 47 anos, hipertensa controlada, obesidade grau I (IMC= 32 kg/m²), com queixa de sensação de “globo vaginal”. Nega perdas urinárias, refere manter atividade sexual. Durante avaliação ginecológica, apresenta o seguinte resultado, segundo a classificação para quantificação de prolapso dos órgãos pélvicos (POP-Q): Aa +2 / Ba +2 / Ap -2 / Bp -1 / C 0 / D -1 / HG 5 / CP 3 / TVL 13; A melhor abordagem terapêutica é

- A histerectomia vaginal e colporrafia anterior com plicatura da fâscia vaginal.
- B colpocleise à Le Fort e colpoperineoplastia posterior.
- C histerectomia total abdominal e cirurgia de Burch.
- D histerectomia subtotal e promontofixação laparoscópica.

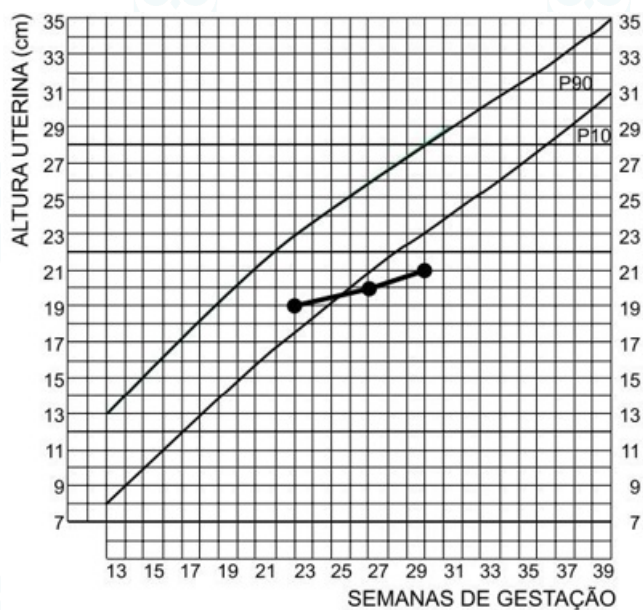
Proibida venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119934](#)

Questão 73 **Altura uterina AU** **Assistência pré-natal** **Obstetrícia**

No acompanhamento pré-natal de uma primigesta, observa-se a curva de crescimento uterino (imagem a seguir). US obstétrico: peso fetal no percentil 30, líquido amniótico normal e resistência normal na dopplerfluxometria da artéria umbilical. O diagnóstico é



- A crescimento normal.
- B feto pequeno constitucional.
- C restrição de crescimento fetal.
- D feto grande para idade gestacional.

4000119929

Questão 74 Abaixo de 34 semanas

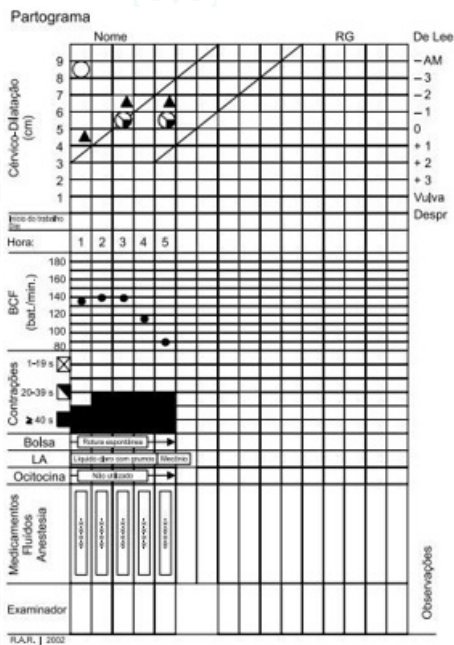
A paciente é internada com 31 semanas de gestação, queixando-se de dor em baixo do ventre. Exame obstétrico: colo uterino amolecido, centrado, esvaecido 70% e dilatado 4-5 cm. Nesse momento, além de prescrever betamesona, a prescrição médica deve ter

- A terbutalina, inibina e penicilina cristalina.
- B nifedipina, inibina e amoxicilina com clavulanato.
- C nifedipina, sulfato de magnésio e penicilina cristalina.
- D terbutalina, sulfato de magnésio e amoxicilina com clavulanato.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119908](https://www.4000119908.com.br)

Questão 75 Parada secundária da dilatação

Parturiente de 32 anos, G3P2A0C0, está sob assistência ao trabalho de parto e com evolução apresentada no partograma a seguir. O diagnóstico identificado na evolução do trabalho de parto e a conduta são:



- A parada secundária da dilatação e descida; cesárea.
- B parada secundária da dilatação e descida; fórceps de Kjelland.
- C parada secundária da dilatação; fórceps de Kjelland.
- D parada secundária da dilatação; cesárea.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119898](https://www.4000119898.com)

Questão 76 Avaliação do colo uterino

Tercigesta de 32 anos, com idade gestacional de 20 semanas, assintomática, apresenta antecedente de prematuridade, dois partos vaginais com 34 e 30 semanas, respectivamente. Exame físico normal. US: comprimento do colo de 40 mm. Nesse momento, a conduta é

- A circlagem.
- B progesterona.
- C inibina.
- D carbonato de cálcio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119882](https://www.4000119882.com)

Questão 77 Transmissão vertical do HIV

Gestante de 23 anos, G1P0, com 35 semanas de gestação, apresenta infecção por HIV, em terapia antirretroviral correta. Carga viral indetectável realizada há 3 dias. A via de parto recomendada e a conduta, quanto à utilização de antirretroviral profilático no parto, são:

- A parto cesário eletivo, a partir da 38ª semana; utilizar zido-vudina por via intravenosa três horas antes do parto.
- B parto segundo indicação obstétrica, podendo ser vaginal; utilizar zidovudina por via intravenosa três horas antes do parto.
- C parto cesário eletivo, a partir da 38ª semana; utilizar zido-vudina por via intravenosa no momento do parto.
- D parto segundo indicação obstétrica, podendo ser vaginal; manter terapia antirretroviral habitual oral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119874](#)

Questão 78 Diagnóstico

Gestante de 33 anos, G4P3A0C2, e idade gestacional de 27 semanas e 4 dias, apresenta sangramento vaginal há 1 hora. Nega outras queixas. Exame físico: PA 120x70 mmHg, FC 88 bpm, altura uterina 25 cm, tônus uterino normal, dinâmica uterina negativa, situação transversa, BCF 144 bpm. Exame especular: presença de pequena quantidade de sangue se exteriorizando pelo orifício cervical externo. A conduta é:

- A solicitar ultrassonografia.
- B realizar toque vaginal.
- C solicitar ressonância magnética.
- D realizar toque e solicitar ultrassonografia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119861](#)

Questão 79 Dieta Diagnóstico Doenças crônicas

Secundigesta, 38 anos, IMC 41 kg/m², inicia o pré-natal com 7 semanas e apresenta nos exames de primeiro trimestre os seguintes resultados: Ht 36%; Hb 12,1 g/dL; glicemia de jejum 127 mg/dL; urina tipo I raros leucócitos, glicose +++/4+, sorologias não reagentes para sífilis, HIV e toxoplasmose. A hipótese diagnóstica e a conduta são:

- A Diabetes mellitus gestacional; orientar dieta.
- B Diabetes mellitus tipo II; orientar dieta e introduzir metformina.
- C Diabetes mellitus tipo II; orientar dieta e introduzir insulina.
- D Diabetes mellitus gestacional; orientar dieta e introduzir metformina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119853](#)

Questão 80 Doenças associadas à gestação Hipertensão gestacional Distúrbios hipertensivos na gestação DHEG

Gestante com hipertensão arterial crônica há 10 anos comparece para sua primeira consulta de pré-natal. Além dos exames de rotina, deve-se solicitar:

- A cultura de urina, creatinina sérica e proteinúria de 24 horas.
- B ultrassom renal, creatinina sérica e proteinúria de 24 horas.
- C ácido úrico, relação proteinúria/creatinúria e ultrassom renal.
- D relação proteinúria/creatinúria, ecocardiograma e fundo de olho.

Questão 81 Tratamento

RN de termo apresenta macrocrania (perímetro cefálico de 39 cm), abaulamento da fontanela anterior e ingurgitamento de veias cefálicas. TC de crânio: sugestiva de neurotoxoplasmose (imagem a seguir). A melhor conduta é



- A derivação ventricular externa.
- B derivação ventricular para o peritônio.
- C terceiro ventriculostomia endoscópica.
- D expectante, com medidas periódicas do perímetro cefálico.

Livre
Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000119831

Questão 82 Astigmatismo

Criança de 9 anos apresenta cefaleia supraorbitária, fotofobia, ardor, lacrimejamento e hiperemia ocular. Os diagnósticos clínico e de ametropia, e a necessidade de lentes, são, respectivamente:

- A astenopia e astigmatismo miópico baixo; cilindro negativo.
- B anisometropia e miopia; esférica positiva.
- C ambliopia e hipermetropia; esférica negativa.
- D anisocoria e presbiopia; esférica positiva.

4000119814

Questão 83 Molusco contagioso

Adolescente de 17 anos refere surgimento há quatro semanas de lesões assintomáticas na base do pênis, com extensão para raiz de coxas e hipogástrico (imagem a seguir). Tem história de contato sexual desprotegido há seis semanas. O diagnóstico e a proposta terapêutica são:



- A molusco contagioso; curetagem.
- B verruga genital (HPV); cauterização com ácido tricloroacético 90%.
- C sífilis primária (cancro duro); penicilina benzatina 2400000 UI intramuscular dose única.
- D herpes genital; aciclovir 400 mg cinco vezes por dia por 7 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119808](https://www.t.me/medicinalivre)

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Questão 84

Condutas

Tratamento

A conduta inicial preconizada para um RN com 4 dias de vida, com suspeita de displasia do desenvolvimento do quadril, realizada pela manobra de Ortolani, em sua primeira consulta médica em UBS, antes do encaminhamento ao ortopedista, é a instalação

- A da órtese de Petri.
- B da fralda de Frejka e do suspensório de Pavlik.
- C da fralda de Frejka, apenas.
- D do suspensório de Pavlik.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119791](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 85

Drogas vasoativas

Lactente com choque séptico hipodinâmico compensado, não responsivo à infusão de 60 mL/kg de solução fisiológica intravenosa. A melhor conduta, nesse momento, é administração intravenosa de

- A noradrenalina.
- B vasopressina.
- C dopamina em dose inotrópica.
- D adrenalina em dose inotrópica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119781](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 86

Diagnóstico

Asma

Classificação e Tratamento da Crise

Na criança em estado de mal asmático, é correto afirmar que

- A a intubação traqueal precoce evita complicações da hipoxemia e hipercapnia graves.
- B o sulfato de magnésio intravenoso é terapia broncodilatadora adjuvante e tem bom perfil de segurança.
- C a inalação com altas doses de salbutamol (0,5 mg/kg/hora) é contraindicada por causar taquicardia extrema.
- D a aminofilina intravenosa tem bom perfil de segurança e deve ser usada nos casos refratários à inalação com doses habituais de fenoterol.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119770](#)

Questão 87 Diagnóstico da Diarreia Crônica Etiologia

Menina escolar de 8 anos apresenta dor abdominal que ocorre em episódios frequentes há 3 meses. A criança refere dor difusa, de moderada intensidade; o hábito intestinal é regular, mas às vezes apresenta episódios de diarreia líquida, sem muco, pus ou sangue. Pai refere perda de peso de 3 kg apesar de a criança continuar se alimentando normalmente. A característica clínica, que é um sinal de alerta de que essa dor deva ser de origem orgânica, é

- A intensidade da dor.
- B presença de diarreia.
- C perda de peso.
- D dor difusa.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119761](#)

Questão 88 Taquicardia Supraventricular TSV

Lactente de 11 meses apresenta palidez cutânea, sudorese e taquicardia há 3 horas. Exame físico: febril (39°C), pulsos amplos, perfusão periférica aumentada e tempo de enchimento capilar de um segundo, FC acima de 200 bpm. ECG: FC de 240 bpm, ondas P negativas em D1, D2 e aVF e positiva em aVR, precedendo os complexos QRS, sem sinais de sobrecarga ventricular e com alterações difusas da repolarização ventricular. O ritmo cardíaco é taquicardia

- A sinusal.
- B supraventricular.
- C juncional.
- D ventricular.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119753](#)

Questão 89 Síndrome de Down

São alterações comuns em crianças com a Síndrome de Down, além da cardiopatia:

- A instabilidade atlanto occipital, imunidade celular comprometida e atresia de duodeno.
- B pé cavo varo, processos infecciosos bacterianos e disfunção da tireoide.
- C fêmur curto congênito, hipotireoidismo congênito e imunidade humoral comprometida.
- D bácia posterior da pelve, imunidade celular comprometida, catarata e erro de refração.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119744](#)

Questão 90 Infectologia Imunoglobulina contra raiva Indicações

Dois irmãos foram mordidos por cachorro, nas mãos, cabeça e tronco. O cachorro não foi encontrado. Um dos irmãos, de 4 anos, tem agamaglobulinemia ligada ao X (imunodeficiência primária-IDP), e o outro, de 5 anos, é imunocompetente (IC). As vacinas estão em dia, segundo calendário em vigor. A conduta para profilaxia e redução de danos para os irmãos é

- A vacina e imunoglobulina contra raiva para ambos, soro antitetânico e antibioticoterapia para IDP.
- B vacina e imunoglobulina contra raiva para IC e imunoglobulina para IDP, não fazer profilaxia contra tétano e não indicar antibioticoterapia.
- C vacina e imunoglobulina contra raiva para IDP e vacina contra raiva e contra tétano para IC, soro antitetânico para IDP, antibioticoterapia para ambos.
- D imunoglobulina contra raiva para IDP e vacina para IC, soro antitetânico para ambos, não indicar antibioticoterapia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119734](#)

Questão 91 Cardiopediatria e Cardiopatias congênitas

Assinale a alternativa que correlaciona, corretamente, as cardiopatias congênitas com suas características fisiopatológicas. I. Comunicação interventricular. II. Estenose valvar aórtica. III. Tetralogia de Fallot. IV. Transposição das grandes artérias sem estenose valvar pulmonar. A – Cardiopatia acianótica com hiperfluxo pulmonar. B – Cardiopatia acianótica com normofluxo pulmonar. C – Cardiopatia cianótica com hiperfluxo pulmonar. D – Cardiopatia cianótica com hipofluxo pulmonar.

- A I-A, II-B, III-C, IV-D.
- B I-A, II-B, III-D, IV-C.
- C I-B, II-A, III-C, IV-D.
- D I-B, II-A, III-D, IV-C.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119725](#)

Questão 92 Meningites

Menino de 8 meses apresenta história de irritabilidade e temperaturas até 37,5 °C há 4 dias. Há uma hora, apresentou episódio convulsivo com duração de 15 minutos. AP: estado vacinal desconhecido. Exame físico: REG, FC 120 bpm, FR 36 ipm, afebril, boa perfusão periférica, sonolento, hipoativo e pouco reativo. TC de crânio com contraste: impregnação de leptomeninge, especialmente das cisternas da base. Líquor: 500 células (70% linfócitos, 30% monócitos), 15 mg/dL de glicose e 250 mg/dL de proteínas. A hipótese diagnóstica mais provável é

- A meningoencefalite por citomegalovírus.
- B meningoencefalite herpética.
- C meningite por *Haemophilus influenzae* tipo B.
- D meningite tuberculosa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119708](#)

Questão 93 Diagnóstico Tratamento

Adolescente de 14 anos apresenta febre, tosse, coriza, conjuntivite, com piora após um cruzeiro pela costa do Brasil há 10 dias. Foi medicado com amoxicilina/clavulanato, e após 48 horas evoluiu com aumento da febre e exantema retroauricular,

facial, cervical e posterior progressão para o tronco. Exame físico: REG, febril, prostrado, exantema maculopapular, linfonodomegalia, mucosas hiperemiadas e estertoração crepitante em base de hemitorax direito. Sua conduta é

- A prescrição de macrolídeo, anti-histamínico, retorno em 48 horas e notificação do evento adverso.
- B prescrição de quinolona, anti-histamínico e retorno em 72 horas.
- C internação, prescrição de antibiótico e sintomáticos e notificação à vigilância.
- D internação, prescrição de antibiótico e anti-histamínico e notificação do evento adverso.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119699](#)

Questão 94 Inibição da amamentação Infectologia Transmissão vertical do HIV

Mulher apresenta linfadenomegalia há uma semana com sorologia anti-HIV reagente. É mãe de uma criança de 4 meses e durante toda a gestação teve sorologias normais. Seguindo o atual protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes, a conduta em relação a orientação para o filho de 4 meses é

- A suspender a amamentação e aguardar 60 dias para avaliação com carga viral.
- B suspender a amamentação, colher carga viral e introduzir profilaxia pós-exposição.
- C não suspender a amamentação e repetir anti-HIV da mãe.
- D não suspender a amamentação e solicitar anti-HIV da criança.

4000119686

Questão 95 Tratamento Pediatria

Menino de 3 meses apresenta febre 39,5°C e baixa aceitação do seio materno há 4 dias. EF: REG, hidratado, febril 38,5 °C. Urina I (sondagem vesical): pH 6,0, densidade 1010, nitrito negativo, proteína +1, leucoesterase +3, leucócitos de 150/campo, hemácias de 20/campo. A conduta é

- A antitérmico e retorno para ver o resultado da cultura de urina.
- B antibiótico via oral e retorno para ver resultado da cultura de urina.
- C internação e antibiótico intravenoso.
- D internação e aguardar resultado de cultura de urina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000119676](#)

Questão 96 Investigação diagnóstica Definição Tratamento

Menina de 3 anos apresenta perda urinária diurna em toda micção, com frequência de 8 vezes ao dia. À noite usa fraldas para dormir. Hábito intestinal: normal. Desenvolvimento neuropsíquico motor normal para a idade. AP: desfralde ocorreu com 1 ano. AF: prima de 9 anos apresenta perda urinária diurna sem perdas noturnas. Exame físico: normal. Exames laboratoriais: urina I normal e cultura de urina negativa. A afirmação correta é:

- A o desfralde precoce é a possível causa da perda diurna.
- B a perda diurna tem influência do fator genético.
- C a perda noturna é considerada um distúrbio miccional nessa faixa etária.
- D a uroterapia é indicada para o treinamento da perda noturna antes do treinamento diurno.

Essa questão possui comentário do professor no site [400019669](#)

Questão 97 **Curvas de Crescimento**

Menina de 18 meses vem ganhando cerca de 300 g/mês há 3 meses, mantendo-se no mesmo percentil na curva de peso (P 30). Sua mãe está preocupada, pois acha que ela está sem apetite. A conduta mais adequada é

- A orientar cardápio hipercalórico e marcar retorno breve para reavaliação do ganho de peso.
- B solicitar hemograma, urina tipo I e protoparasitológico de fezes, para uma avaliação clínica mais completa.
- C solicitar urina tipo I e cultura de urina, pois a situação parece sugestiva de infecção do trato urinário.
- D tranquilizar a mãe, orientando sobre a “falsa anorexia” própria dessa idade.

Essa questão possui comentário do professor no site [400019661](#)

Questão 98 **Taquipneia Transitória do Recém-nato TTRN**

RN de 36 semanas de idade gestacional, parto cesáreo por indicação materna. Apgar de 5-7 no primeiro e quinto minutos. Após os procedimentos habituais de reanimação, com 15 minutos de vida, apresenta desconforto respiratório caracterizado por gemência, batimento de asa nasal, tiragem intercostal e retração diafragmática. A saturação de oxigênio pré-ductal é de 91% com FC 110 bpm e FR 80 irpm. A conduta mais adequada é

- A iniciar oferta de oxigênio por via inalatória.
- B administrar surfactante exógeno nas primeiras duas horas de vida.
- C indicar suporte respiratório com pressão contínua nas vias aéreas (CPAP).
- D realizar VPP com balão e máscara com FR de 40-60 irpm.

400019655

Questão 99 **Definição Conduta**

RN de 10 dias de vida apresenta insuficiência respiratória e está em atendimento no pronto-atendimento geral. Na avaliação para estabilização pré-transporte para o serviço médico de referência, o paciente apresenta, além dos sinais e sintomas respiratórios, vômitos, tremores e palidez cutâneo-mucosa. Glicemia de 30 mg/dL (glicofita). A conduta correta é

Questão 1 HIVAids Medicina de Família e Comunidade

O aspecto mais difícil no processo de atenção e cuidado contínuo às pessoas que vivem com HIV/aids é

- A a supressão da carga viral do HIV.
- B iniciar tratamento específico antirretroviral.
- C adesão ao acompanhamento e à terapia antirretroviral.
- D vinculação e retenção a um serviço de saúde.

4000141702

Questão 2 Vacinas meningocócicas Doença meningocócica

Em estratégias vacinais contra *Neisseria meningitidis*, o sorogrupo

- A tornou-se o mais prevalente mundialmente, após as extensas campanhas de vacinação realizadas no continente africano.
- B foi precocemente eliminado da maior parte dos países ocidentais, uma vez que foi o primeiro para o qual uma vacina eficaz foi desenvolvida.
- C Y e sua maior gravidade nas meningites no primeiro ano de vida são a principal razão para sua inclusão recente no calendário vacinal infantil brasileiro.
- D C suplantou o B e tornou-se o predominante no Brasil, nas últimas duas décadas, fato que tem guiado as políticas públicas de vacinação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141701](https://t.me/medicinalivre)

Questão 3 Classificação das Epilepsias Tratamento Cirúrgico Neurologia

A epilepsia

- A do lobo frontal é a mais frequente na população geral adulta.
- B benigna da infância tem alta prevalência e é uma das principais causas de epilepsia na idade adulta.
- C do lobo temporal é importante causa de esclerose hipocampal, tem alta prevalência na idade adulta e possui tratamentos clínico e cirúrgico para controle das crises.
- D do lobo temporal tem relação com convulsão febril na infância e tem baixa prevalência na idade adulta. do lobo frontal é a mais frequente na população geral adulta.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141700](https://t.me/medicinalivre)

Questão 4 Abstinência de Álcool Psiquiatria

Homem de 28 anos interrompeu o uso de álcool há 2 dias, ocasião em que passou a apresentar tremores, sudorese, discurso incoerente, ilusões e alucinações visuais (zoopsias). Segundo familiares, nos últimos dias o paciente estava mais isolado, com diminuição do apetite e do sono. Foi prescrita reposição hidroeletrolítica e 10 mg VO de diazepam. Observou-se atenuação dos sinais de hiperatividade autonômica por 2 horas, quando os sintomas retornaram e o paciente apresentou-se mais inquieto, aparentando estar assustado.

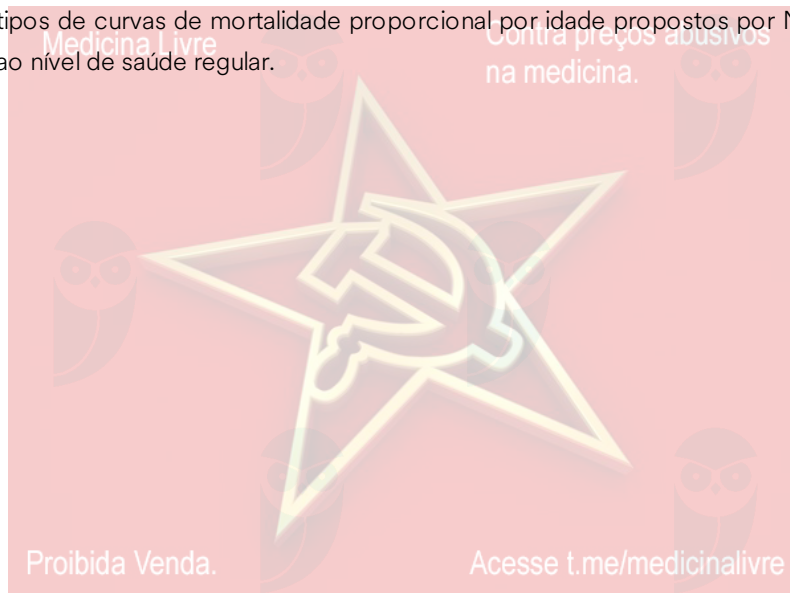
Com base nessa descrição, o paciente deve

- A permanecer internado, pois se trata de quadro que necessita de assistência hospitalar por trazer riscos ao indivíduo (*delirium tremens*).
- B ser liberado para tratamento no CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas), sendo recomendado associar o uso de antidepressivo desde o início visando aumentar a adesão ao tratamento e atenuar a sintomatologia depressiva.
- C ser liberado após orientação quanto à necessidade de hidratação e uso correto dos medicamentos prescritos (benzodiazepínico e reposição de tiamina), pois os dados indicam abstinência, e ele pode ser tratado no CAPS AD.
- D permanecer internado, e, em caso de agitação psicomotora é recomendado o uso endovenoso de neurolépticos de baixa potência.

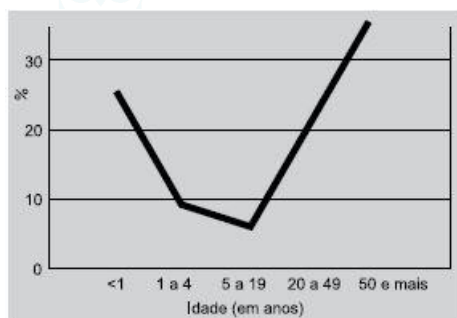
Essa questão possui comentário do professor no site [4000141699](#)

Questão 5 **Curvas de Nelson de Moraes**

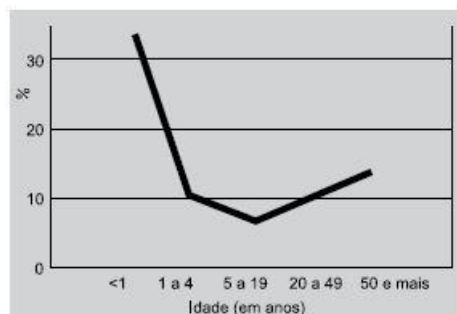
Considerando os quatro tipos de curvas de mortalidade proporcional por idade propostos por Nelson de Moraes, assinale aquele que corresponde ao nível de saúde regular.



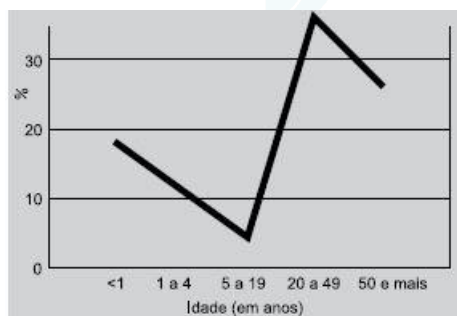
A



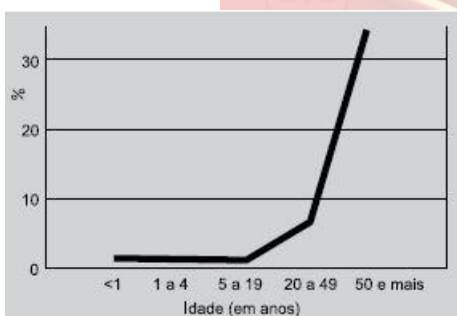
B



C



D



Contra preços abusivos
na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141698](https://www.4000141698.com)

Questão 6 **Sigilo profissional**

Conforme disposto no Código de Ética Médica, é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo, entre outros motivos

- A quando do exame médico de trabalhadores.
- B se tiver consentimento, por escrito, do paciente.
- C quando de seu depoimento como testemunha.
- D se o paciente tiver falecido.

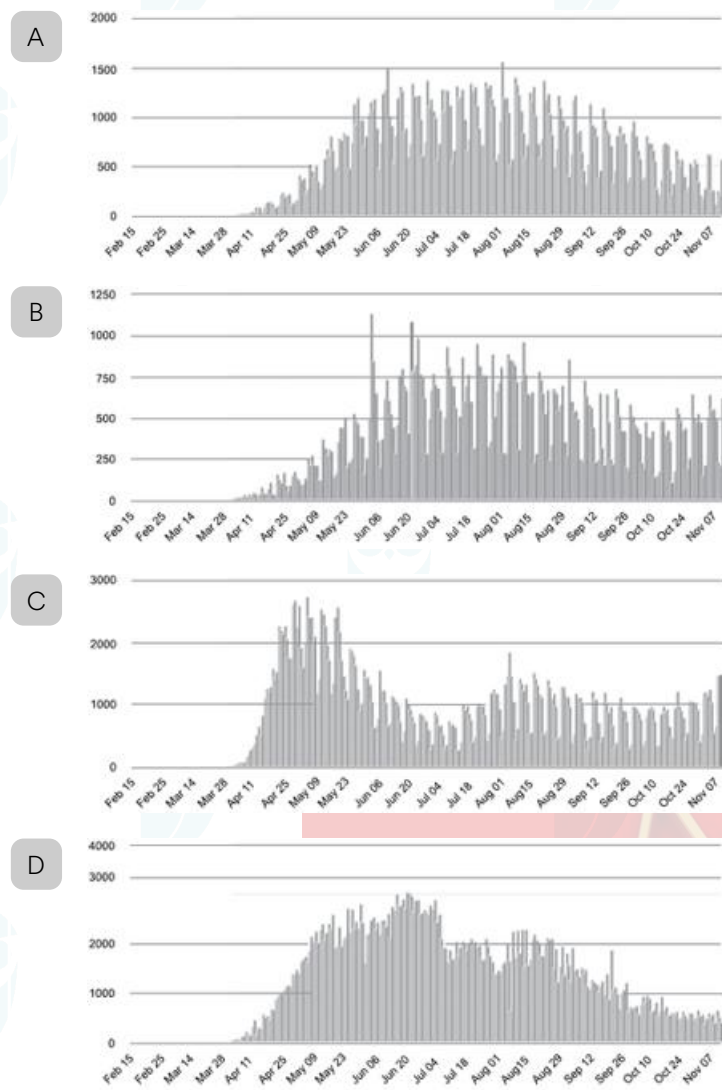
Essa questão possui comentário do professor no site [4000141698](https://www.4000141698.com)

Questão 7 **Medicina Preventiva** **Medidas de saúde coletiva**

Sistemas de Informação em Saúde SIS e Bases de dados do SUS

Assinale a alternativa que representa graficamente a evolução de óbitos diários por COVID-19, ocorridos no Brasil, de

fevereiro a novembro de 2020 (as barras representam o número de óbitos diários)



Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141696](#)

Questão 8 Declaração de óbito DO Atestado de óbito

A obrigação legal da emissão da Declaração de Óbito, em casos de “morte não natural” (decorrente de causas externas) compete ao médico

- A** que vinha prestando assistência ao paciente, sempre que o tempo entre o evento violento e a morte for superior a 30 dias.
- B** legista ou de SVO (Serviço de Verificação de Óbito), nas localidades que dispõem desses tipos de serviço.
- C** legista, qualquer que tenha sido o tempo entre o evento violento e a morte propriamente.
- D** do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento, nas localidades que não dispõem de Instituto Médico Legal.

4000141695

Questão 9 Políticas de Saúde do Sistema Único de Saúde Medicina Preventiva Política Nacional de Humanização

Entre as diretrizes gerais para a implementação da Política Nacional de Humanização nos serviços de Urgência e Emergência, está:

- A definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito.
- B acolher a demanda independentemente de critérios de risco, garantindo o livre acesso aos demais níveis de assistência.
- C ampliar a resolução das urgências e emergências, bloqueando o acesso às estruturas hospitalares.
- D evitar a alta precoce e os riscos decorrentes dos cuidados domiciliares.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141694](#)

Questão 10 Saúde Suplementar

No Brasil, o setor de saúde suplementar exibe diferentes modalidades de gestão e operação. A modalidade denominada “cooperativa de trabalho médico” tem a seguinte característica, entre outras:

- A algumas cooperativas possuem hospitais próprios, onde os médicos são cooperados e a clientela é composta por pessoas físicas e jurídicas.
- B gestão feita por organização formada por profissionais cooperados ou entidades de trabalhadores em geral.
- C uniformidade do padrão dos serviços prestados, dos preços cobrados e dos instrumentos de gestão, em todo o país.
- D serviços prestados em unidades próprias ou por meio de empresa de medicina de grupo que emprega os profissionais médicos.

4000141693

Questão 11 Lei n 8142/1990

Nos termos da Lei no 8.142, de 28/12/1990, os Conselhos de Saúde devem ter

- A atuação na formulação de estratégias da política de saúde, excluídos os aspectos econômicos e financeiros.
- B caráter permanente e consultivo.
- C composição paritária entre representantes do governo e profissionais de saúde.
- D decisões homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141692](#)

Questão 12 Tuberculose Controle dos comunicantes Pediatria

RN foi vacinado com BCG ao nascer. Sua mãe foi diagnosticada com tuberculose pulmonar bacilífera logo após o parto.

A conduta para o RN, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, é:

- A isoniazida por três meses; em seguida, realizar prova tuberculínica; e, se < 5 mm, suspender isoniazida e revacinar com BCG.
- B rifampicina suspensão por três meses; em seguida, realizar prova tuberculínica; e, se ≥ 5 mm, manter rifampicina por mais 3 meses.
- C rifampicina suspensão por seis meses, não estando indicada a realização da prova tuberculínica.
- D isoniazida por seis meses, não estando indicada a realização da prova tuberculínica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141691](#)

Questão 13 **Asma ocupacional x asma relacionada ao trabalho** **Classificação de Schilling**

Asma brônquica ocupacional e asma brônquica relacionada ao trabalho são

- A respectivamente, a asma que aparece pela primeira vez em paciente adulto sem antecedentes do agravo e a desencadeada por exposição a alérgeno do trabalho que acomete paciente que já teve asma no passado.
- B denominações usadas para distinguir casos de asma decorrentes, respectivamente, de exposições a alérgenos de alto peso molecular e a irritantes de baixo peso molecular.
- C formas de manifestação da asma brônquica reconhecida como acidente do trabalho na lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho, sendo seus diagnósticos apoiados, respectivamente, em testes de hiper-reatividade brônquica específica e inespecífica.
- D respectivamente, a asma manifestada depois que o trabalhador saiu do local de trabalho e a asma manifestada ainda no local de trabalho.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141690](#)

Questão 14 **Política Nacional de Atenção Básica PNAB**

O objetivo de se trabalhar com a territorialização na Saúde Coletiva é

- A realizar a avaliação do impacto epidemiológico dos serviços hospitalares gerais e especializados sobre os níveis de saúde da população.
- B possibilitar a caracterização da homogeneidade do acometimento de agravos em cidades de médio e grande portes.
- C caracterizar os problemas de saúde das populações identificados num território com a perspectiva de sua generalização para a cidade como um todo.
- D prevenir riscos e evitar danos à saúde, a partir de um diagnóstico da situação de saúde e das condições de vida de populações em áreas delimitadas.

4000141689

Questão 15 **Medicina Preventiva** **Transição Epidemiológica no Brasil**

Analisando-se o perfil epidemiológico do Brasil, pode-se observar que, nas últimas três décadas, de 1990 a 2020, ocorreu

- A aumento da mortalidade por câncer de mama e por câncer de colo de útero e controle da dengue.
- B aumento da expectativa de vida ao nascer, diminuição da mortalidade infantil e controle da paralisia infantil.
- C controle da tuberculose e da hanseníase e diminuição das mortes por causas pré-natais e perinatais.
- D aumento da mortalidade infantil tardia e reintrodução da dengue como causa de epidemia.

4000141688

Questão 16 Program Saúde da Família PSF e Estratégia Saúde da Família ESF

A Estratégia de Saúde da Família é considerada prioridade para o reordenamento do modelo assistencial à saúde e objetiva o estabelecimento de

- A maior vínculo entre equipe de profissionais de saúde e indivíduo, família e comunidade com base territorial, considerando o espaço como construção social.
- B medidas de controle de doenças agudas infecciosas por meio da visita domiciliar realizada exclusivamente por profissional médico, contribuindo para a redução de gastos hospitalares.
- C ações de educação e promoção à saúde, voltadas a populações vulneráveis, com o objetivo de impor mudanças de estilo de vida a indivíduo, família e comunidade.
- D maior vínculo entre médicos e indivíduos de comunidades com populações pobres, desassistidas por planos de saúde, em regiões remotas ou de periferias das cidades de pequeno e médio portes.

4000141687

Questão 17 Letalidade

No dia 24 de maio de 2020, o Brasil registrou 363 211 casos confirmados de COVID-19, sendo: 149 911 casos recuperados, 190 634 casos em acompanhamento e 22 666 óbitos.

O coeficiente de letalidade da doença nessa data foi de

- A 73,4‰.
- B 0,58‰.
- C 5,24%.
- D 6,24%.

4000141686

Questão 18 Medicina Preventiva Epidemiologia Causalidade

Um estudo de coorte encontrou a associação entre o consumo frequente de carne bovina e o risco de câncer de boca e orofaringe. Foi encontrada, ainda, uma forte relação dose- -resposta com o aumento do consumo.

Os critérios de causalidade propostos por Hill que estão representados no trecho acima são

- A gradiente biológico e temporalidade.
- B temporalidade e evidência experimental.
- C especificidade e coerência.
- D analogia e gradiente biológico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141685](#)

Questão 19 Falácia ecológica

Em um estudo de conglomerados, atribuir ao indivíduo um resultado de dados agregados pode levar a um erro de interpretação chamado

- A erro tipo II.
- B erro de classificação.
- C viés de seleção.
- D falácia ecológica.

4000141684

Questão 20 Medicina Preventiva Epidemiologia Estudos Epidemiológicos

O principal objetivo da randomização em ensaio clínico é

- A ajudar a assegurar a representatividade da população geral nos grupos de tratamento.
- B facilitar as medidas de variáveis.
- C assegurar que os grupos de estudos sejam comparáveis nas características iniciais.
- D reduzir o viés de informação na alocação do tratamento.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141683](#)

Questão 21 Cardiopediatria e Cardiopatias congênitas Principais cardiopatias congênitas Pediatria

A comunicação interatrial (CIA)

- A tem indicação de correção cirúrgica somente quando há sintomatologia significativa.
- B do tipo *ostium secundum* é a menos comum e deve ser corrigida cirurgicamente na adolescência.
- C geralmente leva à cianose na idade pré-escolar, que regride espontaneamente, não necessitando cirurgia para sua correção.
- D do tipo *ostium secundum* pode ser corrigida cirurgicamente por sutura simples ou com uso de retalho.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141682](#)

Questão 22 Classificação da Isquemia Aguda dos Membros Oclusão Arterial Aguda OAA Tromboembolismo Arterial

Mulher de 68 anos apresenta dor intensa no membro inferior esquerdo (MIE) há 36 horas, com perda de motricidade, restrição ao leito, frialdade e mudança da cor do pé, conforme imagem:



Fez uso de analgésicos e anti-inflamatórios sem melhora. AP: fibrilação atrial crônica sem tratamento. Exame físico: MIE com cianose fixa, presença de flictenas, gradiente térmico em terço médio da perna, ausência de pulsos poplíteo e distais à esquerda e presença de todos os pulsos 4+/4 no membro inferior direito. O provável diagnóstico, a etiologia, a classificação clínica e o tratamento são, respectivamente:

- A oclusão arterial aguda; embólica; Rutherford IIB; amputação primária e antiagregação plaquetária.
- B doença arterial obstrutiva periférica; trombótica; Rutherford IIB; tromboembolectomia à Fogarty e anticoagulação.
- C doença arterial obstrutiva periférica; aterosclerótica; Rutherford I; angioplastia com stent e antiagregação plaquetária.
- D oclusão arterial aguda; embólica; Rutherford III; amputação primária e anticoagulação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141681](#)

Questão 23 **Abordagem cirúrgica do pé diabético**

Homem de 60 anos apresenta necrose indolor do hálux esquerdo após usar calçado apertado. AP: DM. Exame físico: necrose bem delimitada com área exsudativa puntiforme na face plantar da base do hálux, pele xerótica, com redução de sensibilidade tátil, pulsos femorais e poplíteos presentes e fortes, pulsos distais ausentes bilateralmente. Índice Tornozelo-Braquial à esquerda: 1,10 na artéria tibial anterior e 1,20 na artéria tibial posterior. Raio X do pé esquerdo: normal.

O tipo de acometimento do pé diabético e o adequado tratamento, além de antibioticoterapia e curativos, são respectivamente:

- A microvascular apenas; repouso.
- B macrovascular apenas; amputação aberta do hálux.
- C macro e microvascular; arteriografia, revascularização e amputação do hálux.
- D macro e microvascular; arteriografia e amputação do hálux.

4000141680

Questão 24 **Diagnóstico Cirurgia**

Considere a radiografia a seguir:



A principal conclusão diagnóstica da radiografia apresentada é:

- A presença de nível hidroaéreo sugestivo de obstrução intestinal.
- B opacidade abdominal sugestiva de ascite.
- C elevação diafrágica sugestiva de hérnia diafrágica de Morgagni.
- D pneumoperitônio sugestivo de perfuração de víscera oca.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141679](https://www.4000141679.com.br)

Questão 25 Diagnóstico Pediatria

Menino com 16 dias de vida apresenta dificuldade para evacuar desde o nascimento, associada a distensão abdominal. AP: nascido a termo, eliminou mecônio com 3 dias de vida, após estímulo retal. Desde a alta da maternidade, evacuou duas vezes, após aplicação de supositório de glicerina. Exame físico: abdome globoso, distendido, RHA propulsivos, sem sinais de reação peritoneal.

O método considerado como padrão-ouro para o diagnóstico da principal hipótese diagnóstica é

- A manometria anorretal.
- B enema opaco.
- C biópsia retal de sucção.
- D ressonância nuclear magnética.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141678](https://www.4000141678.com.br)

Questão 26 Intussuscepção ou Invaginação Intestinal

Menino de 9 meses apresenta dor abdominal intermitente há 1 dia. Mãe relata que ele apresenta momentos com muita dor, que duram alguns minutos e, em seguida, fica quieto e pálido. Hoje apresentou 4 episódios de vômitos: os dois primeiros com conteúdo alimentar; e os 2 mais recentes esverdeados. Não evacua há 2 dias. Exame físico: REG, calmo, descorado +/4, desidratado +/4, FC 140 bpm. Abdome distendido, RHA diminuído, doloroso à palpação, com massa móvel palpável em hipocôndrio direito, e fossa ilíaca direita “vazia”.

A principal hipótese diagnóstica é

- A apendicite aguda.
- B enterocolite necrosante.
- C invaginação intestinal.
- D obstrução intestinal por *Ascaris lumbricoides*.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141677](https://www.4000141677.com)

Questão 27 Etiologia e Epidemiologia Diagnóstico Apresentação Clínica

Mulher de 32 anos apresenta dor facial à direita e obstrução com eliminação de secreção nasal à direita há 15 dias. AP: extração do 2º molar superior à direita há 1 mês, cujo procedimento foi doloroso e traumático. Exame otorrinolaringológico: ausência de 2º molar superior à direita com mucosa friável ao toque e tecido de granulação; fossa nasal direita com saída de secreção amarelada pela concha nasal média e hiperemia de mucosa à direita (figura 1); fossa nasal esquerda normal. Rinoscopia posterior: secreção amarelada em rinofaringe; raio X de seios paranasais: figura 2.

FIGURA 1



FIGURA 2



Assinale a alternativa correta.

- A O diagnóstico é sinusite aguda maxilar bacteriana, e o quadro atual não deve ter relação com a extração dentária.
- B Não há relação entre os fatos, pois a drenagem do seio maxilar se dá pela concha nasal inferior e não pela concha média.
- C O raio X de seios da face mostra velamento de ambos os seios maxilares, portanto o quadro atual não tem relação com o procedimento odontológico.
- D Trata-se de um quadro de sinusite maxilar bacteriana de causa odontogênica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141676](https://www.4000141676.com)

Questão 28 Glaucoma Agudo de Ângulo Fechado Crise Aguda de Glaucoma

Mulher de 60 anos refere que estava assistindo à televisão quando se levantou e, sem acender as luzes, foi na penumbra buscar uma manta em seu quarto. Informa que, pouco tempo depois, começou a apresentar náuseas, forte cefaleia supraorbitária e dor ocular à direita de forte intensidade com visão turva e halos coloridos. Ao exame externo, você detecta

semimidríase paralítica, córnea com diminuição de brilho, grande hiperemia conjuntival com injeção ciliar e olho direito com digito-pressão elevada.

Sua hipótese diagnóstica e o tratamento inicial até a chegada do especialista, após afastar contraindicações sistêmicas, seriam:

- A neurite óptica isquêmica; vasodilatadores e antiagregantes plaquetários.
- B glaucoma agudo; manitol 20% intravenoso, inibidor da anidrase carbônica e colírio de pilocarpina 2%.
- C uveíte hipertensiva; colírio de corticosteroide de hora em hora até sair da crise.
- D esclerite posterior; pomada de corticosteroide mais curativo oclusivo para não entrar luz e repouso.

4000141675

Questão 29 Hemorragia Subaracnoidea HSA Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico
Acidentes Vasculares Cerebrais AVC

Mulher de 52 anos apresenta cefaleia de forte intensidade há 5 dias. É encaminhada ao Serviço de Referência com hipótese diagnóstica de hemorragia subaracnóidea (HSA). AP: hipertensa e tabagista. TC de crânio: normal. Líquor, conforme imagem:



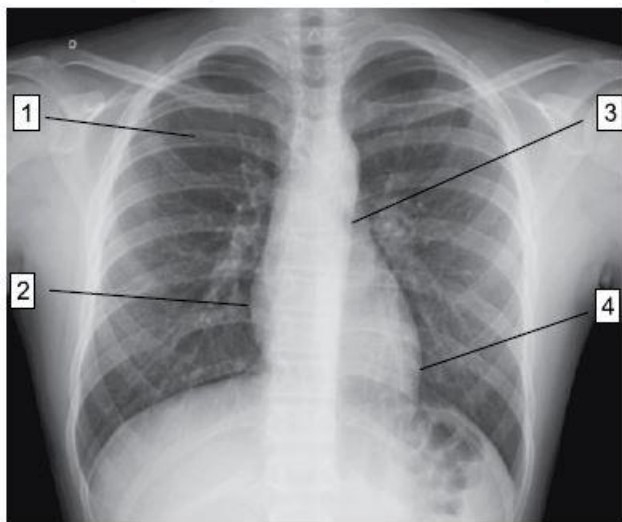
Pode-se afirmar que

- A a ausência de sinais de sangramento na TC indica classificação de Fisher 1, porém a presença de sangue no líquido confirma HSA.
- B a prova dos 3 tubos sugere acidente de punção durante a coleta, não se podendo ainda afastar a hipótese de HSA.
- C a ausência de sinais de sangramento na TC (Fisher 1) e a prova dos 3 tubos positiva sugerem rotura de aneurisma da circulação posterior.
- D a prova dos 3 tubos sugere HSA, cuja etiologia deve ser investigada com angiografia digital cerebral ou angiotomografia.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141674

Questão 30 Radiografia de tórax

Considere a imagem:



Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os números às estruturas anatômicas correspondentes.

- A 1 – porção posterior do arco costal; 2 – átrio direito; 3 – brônquio principal esquerdo; 4 – ventrículo esquerdo.
- B 1 – porção anterior do arco costal; 2 – átrio direito; 3 – brônquio principal esquerdo; 4 – átrio esquerdo.
- C 1 – porção posterior do arco costal; 2 – ventrículo direito; 3 – carina principal; 4 – átrio esquerdo.
- D 1 – porção anterior do arco costal; 2 – ventrículo direito; 3 – carina principal; 4 – ventrículo esquerdo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141673](https://www.4000141673.com.br)

Questão 31 **Indicações**

Homem de 48 anos encontra-se no 5o dia de tratamento de pneumonia comunitária com cefalosporina de 2a geração, porém está mantendo febre e leucocitose. Raio X de tórax: velamento do 1/3 inferior do hemitórax direito, formando a parábola de Damoiseau. Realizada toracocentese diagnóstica. Exames do líquido pleural: aspecto amarelo opaco; pH 7,2; glicose 30 mg/dL; DHL 1800 UI/L.

A conduta mais adequada é a

- A drenagem torácica.
- B tomografia computadorizada de tórax.
- C broncoscopia com lavado broncoalveolar.
- D decorticação pulmonar.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141672](https://www.4000141672.com.br)

Questão 32 **Escoliose**

Menina de 16 anos notou que possui uma perna mais comprida que a outra. Exame físico: assimetria do triângulo de Talhe, teste de Adams positivo e desnivelamento da bacia.

O diagnóstico mais provável é

- A fêmur curto congênito.
- B tíbia vara de Blount.
- C displasia do desenvolvimento do quadril.
- D escoliose juvenil.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141671](#)

Questão 33 Câncer de Bexiga Cirurgia

Homem de 70 anos queixa-se de sangramento intermitente na urina há quatro semanas, acompanhado por dor “em peso” no baixo ventre, sensação de plenitude vesical e urgência miccional. AP: HAS controlada, DM tipo 2, dislipidemia, obesidade e tabagismo (40 anos/maço), dois episódios prévios de hematúria com eliminação de cálculos.

Assinale a alternativa correta a partir das informações.

- A A hematúria, a urgência e a plenitude são decorrentes de provável litíase na junção ureterovesical.
- B A tomografia computadorizada é o melhor exame para investigação, sendo suficiente para o diagnóstico.
- C A principal hipótese é tumor urotelial, sendo necessários exame de imagem do trato urinário alto e cistoscopia.
- D A uretrocistoscopia normal descarta tumor urotelial como causa da hematúria.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141670](#)

Questão 34 Escroto Agudo

Menino de 13 anos apresenta dor testicular à esquerda, de início noturno e de forma súbita há 4 horas. Refere que já teve esse quadro previamente, porém com melhora espontânea.

Considerando o exposto, assinale a alternativa correta.

- A Trata-se de orquido-epididimite, visto que a torção é mais comum em lactentes.
- B Trata-se de varicocele, quadro comum em jovens, que ocorre principalmente à esquerda.
- C O Doppler de bolsa deve ser obrigatoriamente realizado para diferenciação entre orquido-epididimite e torção testicular.
- D A exploração cirúrgica escrotal pode ser indicada, uma vez que a principal hipótese é de torção testicular.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141669](#)

Questão 35 Hérnias Inguinocrurais Cirurgia

Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre números e estruturas anatômicas.

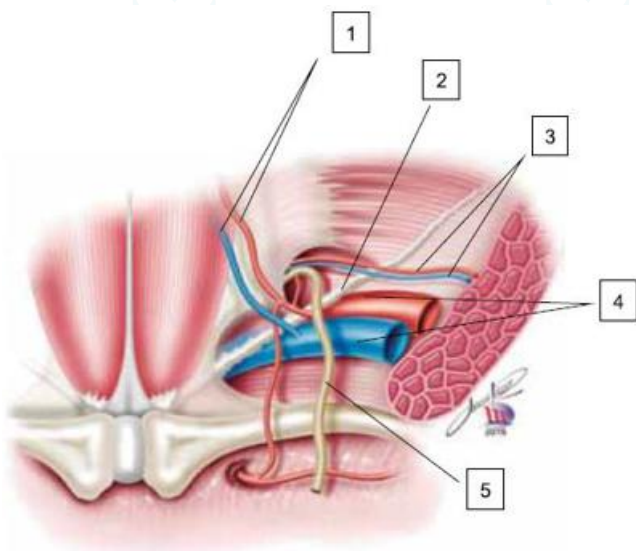


Ilustração esquemática da região inguinal direita, visão posterior

- A 1 – vasos epigástricos superiores; 3 – vasos obturatórios; 5 – ducto deferente.
- B 2 – ligamento inguinal; 4 – vasos ilíacos internos; 5 – ducto deferente.
- C 1 – vasos epigástricos inferiores; 2 – ligamento inguinal; 3 – vasos espermáticos.
- D 1 – vasos epigástricos inferiores; 2 – ligamento de Cooper; 4 – vasos ilíacos externos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141668](https://www.4000141668.com)

Questão 36 Tratamento Cirurgia

Mulher de 23 anos, com dor abdominal inicialmente difusa que, após 6 horas, irradiou para FID, acompanhada de vômitos e inapetência. Exame físico: dor localizada em FID, com descompressão brusca positiva localizada no ponto de McBurney.

Baseando-se na hipótese diagnóstica, o antibiótico deve ser iniciado

- A no momento em que o cirurgião estiver incisando a pele.
- B no momento da indicação cirúrgica.
- C após confirmação do diagnóstico no intraoperatório.
- D se houver secreção purulenta na cavidade abdominal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141667](https://www.4000141667.com)

Questão 37 Tratamento do Adenocarcinoma Gástrico Estadiamento Epidemiologia

Em relação ao câncer gástrico, é correto afirmar que

- A sua incidência está aumentando em todo o mundo, apesar do tratamento do *Helicobacter pylori*.
- B nos casos avançados, a ressecção combinada de órgãos adjacentes não deve ser realizada, mesmo quando possível a ressecção R0.
- C os carcinomas precoces são aqueles que não infiltram além da submucosa, independentemente do estado linfonodal.
- D o principal exame para o estadiamento é a PET-CT.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141666](https://www.4000141666.com)

Questão 38 Tratamento Clínico Tratamento Cirúrgico Manifestações Clínicas

Homem de 26 anos refere dor em andar superior do abdome, acompanhada de náuseas e sensação de empachamento. Após três dias, apresenta piora da dor, com necessidade de morfina. Exame físico na admissão: BEG, abdome globoso, doloroso à palpação de epigástrio. Exames laboratoriais na admissão: Hb 14,2 g/dL; HT 40%; GB 19 000/mm³; plaquetas 224 000/mm³; TGO 88 U/L; TGP 102 U/L; GGT 504 U/L; FA 199 U/L; BT 1,5 mg/dL, glicemia 150 mg/dL, DHL 250 U/L, amilase 2 600 U/L. TC de abdome no terceiro dia apresenta:



Contra preços abusivos na medicina.

De acordo com a principal hipótese diagnóstica, é correto afirmar que

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

- A o antibiótico deveria ter sido introduzido na admissão.
- B a TC de abdome deve ser realizada o mais precoce possível.
- C a hipocalcemia é um critério de gravidade.
- D a CPRE está indicada após estabilização clínica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141666](https://www.4000141666.com)

Questão 39 Tratamento Cirurgia

Na diverticulite aguda, pacientes com classificação de Hinchey grau

- A 1 apresentam abscesso pericólico localizado, podendo ser tratados ambulatorialmente com antibióticos e analgésicos.
- B 2 necessitam de internação para realização de colonoscopia precoce para evitar complicações maiores.
- C 3 dificilmente necessitam de procedimento cirúrgico, e a laparoscopia sempre está contraindicada.
- D 4 necessitam de drenagem percutânea urgente, podendo ser guiada por ultrassonografia ou tomografia computadorizada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141664](https://www.4000141664.com)

Questão 40 Manometria Esofágica Tratamento Cirúrgico da DRGE

Homem de 42 anos refere ter doença do refluxo gastroesofágico há 10 anos. Realizou vários tratamentos com melhora e retorno dos sintomas após a suspensão. EDA realizada há 1 mês: esofagite erosiva leve (classificação grau A de Los Angeles e grau 1 de Savary-Miller). Paciente gostaria de ser submetido a tratamento cirúrgico na tentativa de evitar uso crônico de medicação.

O exame a ser realizado para indicar e definir o tipo de cirurgia é

- A pHmetria esofágica de 24 horas.
- B impedanciometria esofágica.
- C eletromanometria esofágica.
- D repetição de EDA com biópsia da erosão.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141663](https://www.4000141663.com)

Questão 41 O fígado anatomia e histologia

O tecido com menor concentração de enzima creatinofosfoquinase total – CPK é o

- A cardíaco.
- B cerebral.
- C muscular esquelético.
- D hepático.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000141662

Questão 42 Clínica e tipos histológicos

Mulher de 45 anos, oriental, cozinheira, apresenta mácula hiperocrômica assintomática no primeiro quirodáctilo direito, com crescimento progressivo há 2 anos, conforme imagem:



O diagnóstico provável é

- A hematoma com hemossiderose por traumatismo crônico profissional.
- B onicomicose por fungos demáceos.
- C pigmentação exógena por shitake.
- D melanoma lentiginoso acral.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141661

Questão 43 Dor

Homem de 25 anos apresenta queixas inespecíficas de dor generalizada há 1 ano. Essa dor é contínua, profunda e superficial, não se limitando a uma estrutura, sem fatores de melhora ou piora identificados. Realizou extensa investigação diagnóstica sem nenhuma alteração. AP: fadiga e sono não reparador há anos.

Em relação ao diagnóstico desse paciente, podemos afirmar que se trata de dor

- A nociceptiva.
- B neuropática.
- C nociplástica.
- D psicogênica.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000141660

Questão 44 Princípios bioéticos fundamentais ou principialistas ou principialismo Beauchamp e Childress

Os quatro princípios básicos da Bioética que norteiam a abordagem de situações graves e complexas, foram descritos por Tom Beauchamp e James Childress em 1979 e se mantêm vigentes até os dias de hoje.

São eles:

- A não maleficência, beneficência, liberdade e empatia.
- B beneficência, justiça, dignidade e responsabilidade.
- C não maleficência, beneficência, respeito à autonomia e justiça.
- D dignidade, não maleficência, transparência e moralidade.

Questão 45 Concentrado de plaquetas

O hemocomponente e a situação que melhor indicaria seu uso são:

- A concentrado de hemácias para paciente anêmico crônico, com Hb de 8 g/dL e FC de 66 bpm.
- B concentrado de plaquetas para paciente sem sangramento que será submetido inadiavelmente à cirurgia cardíaca e apresenta plaquetometria de 70 000/mm³.
- C crioprecipitado para paciente com sangramento intraoperatório, com plaquetometria de 30 000/mm³, tempo de protrombina com RNI de 3,5 e fibrinogênio de 180 g/dL.
- D plasma fresco congelado para paciente sem sangramento e com tempo de protrombina com RNI de 6.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141658

Questão 46 Neurologia Anatomia Fisiologia e Semiologia Neurológica
 Síndrome do Neurônio Motor Superior e Inferior

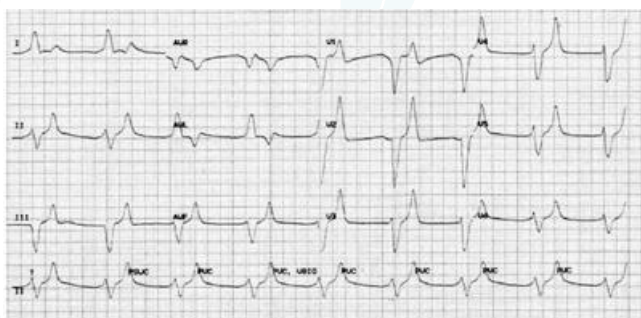
Na síndrome de primeiro neurônio ou do neurônio motor superior, as manifestações são:

- A hipotonia, fraqueza muscular, hiporreflexia, fasciculações.
- B ausência de reflexo cutâneo abdominal, fraqueza muscular, reflexo cutâneo plantar em flexão e hipertonia.
- C reflexo cutâneo plantar em flexão, normorreflexia, normotonia e leve fraqueza muscular.
- D hipertonia, fraqueza muscular, hiperreflexia e presença de sinal de Babinski.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141657

Questão 47 Desviar o potássio para dentro das células Gluconato de cálcio Remover o potássio do organismo

Homem de 32 anos, vítima de politrauma há 3 dias com múltiplas escoriações em membros inferiores, TCE grave com hipertensão intracraniana e trauma esplênico grau II. Paciente manteve-se estável hemodinamicamente sem necessidade de droga vasoativa, sem complicações infecciosas, em suporte ventilatório com FiO₂ 50% e relação pO₂/FiO₂ 300; peso 80 kg. Exames laboratoriais: Cr na admissão 0,9 mg/dL. Atuais: Cr 2,6 mg/dL, Ur 82 mg/dL, K 7,0 mEq/L, fósforo 6,0 mg/dL, DHL 2015 UI/L, pH 7,18, Bicarbonato 10 mEq/L, pCO₂ 24 mmHg, Na 133 mEq/L, Cl 105 mEq/L, albumina 3,9 g/dL. Mantém débito urinário de 0,2 mL/kg/hora nas últimas 24 horas. O ECG apresenta:



A conduta é administrar

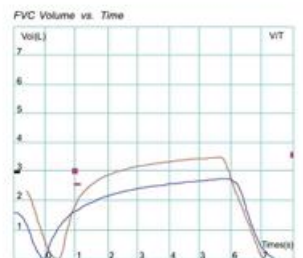
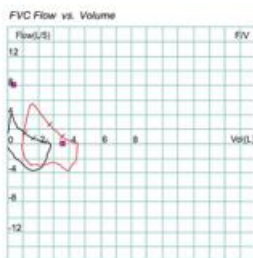
- A cálcio intravenoso; solução glicoinsulínica; solução de bicarbonato; furosemida, independentemente do estado volêmico do paciente, e resinas de troca.
- B cálcio intravenoso; solução glicoinsulínica; solução de bicarbonato; furosemida, se estado volêmico permitir, e avaliar a indicação de suporte renal agudo.
- C solução glicoinsulínica; furosemida, independentemente do estado volêmico do paciente, e avaliar a indicação de suporte renal agudo.
- D cálcio intravenoso; solução glicoinsulínica e reposição de bicarbonato, e sempre indicar suporte renal agudo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141656](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 48 Espirometria Distúrbio ventilatório obstrutivo

Mulher de 18 anos apresenta dispneia esporádica aos esforços, associada a tosse seca e sibilos, principalmente pela manhã, há 3 meses. Refere sintomas de rinite, atualmente controlados. Exame físico: BEG, acianótica, PA 110 x 80 mmHg, FC 80 bpm, FR 15 irpm, oximetria de pulso em ar ambiente 97%. Pico de fluxo expiratório 230 L/min (60% do predito). Espirometria apresenta-se a seguir:

	Predito	Limite inferior	Pré-BD	%Predito	Pós-BD	%Predito	%Rev
CVF (L)	2,69	2,05	2,10	78%	2,51	93%	20%
VEF1(L)	2,39	1,78	1,42	59%	1,90	79%	34%
VEF1/CVF	0,88	0,79	0,68	77%	0,76	86%	12%
PEFR (L/s)	6,18	4,63	3,67	59%	5,26	85%	43%
FEF 25-75% (L/s)	2,96	1,69	0,88	30%	1,49	50%	69%
FEF 50% (L/s)	---	---	1,10	---	1,83	---	66%
FEF 75% (L/s)	1,32	0,70	0,35	27%	0,60	46%	72%
Vext (%)	---	---	0,95	---	1,59	---	67%
VCL (L)	2,69	2,05	2,20	82%	2,59	96%	18%
IC (L)	---	---	1,85	---	2,14	---	15%
VER (L)	---	---	0,34	---	0,45	---	32%



Contra preços abusivos na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

É correto afirmar que

- A se trata de distúrbio pulmonar ventilatório obstrutivo moderado com resposta ao broncodilatador.
- B se trata de distúrbio pulmonar ventilatório restritivo leve com resposta ao broncodilatador.
- C o exame não preenche critérios técnicos para análise; curvas não aceitáveis.
- D se trata de distúrbio pulmonar ventilatório restritivo moderado sem resposta ao broncodilatador.

4000141655

Questão 49 Heparina

Homem de 25 anos apresentou embolia pulmonar aguda depois de 24 horas da apendicectomia.

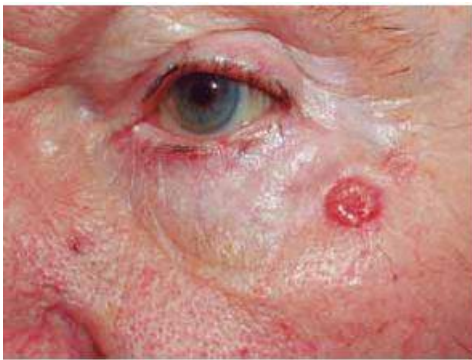
A conduta recomendada em relação à anticoagulação é

- A suspender em, no máximo, 1 mês, desde que não apresente TVP associada e por ser paciente jovem.
- B suspender assim que receber alta hospitalar e retomar as atividades laborais.
- C prolongar por mais de 6 meses, pois se trata de paciente jovem com possibilidade alta de recorrência.
- D manter por três meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141654](#)

Questão 50 Apresentação clínica

Homem de 69 anos, pescador, apresenta nódulo eritemato- -perláceo com telangectasias na região zigomática com crescimento progressivo há 3 anos, conforme imagem:



O diagnóstico provável é

- A leishmaniose tegumentar americana.
- B carcinoma basocelular nodular.
- C linfoma cutâneo.
- D esporotricose.



Essa questão possui comentário do professor no site [4000141653](#)

Questão 51 Saúde do Idoso geriatria Exame físico e Avaliação Funcional do Idoso Síndrome da Fragilidade

Mulher de 83 anos apresenta sensação de cansaço, fraqueza e fadiga, com perda de peso não intencional de 6 kg em 6 meses (peso anterior era de 60 kg); não consegue andar uma quadra. AP: tem escolaridade universitária e utiliza 8 medicações ao dia. Exame físico: IMC 17,9 kg/m²; caminha com passos curtos e gastou 40 segundos para percorrer 4,6 metros; escala de Katz com 4 dependências para atividades básicas de vida diária; miniexame do estado mental com 27 pontos; escala de depressão geriátrica com 9 pontos; inabilidade de levantar-se 5 vezes da cadeira sem ajuda dos braços.

Essa paciente tem diagnóstico de síndrome da fragilidade, pois apresenta

- A sensação de fadiga, perda de peso não intencional, velocidade de marcha diminuída e não anda uma quadra.
- B miniexame do estado mental com 27 pontos, sensação de fadiga, velocidade de marcha diminuída e utiliza mais que 5 medicações ao dia.
- C inabilidade de levantar-se da cadeira sem ajuda dos braços, IMC de 17,9 kg/m², escala de depressão geriátrica com 9 pontos e utiliza mais que 5 medicações ao dia.
- D sensação de fadiga, escala de Katz com 4 dependências, miniexame do estado mental com mais de 20 pontos e não consegue andar uma quadra.

4000141652

Questão 52 Indicações Relativas NãoObrigatórias Tratamento

Mulher de 45 anos apresenta dor epigástrica em queimação associada a sensação de plenitude pós-prandial, há aproximadamente 1 ano. Refere que alguns alimentos costumam causar mais sintomas, como frituras, refrigerantes e molhos industrializados. EDA: pangastrite enantemática leve e gastrite erosiva antral intensa associada a bulbooduodenite erosiva leve com teste da urease positivo.

O tratamento de escolha é

- A amoxicilina 1 g, claritromicina 500 mg e IBP em dose plena, todos de 12/12 h, por 7 dias.
- B amoxicilina 1 g, claritromicina 500 mg e IBP em dose plena, todos de 12/12 h, por 14 dias.
- C levofloxacina 500 mg 1 x ao dia, claritromicina 500 mg e IBP em dose plena de 12/12 h por 7 dias.
- D levofloxacina 500 mg 1 x ao dia, claritromicina 500 mg e IBP em dose plena de 12/12 h por 14 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141651

Questão 53 Diagnóstico

Homem de 48 anos refere falta de ar aos esforços e edema de membros inferiores há 2 anos, de caráter progressivo. Há 3 meses, apresenta edema facial pela manhã que melhora durante o dia. AP: tabagista 80 anos/maço, HAS e DM tipo II há 6 anos. Exame físico: PA 160 x 100 mmHg, FC 104 bpm, ictus no sexto espaço intercostal dois cm para fora da linha hemiclavicular esquerda, estase jugular +/4, crepitações finas até terço médio dos pulmões, edema de membros inferiores até raiz da coxa. Saturação de oxigênio de 90%.

O diagnóstico mais provável é

- A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
- B insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
- C DPOC com cor pulmonale.
- D síndrome nefrótica de etiologia diabética.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141650

Questão 54 Manejo inicial e pacotes

Entre as medidas que devem ser realizadas, na primeira hora do atendimento do paciente com sepsis, estão: a realização de ressuscitação volêmica com

- A 30 ml/kg de cristalóide e a prescrição de noradrenalina para manter PAM maior ou igual a 65 mmHg.
- B 30 ml/kg de coloide e a prescrição de noradrenalina para manter PAM maior ou igual a 65 mmHg, e de dobutamina, se a saturação venosa central for menor que 70%.
- C 30 ml/kg de ringer lactato e a prescrição de noradrenalina e de vasopressina para manter PAM maior ou igual a 75 mmHg e de hidrocortisona 200 mg em infusão contínua por 24 horas.
- D cristalóide até a pressão venosa central ficar maior que 12 mmHg e a prescrição de noradrenalina para manter PAM maior ou igual a 75 mmHg.

4000141649

Questão 55 quick SOFA

Homem de 57 anos apresenta febre de 38 °C, tosse e expectoração amarelada há 3 dias. Exame físico: FC 110 bpm, PA 80 x 50 mmHg, FR 31 mpm e oximetria de pulso 87%. Consciente e orientado, MV presente com crepitações finas na base de hemitórax esquerdo. O valor de quick SOFA desse paciente é

- A dois.
- B um.
- C quatro.
- D três.

4000141648

Questão 56 Intoxicação por Paracetamol Acetaminofeno Medidas gerais

O uso do carvão ativado está indicado na intoxicação por

- A chumbo.
- B monóxido de carbono.
- C paracetamol.
- D ácido muriático.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141647

Questão 57 Tratamento do hiponatremia crônica sintomática

Mulher de 60 anos, assintomática, está em uso de losartana 100 mg à noite, anlodipino 10 mg e hidroclorotiazida 25 mg pela manhã. As doses das medicações foram aumentadas há 2 meses. AP: HAS, AVC há 5 anos, com drenagem de hematoma. Exame físico: euvolêmica. Exame laboratorial de sódio: atual 125 mEq/L e anteriores 128 a 130 mEq/L, desde a cirurgia. A principal causa da hiponatremia e as condutas são:

- A** secreção inapropriada do hormônio antidiurético (SIHAD) associada ao uso de tiazídico; dosar, no soro, ureia e ácido úrico, e, na urina, osmolaridade e sódio; retirar hidroclorotiazida e propor restrição hídrica.
- B** uso de hidroclorotiazida; dosar, no soro, ureia e creatinina, e, na urina, sódio; hidratar com soro fisiológico e suspender a hidroclorotiazida.
- C** efeito colateral da losartana; dosar, no soro, ureia, creatinina e potássio, e, na urina, sódio e potássio; suspender losartana.
- D** SIHAD; dosar, no soro, ureia e ácido úrico, e, na urina, osmolaridade e sódio; solução hipertônica endovenosa para elevar sódio a 130 mEq/L; trocar hidroclorotiazida e losartana por outros anti-hipertensivos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141646](https://www.4000141646.com)

Questão 58 **Apresentação Clínica e Avaliação Inicial** **Endocrinologia**

Mulher de 38 anos apresenta nódulo no lobo esquerdo da tireoide, há 3 meses. Exames laboratoriais: TSH 0,007 mUI/L (VR 0,4 – 4,0), T4L 1,6 ng/dL (VR 0,8 – 1,8). Exame ultrassonográfico: nódulo único de 1,8 cm de diâmetro, regular, sólido isoecogênico, com fluxo central e periférico ao Doppler.

A conduta é

- A** tratar com iodo radiativo.
- B** solicitar cintilografia da tireoide.
- C** realizar punção aspirativa por agulha fina.
- D** introduzir metimazol.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141645](https://www.4000141645.com)

Questão 59 **Hipoglicemia em indivíduos não diabéticos** **Endocrinologia**

Mulher de 28 anos em investigação de hipoglicemia. Nega medicação de uso crônico. AF: mãe portadora de DM em uso de medicação oral e insulina.

Considere os exames laboratoriais:

Data	Glicose (VR 70 – 99 mg/dL)	Insulina (VR 2 – 19 mUI/L)	Peptídeo C (VR 0,36 – 3,59 ng/mL)
28/07/2020	33	30	
10/08/2020	28	43	
11/08/2020	32	47	0,19

Diante desses resultados, a hipótese diagnóstica é hipoglicemia

- A** reacional reativa.
- B** por insulinoma.
- C** pelo uso de insulina.
- D** pelo uso de sulfonilureias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141644](https://www.4000141644.com)

Questão 60 Estenose aórtica

Paciente portador de estenose aórtica, confirmada com ecocardiograma. Os três sintomas que indicam gravidade da doença são:

- A dor torácica, dispneia e síncope.
- B dispneia, escarro hemoptoico e tosse produtiva.
- C dor precordial aos esforços, síncope e palpitações.
- D síncope, edema de membros inferiores e escarro hemoptoico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141643](https://www.4000141643.com.br)

Questão 61 Diagnóstico da Depressão Tratamento da Depressão Psiquiatria

Mulher de 42 anos apresenta, há 2 meses, dores pelo corpo, desânimo, irritabilidade, insônia com sono não reparador, diminuição do apetite e emagrecimento de 5 kg, com piora há 15 dias. Não tem conseguido fazer as tarefas domésticas, nem outras atividades de que antes gostava, passando a maior parte do dia com os sintomas, com discreta melhora da disposição física no período da tarde. Não consegue relacionar sua situação a nenhum fator ambiental, mas relata maior indisposição para o trabalho, o que tem gerado alguma dificuldade com os colegas. AP: episódio semelhante há 10 anos.

O diagnóstico e a conduta medicamentosa são:

- A transtorno depressivo maior; inibidor preferencial de recaptura de serotonina.
- B transtorno do sintoma somático; benzodiazepínicos.
- C transtorno bipolar; estabilizador de humor.
- D transtorno depressivo persistente (distímia); antidepressivo tricíclico.

4000141642

Questão 62 Endometriose

Mulher de 27 anos, em consulta na Unidade Básica de Saúde, apresenta dismenorreia incapacitante e progressiva desde a menarca. Relata que nos últimos 5 anos passou a apresentar limitações em sua vida diária devido ao quadro de dor pélvica, necessitando com frequência procurar ambiente hospitalar para administração de medicação endovenosa. AP: G0P0. Exame físico: IMC 29 kg/m². Toque vaginal: colo fibroelástico, indolor à mobilização, útero intrapélvico, mobilidade preservada, pouco doloroso à palpação bimanual, anexos não palpáveis, sem massas ou coleções palpáveis em sua topografia, ausência de nodulações e espessamentos em fundo de saco posterior. US transvaginal: normal. A conduta é

- A solicitar exames especializados (US transvaginal com preparo intestinal ou RNM abdome) e manter seguimento em serviço primário.
- B prescrever tratamento clínico com anti-inflamatórios e contraceptivos orais e manter seguimento em serviço primário.
- C prescrever tratamento clínico com analgésicos potentes (opioides) e imunomoduladores e encaminhar para serviço especializado.
- D indicar laparoscopia exploradora e encaminhar para serviço especializado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141641](https://www.4000141641.com.br)

Questão 63 Câncer de Endométrio

Mulher de 72 anos apresenta sangramento vaginal há 6 meses. AP: G2P2A0C0, DUM aos 49 anos. AF: irmã falecida de neoplasia ovariana aos 68 anos. Exame físico: IMC 27 kg/m². Exame ginecológico: colo atrófico, ausência de sangramento ativo com presença de discreto sangramento residual em fundo vaginal, útero intrapélvico, mobilidade preservada, palpada massa cística de difícil delimitação em fundo de saco lateral esquerdo. US transvaginal: útero com volume de 86 cm³; espessura endometrial 7 mm; massa cística anecoica com maior diâmetro de 6 cm, sem septos ou vegetações e sem fluxo ao Doppler em ovário esquerdo; ovário direito de aspecto atrófico. TC abdome e pelve: extensa linfadenopatia pélvica bilateral e em cadeia paraórtica próximo à bifurcação das ilíacas. O diagnóstico provável é câncer de

- A endométrio do tipo II.
- B ovário do tipo I produtor de estrogênio.
- C ovário do tipo II produtor de estrogênio.
- D endométrio do tipo I.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141640](https://www.4000141640.com.br)

Questão 64 Ortotanásia Conceitos relacionados à morte

SAMU foi acionado pelo marido de mulher de 58 anos que apresenta insuficiência respiratória aguda. AP: tratamento para neoplasia ovariana há 6 meses, atualmente em quimioterapia paliativa; marido relata clareza da paciente sobre o seu prognóstico e que não desejava ser submetida a medidas como intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Exame físico:

extremamente desconfortável e confusa. FR: 38 irpm com uso de musculatura acessória, saturação de O₂ em ar ambiente de 70%, PA 160 x 100 mmHg; MV abolido em hemitórax direito e reduzido em 1/3 inferior de hemitórax esquerdo. Marido manifesta desejo de honrar a vontade da esposa.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata.

- A Acionar o comitê de bioética local.
- B Sedação para intubação orotraqueal e solicitar leito de UTI, pois não fazê-lo implicaria em omissão de socorro.
- C Sedação para intubação orotraqueal e solicitar leito de UTI, pois o relato da família não possui validade legal, uma vez que a paciente não registrou sua diretiva antecipada de vontade em cartório.
- D Iniciar titulação de morfina até controle dos sintomas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141639](https://www.4000141639.com.br)

Questão 65 Tratamento cirúrgico

Mulher de 62 anos foi submetida a histerectomia total + salpingooforectomia bilateral por via laparoscópica. Histopatológico da peça cirúrgica: carcinoma endometrial tipo endometrióide, grau de diferenciação nuclear 1, estágio FIGO IA.

A conduta é:

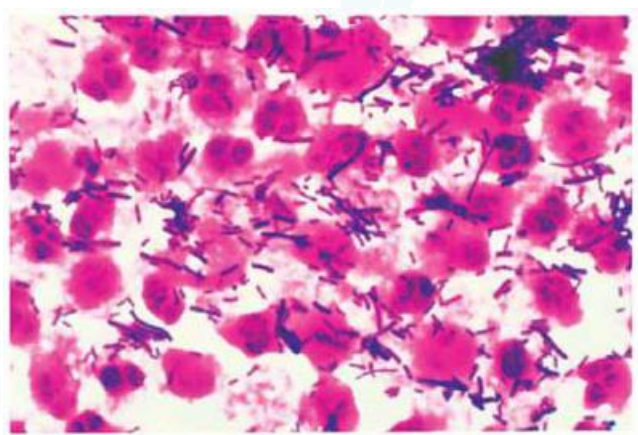
- A reabordagem cirúrgica para realização de linfadenectomias pélvica e paraórtica.
- B complementação do tratamento cirúrgico com radioterapia e braquiterapia.
- C complementação do tratamento cirúrgico com quimioterapia.
- D seguimento oncológico com observância clínica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141638](https://www.4000141638.com)

Questão 66 Vulvovaginites Cervicites

Mulher de 21 anos queixa-se de dispareunia. Exame ginecológico: colo com intensa hiperemia e edema, JEC-3, recoberta por secreção amarelada espessa, teste de aminas negativo e pH vaginal 4,4.

Exame microscópico do conteúdo vaginal a seguir:



Contra preços abusivos
na medicina.

A hipótese diagnóstica e o melhor tratamento são, respectivamente:

- A vaginite aeróbia; clindamicina creme vaginal a 2% por 14 dias.
- B cervicite; azitromicina 1 g (VO) e ceftriaxone 500 mg (IM) em doses únicas.
- C vaginose bacteriana; metronidazol 500 mg (VO) de 12/12 h por 7 dias.
- D candidíase vulvovaginal; fluconazol 150 mg (VO) em dose única.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141638](https://www.4000141638.com)

Questão 67 Anatomia do Assoalho Pélvico

O diafragma pélvico feminino é formado pelos músculos

- A levantador do ânus (iliococcígeo, pubococcígeo e puborretal) e coccígeo.
- B levantador do ânus (coccígeo, iliococcígeo e puborretal) e obturador interno.
- C puborretal e obturador interno.
- D coccígeo e obturador interno.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141638](https://www.4000141638.com)

Questão 68 Tratamento Ginecologia Miomatose uterina

Mulher de 48 anos apresenta aumento do volume menstrual e cólicas intensas que não melhoram com uso de analgésicos. AP: menstruações regulares a cada 30 dias com duração de 6 dias, G3P3C3, laqueadura prévia, HAS, obesidade e tabagismo. Exame ginecológico: útero aumentado de volume, superfície lobulada. Ultrassom transvaginal: útero com volume 200 cm³, várias imagens nodulares de até 20 mm sugestivas de miomas de localização intramural e subserosa, endométrio regular de 7 mm, ovários sem alterações. A conduta inicial é indicar

- A miomectomia laparoscópica.
- B anticoncepcionais combinados.
- C anti-inflamatórios não hormonais no período menstrual.
- D análogo de GnRH.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141635](#)

Questão 69 Dor mamária mastalgia

Paciente de 35 anos queixa-se de mastalgia de intensidade moderada, quase todos os meses, antes das menstruações. AP: GOP0. AF: mãe recentemente diagnosticada com câncer de mama aos 61 anos. Exame das mamas: desconforto à palpação dos quadrantes superolaterais bilateralmente. A conduta é

- A evitar suporte mamário (sutiã, top).
- B prescrever anti-inflamatórios não esteroidais tópicos ou orais.
- C iniciar rastreamento anual com mamografia e ressonância magnética das mamas.
- D prescrever óleo de prímula e vitamina D, medidas comprovadamente eficazes.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141634](#)

Questão 70 Ginecologia Puericultura Flora vaginal na criança

Menina de 4 anos e 5 meses apresenta sangramento vaginal há 4 dias e odor diferente nas calcinhas. A principal hipótese é

- A dermatite por candidíase.
- B sarcoma botrioide.
- C corpo estranho.
- D condilomatose.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141633](#)

Questão 71 Roteiro diagnóstico

Mulher de 45 anos, em consulta ginecológica, queixa-se de ausência de menstruação há quatro meses. Nega episódio anterior de amenorreia e queixas climatéricas. AP: G4P3A1C3, laqueadura tubárea. A conduta é

- A expectante, sem indicação de avaliação hormonal.
- B dosar FSH, LH e estradiol basal.
- C realizar a biópsia de endométrio e beta-hcg.
- D dosar FSH, LH, estradiol basal, TSH e progesterona em fase lútea.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141632](#)

Questão 72 Climatério

Mulher de 51 anos queixa-se de fogachos principalmente à noite, acompanhados de suor e insônia. Relata cansaço e indisposição. AP: G2P2C2, DUM em 2018, HAS e hipotireoidismo controlados. AF: pai falecido por AVC aos 65 anos e avó materna por câncer de mama aos 75 anos. Exame físico: PA 125 x 80 mmHg, IMC 31 kg/m². Exame ginecológico: hipotrofismo vaginal. Mamografia recente: BI-RADS 2.

Considerando o caso, assinale a alternativa correta.

- A Terapia hormonal (TH) pode ser indicada, sendo a via transdérmica a primeira escolha.
- B Pelos antecedentes pessoais e familiares, estrogênio via vaginal é a melhor indicação.
- C Pelas contraindicações à TH, melhor indicar o uso de antidepressivos no alívio dos fogachos.
- D Pela contraindicação do uso do estrogênio no hipotireoidismo, indica-se progesterona isolada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141631](#)

Questão 73 Conduta Obstetrícia

Feto restrito com 30 semanas de gestação, morfologicamente normal, apresenta dopplervelocimetria com diástole ausente nas artérias umbilicais.

A conduta é

- A resolução por cesárea após corticoterapia e sulfato de magnésio.
- B acompanhamento pelo ducto venoso.
- C avaliação diária com cardiotocografia convencional até 34 semanas.
- D resolução imediata por cesárea.

4000141630

Questão 74 Avaliação do risco gestacional Obstetrícia

Tercipara, portadora de HAS sob controle, em uso de inibidor de receptor de angiotensina (IECA) e hidroclorotiazida (HCTZ), em consulta de rotina com clínico geral, refere que pretende engravidar e quer orientação sobre os medicamentos que está usando, a qual deve ser:

- A substituir o IECA por alfametildopa e manter a HCTZ.
- B manter os medicamentos em uso, pois a PA está sob controle.
- C substituir o IECA por bloqueador de receptor de angiotensina.
- D substituir os medicamentos em uso por levomepromazina.

4000141629

Questão 75 **Atendimento**

Mulher de 18 anos refere ter sofrido violência sexual com penetração vaginal há cinco dias por um desconhecido. Não realizou boletim de ocorrência (BO) e só procurou atendimento médico hoje. Não sabe informar sobre a situação vacinal. Refere menstruação há 10 dias e não faz uso de anticoncepcional. Além da solicitação das sorologias (sífilis, HIV e hepatite B), a conduta imediata é administrar

- A contracepção de emergência, profilaxia contra ISTs não virais, primeira dose da vacina para hepatite B, profilaxia para HIV e sugestão de realização do BO.
- B profilaxia contra ISTs não virais, imunoglobulina anti-hepatite B, notificação compulsória e orientação sobre a possibilidade de gravidez.
- C primeira dose da vacina para hepatite B, profilaxia para HIV, realização de notificação compulsória, orientação sobre a possibilidade de gravidez e da realização do BO.
- D contracepção de emergência, profilaxia contra ISTs não virais, imunoglobulina anti-hepatite B e realização de notificação compulsória.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141628](#)

Questão 76 **Sangramento segunda metade da gestação** **Intercorrências obstétricas** **obstetrícia patológica** **Descolamento prematuro de placenta DPP**

Secundigesta de 22 anos, com 36 semanas e 2 dias, procura a maternidade com desconforto abdominal e um pequeno sangramento vaginal há 1 hora. Exame físico: BEG, eupneica, hidratada, FC 110 bpm, PA 150 x 100 mmHg, tônus uterino aumentado, BCF 170 bpm. Presença de discreta quantidade de sangue coletado em fundo de saco vaginal, colo grosso e impérvio. O diagnóstico e a conduta são, respectivamente:

- A rotura de seio marginal; ultrassom e observação de sangramento.
- B trabalho de parto prematuro; inibição do trabalho de parto.
- C placenta prévia; ultrassom e observação de sangramento.
- D descolamento prematuro de placenta; cesárea de emergência.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141627](#)

Questão 77 **Diabetes na gestação DMG** **Diagnóstico** **Obstetrícia**

Secundigesta de 37 anos apresenta atraso menstrual de 7 semanas e teste de gravidez positivo. AP: prematuridade e pré-eclâmpsia na gestação anterior. AF: HAS e DM. Exame físico: IMC 31,2 kg/m². A idade gestacional pelo ultrassom é compatível com a DUM. Exames bioquímicos: primeira glicemia de jejum 116 mg/dL, segunda glicemia de jejum 108 mg/dL, hemoglobina glicada 6,8%. A hipótese diagnóstica e a conduta são, respectivamente:

- A DM pré-gestacional; iniciar tratamento.
- B DM gestacional; iniciar tratamento.
- C gestante de alto risco; realizar GTT 75 g imediatamente.
- D gestante de baixo risco; realizar GTT 75 g entre 24 e 28 semanas.

4000141626

Questão 78 Imunização na gestação

Primigesta de 21 anos, com 12 semanas de gestação, comparece assintomática na primeira consulta de pré-natal. Antes da gravidez, recebeu duas doses de vacina contendo o componente tetânico. A orientação quanto à vacina antitetânica é

- A informar que não há necessidade de vacinar durante a gestação.
- B indicar uma dose de tríple bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche – dTpa) imediatamente.
- C indicar uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação.
- D indicar uma dose de dupla adulto (difteria e tétano) imediatamente e uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação.

4000141625

Questão 79 Doenças associadas à gestação Doenças infecciosas na gestação HIV sífilis hepatites herpes

Sífilis na gestação

Gestante de 29 anos, G3P1A1, com 13 semanas de gestação, retorna à consulta de pré-natal com seu parceiro sexual. Os resultados da sorologia para sífilis estão apresentados a seguir:

	Teste treponêmico 1	Teste não treponêmico	Teste treponêmico 2
Gestante	Reagente	Reagente (1/32)	Não realizado
Parceiro	Não reagente	Não realizado	Não realizado

Em relação ao parceiro, a interpretação do resultado e a conduta são, respectivamente:

- A não é um caso de sífilis; não tratar o parceiro e repetir a sorologia para sífilis em 15 dias.
- B diagnóstico presumido de sífilis; tratá-lo com penicilina benzatina, por via intramuscular, em dose única totalizando 2 400 000 UI.
- C sífilis latente recente; tratá-lo com penicilina benzatina, por via intramuscular, em duas doses com intervalo semanal, totalizando 4 800 000 UI.
- D sífilis latente tardia; tratá-lo com penicilina benzatina, por via intramuscular, em três doses com intervalo semanal, totalizando 7 200 000 UI.

4000141624

Questão 80 Rotura prematura de membranas ovulares RPM Intercorrências obstétricas obstetrícia patológica

Obstetrícia

Gestante de 29 anos, G2P1A0C0, com 31 semanas e pré- -natal sem intercorrências, é avaliada no pronto atendimento de maternidade de alto risco. Apresenta, há quatro horas, perda de líquido claro vaginal e, há uma hora, dor em cólica de

moderada intensidade em hipogástrio. Exame físico: BEG, sinais vitais normais. A altura uterina de 29 cm, feto cefálico, BCF 140 bpm, dinâmica uterina de 3 contrações em 10 minutos, com 50 segundos de duração, rítmicas, dolorosas. Exame ginecológico: vulva umedecida, líquido amniótico escoando pela rima vulvar e acumulado em fundo de saco vaginal. Exame de toque: colo esvaecido 50%, medianizado, 5 cm de dilatação, com saída de líquido claro sem grumos, cefálico, plano 0 de De Lee.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A Indometacina, betametasona e antibioticoterapia para tratamento de corioamnionite subclínica.
- B Nifedipina, dexametasona e antibiótico para profilaxia de infecção neonatal por estreptococo do grupo B.
- C Sulfato de magnésio, betametasona e antibiótico para profilaxia de infecção neonatal por estreptococo do grupo B.
- D Terbutalina, sulfato de magnésio, dexametasona e antibioticoterapia para tratamento de corioamnionite subclínica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141623](https://www.4000141623.com)

Questão 81 Etiologia

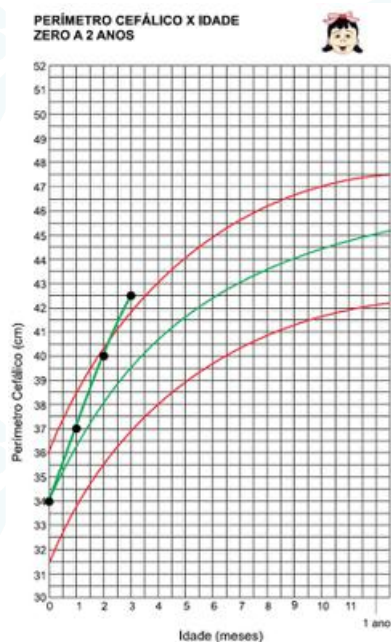
Os principais agentes causadores de meningites em neonatos são:

- A *Haemophylus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae* e *Neisseria meningitidis*.
- B *Listeria spp*, *Streptococcus agalactiae* e *Haemophylus influenza*.
- C *Streptococcus agalactiae*, *Haemophylus Influenzae* e *Streptococcus pneumonia*.
- D *Escherichia coli*, *Listeria spp* e *Streptococcus agalactiae*.

4000141622

Questão 82 Avaliação do Crescimento Pediatria Puericultura

Menina de 3 meses não consegue firmar a cabeça e é muito irritada. AP: mãe não teve intercorrências durante a gestação. Na imagem, apresenta-se a curva de perímetro cefálico:



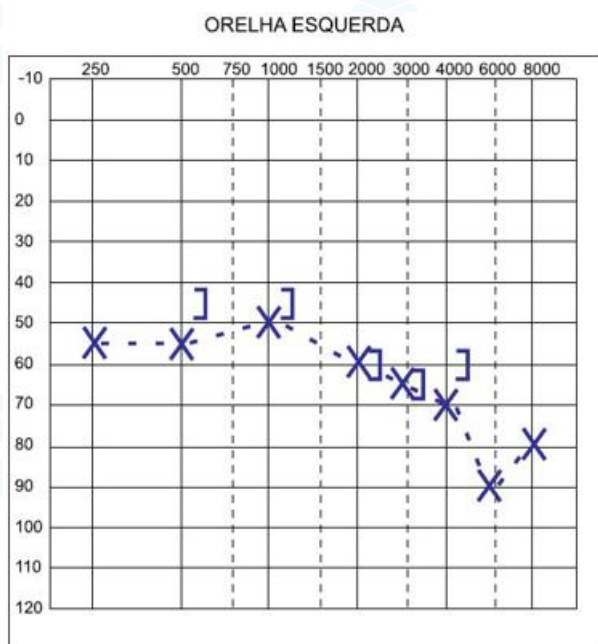
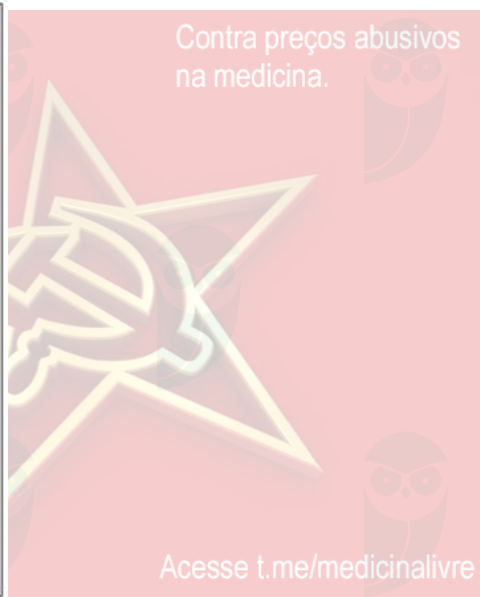
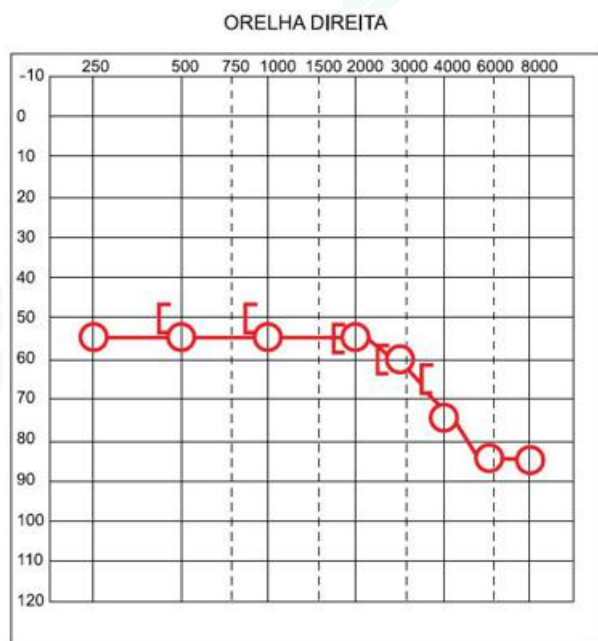
A hipótese diagnóstica é

- A síndrome de Crozon.
- B craniossinostose.
- C porencefalia.
- D hidrocefalia.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141621

Questão 83 Perda Neurossensorial

Criança de quatro anos é desatenta na escola, está demorando para falar frases mais elaboradas, mantendo muitas trocas fonêmicas. Mãe e professora têm dúvida quanto à acuidade auditiva da criança. Nega antecedentes otológicos importantes como secreção ou dor. Audiograma apresenta:



Trata-se de

- A otite média serosa, e o exame de otoscopia estará provavelmente alterado.
- B surdez neurossensorial bilateral, e a investigação diagnóstica deve incluir avaliação genética, exames sorológicos e de imagem.
- C surdez do tipo neurossensorial, e a causa mais comum é a hipertrofia das adenoides culminando em obstrução da tuba auditiva.
- D surdez do tipo condutiva, quadro reversível com o tratamento de desobstrução das tubas auditivas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141620](#)

Questão 84 **Abrasões Corneanas**

Criança de 6 anos foi acompanhar o pai no serviço de instalação de cerca na fazenda. Refere que bateu algo no olho esquerdo e sentiu correr uma “água quente”. Exame ocular: não realizado devido ao blefaro-espasmo à esquerda. Até o especialista chegar, a conduta é:

- A jejum, colírio, pomada de antibiótico, curativo compressivo e estudo da profilaxia antitetânica.
- B jejum, colírio de antibiótico de hora em hora sem necessidade de curativo e avaliação da profilaxia antitetânica.
- C dieta livre, pois provavelmente se trata de abrasão corneana superficial.
- D jejum, curativo oclusivo, repouso e avaliação da profilaxia antitetânica.

4000141619

Questão 85 **Pediatria** **Cetoacidose diabética** **Endocrinologia pediátrica**

Na cetoacidose diabética em crianças,

- A a principal causa de óbito é o choque.
- B o tratamento baseia-se em reposição fluidica, insulino terapia e correção dos distúrbios eletrolíticos.
- C na primeira hora de atendimento, deve receber cristaloide, insulina subcutânea e bicarbonato de sódio (se menor que 15 mEq/L).
- D a normalização da glicemia é a meta principal do tratamento da primeira hora.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141618](#)

Questão 86 **Mecanismo Fisiopatológico**

As características das diarreias inflamatória, osmótica e secretora são, respectivamente:

- A pH fecal maior que 5,5; gordura nas fezes usualmente; pH fecal menor que 5,5.
- B frequência evacuatória alta; geralmente cessa durante o jejum; pH fecal menor que 5,5.
- C não cessa durante o jejum; pH fecal menor que 5,5; geralmente cessa durante o jejum.
- D fezes pouco volumosas; odor ácido; fezes muito volumosas.

Questão 87 Doença de Crohn

Menina de 14 anos apresenta queixa principal de dor abdominal há 4 meses associada a apetite diminuído, perda de 5 kg e ocasionais evacuações amolecidas e sem sangue. Na inspeção anal, são observados dois grandes plicomas. Exames laboratoriais: pesquisa de sangue oculto nas fezes positivo, hemoglobina de 8,8 g/dL e albumina de 3,2 g/dL. A principal hipótese diagnóstica é

- A infestação crônica por giárdia.
- B doença de Crohn.
- C doença celíaca.
- D síndrome do intestino irritável.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141616

Questão 88 Pediatria Artrite Séptica

Menino de 8 anos apresenta marcha claudicante e febre há 5 dias. Exame físico: toxemia, palidez, com edema, hiperemia, dor e limitação ao movimento do joelho direito. Exames laboratoriais: hemograma anemia, leucocitose com desvio à esquerda, proteína C reativa elevada. O diagnóstico mais provável é

- A artrite séptica.
- B artrite reativa.
- C febre reumática.
- D artrite idiopática juvenil.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141615

Questão 89 Dor do Crescimento

Assinale a alternativa que apresenta a melhor opção terapêutica para menina de 4 anos com dor em membros noturna benigna (dor de crescimento).

- A Analgésicos e anti-inflamatórios.
- B Calor local, massagem e analgésicos.
- C Calor local, massagem e anti-inflamatórios.
- D Massagem, analgésicos e anti-inflamatórios.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141614

Questão 90 Doença por lesões mínimas

Menino de 3 anos apresenta edema em face há 2 semanas, que progrediu para pernas e barriga há 7 dias, e diminuição da diurese há 2 dias. Exame físico: FC 110 bpm, FR 20 irpm, PA 87 x 50 mmHg. BEG, hidratado, corado, edemaciado: palpebral +2/+4, membros inferiores +3/+4, escrotal e na região sacral, presença de ascite. As alterações laboratoriais urinárias e sanguíneas, respectivamente, que sugerem o diagnóstico da doença são:

- A hematúria; diminuição do C3 e elevação do ASLO.
- B proteinúria; hipoalbuminemia e diminuição do C3.
- C proteinúria e hematúria; hipoalbuminemia.
- D proteinúria e hematúria; elevação do ASLO e da creatinina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141613](https://www.4000141613.com)

Questão 91 Infecção de Trato Urinário ITU Pediatria Diagnóstico laboratorial

Menina de 2 meses apresenta febre (39,5 °C) há 5 dias, irritabilidade e diminuição das mamadas há 2 dias e está em uso de cefalexina há 1 dia. Exame físico: T 38 °C, REG. Exames laboratoriais: urina por sondagem vesical pH 6,0, densidade 1013, nitrito positivo, leucoesterase +3, 106 leucócitos/campo; cultura de urina negativa. Para o diagnóstico de infecção urinária, o exame de imagem a ser solicitado é

- A ultrassonografia renal.
- B cintilografia renal estática com DMSA.
- C cintilografia renal dinâmica com DTPA.
- D uretrocistografia miccional.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141612](https://www.4000141612.com)

Questão 92 Pediatria Tipos de insuficiência cardíaca na pediatria Quadro clínico

Lactente masculino com 3 meses de idade apresenta cansaço e interrupções às mamadas, cianose perioral quando chora muito e ganho pondero-estatural insuficiente. AP: sopro cardíaco desde o nascimento. Exame físico: REG, FR 71 irpm, FC 159 bpm, mucosas descoradas (2+/4+), acianótico, pulsos com amplitude aumentada, tempo de enchimento capilar de 3 segundos, tiragens intercostal e subdiafragmática, crepitações pulmonares bilaterais, sopro sistólico e diastólico (2+/6+) na borda esternal esquerda superior com irradiação para o dorso, fígado palpável a 4 centímetros do RCD e o baço palpável a 2 centímetros do RCE.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Esse lactente encontra-se em insuficiência cardíaca com padrão hemodinâmico

- A quente (sem sinais de baixo débito) e seco (sem sinais de congestão venosa).
- B quente (sem sinais de baixo débito) e úmido (com sinais de congestão venosa).
- C frio (com sinais de baixo débito) e seco (sem sinais de congestão venosa).
- D frio (com sinais de baixo débito) e úmido (com sinais de congestão venosa).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141611](https://www.4000141611.com)

Questão 93 Anemia ferropriva na infância Pediatria Diagnóstico

Lactente de 11 meses apresenta palidez. No investigatório alimentar, observa-se apenas consumo eventual de frutas, legumes, verduras e carne, pois a criança prefere mamadeira de leite de vaca e mingau com bolacha. AP: aleitamento exclusivo até os 4 meses de vida e após introdução de leite de vaca. Exame físico: BEG, descorado +2/+4, presença de sopro sistólico discreto a ausculta cardíaca, sem visceromegalias. Exame laboratorial: hemograma: Hb 7,5 g/dL, Ht 24%, VCM 62, HCM 19,5, RDW 25%, leucócitos 8 900/mm³ (neutrófilos – 21%, linfócitos – 61%, eosinófilos – 2,6%, monócitos – 15%), plaquetas 460 000/mm³. A classificação morfológica das hemácias e a provável etiologia da anemia são,

respectivamente:

- A normocítica e normocrômica; anemia hemolítica autoimune.
- B macrocítica e normocrômica; anemia megaloblástica.
- C microcítica e hipocrômica; anemia ferropriva.
- D microcítica e hipocrômica; anemia de doença crônica.

4 000141610

Questão 94 Agentes etiológicos Pediatría PneumoniasBroncopneumonias BCP na Infância

Com relação à pneumonia na infância, assinale a alternativa correta.

- A A implantação da imunização contra o pneumococo não alterou o cenário etiológico das pneumonias, de acordo com sua abrangência populacional.
- B O uso de antibióticos protege a flora da orofaringe, dificultando a aquisição de infecção comunitária.
- C Entre os principais mecanismos de defesa do aparelho respiratório, estão o reflexo de tosse e a função mucociliar, que adere e elimina agentes infecciosos.
- D O agente *H. Influenzae* ainda é responsável por grande parte das pneumonias graves e complicadas na infância.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141609](https://www.4000141609.com)

Questão 95 Pediatría Vacina BCG

Com relação à vacina BCG, assinale a alternativa correta.

- A As complicações mais comuns são abscesso, úlcera e linfonodos fistulizados.
- B Exerce proteção contra as manifestações iniciais da tuberculose.
- C A revacinação é indicada após a segunda dose sem evidência de cicatriz vacinal.
- D Para melhor cicatrização da lesão vacinal, devem-se orientar pomadas cicatrizantes.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141608](https://www.4000141608.com)

Questão 96 Amamentação Aleitamento Materno Obstetrícia

Em relação ao aleitamento materno, assinale a alternativa correta.

- A As infecções maternas por retrovírus como o HTLV1 e HTLV2 são contraindicações relativas para a amamentação, devendo-se analisar a carga viral materna.
- B O Ministério da Saúde não contraindica a amamentação em mães infectadas pelo vírus da hepatite C, porque, apesar de teoricamente possível, a transmissão pelo leite materno não foi documentada.
- C A mãe que usa medicamento contínuo deverá amamentar a criança logo após a sua ingestão, de forma a haver um período de tempo de, pelo menos, meia hora até a próxima mamada.
- D No recém-nascido cardiopata, a amamentação está contraindicada devido à possibilidade de aumento do trabalho cardíaco.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141607](https://www.4000141607.com)

Questão 97 **Pediatria** **Puericultura** **Puericultura Geral**

Após o nascimento, entre os sinais de alerta para a necessidade de procurar um profissional de saúde, está:

- A fralda seca por mais de 12 horas.
- B presença de cólicas, antes dos primeiros 30 dias de vida.
- C oscilação no padrão das fezes, em relação a consistência, cor e frequência.
- D choro muito frequente nas primeiras semanas de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141606](https://www.4000141606.com.br)

Questão 98 **Diagnóstico** **Distúrbios respiratórios do período neonatal** **Pediatria**

Após parto cesáreo, RN de 35 semanas de idade gestacional necessita de ventilação com pressão positiva na sala de parto. Com 30 minutos de vida, apresenta FR 80 irpm, tiragem intercostal e batimento de aletas nasais. O padrão radiológico esperado, a etiopatogenia e o tratamento para estabilização do paciente são, respectivamente:

- A hiperinsuflação pulmonar e derrame intercisural; retardo da absorção do líquido pulmonar; CPAP nasal.
- B infiltrado retículo-granular difuso e broncogramas aéreos; deficiência e inativação do surfactante pulmonar; administração de surfactante.
- C condensação pulmonar grosseira, atelectasia e hiperinsuflação; aspiração de mecônio; CPAP nasal.
- D hiperinsuflação pulmonar e infiltrado retículo-granular grosseiro; extravazamento de ar (pneumotórax); oxigênio inalatório.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141605](https://www.4000141605.com.br)

Questão 99 **Massagem cardíaca** **Reanimação neonatal** **Pediatria**

Em relação à massagem cardíaca na reanimação em sala de parto, é correto afirmar que

- A deve ser rapidamente realizada independentemente da adequação da ventilação pulmonar.
- B a técnica dos 2 dedos é mais recomendada por ser mais fácil, menos cansativa e mais efetiva.
- C deve ser intercalada com ventilação por cânula traqueal utilizando oxigênio a 100%.
- D a sincronização da massagem com a ventilação deve possibilitar 30 ventilações e 120 compressões por minuto.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141604](https://www.4000141604.com.br)

Questão 100 **Sangramento segunda metade da gestação** **Descolamento prematuro de placenta DPP** **Obstetrícia**

Gestante com 35 semanas apresentou sangramento vaginal, sendo indicada cesárea de urgência. O líquido amniótico era sanguinolento, e o bebê chorou ao nascer. O tempo indicado para o clampamento do cordão é

- A de até 30 segundos.
- B de 30 a 60 segundos.
- C de 1 a 3 minutos.
- D imediato.

Respostas:

1	C	2	D	3	C	4	A	5	A	6	B	7	A	8	C	9	A	10	A	11	D
12	D	13	A	14	D	15	B	16	A	17	D	18	A	19	D	20	C	21	D	22	D
23	C	24	D	25	C	26	C	27	D	28	B	29	B	30	A	31	A	32	D	33	C
34	D	35	C	36	B	37	C	38	C	39	A	40	C	41	D	42	D	43	C	44	C
45	B	46	D	47	B	48	A	49	D	50	B	51	A	52	B	53	B	54	A	55	A
56	C	57	A	58	B	59	C	60	A	61	A	62	B	63	A	64	D	65	D	66	B
67	A	68	C	69	B	70	C	71	A	72	A	73	B	74	A	75	B	76	D	77	A
78	C	79	B	80	C	81	D	82	D	83	B	84	D	85	B	86	D	87	B	88	A
89	B	90	C	91	B	92	B	93	C	94	C	95	A	96	B	97	A	98	A	99	C
100	D																				

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Questão 1 COVID 19 Infectologia

Sobre o uso de máscaras para prevenção da covid-19, é correto afirmar que

- A tem sido associado à acidose respiratória, sendo arriscado para idosos, apesar da proteção evidente contra a doença.
- B as cirúrgicas podem ser utilizadas para proteção contra a doença e devem ser trocadas semanalmente.
- C existe efetividade de filtragem em máscaras caseiras, a depender do tecido de confecção e número de camadas.
- D as N95 com válvulas expiratórias são especialmente adequadas para uso em Unidades de Terapia Intensiva que atendem pacientes com a doença.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170102](https://t.me/medicinalivre)

Questão 2 Apresentação clínica

Homem de 48 anos apresenta há 1 ano úlceras espontâneas indolores em ambos os pés, conforme a imagem, que se iniciaram a partir de calosidades, além de deformidades dos pododáctilos. AP: "adormecimento" nas mãos e pés há mais de 5 anos, com perda progressiva de força de preensão.

Exames laboratoriais: HIV e FTA-Abs não reagentes; hemograma, glicemia, hemoglobina glicada, TSH e enzimas canaliculares hepáticas normais.



A hipótese diagnóstica é:

- A hanseníase.
- B siringomielia.
- C sífilis terciária.
- D esclerose múltipla.

4000170101

Questão 3 Abrasões Corneanas Oftalmologia Queimaduras Químicas Oculares

Homem de 30 anos relata a entrada de pó de cal em um olho há cerca de 30 minutos. Apresenta dor ocular,

embaçamento da visão e lacrimejamento. Exame físico: hiperemia conjuntival e dificuldade em manter o olho aberto.

A conduta inicial é:

- A aplicação de pomada oftálmica epitelizante e prescrição de colírio com corticoide.
- B irrigação copiosa do olho com solução salina ou solução de Ringer lactato.
- C curativo oclusivo do olho com pomada oftálmica epitelizante.
- D uso de colírio lubrificante.

4000170100

Questão 4 Rede Cegonha

Os serviços de saúde do SUS, nos termos da Lei nº 11.108, de 2005, ficam obrigados a permitir a presença, junto às parturientes, de um acompanhante, determinando no texto legal que

- A o acompanhamento se dará durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- B tal disposição é obrigatória na rede própria, sendo facultativa aos serviços conveniados.
- C esse acompanhante deverá ser, obrigatoriamente, o cônjuge ou aquele que venha ser indicado pela parturiente como pai da criança.
- D a mencionada obrigatoriedade está sujeita à existência de condições ambientais adequadas para sua prática.

4000170099

Questão 5 Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS Lei n 80801990

A saúde tem “como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais”, como refere o texto da

- A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080), Brasil, 1990.
- B Declaração de Alma Ata sobre Cuidados Primários, OMS, 1978.
- C Constituição da República Federativa do Brasil, Brasil, 1988.
- D Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948.

4000170098

Questão 6 Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS

Em relação à territorialização, pode-se afirmar que

- A** ela representa importante instrumento de organização dos processos de trabalho e das práticas de saúde, posto que as ações de saúde são implementadas sobre uma base territorial sem delimitação.
- B** a execução das práticas de saúde sobre um substrato territorial já vem sendo utilizada por distintas iniciativas no âmbito do SUS, como na proposta dos municípios/cidades saudáveis e na própria centralização prevista na constituição federal.
- C** o território apresenta, além de uma delimitação espacial, um perfil histórico, demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social e cultural, que o caracteriza como um território em permanente construção.
- D** a apreensão e a compreensão do território inviabilizam a avaliação dos reais impactos dos serviços sobre os níveis de saúde da população e, conseqüentemente, o desenvolvimento de práticas de saúde.

4000170097

Questão 7 **Medicina Preventiva**

O Sistema de Informação de Saúde do SUS agrega diversos tipos de bases de dados com funções e objetos de registro de diferentes naturezas, como o

- A** Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
- B** SIM: Sistema de Informação sobre Morbidade.
- C** Sisvan: Sistema de Vigilância de Agravos de Notificação.
- D** SIH-SUS: Sistema de Informações de Hanseníases do SUS.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170096](#)

Questão 8 **Dermatologia** **Diagnóstico**

Médico em unidade básica de saúde localizada em região onde a leishmaniose tegumentar americana é endêmica atende paciente com 45 dias de evolução de lesão cutânea única, indolor, de formato arredondado, com base eritematosa, infiltrada e de consistência firme, borda bem delimitada e elevada, fundo avermelhado e com granulações grosseiras, localizada no dorso da mão.

A abordagem correta é:

- A** confirmar o diagnóstico com exames parasitológico e/ou imunológico para notificar no Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
- B** iniciar tratamento com isotionato de pentamidina.
- C** acionar as ações de vigilância de animais silvestres e domésticos no peridomicílio do paciente.
- D** realizar exame parasitológico com pesquisa de amastigotas em esfregaço da lesão ou *imprint* de fragmentos de tecido do paciente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170095](#)

Questão 9 **Dermatologia** **Teste da histamina e da pilocarpina**

A presença de uma prova de histamina incompleta é altamente sugestiva de hanseníase e ocorre quando na área lesionada não se observa

- A o sinal da puntura.
- B o eritema reflexo secundário.
- C a pápula edematosa lenticular.
- D a anidrose.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170094](#)

Questão 10 Medicina Preventiva

A política nacional da atenção básica de 2017 permitiu estabelecer equipes de saúde da família com apenas um agente comunitário de saúde (ACS) e equipes de atenção primária sem ACS. A possibilidade de ausência do ACS afeta um dos pilares do modelo assistencial da estratégia de saúde da família em seu componente comunitário e de promoção da saúde, pautado pela

- A concepção da determinação social do processo saúde-doença e da clínica ampliada.
- B concepção médico-centrada e pontual de acolhimento e vínculo, relacionada ao combate às doenças.
- C ótica de territorialização e vínculo comunitário com famílias e comunidade com prioridade para demanda espontânea.
- D lógica do modelo de atenção à saúde de controle de riscos individuais.

4000170093

Questão 11 Medicina Preventiva

A regra de ouro do atual guia alimentar, de 2014, para a população brasileira é

- A utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.
- B fazer de alimentos *in natura* ou minimamente processados a base de sua alimentação.
- C preferir sempre alimentos *in natura* ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados.
- D utilizar alimentos ultraprocessados com moderação.

4000170092

Questão 12 Saúde ColetivaAtenção Primária à Saúde Medicina Preventiva
Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

No Brasil, a Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada como o centro ordenador das redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde. Para o fortalecimento da APS, deve(m)-se

- A** conhecer as especificidades de problemas de saúde de cada território adscrito, organizar ações assistenciais e educativas voltadas à integralidade do cuidado, priorizar a atenção aos problemas de saúde prevalentes e àqueles que acarretam maior risco à saúde, desenvolver ações de educação permanente e estimular o trabalho em equipe e a participação social da comunidade.
- B** assumir a estratégia de saúde da família como única porta de entrada do sistema de saúde, com um mesmo modelo de atenção em todo território nacional, considerando-se as diferenças locais e a frequência das doenças em cada região a partir do conceito de igualdade, valorizando a assistência médica individual.
- C** realizar o matriciamento de pacientes atendidos por meio do trabalho e da presença do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família nos pequenos e médios municípios, identificando-se a impossibilidade de implantar e qualificar a estratégia de saúde da família nos grandes centros urbanos.
- D** garantir acesso à população moradora do território adscrito, adequar a infraestrutura necessária ao funcionamento das unidades básicas de saúde, dotando-as de recursos materiais e insumos para que elas executem um conjunto de ações de assistência à saúde de nível primário, secundário e terciário.

4000170091

Questão 13 Medicina Preventiva Estudos de Coorte

Um estudo de 2019 teve como objetivo analisar a sobrevivência de pessoas com AIDS com idade de 13 anos ou mais, residentes nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, diagnosticadas entre 1998 e 1999, com seguimento de dez anos, e sua associação com escolaridade e raça/cor da pele. Nesse estudo, os participantes foram identificados através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação e os dados referentes às variáveis dependentes e independentes foram obtidos nos prontuários dos pacientes.

O delineamento desse estudo foi

- A** transversal.
- B** coorte.
- C** caso controle.
- D** descritivo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170090](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 14 Medicina Preventiva Teorema de Bayes Sensibilidade Especificidade e Valores Preditivos
Sensibilidade

Sobre a acurácia dos testes diagnósticos para a covid-19 registrados na Anvisa, a sensibilidade e a especificidade variaram entre os fabricantes, contudo, em geral, a sensibilidade foi superior a 85%, e a especificidade foi superior a 94%. Caso dois indivíduos que residam em diferentes cidades, uma com prevalência de covid-19 de 20% e a outra de 33%, realizem testes sorológicos do mesmo fabricante e ambos obtenham resultados positivos, a probabilidade desses indivíduos realmente apresentarem a doença é:

- A igual, pois quanto maior a especificidade de um teste, maior será o seu valor preditivo positivo.
- B igual, pois o valor preditivo positivo de um teste é uma propriedade exclusiva deste, ou seja, não depende da prevalência da doença.
- C diferente, pois quanto maior a prevalência de uma doença, maior é o valor preditivo de um teste.
- D diferente, pois quanto maior a sensibilidade de um teste, maior será o seu valor preditivo positivo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170089](https://www.4000170089.com)

Questão 15 **Medicina Preventiva** **Declaração de óbito DO Atestado de óbito**

Homem de 63 anos, assintomático, estava cumprindo medida de isolamento domiciliar, após diagnóstico confirmado para covid-19. Foi atingido por projétil de arma de fogo (“bala perdida”) que provocou perfuração craniana com perda de massa encefálica e faleceu. Era diabético há 8 anos, controlado.

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento correto da declaração de óbito.



A

PARTE I

- a) Ferimento perfurocontuso cranioencefálico
- b) Projétil de arma de fogo
- c) _____
- d) _____

PARTE II

Covid-19

Diabetes *Mellitus* compensado

B

PARTE I

- a) Covid-19
- b) Ferimento de cabeça por arma de fogo
- c) _____
- d) _____

PARTE II

Diabetes *Mellitus* compensado

C

PARTE I

- a) Ferimento perfurocontuso cranioencefálico
- b) Projétil de arma de fogo
- c) Covid-19
- d) _____

PARTE II

Diabetes *Mellitus*

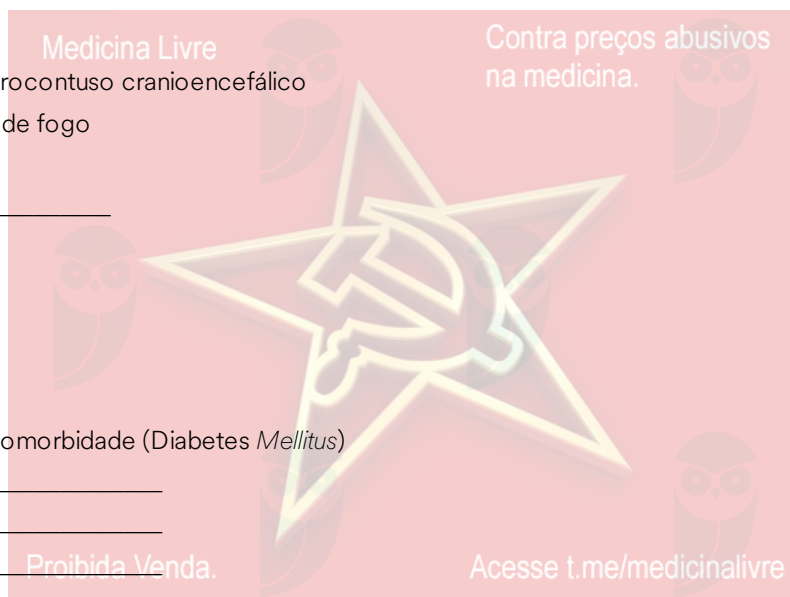
D

PARTE I

- a) Covid-19 com comorbidade (Diabetes *Mellitus*)
- b) _____
- c) _____
- d) _____

PARTE II

Traumatismo cranioencefálico por projétil de arma de fogo



4000170088

Questão 16

Medicina Preventiva

Coeficiente de Natalidade Taxa bruta de natalidade

O conceito de nascido vivo refere-se à expulsão ou extração completa do corpo da mãe de um produto de concepção

A

com sinal de vida e peso igual ou superior a 500 gramas, ou estatura igual ou superior a 25 centímetros.

B

que, depois da separação, respire e apresente dois outros sinais de vida.

C

com sinal de vida, desde que o cordão umbilical esteja cortado ou desprendida a placenta.

D

com sinal de vida, independentemente da duração da gravidez.

4000170087

Questão 17

Documentos médicos

O Código de Ética Médica, em seu Capítulo X (Documentos Médicos) estabelece que é vedado ao médico

- A atestar óbito quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, exclusivamente, em caso de verificação médico-legal.
- B atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente.
- C atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, com morte domiciliar, sem indícios de morte violenta.
- D atestar óbito de nascido vivo que resulte de gestação com duração inferior a 20 semanas.

4000170086

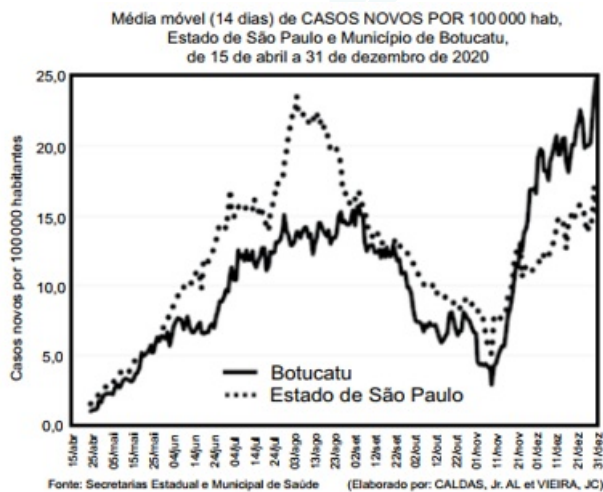
Questão 18

Incidência e Prevalência

Medicina Preventiva

Usos da Incidência e da Prevalência em Saúde Pública

O gráfico representado na imagem expressa a evolução de casos novos de covid-19 no município de Botucatu e no estado de São Paulo, de abril a dezembro de 2020.



A medida de saúde que está expressa no gráfico é

- A razão de morbidade média.
- B risco relativo médio.
- C coeficiente médio de prevalência.
- D coeficiente médio de incidência.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170085

Questão 19

Principais medidas de frequência de doenças

Medicina Preventiva

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, a situação da covid-19, no município de Botucatu e no estado de São Paulo, era a seguinte, nas datas a seguir indicadas.

Obs: para fins de cálculos, se necessário, deve-se usar a população IBGE, estimada para 2021: Botucatu = 149.718 habitantes; estado de São Paulo = 46.649.432 habitantes.

	Acumulado desde início da pandemia até 31.12.20		Acumulado desde início da pandemia até 31.08.21	
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
Botucatu	4.051	58	18.488	305
Estado de São Paulo	1.462.297	46.717	4.262.684	145.836

Para se comparar o risco de ocorrência e o risco de óbito da covid-19 entre as populações de Botucatu e São Paulo, devem-se usar, respectivamente:

- A a prevalência instantânea e o coeficiente de letalidade, ambos no final do período.
- B o coeficiente de prevalência e o coeficiente de mortalidade.
- C o coeficiente de incidência e o coeficiente de mortalidade.
- D a taxa de transmissão (ou o número efetivo de reprodução "R") e o coeficiente de letalidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170084](https://www.4000170084.com.br)

Questão 20 Medicina Preventiva Letalidade

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, a situação da covid-19, no município de Botucatu e no estado de São Paulo, era a seguinte, nas datas a seguir indicadas.

Obs: para fins de cálculos, se necessário, deve-se usar a população IBGE, estimada para 2021: Botucatu = 149.718 habitantes; estado de São Paulo = 46.649.432 habitantes.

	Acumulado desde início da pandemia até 31.12.20		Acumulado desde início da pandemia até 31.08.21	
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
Botucatu	4.051	58	18.488	305
Estado de São Paulo	1.462.297	46.717	4.262.684	145.836

O coeficiente de letalidade por covid-19, no município de Botucatu, no ano de 2021 (até 31.08), foi de

- A 2,64%.
- B 203,7 por 100000 habitantes.
- C 195,0 por 100000 habitantes.
- D 1,71%.

4000170083

Questão 21 Princípios da Anestesiologia Cirurgia

Homem de 65 anos necessita de correção emergencial de fratura exposta e lesão vascular em membro superior esquerdo, com tempo cirúrgico estimado de 4 horas. AP: HAS, DM, obesidade grau II, roncos e sonolência durante o dia, dificuldade no manejo de via aérea em cirurgias anteriores. Exame físico: ansioso, PA 140/90 mmHg, edêntulo, com pequena abertura bucal (menor que 3,5 cm) e espaço submandibular firme à palpação. Última refeição há 3 horas.

A conduta mais indicada é:

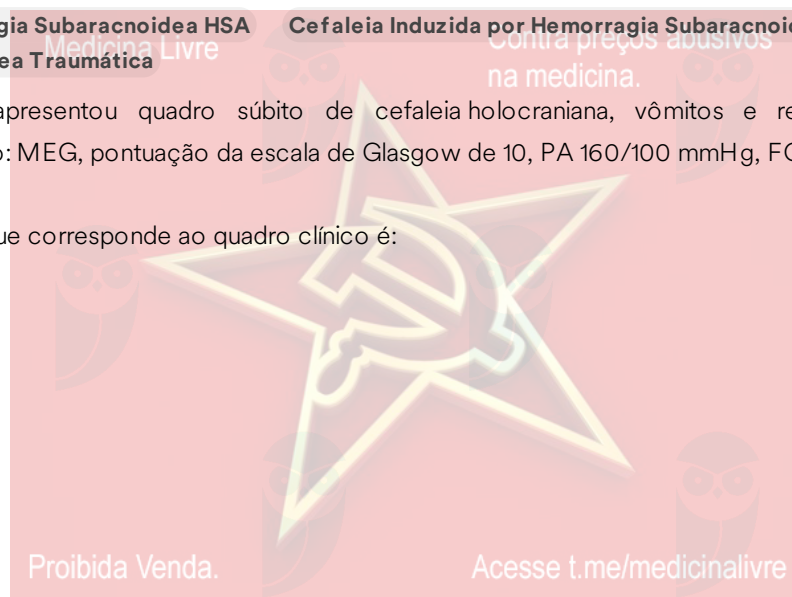
- A suspender o procedimento até que o tempo de jejum para sólidos seja de 8 horas.
- B realizar indução e intubação sob sequência rápida, evitando ventilação sob pressão positiva durante etapa de pré-oxigenação.
- C proceder com realização da cirurgia sob sedação e infiltração local, para que se evite manipulação das vias aéreas.
- D prosseguir com intubação via fibroscopia óptica com paciente acordado e mantendo reflexos protetores de via aérea, antes de indução da anestesia geral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170082](https://www.4000170082.com.br)

Questão 22 Hemorragia Subaracnoidea HSA Cefaleia Induzida por Hemorragia Subaracnoidea
Hemorragia Subaracnoidea Traumática

Mulher de 63 anos apresentou quadro súbito de cefaleia holocraniana, vômitos e rebaixamento do nível de consciência. Exame físico: MEG, pontuação da escala de Glasgow de 10, PA 160/100 mmHg, FC 90 bpm.

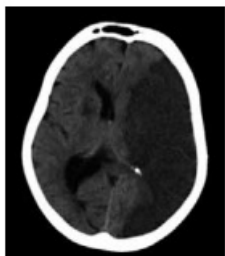
A imagem tomográfica que corresponde ao quadro clínico é:



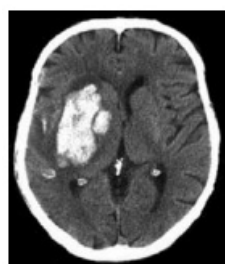
A



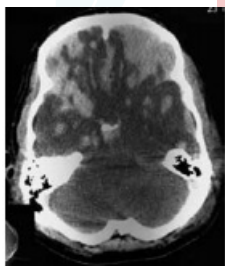
B



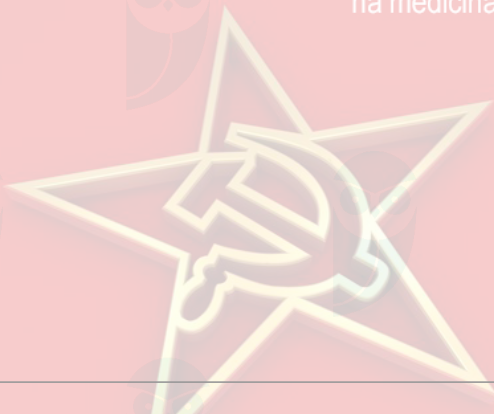
C



D



Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

4000170081

Questão 23

Metástases hepáticas

Cirurgia

A lesão apresentada nesta imagem é um achado frequente nos exames pós-morte em nosso país.



Sua etiopatogenia é:

- A hipóxica e hepática.
- B vascular e cardíaca.
- C neoplásica e hematogênica.
- D infecciosa e ascendente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170080](https://www.4000170080.com)

Questão 24 Osteonecrose da Cabeça do Fêmur

Homem de 40 anos apresenta dores espontâneas em ambos os quadris há um ano, com piora progressiva. AP: etilismo desde os 15 anos. RNM da bacia, conforme imagem.



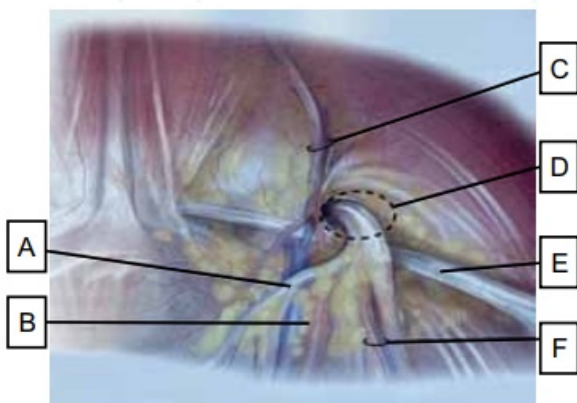
O diagnóstico mais provável é:

- A hematoma encapsulado intraósseo nas cabeças femorais.
- B osteocondroma nas cabeças femorais.
- C osteonecrose avascular das cabeças femorais.
- D osteomielite nas cabeças femorais.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170079](https://www.4000170079.com)

Questão 25 Hérnias Inguinocrurais Cirurgia

Com base na figura, que corresponde à visão posterior da região inguinal direita, pode-se afirmar que a letra



- A D corresponde à área do triângulo de Hasselbach.
- B E corresponde ao trato iliopúbico.
- C C corresponde aos vasos epigástricos superiores.
- D B corresponde à artéria ilíaca interna.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170078](https://www.4000170078.com)

Questão 26 Deiscência Anastomótica Fístulas Intestinais Cirurgia

Homem de 55 anos submetido à gastrectomia total por adenocarcinoma gástrico, com reconstrução em Y de Roux, vinha apresentando secreção serossanguinolenta desprezível no dreno sentinela do coto duodenal até o 4º PO, quando passou a ser bilioentérica, com débito de 200 mL nas últimas 24 h. Está com SNE locada após a enteroenteroanastomose. Exame físico: taquicárdico.

A conduta mais adequada é:

- A abordagem cirúrgica imediata.
- B dieta parenteral exclusiva.
- C passagem de outro dreno guiado por exame de imagem.
- D conduta conservadora e dieta enteral.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170077](https://www.4000170077.com)

Questão 27 Princípios da Cirurgia Oncológica Cirurgia

Com relação aos princípios básicos da cirurgia oncológica, pode-se afirmar que

- A na ressecção R1 há doença macroscópica residual.
- B a biópsia incisional consiste na remoção completa da lesão e tem papel terapêutico.
- C a biópsia por agulha fina permite a obtenção de amostra tecidual satisfatória.
- D o critério de operabilidade diz respeito às condições clínicas do paciente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170076](https://www.4000170076.com)

Questão 28 Complicações Cirurgia

Homem de 55 anos apresenta desconforto epigástrico e plenitude gástrica. AP: etilista e internação prévia por pancreatite aguda há 2 semanas. TC de abdome: conforme imagem.



A conduta correta é:

- A observação clínica e seguimento com exame de imagem.
- B laparotomia exploradora de urgência.
- C drenagem percutânea.
- D EDA para possível conduta terapêutica.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170075](https://www.4000170075.com)

Questão 29

Choque

Cirurgia

Homem de 34 anos foi vítima de acidente automobilístico. Exame físico: desacordado, pele fria e pálida, PA 85/40 mmHg, FC 70 bpm, FR 12 irpm, sem fontes de sangramento externo. Pode-se afirmar que a

- A causa do choque é decorrente de lesão parassimpática.
- B suspeita é de choque neurogênico, por isso a hipotensão permissiva deve ser considerada.
- C ausência de reflexo bulbo cavernoso indicaria choque medular.
- D succinilcolina é a droga de escolha nesse caso, se houver necessidade de intubação.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

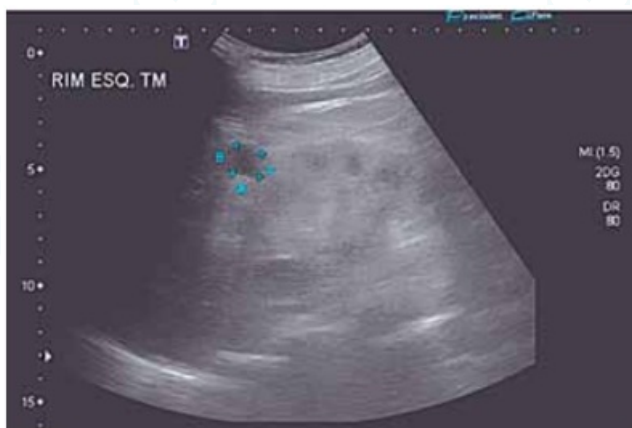
4000170074

Questão 30

Urologia

Cirurgia

Mulher de 43 anos apresenta dor lombar crônica. AP: HAS e DM II. Exames laboratoriais: Hb 14 mg/dL, Cr 1,1 mg/dL, Ur 24 mg/dL, glicemia 220 mg/dL. US, conforme imagem: rim esquerdo em topografia habitual, 12,1cm em seu maior eixo, contornos definidos, distinção corticomedular preservada e ecogenicidade cortical preservada, cisto renal hipocogênico exofítico no terço médio, medindo 1,5 x 1,6 cm; rim direito em topografia habitual, 11,7cm em seu maior eixo, contornos definidos, distinção corticomedular preservada e ecogenicidade cortical preservada; não há sinais de litíases ou hidronefrose.



Assinale a alternativa correta.

- A Trata-se de lesão renal neoplásica, sendo indicada tomografia para classificação de Bosniack.
- B Trata-se de um cisto renal simples, não necessitando de exames complementares.
- C A lesão é de classificação Bosniack II, devendo ser confirmada por tomografia e reavaliada em 6 meses.
- D A lesão tem associação com neoplasia maligna e doença renal crônica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170073](#)

Questão 31 **Pneumologia** **Cirurgia**

Com relação à fisiologia respiratória aplicada à drenagem de tórax, é correto afirmar que na

- A inspiração, o volume da caixa torácica diminui, a pressão na cavidade pleural aumenta e a coluna de líquido no interior do tubo rígido do selo d'água sobe.
- B inspiração, o volume da caixa torácica aumenta, a pressão na cavidade pleural diminui e a coluna de líquido no interior do tubo rígido do selo d'água desce.
- C expiração, o volume da caixa torácica aumenta, a pressão na cavidade pleural diminui e a coluna de líquido no interior do tubo rígido do selo d'água sobe.
- D expiração, o volume da caixa torácica diminui, a pressão na cavidade pleural aumenta e a coluna de líquido no interior do tubo rígido do selo d'água desce.

4000170072

Questão 32 **Avaliação Inicial** **Choque** **Cirurgia**

Homem de 21 anos, vítima de acidente com motocicleta, dirigia sem capacete. Exame físico: múltiplas escoriações e lacerações em crânio, face e tórax, abertura ocular ausente, emissão de sons incomprensíveis e flexão dos membros superiores ao estímulo de dor, murmúrio vesicular abolido em hemitórax direito, pulso fino, FC 130 bpm, PA 70/40 mmHg. As hipóteses diagnósticas e a conduta inicial são:

- A choque hemorrágico, hemotórax e/ou pneumotórax, trauma cranioencefálico grave; garantir via aérea definitiva.
- B choque hemorrágico, hemotórax e/ou pneumotórax, trauma cranioencefálico moderado; drenagem torácica à direita.
- C choque neurogênico, atelectasia do pulmão direito, trauma cranioencefálico grave; garantir via aérea definitiva.
- D choque neurogênico, atelectasia do pulmão direito, trauma cranioencefálico moderado; drenagem torácica à direita.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170071](https://www.4000170071.com.br)

Questão 33 Abscesso pulmonar

Homem de 45 anos apresenta tosse com expectoração, astenia e febre há 10 dias. Refere que no início a secreção era amarelada, mas há 3 dias se tornou purulenta. AP: etilista e tabagista. Exames laboratoriais: leucocitose e PCR elevada. TC de tórax, conforme imagem.



A conduta correta é:

- A drenagem torácica.
- B antibioticoterapia e fisioterapia respiratória.
- C videotoroscopia para ressecção da lesão.
- D toracocentese diagnóstica.

Contra preços abusivos
na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170070](https://www.4000170070.com.br)

Questão 34 Atendimento Inicial às Vítimas de Queimadura Cirurgia

Homem de 26 anos apresenta queimaduras produzidas pela explosão de um vasilhame com álcool combustível, há 1 hora. Exame físico: consciente, orientado, respirando normalmente, sem rouquidão ou escarro com fuligem, bolhas rotas na face, na parte anterior do tronco e MMSS. As superfícies queimadas são avermelhadas, com áreas esbranquiçadas e outras vermelho vivo. Estimativa da área queimada: 25%. A conduta nesse momento é realizar

- A atendimento inicial ao traumatizado, infusão de líquidos por via endovenosa, avaliação da profundidade da área queimada e passagem de sonda vesical de demora.
- B infusão de Ringer lactato, com volume calculado pela fórmula de Parkland, sendo a metade do volume calculado infundido em 8 horas.
- C intubação precoce por suspeita de queimadura de via aérea, cálculo do volume a ser infundido pela fórmula de Parkland e passagem de sonda vesical de demora.
- D infusão de Ringer lactato, com volume calculado pela fórmula de Parkland, antibioticoterapia de largo espectro e internação em unidade de queimados.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170069](https://www.4000170069.com)

Questão 35 Fases da Cicatrização Cirurgia

Sobre o processo de cicatrização tecidual, é correto afirmar que

- A quanto mais derme presente, maior será a contração secundária.
- B na fase inflamatória, a resposta celular é inicialmente de linfócitos.
- C na fase proliferativa, a perda da inibição por contato impede a epitelização.
- D na fase de maturação, há substituição do colágeno tipo III pelo tipo I.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170068](https://www.4000170068.com)

Questão 36 Anticoagulantes antagonistas da vitamina K

Assinale a alternativa que apresenta a razão para a utilização de anticoagulante injetável concomitante ao início da terapia por varfarina na anticoagulação.

- A A varfarina bloqueia a ativação de fatores da cascata de coagulação e a produção dos inibidores de coagulação (proteína C e S) dependentes da vitamina K.
- B Não se pode confiar na absorção oral da varfarina, sendo esse o motivo pelo qual há tanta variabilidade no resultado do tempo de protrombina.
- C O uso de anticoagulantes parenterais traz benefício na terapêutica intra-hospitalar pela sua fácil via de administração.
- D A varfarina é uma pró-droga que chega inativada ao fígado, pelo contato com as proteínas C e S, sendo somente ativada após o efeito de primeira passagem pela enzima P450.

4000170067

Questão 37 Oclusão Arterial Aguda OAA Cirurgia

O local mais frequente de acometimento periférico nas oclusões arteriais agudas de etiologia embólica é a

- A bifurcação aórtica.
- B bifurcação ilíaca.
- C bifurcação femoral.
- D artéria poplítea.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170066](https://www.4000170066.com)

Questão 38 **Profílatia Secundária** **Investigação Etiológica**

Mulher de 30 anos apresentou acidente vascular encefálico (AVE) há um mês. AP: sem comorbidades. Exame físico: sem déficits neurológicos. Exames: tomografia cervical, tomografia encefálica e holter: normais, ecocardiograma transesofágico: persistência de forame oval pérvio com diâmetro de 0,5 x 0,7 cm. A conduta mais adequada para a prevenção de recorrência de AVE é:

- A antiagregação plaquetária.
- B anticoagulação.
- C fechamento do forame oval.
- D seguimento ambulatorial.

4000170065

Questão 39 **Apendicite Aguda** **Apendicite Aguda** **Cirurgia**

Menina de 3 anos tem dor abdominal há 3 dias, mais localizada em andar inferior. Há 2 dias apresenta episódios de vômitos esverdeados, inapetência e picos febris (38,5 °C). Há 1 dia apresenta episódios de diarreia líquida. Exame físico: REG, desidratada 2+/4, irritada. Abdome: RHA diminuídos, dor difusa à palpação profunda, com reação peritoneal em hipogástrio. Hemograma: 14.000 glóbulos brancos, sem desvio. Raio-X de abdome, conforme a imagem.



O diagnóstico e a conduta são:

- A gastroenterocolite aguda; hidratação e coleta de coprograma e coprocultura.
- B apendicite aguda; apendicectomia.
- C pielonefrite aguda; TC de rins e vias urinárias.
- D abdome agudo obstrutivo por ingestão de corpo estranho; laparotomia exploradora.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170064](https://t.me/medicinalivre)

Questão 40 **Persistência do Conduto Peritônio vaginal Patente** **Cirurgia**

Menino de 4 meses apresenta choro intenso há 2 horas. Mãe relata última mamada há 30 minutos. Nega vômitos e febre e refere que a última evacuação ocorreu há 3 horas. Exame físico: BEG, ativo, bastante irritado e choroso. Abdome: normotenso, RHA presentes, sem sinais de reação peritoneal. Presença de abaulamento fixo em FID (conforme a

imagem). Testículos tópicos bilateralmente.



O diagnóstico é hérnia inguinal direita

- A estrangulada, necessitando de herniorrafia imediatamente.
- B encarcerada, e deve-se realizar tentativa de redução manual.
- C devendo-se agendar consulta ambulatorial com especialista.
- D encarcerada, e deve-se realizar herniorrafia imediatamente.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170063](#)

Questão 41 Fobia Social ou Transtorno de Ansiedade Social Transtornos Ansiosos

Mulher de 21 anos refere que está muito preocupada e com medo de não conseguir concluir seu curso universitário, pois tem apresentado sintomas de ansiedade intensa sempre que deve realizar uma apresentação oral, temendo ser reprovada novamente. Esse quadro inicia-se com rubor, taquicardia, sudorese, dor abdominal, náuseas e sensação de sufocamento. Considera-se uma pessoa retraída e, sempre que possível, prefere fazer tudo sozinha e assim evitar o julgamento dos outros.

A hipótese diagnóstica é:

- A transtorno de pânico.
- B fobia específica.
- C transtorno de ansiedade generalizada.
- D transtorno de ansiedade social.

4000170062

Questão 42 Tratamento Dermatologia Manifestações clínicas

Homem de 35 anos, proprietário rural, apresenta lesão na face lateral da perna direita há 5 meses, que se iniciou como “pelo encravado” com evolução progressiva (imagem). Nega outras lesões cutâneas ou sintomas sistêmicos. Exame histopatológico da lesão: reação granulomatosa em arranjo tuberculoide constituída por macrófagos, células epitelioides e células gigantes, com presença de estruturas arredondadas dentro dos macrófagos, além de infiltrado

histioplasmocitário. Exame parasitológico direto da lesão: negativo.



O diagnóstico e tratamento são, respectivamente,

- A hanseníase dimorfa; rifampicina associada à clofazimina.
- B leishmaniose tegumentar; antimoniato de N-metilglucamina.
- C leishmaniose tegumentar; cetoconazol.
- D hanseníase tuberculoide; rifampicina associada à dapsona.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170061](#)

Questão 43 Neurologia Estado de Mal Epiléptico

Homem de 65 anos apresenta movimentos involuntários no braço direito e face que se iniciaram há 2 horas e permaneceram de forma ininterrupta até o momento. AP: HAS, DM e DLP. Exame físico: REG, desidratado, PA 130/90 mmHg, HGT 560 mg/dL, movimentos estereotipados clônicos em membro superior direito e automatismos oromastigatórios. O diagnóstico e a conduta sequencial, além da monitorização, são:

- A estado de mal epiléptico; midazolam EV, seguido de fenitoína EV com velocidade de infusão de 50 mg/min, se necessário, e corrigir glicemia.
- B crises convulsivas; diazepam EV, fenobarbital EV, se necessário, e corrigir glicemia.
- C estado de mal epiléptico; corrigir glicemia, fenitoína EV com velocidade de infusão de 50 mg/min.
- D crises convulsivas; midazolam EV, fenitoína EV com velocidade de infusão de 75 mg/min, se necessário, e corrigir glicemia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170060](#)

Questão 44 Síndrome do Manguito Rotador

Mulher de 56 anos há 9 meses apresenta dor na região anterolateral dos ombros com piora ao abduzir e elevar os braços e limitação para carregar pesos. Nega trauma associado, parestesias ou parestesia dos membros. AP: diabética, hipertensa, dislipidêmica em uso irregular de losartana 100 mg/dia, metformina 1000 mg/dia e sinvastatina 40 mg/dia. Exame físico: dor à manobra do arco doloroso com abdução dos braços a 80°, teste de Neer, Hawkins e Jobe positivos bilateralmente. O diagnóstico e a conduta são:

- A polineuropatia periférica diabética; eletroneuromiografia, antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes.
- B cervicobraquialgia; TC de coluna cervical e eletroneuromiografia, AINE e fisioterapia.
- C miopatia necrosante imunomediada induzida por estatina; dosar CPK e anticorpos, eletroneuromiografia, biópsia muscular, altas doses de prednisona.
- D doença do manguito rotador; fisioterapia, AINE, orientação para não realizar movimentos acima do nível dos ombros e evitar sobrecarga.

4000170059

Questão 45 Tratamento de manutenção da asma Pneumologia

Mulher de 27 anos apresenta tosse e chiado no peito desde os 6 anos de idade. Atualmente, os sintomas ocorrem até 2 vezes no mês. Nega despertar noturno ou limitações de atividades e não usa medicações de resgate. A conduta medicamentosa indicada é:

- A salbutamol 100 mcg, 2 puffs inalatório de resgate.
- B salmeterol 50 mcg/fluticasona 250 mcg inalatório de resgate.
- C formoterol 6mcg/budesonida 200 mcg de 12/12 h de manutenção.
- D formoterol 6 mcg/budesonida 200 mcg inalatório de resgate.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170058](https://www.4000170058.com)

Questão 46 Fatores de Risco Neurologia Quadro Clínico

Homem de 62 anos apresenta cansaço intenso diário e episódios de esquecimentos há 5 anos. AP: doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), HAS e consumo de duas doses de cerveja/dia. Nega tabagismo. Faz uso contínuo de omeprazol, hidroclorotiazida, losartana e propranolol. Exame físico: altura 1,60 m; peso 98 kg; circunferência cervical 41 cm; P A 180/90 mmHg; FC 89 bpm; FR 18 ipm. Hipoplasia mandibular; 2 bulhas rítmicas hipofonéticas; pulmonar: murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios; abdome globoso. Dentre os exames complementares relacionados, o mais adequado a ser solicitado nesse momento é:

- A espirometria pré e pós-broncodilatador.
- B tomografia computadorizada de tórax.
- C polissonografia.
- D ressonância magnética de tórax.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170057](https://www.4000170057.com)

Questão 47 Síndrome de Lise Tumoral SLT Síndrome de lise tumoral SLT

Homem de 25 anos apresenta náuseas, vômitos, discreta sonolência e fraqueza muscular. AP: diagnóstico recente de carcinoma de células germinativas do testículo esquerdo, com grande massa tumoral retroperitoneal, em quimioterapia com etoposídeo e cisplatina há 4 dias. Exame físico: PA 110/70 mmHg, FC 100 bpm, temperatura 37,8 °C, orientado, sem outras alterações.

A conduta inicial e sua justificativa são:

- A antibioticoterapia empírica de amplo espectro, considerando alta possibilidade de neutropenia pós-quimioterapia.
- B antieméticos via oral, considerando que se trata de toxicidade gastrointestinal relacionada à quimioterapia.
- C encaminhamento à UTI devido ao risco de instabilidade hemodinâmica, considerando alta possibilidade de perfuração neoplásica abdominal.
- D hidratação endovenosa e coleta de hemograma, função renal, cálcio, potássio, ácido úrico e fosfato, pela possibilidade de síndrome de lise tumoral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170056](https://www.4000170056.com)

Questão 48 Hipertensão Arterial Sistêmica HAS

Mulher de 56 anos com HAS há 20 anos sem outras comorbidades. Inicialmente obteve bom controle pressórico, entretanto, há 5 anos passou a ter elevação da pressão arterial sempre > 140/90 mmHg, em medidas residenciais com aparelho automático bem calibrado. Em uso regular e correto de hidroclorotiazida 25 mg/dia, enalapril 40 mg/dia, amlodipina 10 mg/dia e atenolol 100 mg/dia. Trata-se de hipertensão

- A resistente devido à hipertensão essencial, sem necessidade de investigação de causas secundárias.
- B resistente, com necessidade de ampliar investigação para causas secundárias.
- C refratária devido à hipertensão essencial, sem necessidade de investigação de causas secundárias.
- D refratária, e a causa mais provável é hipertensão renovascular.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170056](https://www.4000170056.com)

Questão 49 Quadro clínico da anemia megaloblástica

Considere os seguintes valores normais para esta questão.

Valores normais

- VCM = 80 – 100 fL
- HCM = 26 – 34 pg
- CHCM = 31 – 37 g/dL
- RDW < 14,5%
- GB = 4 000 – 10 000 / mm³
- Neutro = 2 000 – 7 000 / mm³
- Linfo = 1 000 – 4 000 / mm³
- Mono = 80 – 800 / mm³
- Eosi = 0 – 450 / mm³
- Baso = 0 – 120 mm³

Homem de 68 anos, branco, lavrador, ex-tabagista (43 anos/maço), queixa-se de fraqueza há 5 semanas, mais intensa há 15 dias. Exame físico: FC 94 bpm, PA 110/70 mmHg, palidez 3+/4, icterícia conjuntival 1+/4, sopro holossistólico 1+ (suave), varizes sublinguais 3+/4, gengivite tartárica inferior, fígado palpável a 1 cm do rebordo costal na linha hemiclavicular direita, baço percutível. Exames laboratoriais: DHL 1389 U/mL, haptoglobina zero, BT 3,8 mg/dL (direta 0,5, indireta 2,3); glóbulos vermelhos 2.680.000/mm³, Hb 10,3 g/dL, Ht 33,2 %, VCM 124 fL, HCM 42, 2 pg, CHCM 34,1 g/dL, RDW 16,8%, plaquetas 82.000/mm³, leucócitos 6.050/mm³ (neutro 4.230/mm³, linfo 1.490/mm³, mono 270/mm³, eosí 60/mm³, baso 10/mm³).

O diagnóstico é anemia macrocítica

- A por hemólise com consumo de plaquetas.
- B e plaquetopenia por megaloblastose.
- C com consumo de plaquetas por hemólise microangiopática.
- D e plaquetopenia por síndrome mielodisplásica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170054](#)

Questão 50 Neutropenia febril

Homem de 61 anos apresenta febre de 39,0 °C. AP: linfoma de alto grau, no D14 da quimioterapia de alta intensidade. Exame físico: PA 120/70 mmHg; FC 112 bpm; FR 20 ipm; SatO₂ 98%; desidratado +/4+; hiperemia intensa e aumento de temperatura na região do portocath. Considerando a principal hipótese diagnóstica, a conduta correta é:

- A aguardar resultado de hemograma antes de iniciar o tratamento.
- B indicar tratamento ambulatorial após a sua confirmação.
- C indicar antibioticoterapia sem cobertura para bactérias Gram positivo.
- D iniciar antibioticoterapia de amplo espectro, antes da confirmação diagnóstica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170053](#)

Questão 51 Saúde do Idoso geriatria

Em relação ao *delirium* em idosos hospitalizados,

- A os antipsicóticos representam a principal abordagem farmacológica para o tratamento de pacientes portadores de *delirium* hipoativo.
- B de acordo com o *Confusion Assessment Method*, o diagnóstico é firmado quando há alteração aguda do estado mental e flutuação cognitiva, associados a alucinações ou alteração do nível de consciência.
- C as medidas de prevenção incluem estimular a mobilidade e a ingestão hídrica, orientá-los no tempo e no espaço e otimizar o sono à noite com medidas não farmacológicas.
- D está indicada a realização de um exame de neuroimagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética.

4000170052

Questão 52 Diarreia Crônica Cirurgia

Mulher de 55 anos apresenta diarreia há 2 meses, acompanhada de dor abdominal e perda de peso (< 10% do peso corpóreo). HI: 6 evacuações ao dia, fezes amolecidas a líquidas, sem muco ou sangue. AP: HAS e DM controlados com uso regular de enalapril e metformina. A conduta correta é:

- A realizar investigação com colonoscopia para descartar neoplasia de cólon.
- B suspender o uso das medicações pela suspeita de diarreia medicamentosa.
- C investigar doença celíaca com endoscopia digestiva alta e biópsia de duodeno.
- D iniciar tratamento com amitriptilina pela suspeita de síndrome do intestino irritável.

4000170051

Questão 53**Manometria Esofágica****pHmetria de 24 horas e Impedância****Endoscopia Digestiva Alta EDA**

É considerada evidência conclusiva para doença do refluxo gastroesofágico:

- A endoscopia digestiva alta com esofagite erosiva grau C de Los Angeles.
- B pH-metria de 24 horas com tempo de exposição ácida de 3%.
- C pH-metria com impedanciometria, registrando 35 episódios de refluxo em 24 horas.
- D manometria de esôfago com hipotonia do esfíncter inferior do esôfago.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170050

Questão 54**Insulinoterapia no tratamento do diabetes mellitus tipo 2**

Homem de 39 anos é diabético e faz uso de insulina NPH 20 UI pela manhã e 10 UI à noite (*bed time*). Exames laboratoriais: glicemia de jejum 157 mg/dL; HbA1c 7,3%. Mapa de glicemia capilar (quadro):

Glicemia capilar					
Jejum	Pós-café	Pré-almoço	Pós-almoço	Pré-jantar	Pós-jantar
156	164	132	149	112	189
148	155	128	133	119	193
162	170	126	152	127	201
139	159	126	141	98	197

Contra preços abusivos
na medicina.

Considerando as metas preconizadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes, a conduta é

- A aumentar a NPH da manhã e da noite.
- B aumentar a NPH da noite.
- C adicionar insulina regular antes do jantar.
- D trocar insulina NPH por insulina glargina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000170049

Questão 55**Tireoidite granulomatosa subaguda TGSA**

Mulher de 38 anos apresenta astenia, mal-estar, artralgia, mialgia, faringite, febre e dor intensa na região cervical, principalmente à direita com irradiação para mandíbula e ouvido direito há 10 dias. Há 4 dias queixa-se de palpitações, tremor e sudorese. Exame físico: bócio nodular de consistência firme, doloroso. Exames laboratoriais: TSH 0,002 mUI/mL (VR 0,4 – 4,0); T4 livre 2,5 ng/dL (VR 0,8 – 1,9); tireoglobulina 75 ng/mL (VR <10); PCR 12 mg/L (VR <3); VHS 68 mm/h (VR < 20 mm/h). Cintilografia de tireoide: captação do iodo radioativo nas 24 horas < 1% (VR 15 – 45%).

É correto afirmar que essa condição

- A é uma doença inflamatória crônica da tireoide que evolui para hipotireoidismo.
- B geralmente segue um curso de quatro fases: tireotoxicose, eutireoidismo, hipotireoidismo e eutireoidismo.
- C se trata da doença de Graves, e o tratamento com antitireoideanos é necessário.
- D indica a necessidade de punção aspirativa (PAAF) devido à presença do nódulo.

4000170048

Questão 56 Infectologia Pneumologia

Homem de 50 anos apresenta dispneia, tosse, expectoração amarelada e febre de 38 °C há 5 dias. AP: HAS. Exame físico: PA 60/40 mmHg, FC 110 bpm, FR 35 ipm e SatO₂ 85%. Além da suplementação de oxigênio, na primeira hora devem-se:

- A coletar hemoculturas e lactato sérico, administrar antibioticoterapia, fazer 30 mL/kg de cristalóide e entrar com noradrenalina se necessário.
- B coletar hemoculturas, lactato sérico e saturação venosa central, fazer 30 mL/kg de cristalóide, antibioticoterapia, dobutamina se saturação venosa central < 70%.
- C coletar culturas, iniciar antibioticoterapia de amplo espectro, prescrever noradrenalina para manter pressão arterial média > 65 mmHg.
- D coletar culturas, fazer 30 mL/kg de solução cristalóide, iniciar antibioticoterapia de largo espectro, prescrever dobutamina se saturação venosa central < 70%.

4000170047

Questão 57 Sarcoidose Sarcoidose Pneumologia

Mulher de 37 anos apresenta dispneia progressiva, tosse seca, calafrios, febre baixa diária há 6 meses, evoluiu com desorientação, fraqueza muscular e apatia. Exame físico: PA 100/60 mmHg, FC 105 bpm, SatO₂ 94%, desidratada 3+/4+; hiperemia, aumento de temperatura e dor em 2ª e 3ª articulações interfalangianas proximais da mão direita; lesões hiperpigmentadas nos membros (imagem 1). Exames laboratoriais: escarro negativo para BAAR; sorologias para HIV, histoplasmose, paracoccidioidomicose e apherilose negativas; hemograma normal, PCR 7 mg/dL, Na 135 mEq/L, K 4.5 mEq/L, Cr 2.0 mg/dL, Ur 102 mg/dL, cálcio corrigido 11.8 mg/dL, 1,25 (OH)₂ vitD₃ = 200 pg/mL. Radiografia de tórax (imagem 2).



(Imagem 1)



(Imagem 2)

A principal hipótese diagnóstica, mecanismo fisiopatológico e manejo inicial são, respectivamente,

- A neoplasia pulmonar; hipercalcemia relacionada com secreção ectópica de PTH; pamidronato 60 – 90 mg IV e furosemida IV.
- B neoplasia pulmonar; hipercalcemia por produção de proteína PTH-like; hidratação IV vigorosa.
- C sarcoidose; hipercalcemia por aumento da expressão de 1α -hidroxilase pelos macrófagos dos granulomas; hidratação IV vigorosa.
- D sarcoidose; hipercalcemia por secreção ectópica de PTH pelos granulomas; hidratação vigorosa, pamidronato 60 – 90 mg IV e furosemida IV.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170046](https://www.4000170046.com)

Questão 58 **Diagnostico** **Pneumologia**

Mulher de 79 anos apresenta tosse seca e dispneia súbita. AP: adenocarcinoma de mama em vigência de quimioterapia. Exame físico: FC 118 bpm, SatO₂ 89% em ar ambiente. Iniciada anticoagulação com enoxaparina. Angiotomografia de tórax: negativa para trombos.

A melhor conduta é:

- A suspender anticoagulação e realizar cintilografia de ventilação-perfusão miocárdica.
- B manter anticoagulação e realizar ultrassom doppler de membros inferiores.
- C suspender anticoagulação e realizar ultrassom doppler de membros inferiores.
- D manter anticoagulação e não prosseguir a investigação.

4000170045

Questão 59 **Tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida**

Mulher de 35 anos em seguimento ambulatorial por miocardiopatia periparto com fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) de 32%. Faz uso de dose máxima possível de losartana, carvedilol, espironolactona e furosemida. Apesar disso, a paciente continua com sintomas limitantes (dispneia aos pequenos esforços e edema moderado nas pernas). Exame físico: PA 115/80 mmHg; FC 70 bpm. Exames bioquímicos normais.

Assinale a alternativa que apresenta o melhor esquema terapêutico.

- A Substituir losartana por enalapril.
- B Acrescentar ivabradina.
- C Substituir losartana por valsartana-sacubitril.
- D Acrescentar digoxina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170044](https://www.4000170044.com)

Questão 60 **Cardiologia** **Terapia antitrombótica**

Homem de 65 anos, com IAM sem supra de ST, foi submetido à angioplastia de artéria coronária descendente anterior com *stent* farmacológico com sucesso. AP: HAS, dislipidemia e AVC há 10 meses, sem sequelas neurológicas significativas. A melhor estratégia de tratamento com antiagregante plaquetário é doses de ataque de AAS 200 mg

- A e clopidogrel 300 mg, seguido por AAS 100 mg/dia e clopidogrel 75 mg/dia por 12 meses após o evento agudo.
- B e ticagrelor 180 mg, seguido por AAS 100 mg/dia e ticagrelor 180 mg/dia por 12 meses após o evento agudo.
- C e prasugrel 60 mg, seguido por AAS 100 mg/dia e prasugrel 10 mg/dia por 12 meses após o evento agudo.
- D e prasugrel 60 mg, seguido por AAS 100 mg 1x ao dia e prasugrel 20 mg/dia por 6 meses após o evento agudo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170043](#)

Questão 61 Covid na gestação Obstetrícia

Os riscos da covid-19 em gestantes

- A em geral, não são reduzidos pela vacinação baseada em vacinas de RNA.
- B inclui o desenvolvimento de malformações fetais envolvendo sistema nervoso central entre o maior deles.
- C apresentam-se aumentados para internações, inclusive em Unidades de Terapia Intensiva, quando comparadas a mulheres não gestantes.
- D inclui descolamento precoce de placenta em cerca de 20% das gestantes com a doença, devido à grande carga viral placentária.

4000170042

Questão 62 Papilomavírus humano HPV

Mulher de 58 anos apresenta lesões assintomáticas na vulva há seis meses, conforme a imagem. Antecedente pessoal: HAS e portadora do HIV, com carga viral indetectável e CD4+ 300 células/mm³, em uso regular de TARV e captopril. Refere prática sexual sem preservativo no último ano, porém, sem parceiro fixo.



De acordo com seu diagnóstico, pode-se afirmar que as lesões vulvares

- A podem ser tratadas ambulatorialmente com ácido tricloroacético 90%.
- B são causadas por HPV de alto risco oncogênico.
- C são devido à sífilis maligna precoce no HIV, devendo ser tratadas com penicilina benzatina, 2400000 UI, intramuscular, dose única.
- D são de molusco contagioso em paciente imunossuprimido e devem ser tratadas com curetagem.

Questão 63 Clamídia Ginecologia

Mulher de 30 anos, assintomática, retorna para buscar resultado do exame citopatológico do colo do útero, cujo resultado é “sugestivo de *Chlamydia sp*”. Assinale a alternativa correta.

- A A infecção por clamídia está incluída como um resultado no Sistema de Bethesda.
- B O tratamento pode ser instituído, independentemente dos sintomas.
- C O papanicolaou é capaz de detectar infecção por clamídia somente em pacientes sintomáticas.
- D O diagnóstico de infecção por clamídia depende de teste molecular.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170040

Questão 64 Ginecologia Doença trofoblástica gestacional

Mulher de 22 anos apresenta aumento progressivo do volume abdominal associado à dor em peso no baixo ventre e irregularidade menstrual há 04 meses. AP: G0P0. Exame físico: IMC 28 Kg/m², massa endurecida palpável em baixo ventre 2 cm acima da cicatriz umbilical com mobilidade reduzida. US pélvica: massa expansiva heterogênea solidocística em região anexial direita, com fluxo anárquico ao color doppler e moderada quantidade de líquido livre na cavidade.

A hipótese diagnóstica e os marcadores necessários para avaliação são:

- A tumor maligno de células germinativas; β -hCG e α -feto proteína.
- B tumor maligno epitelial; DHL e CEA.
- C teratoma ovariano maduro; 17- β estradiol e inibina.
- D *Struma ovarii*; TSH e T4 livre.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170039

Questão 65 Câncer de colo do útero

Mulher de 46 anos apresenta sangramento vaginal em grande quantidade há 3 dias. Relata irregularidade menstrual com presença de sangramento intermenstruo recorrente, de moderada quantidade, há 2 anos, além de sinusorragia e secreção vaginal de forte odor de longa data. AP: G5P3A2C2. Exame especular: moderada quantidade de sangramento vaginal, lesão exofítica friável com aproximadamente 2 cm de diâmetro. Toque vaginal: lesão nodular endurecida, confinada a cérvix uterina, útero e anexos de difícil delimitação, fundos de saco vaginais livres. Toque retal: paramétrios livres. Exames laboratoriais: Hb 6,8 g/dL, Ht 27%, ureia 32 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL.

A conduta correta é:

- A citologia oncótica cervical, conização e radioterapia.
- B citologia oncótica cervical, colposcopia e abordagem cirúrgica.
- C colposcopia, biópsia da lesão, radioterapia e quimioterapia.
- D biópsia da lesão, tomografia computadorizada e abordagem cirúrgica.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170038

Questão 66 Ginecologia Tratamento

Em relação à doença inflamatória pélvica (DIP), assinale a alternativa correta.

- ☐ A Pacientes com imagem ultrassonográfica sugestiva de abscesso tubo ovariano podem receber tratamento ambulatorial se estiverem em regular estado geral e mostrarem-se aderentes ao tratamento.
- ☐ B A síndrome de Fitz Hugs Curtis é uma complicação aguda da DIP, com grave envolvimento hepático, alteração de função do órgão e prognóstico sombrio.
- ☐ C O(s) parceiro(s) sexual(ais) deve(m) ser tratado(s), mesmo que assintomático(s), com dose única de ceftriaxona 500 mg por via intramuscular e de azitromicina 1 g por via oral.
- ☐ D Em esquema de tratamento hospitalar, a doxiciclina deve ser usada preferencialmente por via intravenosa, mantendo-se sua prescrição até 72 horas da melhora clínica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170037](https://www.4000170037.com)

Questão 67 Tratamento

Mulher de 35 anos apresenta lesão intraepitelial de alto grau em citologia oncológica de colo uterino (HSIL). Colposcopia: zona de transformação tipo 1 com áreas de epitélio branco espesso e mosaico grosseiro, restritas ao colo, sem sinais de invasão ou doença glandular. A conduta correta é:

- ☐ A repetir a citologia oncológica, direcionando a coleta de amostras das áreas alteradas, sob colposcopia.
- ☐ B propor o “ver e tratar” e realizar exérese da zona de transformação do tipo 1.
- ☐ C solicitar a genotipagem de HPV e agendar retorno breve.
- ☐ D solicitar a revisão da lâmina e propor rastreamento para cervicites.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170036](https://www.4000170036.com)

Questão 68 Deficiência esfinteriana intrínseca Ginecologia

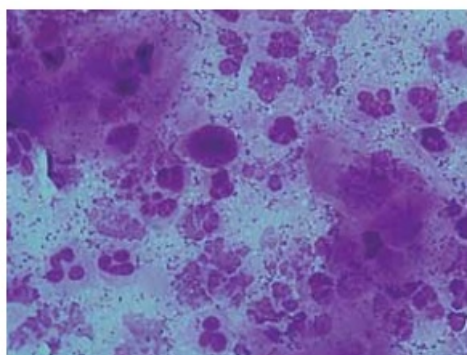
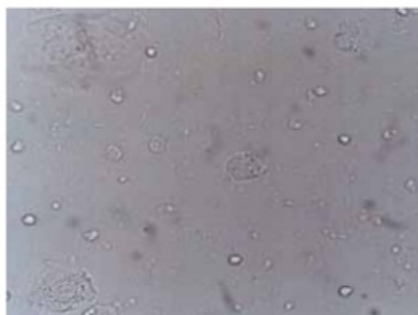
Na incontinência urinária de esforço, a perda de urina aos pequenos esforços sugere:

- ☐ A litíase vesical.
- ☐ B lesão neurológica periférica.
- ☐ C hiperatividade do detrusor
- ☐ D deficiência esfinteriana intrínseca.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170035](https://www.4000170035.com)

Questão 69 Tricomoníase Ginecologia

Mulher de 32 anos apresenta corrimento vaginal e mau odor genital há 6 dias, após relação sexual desprotegida com parceiro eventual. Nega atraso menstrual e refere uso de contraceptivo injetável trimestral há 3 anos. Exames ginecológico e microscópico, conforme as imagens, com teste de aminas positivo e pH 5,8.



A hipótese diagnóstica e a conduta mais adequada são:

- A tricomoniase vaginal; metronidazol 250 mg 2 cps VO 12/12h por 7 dias.
- B vaginite aeróbia; clindamicina creme vaginal a 2% por 14 dias.
- C candidíase vaginal; itraconazol 100 mg 2 cps VO 12/12h por 1 dia.
- D vaginose citolítica; óvulos vaginais de borato de sódio a 2% por 10 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170034](https://www.4000170034.com)

Questão 70 **Ginecologia** **Ciclo menstrual**

Em relação à dinâmica do folículo ovariano no ciclo menstrual, é correto afirmar que

- A as células da teca fazem parte dos folículos primordiais, assim como as células da granulosa.
- B a atresia folicular é interrompida quando a mulher faz uso de contraceptivo hormonal combinado.
- C as principais fases de maturação folicular são recrutamento, seleção e dominância.
- D após a ovulação, o ovócito secundário termina a primeira divisão meiótica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170033](https://www.4000170033.com)

Questão 71 Câncer de mama

Mulher de 44 anos apresentou em mamografia de rastreamento imagem nodular irregular de 1,5 cm na mama esquerda (BIRADS 5). DUM há 15 dias. Biópsia percutânea: carcinoma invasivo sem outras especificações, grau histológico 3 (imuno-histoquímica: receptor de estrogênio 60%, receptor de progesterona 30%, HER2 escore 0, Ki-67 30%). Estadiamento T1N0. Assinale a alternativa correta.

- ☐ A Exames de imagem com achados BIRADS 5 apresentam risco de malignidade entre 50 e 95%.
- ☐ B Para essa paciente, o tratamento adjuvante com tamoxifeno é mais adequado do que inibidores da aromatase.
- ☐ C Por ser um tumor luminal B, a paciente tem indicação do uso de trastuzumabe.
- ☐ D Caso essa paciente seja submetida à cirurgia conservadora, a margem ideal é de 1 cm para que não precise de radioterapia adjuvante.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170032](#)

Questão 72 Ginecologia Síndrome de Rokitansky

Adolescente de 17 anos queixa-se de nunca haver menstruado. Exame físico: estatura 1,69 m, mamas e pelos pubianos em estágio 5 de Marshall e Tanner. Cariótipo: 46 XX. O diagnóstico mais provável é:

- ☐ A agenésia Mülleriana.
- ☐ B síndrome de Morris.
- ☐ C disgenesia gonadal pura XX.
- ☐ D síndrome de Swyer.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170031](#)

Questão 73 Estática fetal

Secundigesta com 39 semanas, em trabalho de parto, está com colo uterino esvaecido e dilatado 10 cm, apresentação cefálica fletida, numa variedade esquerda anterior e no plano + 2 de De Lee. O ponto de referência fetal e o quanto ele deve rodar para que se dê o desprendimento da cabeça são:

- ☐ A bregma; 135° no sentido anti-horário.
- ☐ B bregma; 45° no sentido horário.
- ☐ C occipício; 315° no sentido horário.
- ☐ D occipício; 45° no sentido anti-horário.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170030](#)

Questão 74 Restrição de crescimento fetal RCF Obstetrícia

Primigesta de 19 anos com idade gestacional de 31 semanas apresenta altura uterina abaixo do percentil 10. US: morfologia fetal normal, peso estimado no percentil 3 para a idade gestacional e resistência aumentada ao doppler das artérias umbilicais. O provável diagnóstico é:

- A feto pequeno constitucional.
- B restrição de crescimento fetal tardia.
- C restrição de crescimento fetal precoce.
- D datação incorreta.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170029](#)

Questão 75 **Obstetrícia** **Eclâmpsia**

Primigesta de 34 semanas refere inchaço nas pernas e mãos há uma semana. Hoje apresenta dor de cabeça que não melhora com o uso de analgésico, dor em região epigástrica e visão embaçada. PA 140/90 mmHg, confirmada após 30 minutos. Urina | ausência de proteinúria. A hipótese diagnóstica e a conduta são:

- A crise hipertensiva; hipotensor de ação rápida.
- B pré-eclâmpsia grave; sulfato de magnésio.
- C hipertensão gestacional; hidroclorotiazida.
- D pré-eclâmpsia leve; hipotensor de ação rápida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170028](#)

Questão 76 **Trabalho de parto prematuro TPP** **Obstetrícia**

Secundigesta, na 20ª semana, está em uso de progesterona natural (200 mcg/dia, via vaginal) desde a 16ª semana de gestação. AP: parto prematuro espontâneo com 30 semanas na primeira gestação. US colo uterino de 35 mm. As condutas são:

- A manter a progesterona e fazer ultrassom seriado.
- B suspender a progesterona e realizar cerclagem.
- C manter a progesterona e realizar cerclagem.
- D suspender progesterona e realizar ultrassom seriado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170027](#)

Questão 77 **Sangramento segunda metade da gestação** **Obstetrícia**

Gestante de 27 semanas, com 3 cesáreas anteriores, apresenta sangramento vaginal discreto e indolor. Exame físico: BEG, eupneica, hidratada, PA: 115/75 mmHg, FC materna 80 bpm, AU no percentil 50, ausência de dinâmica uterina em 10 minutos, tônus uterino normal, BCF 146 bpm. Exame especular: discreta quantidade de sangue vermelho vivo coletado em fundo de saco, colo puntiforme, ausência de lesões vaginais e cervicais. A hipótese diagnóstica é:

- A descolamento prematuro de placenta.
- B trabalho de parto prematuro.
- C insuficiência istmocervical.
- D placenta prévia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170026](#)

Questão 78 Medicamentoso Indicação de parto

Tercigesta de 36 anos, com 34 semanas de gestação, tem diagnóstico de diabetes gestacional (GTT 75 g alterado) e está sendo tratada com dieta para diabéticos (1800 Kcal/dia) e caminhada (150 minutos/semana). Exame físico: IMC: 37 kg/m², PA: 130/80 mmHg, altura uterina > percentil 90. Ultrassom obstétrico: peso fetal no percentil 80, índice de líquido amniótico > percentil 90. Controle glicêmico (HGT): jejum (92 mg/dL), 2 horas pós-café (121 mg/dL), 2 horas pós-almoço (144 mg/dL) e 2 horas pós-jantar (132 mg/dL).

As condutas são:

- A manter controle glicêmico com dieta e programar resolução da gestação a partir da 38ª semana.
- B prescrever metformina e programar resolução da gestação a partir da 39ª semana.
- C prescrever insulina e programar resolução da gestação a partir da 37ª semana.
- D prescrever metformina e programar resolução da gestação a partir da 37ª semana.

4000170025

Questão 79 Líquido Amniótico Controle glicêmico Crescimento fetal

Tercigesta de 36 anos, com 34 semanas de gestação, tem diagnóstico de diabetes gestacional (GTT 75 g alterado) e está sendo tratada com dieta para diabéticos (1800 Kcal/dia) e caminhada (150 minutos/semana). Exame físico: IMC: 37 kg/m², PA: 130/80 mmHg, altura uterina > percentil 90. Ultrassom obstétrico: peso fetal no percentil 80, índice de líquido amniótico > percentil 90. Controle glicêmico (HGT): jejum (92 mg/dL), 2 horas pós-café (121 mg/dL), 2 horas pós-almoço (144 mg/dL) e 2 horas pós-jantar (132 mg/dL).

O controle glicêmico, o crescimento fetal e o líquido amniótico estão, respectivamente:

- A adequado; grande para idade gestacional, aumentado.
- B inadequado; adequado para idade gestacional; aumentado.
- C adequado; adequado para idade gestacional, normal.
- D inadequado; grande para idade gestacional, normal.

4000170024

Questão 80 Obstetrícia Infecção puerperal endometrite puerperal

Puérpera de 24 anos, no 6º dia após parto cesáreo, apresenta dois episódios de febre. Exame físico: BEG, T: 38,4 °C, PA: 120/80 mmHg, FC 105 bpm, abdome semigloboso, depressível, útero palpável na cicatriz umbilical, doloroso à mobilização, colo uterino pérvio 3 cm, indolor à mobilização, fundo de saco livre. O diagnóstico e a conduta são:

- A endometrite; clindamicina e gentamicina.
- B parametrite; clindamicina e metronidazol.
- C endometrite; ampicilina e ciprofloxacina.
- D parametrite; ceftriaxona + metronidazol.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170023

Questão 81 Mielomeningocele e defeitos de fechamento posterior do tubo neural **Neurologia**

Recém-nascido de termo é avaliado na sala de parto apresentando deformidade craniana grande, com grande base de implantação fronto-parietal bilateral. Não apresenta outras anormalidades nos demais segmentos corporais. Foi realizada prova de transiluminação apresentada a seguir.



Sobre o prognóstico neurológico dessa criança, pode-se afirmar que

- A é bom, pois a malformação se trata de meningocele, sem herniação de tecido cerebral.
- B é reservado, pois a malformação compromete a drenagem venosa cerebral.
- C depende da presença de outras malformações encefálicas intracranianas.
- D é reservado, pois há chance de 90% de evolução para hidrocefalia.

4000170022

Questão 82 Pediatria **Infecções congênicas**

O vírus mais relacionado com perdas auditivas congênicas é:

- A adenovírus.
- B vírus sincicial respiratório.
- C citomegalovírus.
- D rubéola.

4000170021

Questão 83 **Glaucoma Congênito Primário**

Lactente de 1 mês de idade apresenta lacrimejamento e aparente aversão à luz há cerca de 2 semanas. AP: pré-natal sem intercorrências, gestação a termo, parto normal. Exame físico: fecha os olhos com força, principalmente à tentativa de avaliação dos olhos com uma lanterna, lacrimejamento bilateral, córnea de ambos os olhos com perda de transparência e aspecto azulado. A hipótese diagnóstica é:

- A catarata congênita.
- B conjuntivite gonocócica.
- C toxoplasmose congênita.
- D glaucoma congênito.

4000170020

Questão 84 Dermatologia Antihistamínicos Manifestação Clínica

Adolescente de 17 anos apresenta lesões cutâneas há dois dias, conforme a imagem, que aparecem e desaparecem em um período de 4 a 6 horas, sem outras alterações cutâneas ou sistêmicas. AP: em uso de amoxicilina há 10 dias devido à infecção de orofaringe prescrita para ser mantida por 14 dias.



Contra preços abusivos
na medicina.

O diagnóstico e a conduta são, respectivamente,

- A urticária aguda com angioedema; corticoterapia via oral e manutenção da amoxicilina até completar 14 dias.
- B urticária aguda; anti-histamínico via oral e suspensão da amoxicilina.
- C urticária crônica; anti-histamínico via oral, corticoterapia via oral e manutenção da amoxicilina até completar 14 dias.
- D anafilaxia; adrenalina subcutânea, anti-histamínico via endovenosa, corticoterapia via endovenosa e suspensão da amoxicilina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170019](#)

Questão 85 Tetralogia de Fallot Pediatria

Assinale a alternativa que corresponde a uma cardiopatia congênita cianótica com hipofluxo pulmonar.

- A Defeito do septo atrial.
- B Estenose aórtica valvar.
- C Defeito do septo atrioventricular.
- D Tetralogia de Fallot.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170018](#)

Questão 86 Infectologia Parasitoses

A eosinofilia no sangue periférico está associada às seguintes parasitoses intestinais:

- A *Giardia intestinalis* e *Strongyloides stercoralis*.
- B *Entamoeba histolytica* e *Enterobius vermicularis*.
- C *Entamoeba histolytica* e *Giardia intestinalis*.
- D *Strongyloides stercoralis* e *Enterobius vermicularis*.

4 000170017

Questão 87 Síndrome Inflamatória Multissistêmica

Menino de 8 anos apresenta há 3 dias dor abdominal, em cólica, com piora associada a 2 episódios de diarreia e febre persistente. Hoje, apareceram placas eritematosas em tronco, pescoço e membros, não pruriginosas e evoluiu com queda do estado geral, sonolência e apatia. AP: asmático e teve covid-19 há 1 mês. Exame físico: REG, sonolento, FC 130 bpm, FR 22 irpm, PA 75/40 mmHg, temperatura axilar 38,9 °C; pulsos finos e tempo de enchimento capilar 4 segundos. Hiperemia ocular. Dor difusa no abdome, sem sinais de reação peritoneal. Exames laboratoriais: linfopenia, trombocitopenia e neutrofilia, VHS e PCR aumentados. A hipótese diagnóstica é:

- A dengue.
- B síndrome inflamatória multissistêmica associada à covid-19.
- C síndrome de ativação macrofágica.
- D meningococcemia.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170016](https://www.4000170016.com)

Questão 88 Diagnóstico

Com relação ao diagnóstico de tuberculose em crianças, assinale a alternativa correta.

- A A leitura correta da reação de sensibilidade ao teste da tuberculina é realizada somando-se à enduração ao halo inflamatório.
- B O estado nutricional é um dos critérios utilizados para o diagnóstico de tuberculose pulmonar em crianças e adolescentes com baciloscopia negativa.
- C Em crianças menores de 10 anos, ou que não conseguem escarrar, o lavado gástrico é uma alternativa à baciloscopia e possui elevada sensibilidade (90%).
- D No caso de tuberculose latente, pode-se utilizar, além da prova tuberculínica, o método IGRA (*Interferon Gama Release Assays*). Caso negativo, afasta infecção latente, incluindo crianças menores de 5 anos e imunossuprimidos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170015](https://www.4000170015.com)

Questão 89 Programa Nacional de Imunizações Calendário dos adolescentes ImunizaçõesVacinação

Menino de 12 anos realiza consulta de rotina e está assintomático. AP: suspeita de caxumba aos 11 anos; recebeu últimas vacinas aos 5 anos. Em relação às vacinas, hoje deverá receber

- A HPV e meningocócica ACWY.
- B HPV, meningocócica C e dT.
- C HPV, influenza (disponível neste momento de pandemia covid-19), meningocócica ACWY e dT.
- D HPV, influenza (disponível neste momento de pandemia covid-19) e dT.

4000170014

Questão 90 Medição da pressão arterial

Menina de 6 anos está sentada e tranquila; sua pressão arterial foi aferida por aparelho aneróide com comprimento do manguito de 90% da circunferência do braço cobrindo-o totalmente, o braço direito foi posicionado na altura do coração, com o estetoscópio colocado sob o manguito, insuflado e desinsuflado para a aferição. O valor da pressão arterial obtida pode não ser confiável devido à

- A posição sentada da criança.
- B escolha de manguito grande para a criança.
- C escolha de aparelho inadequado.
- D presença do estetoscópio sob o manguito.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170013](https://www.4000170013.com.br)

Questão 91 Taquicardia Ventricular TV

Lactente de 10 meses apresenta palidez cutânea, taquipneia e taquicardia há 4 horas. Exame físico: FC acima de 150 bpm, afebril, com pulsos finos, perfusão periférica diminuída e tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Eletrocardiograma: FC 160 bpm, ausência de ondas P, complexos QRS com duração aumentada (0,16 seg) e monomórficos, conforme imagem.



O diagnóstico é taquicardia

- A sinusal.
- B atrial não sinusal.
- C juncional.
- D ventricular.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170012](https://www.4000170012.com.br)

Questão 92 Profilaxia Ferro

A dose profilática de ferro elementar para lactente em aleitamento materno exclusivo livre demanda, nascido a termo, com

peso de nascimento de 2100 g, é

- A 1 mg/kg/dia a partir dos 6 meses de vida até os 24 meses de vida.
- B 2 mg/kg/dia a partir dos 3 meses de vida até os 24 meses de vida.
- C 2 mg/kg/dia a partir de 30 dias de vida por 1 ano e 1 mg/kg/dia por mais 1 ano.
- D 2 mg/kg/dia a partir de 3 meses de vida por 1 ano e 1 mg/kg/dia por mais 1 ano.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170011](https://www.4000170011.com)

Questão 93 Abordagem do RGE Fisiológico

Lactente de 4 meses apresenta regurgitações frequentes após as mamadas, além de chorar de 30 a 60 minutos por dia. Está recebendo volume adequado de fórmula láctea. O ganho de peso é adequado e está no percentil 50. A conduta é:

- A solicitar um exame contrastado de esôfago-estômago-duodeno para diagnosticar refluxo gastroesofágico.
- B solicitar exame de pHmetria esofágica de 24 horas para demonstrar doença do refluxo gastroesofágico.
- C recomendar a substituição por fórmula infantil antirregurgitação.
- D prescrever medicação para redução da secreção ácida gástrica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170010](https://www.4000170010.com)

Questão 94 Classificação do controle clínico da asma

Assinale a alternativa que apresenta o quadro clínico de uma criança com asma parcialmente controlada, de acordo com a *Global Initiative for Asthma* (GINA).

- A Tosse seca durante 4 dias na semana, utilizando medicação de resgate 3 vezes na semana, consegue brincar normalmente e dorme a noite toda.
- B Cansaço para correr em todas as brincadeiras, utiliza medicação de resgate para tosse todas as vezes que brinca e tosse noturna.
- C Uso de medicação de controle (beclometasona), brinca normalmente, dorme a noite toda e apresentou uso de medicação de resgate há 4 meses.
- D Uso de medicação de controle, tosse todos os dias, apresenta tosse noturna e faz uso de medicação de resgate a maioria dos dias da semana.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170009](https://www.4000170009.com)

Questão 95 Tratamento

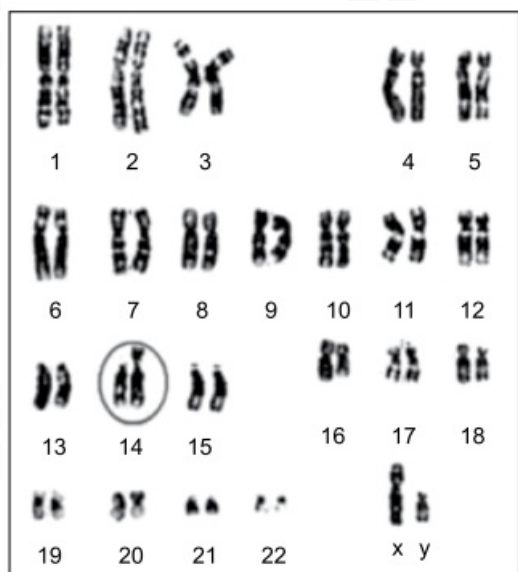
O principal determinante para o sucesso do tratamento de uma criança com anafilaxia é:

- A a identificação antecipada do alérgeno.
- B a ressuscitação fluídica.
- C o uso precoce de adrenalina IM.
- D a prescrição imediata de corticoide e anti-histamínico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170008](https://www.4000170008.com)

Questão 96 Síndrome de Down

Menino de 6 meses com suspeita de síndrome de Down (SD) comparece à consulta com seus pais. Cariótipo: 46,XY t(14,21)(14q;21q), como na imagem.



Para a orientação de seus pais, é importante

- A realizar o cariótipo dos pais, pois trata-se de translocação Robertsoniana, a qual pode haver herança de um dos pais, evidenciando risco de recorrência da SD em outros filhos, maior do que na população em geral.
- B realizar o cariótipo dos pais, pois trata-se de translocação Robertsoniana, sempre decorrente de herança de um dos pais, evidenciando risco de recorrência da SD em outros filhos, de 50% a 100%.
- C esclarecer a eles de que não se trata da trissomia livre do cromossomo 21, mas sim de “mosaicismo”, com expressão da SD mais leve.
- D realizar novo cariótipo da criança, pois este não se configura com nenhuma das situações nas quais pode ocorrer a SD.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170007

Questão 97 Amamentação Aleitamento Materno

Sobre o aleitamento materno, é correto afirmar que

- A as fases do leite materno são duas: o colostro e o leite maduro, sendo que o primeiro contém mais proteínas e menos gorduras do que o leite maduro.
- B o leite materno apresenta composição semelhante para todas as mulheres, porém é individualizado para cada mãe e seu bebê.
- C o leite do Banco de Leite Humano é pasteurizado e está disponível para todos os bebês cujas mães não conseguem amamentar.
- D há a indicação de suspender a amamentação em caso de infecção da mãe pela covid-19.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000170006

Questão 98 Icterícia neonatal Pediatria Hiperbilirrubinemia não fisiológica

RN de termo, com peso adequado para idade gestacional está em alojamento conjunto e em aleitamento

materno exclusivo em livre demanda. Com 10 horas de vida, a mãe se queixa que o RN está mamando pouco e parece “estar com fome”. AP: mãe primigesta, pré natal sem intercorrências. Exame físico: icterícia 3+ em Zona III de Kramer. Exames laboratoriais: tipagem sanguínea materna: O +; tipagem sanguínea do RN: B +; teste de Coombs direto: negativo; bilirrubina indireta: 2,9 mg/dL (sangue do cordão). O diagnóstico mais provável e a conduta correta são:

- A icterícia fisiológica agravada pela baixa oferta de leite materno; iniciar fototerapia e reavaliar após 12 horas.
- B doença hemolítica por provável incompatibilidade sanguínea; iniciar fototerapia e coletar bilirrubinas, hematócrito, hemoglobina e reticulócitos.
- C doença hemolítica por provável incompatibilidade sanguínea; coletar bilirrubinas e preparar exsanguíneo transfusão.
- D hiperbilirrubinemia própria do RN; monitorizar clinicamente até 48 horas de vida.

4000170005

Questão 99 **Passos iniciais** **Recepção do neonato com boa vitalidade** **Hipotermia neonatal**

Na assistência de sala de parto, atualmente há uma preocupação em relação à normotermia dos recém-nascidos. A temperatura desejada tanto para o recém-nascido quanto para o ambiente na sala de parto são, respectivamente,

- A entre 36,5 – 37,5 °C; entre 23 – 26 °C.
- B entre 35,5 – 36,5 °C; entre 26 – 28 °C.
- C entre 36,5 – 37,5 °C; entre 26 – 28 °C.
- D entre 37,5 – 38,5 °C; entre 23 – 26 °C.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170004](https://www.4000170004.com.br)

Questão 100 **Reanimação neonatal em maiores de 34 semanas**

Gestante de 25 anos não realizou pré-natal, idade gestacional de 38 semanas, feto único, bolsa rota de 36 horas. Na sala de parto, após o nascimento, o RN apresentou hipotonia e choro fraco. A conduta é

- A deixar o RN junto à mãe e avaliar a vitalidade periodicamente.
- B estimular o RN e aguardar 1 minuto para clampar o cordão umbilical.
- C clampar o cordão umbilical após 3 minutos e realizar os passos iniciais da reanimação.
- D clampar imediatamente o cordão umbilical e realizar os passos iniciais da reanimação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000170003](https://www.4000170003.com.br)

Respostas:

1	C	2	A	3	B	4	A	5	A	6	C	7	A	8	D	9	B	10	A	11	C
12	A	13	B	14	C	15	A	16	D	17	B	18	D	19	C	20	D	21	D	22	A
23	C	24	C	25	B	26	D	27	D	28	A	29	C	30	B	31	D	32	A	33	B
34	A	35	D	36	A	37	C	38	C	39	B	40	B	41	D	42	B	43	A	44	D
45	D	46	C	47	D	48	B	49	B	50	D	51	C	52	A	53	A	54	C	55	B
56	A	57	C	58	B	59	C	60	B	61	C	62	A	63	B	64	A	65	D	66	C
67	B	68	D	69	A	70	C	71	B	72	A	73	D	74	C	75	B	76	A	77	D
78	C	79	B	80	A	81	C	82	C	83	D	84	B	85	D	86	D	87	B	88	B
89	A	90	D	91	D	92	C	93	C	94	A	95	C	96	A	97	B	98	B	99	A
100	D																				

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.



Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Questão 1 **Sepese Neonatal Tardia**

Recém-nascido com 9 dias de vida apresenta dificuldade para respirar há 1 dia, com piora nas últimas horas, além de não estar mamando bem. Exame físico: regular estado geral, icterícia leve até cicatriz umbilical, hipoatividade, gemência, batimento de aleta nasal, tiragem intercostal e retração diafragmática, FR 80 ipm, FC 170 bpm, temperatura axilar 37,5 °C. A conduta mais adequada é

- A** jejum, iniciar terapia de hidratação venosa, monitorizar, avaliar necessidade de suplementação de oxigênio e solicitar internação hospitalar.
- B** antitérmico, iniciar antibioticoterapia por via oral e orientar a família para observação domiciliar e reavaliação em 48 horas.
- C** antitérmico, leite materno por sonda nasogástrica, iniciar tratamento com ceftriaxona intramuscular e realização de radiografia de tórax.
- D** expansão com soro fisiológico 40 ml/kg em 20 minutos, dosagem de bilirrubinas e realização de radiografia de tórax.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.Essa questão possui comentário do professor no site [4000182998](https://t.me/medicinalivre)**Questão 2** **Ventilação com pressão positiva**

Recém-nascido em sala de parto, após a extração completa do conteúdo da cavidade uterina apresentou hipotonia e choro fraco. AP IG 36 semanas, parto cesárea. Realizado os passos iniciais e avaliadas frequência cardíaca e respiração. Assinale a alternativa correta.

- A** Se FC menor ou igual 100 bpm e respiração irregular, iniciar ventilação com pressão positiva com concentração de oxigênio a 21%.
- B** Se FC menor ou igual 60 bpm, iniciar imediatamente a massagem cardíaca, mantendo relação de 3 massagens para uma ventilação (3:1).
- C** Se respiração irregular e FC maior ou igual 100 bpm, iniciar oxigênio inalatório e, a seguir, oferecer pressão de distensão contínua em vias aéreas (CPAP nasal).
- D** Se houver presença de mecônio no líquido amniótico, realizar imediatamente a aspiração de vias aéreas e de traqueia sob visualização direta.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivreEssa questão possui comentário do professor no site [4000182997](https://t.me/medicinalivre)**Questão 3** **Toxoplasmose congênita**

RN com 39 semanas de idade gestacional, nasceu em boas condições e está em alojamento conjunto e aleitamento exclusivo. AP PN 2450 g, mãe IgG positiva, com índice de avidéz baixo e IgM positiva para toxoplasmose na 20ª semana de gestação, tratada com Espiramicina por 1 mês, sem seguimento de pré-natal após. Exame físico: BEG, icterícia leve na face, mucosas levemente descoradas. Fígado a 3,0 cm do RCD, baço a 2,0 cm do RCE, perímetro cefálico 40 cm, perímetro torácico 35 cm e perímetro abdominal 38 cm. Exames complementares: toxoplasmose IgG reagente 1: 4.096, IgM não reagente, Hb 12 g/dL, Ht 36%, Leucograma normal, BI 4,0 mg/dL; BD1,5 mg/dL. Líquor normal, fundoscopia direta com sinais de coriorretinite, ultrassonografia de crânio com calcificações disseminadas. A conduta para o RN é

- A expectante e, se IgG se mantiver elevada e IgM positiva após 3 meses de seguimento, iniciar o tratamento com espiramicina, sulfadiazina e pirimetamina por 12 meses, suplementação de ácido folínico e corticosteroide.
- B tratamento com espiramicina e suplementação de ácido folínico por 6 meses.
- C tratamento com sulfadiazina e pirimetamina por 12 meses, suplementação de ácido folínico e corticosteroide.
- D tratamento com sulfadiazina e pirimetamina por 6 a 12 meses e suplementação de ácido fólico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182996](#)

Questão 4 Mães diabéticas

Assinale a alternativa em que a condição clínica não está associada ao recém-nascido, filho de mãe diabética.

- A Hipoglicemia.
- B Macrossomia.
- C Restrição do crescimento intrauterino.
- D Hipermagnesemia.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182995](#)

Questão 5 Fatores de risco para hiperbilirrubinemia

São fatores de risco para o desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significativa em RNs ≥ 35 semanas:

- A valor bilirrubina total menor que percentil 75 antes da alta hospitalar.
- B irmão com icterícia neonatal tratado com fototerapia ou ser do sexo masculino.
- C mãe com hipotireoidismo.
- D perda de peso $< 4\%$ em relação ao peso de nascimento.

Proibida Venda.

Acesse [t.me/medicinalivre](#)

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182994](#)

Questão 6 Pediatria Síndrome de Down

Considerando a saúde bucal das crianças com síndrome de Down (SD), é correto afirmar :

- A a amamentação é desaconselhada devido a não ser um bom exercício para o desenvolvimento de estruturas ósseas e musculares da face pela hipotonia do lactente. A posição indicada durante uso de mamadeira, com bico ortodôntico com furo e fluxo adequados é a semisentada.
- B o desenvolvimento dentário e erupção dos dentes decíduos e permanentes ocorrem em idades iguais ao das crianças sem a SD. A sequência da erupção pode estar alterada e o hipertireoidismo é um fator de aceleração na idade da dentição.
- C a primeira avaliação bucal deve ser realizada o mais precoce possível, preferencialmente antes dos três meses de idade, sendo avaliadas as estruturas anatômicas, o vedamento labial e a oclusão dos rebordos gengivais. A saúde bucal pode ser mantida com procedimentos preventivos simples e cuidados em domicílio.
- D a higiene bucal deve ser estimulada desde o nascimento, utilizando-se gaze umedecida com água que também auxilia na dessensibilização da cavidade bucal. Após irromper o primeiro dente, o responsável deve iniciar a escovação e o uso de creme dental sem flúor, em pequena quantidade com bochecho com água e cuspir após.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182993](https://www.4000182993.com)

Questão 7 **Pediatria** **Amamentação Aleitamento Materno**

Sobre o aleitamento materno (AM), é correto afirmar que são

- A sinais de uma pega adequada: boca bem aberta, lábios virados para fora (boca de peixinho), queixo encostado na mama e ver a aréola mais abaixo do que acima da boca do bebê.
- B interferências na absorção de ferro e o zinco do leite materno: oferta de leite de vaca ou outros alimentos antes dos seis meses para as crianças amamentadas exclusivamente ao seio.
- C práticas que podem prejudicar o AM: oferecer mamadeira e chupeta, fumar durante a amamentação, usar medicamentos prescritos pelo obstetra, consumir bebida alcoólica.
- D dificuldades frequentes durante o AM: demora na descida do leite, dificuldade na pega e na sucção do bebê, a pega do bebê em posição de cavalinho(sentada) ou com a mãe deitada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182992](https://www.4000182992.com)

Questão 8 **Tratamento** **Pediatria**

Menina de 8 anos, asmática, durante uma festa de aniversário, comeu doces e salgados, brincou muito na grama, quando passou a sentir tosse, cansaço e fez uso de beta 2 agonista de curta duração sem melhora. No pronto socorro, foram observadas placas e pápulas eritematosas com edema central, de tamanhos variados, em tronco, muito pruriginosas, além da presença de um inseto na pele (imagem).



A conduta inicial é:

- A anti-histamínico via oral e corticoide intravenoso.
- B inalação com fenoterol e anti-histamínico intravenoso.
- C inalação com fenoterol e corticoide via oral.
- D adrenalina (1:10000) 0,3mg via intramuscular.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182991](#)

Questão 9 Aspectos Clínicos Quadro clínico Pediatria

Sobre a bronquiolite viral aguda, assinale a alternativa correta.

- A É comum a ocorrência de diarreia ou vômito.
- B Geralmente é precedida por uma síndrome respiratória viral na semana anterior, apresentando, como desenvolvimento inicial, taquipneia leve, com pouca quantidade de secreção.
- C A oximetria de pulso contínua é indicada em pacientes internados com suportes ventilatórios como cateter, a fim de evitar-se a coleta desnecessária de gasometrias.
- D A taxa de letalidade é de 10%, com morte atribuível à apneia, parada cardiorrespiratória ou crises convulsivas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182990](#)

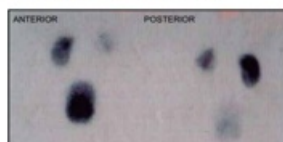
Questão 10 Cirurgia

Menina de 2 anos e 9 meses de idade, atualmente assintomática é trazida para acompanhamento ambulatorial. AP: infecções urinárias de repetição desde os 3 meses de idade, última há 7 meses e está em uso de nitrofurantoina 1mg/kg/dia, diagnóstico de refluxo vesicoureteral grau II bilateral aos 5 meses de idade. Trouxe exames realizados há 1 mês (imagens A e B).

Exame A: Uretrocistografia miccional.



Exame B: Cintilografia renal estática com DMSA (Dimercapto Succinic Acid).



Ativar o Wi-Fi
Aceda a Definições

Assinale a alternativa correta em relação ao risco da evolução para doença renal crônica e conduta, respectivamente.

- A Não há risco; realizar consultas anuais em pediatria geral com aferição da PA, cultura de urina e dosagem da uréia sérica.
- B Não há risco; avaliar história de disfunção vesical, orientar medidas de mudanças no estilo de vida e realizar consultas em Pediatria Geral.
- C Há risco; avaliar história de disfunção vesical, aferir PA e seguimento com especialista com culturas de urina, dosagem creatinina sérica e albuminúria.
- D Há risco; seguimento com especialista e avaliar peso e estatura, aferir PA, cultura de urina, dosagem da uréia sérica e *clearance* de creatinina anual.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182989](#)

Questão 11 Endocrinologia

De acordo com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de investigação e tratamento do hipotireoidismo congênito do Ministério da Saúde publicada em 2021, assinale a alternativa correta.

- A A dosagem de TSH e T4 livre deve ser feita em todos recém-nascidos após 24 horas de vida.
- B Coletas após 72 horas de vida, uso de glicocorticoides pela mãe e transfusão de hemo derivados são as principais causas de resultados falso-positivos.
- C O tratamento deve ser iniciado precocemente (a partir da quarta semana de vida) com o objetivo de evitar as complicações da doença como o retardo mental.
- D Além da coleta em papel-filtro, crianças prematuras extremas ou com muito baixo peso devem ser reavaliadas com 1 mês de vida ou na alta hospitalar.

4000182988

Questão 12 Cirurgia

Menina obesa de 11 anos apresenta dor epigástrica intensa no quadrante superior direito que ocasionalmente irradia para o flanco direito e para as costas, 2 horas após uma grande refeição. Exame físico: anictérica, afebril, dor à palpação do quadrante superior direito do abdome. Exames laboratoriais: alanina aminotransferase 44 U/L; aspartato aminotransferase 25 U/L; bilirrubina total 1,3 mg/dL; fosfatase alcalina 100 U/L; glóbulos brancos 14.500 mm³; amilase 67 U/L; lipase 55 U/L. US abdominal: espessamento da parede da vesícula biliar e sombreamento acústico posterior. O diagnóstico provável é

- A pancreatite aguda.
- B colecistite aguda.
- C coledocolitíase.
- D colangite.

4000182987

Questão 13 Estenose Hipertrófica do Píloro Pediatria

Sobre a estenose hipertrófica do píloro, é correto afirmar que

- A os pacientes apresentam vômitos biliosos.
- B o US abdominal apresenta alta sensibilidade diagnóstica.
- C o tratamento cirúrgico é uma emergência.
- D a correção do distúrbio hídrico-eletrolítico é realizada na fase pós-operatória.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182986](#)

Questão 14 **Pneumologia** **Máscara de Venturi**

Quanto à administração de oxigênio em casos de insuficiência respiratória aguda, assinale a alternativa correta.

- A Na máscara venturi a concentração de oxigênio é definida por adaptadores codificados por cores ou por entrada de ar conectada a cartucho de umidificação.
- B As campânulas de Hood (halo de oxigênio) devem ser utilizadas com fluxo máximo de oxigênio de 5 litros/min.
- C As máscaras simples fornecem altas concentrações de oxigênio quando utilizadas com fluxos acima de 15 litros/min.
- D O cateter nasal de alto fluxo aquecido e umidificado é útil para oferecer ventilação não invasiva com dois níveis de pressão.

4000182985

Questão 15 **Diagnóstico dos linfomas clínico laboratorial citogenética e biologia molecular**

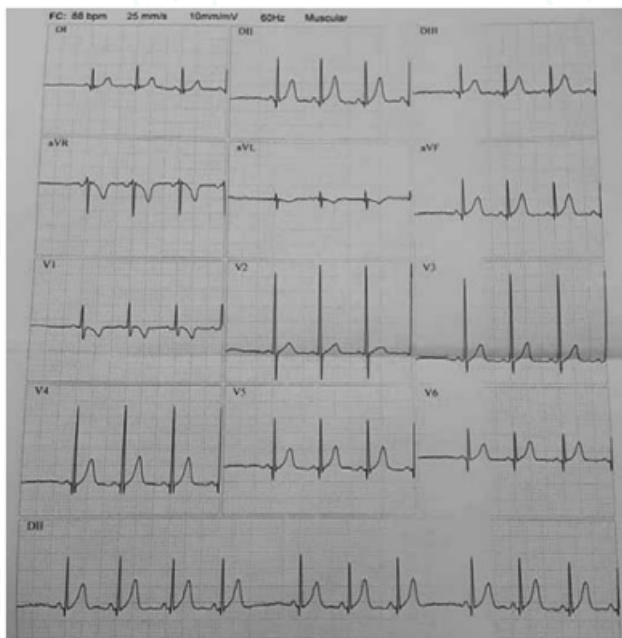
Adolescente de 14 anos, com história de linfonodomegalia há 3 meses, em região de pescoço e de crescimento progressivo, associada a febre e perda de 15% de seu peso. Exame físico: linfonodos palpáveis em região cervical baixa e supraclavicular com cerca de 5 cm de diâmetro, indolor à palpação e endurecido. A conduta adequada é:

- A antibioticoterapia e seguimento clínico.
- B observação clínica e reavaliação em 15 dias.
- C biópsia excisional do linfonodo e estudo histopatológico.
- D hemograma e biópsia de medula óssea.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182984](#)

Questão 16 **Pediatria** **Arritmias**

Menino de 1 ano, assintomático é encaminhado para avaliação cardiológica devido a alteração detectada na ausculta cardíaca. Eletrocardiograma (imagem).



O paciente apresenta:

- A arritmia sinusal.
- B ritmo sinusal alternando com ritmo atrial ectópico.
- C extrassístoles supraventriculares.
- D extrassístoles ventriculares.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

4000182983

Questão 17 Mielomeningocele e defeitos de fechamento posterior do tubo neural

Menina de 8 anos, apresenta dor nos membros inferiores e dificuldade de marcha há 8 meses. Eventualmente, também apresenta escapes urinários. AP: nascida com meningocele e operada no primeiro dia de vida, sem intercorrências, com bom desenvolvimento neuropsicomotor. A hipótese diagnóstica atual é:

- A hidrocefalia.
- B síndrome da medula presa.
- C síndrome de Chiari II.
- D espondilite anquilosante.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182982

Questão 18 Oftalmologia

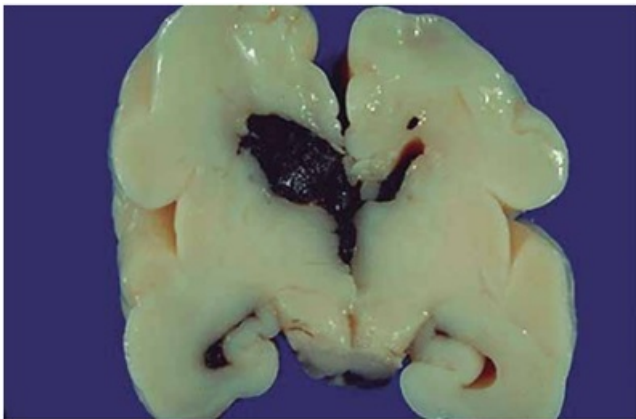
Menino de 8 anos refere que bateu algo no olho esquerdo em um arame e sentiu correr uma “água quente”. Exame ocular: não realizado devido ao blefaro-espasmo à esquerda. A conduta a ser realizada para encaminhar o paciente é:

- A Jejum, colírio e pomada de antibiótico, curativo compressivo e estudo da profilaxia antitetânica.
- B Jejum, curativo oclusivo, repouso e avaliar profilaxia antitetânica.
- C Dieta livre, pois provavelmente trata-se de abrasão corneana superficial.
- D Jejum, colírio de antibiótico de hora em hora sem necessidade de curativo, avaliar profilaxia antitetânica.

4000182981

Questão 19 Hemorragia intracraniana

Recém-nascido, de 28 semanas, apresentou dificuldade respiratória grave e evoluiu para óbito após 6 dias. AP: parto normal, trabalho de parto prematuro. Exame pós-morte: imagem.



O diagnóstico e o mecanismo envolvido no desenvolvimento dessa lesão são, respectivamente:

- A hemorragia intraparenquimatosa; toco traumatismo.
- B hematoma ventricular; coagulação intravascular disseminada.
- C hematoma intraparenquimatoso; sepse.
- D hemorragia de matriz germinativa; fragilidade de vasos subependimários.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182980

Questão 20 Reumatologia

A melhor opção terapêutica para menina de 5 anos com dor em membros, noturna e benigna (dor de crescimento) é

- A analgésicos e anti-inflamatórios.
- B calor local, massagem e analgésicos.
- C calor local, massagem e anti-inflamatórios.
- D massagem, analgésicos e anti-inflamatórios.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182979

Questão 21 Diabetes na gestação DMG Obstetícia

Tercigesta de 36 anos inicia acompanhamento pré-natal com 8 semanas. AP: G3P2C0, macrosomia fetal (4.068g) na

segunda gestação. Exame físico: IMC 30,2 Kg/m². Glicemia de jejum (primeiro trimestre): 88 mg/dL. Nesse momento, o resultado do rastreamento do diabetes mellitus gestacional e a conduta são

- A negativo; GTT 75g entre 24 e 28 semanas.
- B positivo; GTT 100g entre 24 e 28 semanas.
- C positivo; tratamento com dieta e atividade física.
- D negativo; nova glicemia de jejum a partir da 32ª semana.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182978](https://www.4000182978.com.br)

Questão 22 Hemorragias pós parto HPP e rotura uterina Obstetrícia

Puérpera de 28 anos apresenta sangramento uterino em grande quantidade, quarenta minutos pós-parto vaginal sem intercorrências. AP: diabetes gestacional, polidrâmnio e feto GIG. Exame físico: FC 110 bpm, PA 100x60 mmHg, útero com tônus diminuído. O índice de choque, o principal fator de risco para hemorragia pós-parto e o tratamento inicial recomendado são, respectivamente:

- A 1,83; diabetes gestacional; infusão de metilergometrina.
- B 1,1; sobredistensão uterina; infusão de ocitocina + ácido tranexâmico.
- C 1,83; sobredistensão uterina; infusão de ocitocina + misoprostol.
- D 1,1; diabetes gestacional; infusão de ocitocina + ácido tranexâmico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182976](https://www.4000182976.com.br)

Questão 23 Distúrbios hipertensivos na gestação DHEG Obstetrícia

Primigesta na 35ª semana de gestação refere há dois dias dor de cabeça que não melhora com analgésico, há um dia enxerga pontinhos brilhantes e apresenta dor de estômago acompanhada de enjoo. Exame físico: BEG, hidratada, corada, PA 150x110 mmHg e edema de membros inferiores (2/4+). Feto em apresentação cefálica e vivo (FCF 140 bpm). A melhor conduta imediata é

- A fenitoína e metildopa.
- B benzodiazepínico e hidralazina intravenosa.
- C sulfato de magnésio e hidralazina intravenosa.
- D sulfato de magnésio e inibidor de enzima conversora de angiotensina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182973](https://www.4000182973.com.br)

Questão 24 Obstetrícia Imunização na gestação

Durante a assistência pré-natal de baixo risco de gestante com 20 semanas, o resultado do AgHBs (antígeno de superfície do vírus da hepatite B) foi não reagente e em sua carteira de vacinação não há registro de vacina contra hepatite B. A conduta em relação a essa imunização é

- A iniciar esquema de vacinação.
- B orientar vacinação no terceiro trimestre.
- C orientar vacinação no puerpério.
- D contra-indicar vacinação na gestação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182971](https://www.4000182971.com.br)

Questão 25 Obstetrícia Sangramento primeira metade

Secundigesta com 8 semanas de gestação comparece para consulta pré-natal em unidade básica de saúde, referindo há um dia dor tipo cólica em baixo ventre, acompanhada de sangramento vivo em pouca quantidade. A conduta correta é

- A prescrever progesterona micronisada, devido a possibilidade de abortamento inevitável.
- B encaminhar a paciente para uma unidade de atendimento terciário, pois trata-se de abortamento.
- C solicitar ultrassom, pois é a única forma de estabelecer a hipótese diagnóstica nesse momento.
- D realizar exame ginecológico, pois pode ser suficiente para estabelecer a hipótese diagnóstica e orientar a paciente.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182969](https://www.4000182969.com.br)

Questão 26 Descolamento prematuro de placenta DPP Obstetrícia

Gestante de 33 anos com 36 semanas refere dor em baixo ventre há duas horas. AP: G3P1A1. Exame físico: P A 140x100mmHg, FC 96bpm, dinâmica uterina com 5 contrações de 40 segundos em 10 minutos, BCF 164 bpm. Toque vaginal: colo médio, medianizado, dilatado 3cm, bolsa íntegra. Durante a avaliação a paciente apresenta aumento súbito da dor, seguido de sangramento vaginal escuro, em moderada quantidade e dificuldade para ausculta dos batimentos fetais. A hipótese diagnóstica e a conduta são:

- A descolamento prematuro de placenta; rotura imediata da bolsa para reduzir a formação do coágulo retroplacentário e parto cesáreo de emergência.
- B trabalho de parto taquitócico; analgesia de trabalho de parto para reduzir a dinâmica uterina.
- C trabalho de parto taquitócico; rotura da bolsa para reduzir a dinâmica uterina e melhorar o fluxo útero-placentário.
- D placenta prévia sem diagnóstico com sangramento decorrente do exame de toque vaginal; ultrassonografia de urgência para confirmação diagnóstica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182967](https://www.4000182967.com.br)

Questão 27 Toxoplasmose na gestação Obstetrícia

Durante consulta de pré-natal na atenção primária, gestante apresenta os seguintes resultados de sorologia para toxoplasmose:

	11 semanas	30 semanas (atual)
Toxoplasmose - IgG	Não reagente	Reagente
Toxoplasmose - IgM	Não reagente	Reagente

As condutas corretas são:

- A espiromicina; encaminhar para a referência para realizar amniocentese.
- B sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico; encaminhar para a referência para realizar amniocentese.
- C espiromicina; não há necessidade de realizar a amniocentese.
- D sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico; não há necessidade de realizar a amniocentese.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182965](#)

Questão 28 Trabalho de parto prematuro TPP Obstetrícia

Primigesta de 19 anos, com idade gestacional de 32 semanas e 4 dias, apresenta dor em baixo ventre. Exame obstétrico: três contrações a cada 10 minutos, feto longitudinal e cefálico, BCF 148 bpm, colo uterino medianizado, esvaecido 50%, com dilatação de 4 cm e bolsa amniótica íntegra. A conduta correta é prescrever:

- A corticoide, tocolítico, sulfato de magnésio e antibioticoprofilaxia para estreptococo do grupo B.
- B tocolítico, sulfato de magnésio e antibioticoprofilaxia para estreptococo do grupo B.
- C corticoide, tocolítico e antibioticoprofilaxia para estreptococo do grupo B.
- D corticoide, tocolítico e sulfato de magnésio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182962](#)

Questão 29 Obstetrícia Assistência ao parto normal

Parturiente, com idade gestacional de 38 semanas, encontra-se no período expulsivo há 30 minutos, bolsa rota espontânea no início do trabalho de parto. AP: dois partos vaginais. Exame obstétrico: altura uterina 35cm, BCF 155bpm, dinâmica uterina 4 contrações (30"/30"/45"/45"), variedade da posição em occipício esquerda anterior, altura da apresentação +2 do plano De Lee. A conduta é

- A aguardar evolução do parto.
- B administrar ocitocina.
- C indicar cesareana.
- D indicar uso de vácuo extrator.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182961](#)

Questão 30 Restrição de crescimento fetal RCF Obstetrícia

Primigesta na 35ª semana de gravidez, apresenta curva de altura uterina estacionada. Ultrassonografia com Doppler: feto com peso no percentil 8, líquido amniótico normal, índice de pulsabilidade menor que o percentil 95 na artéria umbilical e acima do percentil 5 na artéria cerebral média. O diagnóstico mais provável é

- A restrição de crescimento fetal tardio.
- B restrição de crescimento fetal precoce.
- C pequeno para idade gestacional.
- D crescimento fetal adequado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182960](#)

Questão 31 Câncer de colo do útero

Mulher de 49 anos foi submetida à histerectomia devido a dor no baixo ventre e identificação de massa pélvica. Exame macroscópico da peça cirúrgica: imagem.



As características macroscópicas da imagem favorecem o diagnóstico de:

- ☐ A doença inflamatória pélvica com cicatrizes extensas.
- ☐ B teratoma adulto benigno com áreas de necrose.
- ☐ C cistos de Naboth com infecções recorrentes.
- ☐ D câncer avançado do colo do útero.

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182959](https://www.4000182959.com)
Acesse t.me/medicinalivre

Questão 32 Tratamento

Mulher de 35 anos, sem desejo reprodutivo, apresenta disquesia e dismenorreia incapacitante cíclicas, com controle algíco apropriado em vigência de tratamento medicamentoso. US transvaginal com preparo intestinal: nódulo de 1 cm em ligamento útero-sacro esquerdo acometendo camada serosa da parede do retossigmoide. De acordo com o ECO sistema para abordagem de pacientes com endometriose, é indicado tratamento

- ☐ A cirúrgico em serviço disponível.
- ☐ B clínico em atenção primária.
- ☐ C clínico em serviço de referência.
- ☐ D cirúrgico em serviço de referência.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182957](https://www.4000182957.com)

Questão 33 Ginecologia Estadiamento Tratamento

Mulher de 62 anos apresenta dor hipogástrica associada a sintomas dispépticos há 06 meses. AP: G0P0. US abdome total: grande massa heterogênea de provável origem anexial, apresentando septos e áreas sólidas associadas a fluxo ao Doppler,

com implantes sugestivos de acometimento secundário em andar superior, provável acometimento do fígado e alças intestinais, *omental cake* e volumosa ascite. A melhor conduta é

- A) laparotomia exploradora para estadiamento e ressecção tumoral.
- B) laparoscopia exploradora para estadiamento e biópsia da lesão.
- C) laparotomia para ressecção tumoral seguida de quimioterapia.
- D) radioterapia e quimioterapia exclusivas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182956](https://www.4000182956.com)

Questão 34 **Ginecologia** **Síndrome de Rokitansky**

Paciente de 16 anos e 5 meses, 1,65m, queixa-se de nunca ter menstruado. Exame físico: mamas em estágio 4 e pêlos pubianos em estágio 5 de Marshall e Tanner, cariótipo XX. A síndrome mais provável e os ductos envolvidos nesse defeito são:

- A) Rokitansky; paramesonéfricos.
- B) insensibilidade androgênica; paramesonéfricos.
- C) Ashermann; mesonéfricos.
- D) Swyer; mesonéfricos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182956](https://www.4000182956.com)

Questão 35 **Fisiopatologia**

Mulher de 24 anos, assintomática, tem diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Exame físico: IMC 29,8 Kg/m², PA 120x85 mmHg, circunferência da cintura 89 cm. Os riscos metabólicos e reprodutivos relacionados a doença são:

- A) apneia do sono, hipertensão arterial e incompetência istmo cervical.
- B) apneia do sono, pré-diabetes e pré-eclâmpsia.
- C) dislipidemia, neoplasia de colo de útero e diabetes gestacional.
- D) esteatose hepática não alcoólica, câncer de endométrio e vaginose citolítica durante a gestação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182956](https://www.4000182956.com)

Questão 36 **Quadro clínico**

Mulher de 55 anos notou nodulação em mama direita há 2 meses. Exame físico: nódulo endurecido de difícil delimitação com o tecido adjacente de 3 cm no quadrante superolateral da mama direita. Assinale a alternativa correta.

- A) Deve-se solicitar mamografia e aguardar o resultado para definir a conduta.
- B) Deve-se indicar biópsia do nódulo, de preferência guiada por ultrassonografia.
- C) O exame de ressonância das mamas é o mais indicado.
- D) O exame clínico é característico de cisto mamário.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182956](https://www.4000182956.com)

Questão 37 **Ginecologia** **Ciclo menstrual**

A respeito da fisiologia normal do ciclo menstrual, é correto afirmar que:

- A o hipotálamo secreta o hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) que regula a liberação do hormônio folículo estimulante (FSH), que libera o hormônio luteizante (LH).
- B no início de cada ciclo menstrual os níveis de esteróides gonadais são altos e vêm aumentando desde o final da fase lútea do ciclo anterior.
- C o recrutamento inicial e o crescimento dos folículos primordiais são independentes da gonadotrofinas.
- D o LH estimula a aromatização nas células da teca.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182952](https://www.4000182952.com)

Questão 38 **Complicações** **Ginecologia** **Tratamento**

Em relação ao abscesso tubo-ovariano, é correto afirmar que:

- A o tratamento cirúrgico é mandatório e emergencial para as pacientes sépticas, com abscessos rotos ou naqueles com diâmetros acima de 10 centímetros.
- B o tratamento ambulatorial pode ser considerado nas pacientes com boa compreensão do tratamento e que estejam em bom estado geral, desde que o maior diâmetro do abscesso seja inferior a 5 cm.
- C a ausência de melhora clínica após 48 horas de antibioticoterapia parenteral pode ser manejada com leucograma seriado, PCR e VHS diários, além de curva térmica.
- D o principal agente etiológico envolvido nesses quadros é o *Actinomyces israeli*.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182951](https://www.4000182951.com)

Questão 39 **Ginecologia** **Terapia hormonal**

Mulher de 51 anos queixa-se de diminuição da lubrificação e ardência vaginal no ato sexual há 2 anos. No último ano, sente-se mais triste, sozinha e “esquecida” para atividades do dia a dia. AP: DUM há 1 ano e 6 meses, HAS, tabagista. AF: mãe falecida por câncer de mama. Assinale a alternativa correta. [Acesse t.me/medicinalivre](https://t.me/medicinalivre)

- A Terapia hormonal (TH) sistêmica está indicada para melhora dos sintomas vaginais e sistêmicos.
- B Há contraindicação absoluta ao uso de TH sistêmica.
- C Terapia não hormonal com antidepressivos é a opção mais segura para o alívio dos sintomas climatéricos.
- D TH vaginal está indicada para alívio dos sintomas vaginais.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182950](https://www.4000182950.com)

Questão 40 **Anticoncepção em condições especiais**

Mulher de 15 anos comparece a Unidade Básica de Saúde, pois deseja iniciar um método anticoncepcional. AP: menarca aos 11 anos, sexarca há 1 ano, DUM há 2 dias. Nega comorbidades, tabagismo ou etilismo. Assinale a alternativa correta.

- A Pedir para retornar com um responsável legal, pois a orientação e prescrição de métodos contraceptivos para menores de idade necessita da autorização ou ciência dos pais ou responsáveis.
- B Todos os métodos contraceptivos podem ser usados, cabe ao profissional explicar sobre cada um para que a paciente possa escolher.
- C Devido a idade a melhor alternativa seria o método de barreira, evitando possíveis alterações hormonais sobre a puberdade.
- D O DIU está contraindicado pela idade precoce.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182949](#)

Questão 41 Tratamento da emergência hipertensiva em situações especiais Definição Cardiologia

Com relação às urgências e emergências hipertensivas de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão, assinale a correta.

- A A hipertensão acelerada é a hipertensão diastólica grave (geralmente >120 mmHg) na presença de retinopatia hipertensiva grau III.
- B A hipertensão acelerada com retinopatia hipertensiva grau III é considerada uma urgência hipertensiva, com necessidade da redução da PA em poucos minutos.
- C A urgência hipertensiva se refere às condições clínicas nas quais a hipertensão grave deve ser reduzida em minutos ou poucas horas.
- D São emergências hipertensivas: falência ventricular esquerda aguda, hemorragia intracerebral, crise de feocromocitoma, abuso de drogas e eclampsia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182947](#)

Questão 42 Endocrinologia

Sobre a doença renal do diabetes (DRD) e seu tratamento, assinale a correta.

- A A DRD é um processo multifatorial, que envolve associação entre lesão mecânica, disfunção celular e fibrose. A albuminúria não se correlaciona com o risco cardiovascular, sendo unicamente um marcador fisiopatológico.
- B O tratamento da DRD envolve redução de risco cardiovascular, controle da glicemia e da PA e bloqueio do sistema renina angiotensina-aldosterona (SRAA) com o objetivo de reduzir a pressão intraglomerular.
- C A metformina não pode ser usada se houver alteração de função renal em qualquer grau e os inibidores do SGLT-2 restabelecem o feedback túbulo-glomerular com consequente redução da pressão intraglomerular.
- D O mecanismo de ação das medicações que bloqueiam o SRAA está na vasodilatação da arteríola aferente e vasoconstrição da arteríola eferente, culminando na redução da pressão intraglomerular.

[4000182944](#)

Questão 43 Reumatologia

Mulher de 24 anos apresenta aftas orais indolores, recorrentes há 6 meses. Há 4 meses apresenta artralgia de interfalangeanas proximais da mão direita e punho esquerdo com calor, rubor, aumento de volume, piora ao repouso, melhora ao movimento e rigidez matinal de 1 hora. Há 7 dias as artralgias das mãos e dos punhos desapareceram, mas surgiram no joelho direito e tornozelo esquerdo com as mesmas características. Evoluiu com hematomas nas coxas e sangramentos espontâneos de mucosa nasal e gengival. EF: ausência de artrite ou deformidades. Os exames complementares a solicitar e a provável etiologia são, respectivamente.

- A hemograma, coagulograma, dosagem do fator VIII, provas inflamatórias (PCR e VHS); Hemofilia Primária.
- B látex (fator reumatoide), provas inflamatórias (VHS e PCR), radiografias de mãos; Artrite Reumatoide.
- C FAN, hemograma, urina tipo I, proteinúria 24 h, complementos, anti-SM, anti-dsDNA, anticardiolipinas, anticoagulante lúpico; Lúpus Eritematoso Sistêmico.
- D dosagem de HLA-B27, ressonância magnética de sacroilíacas, provas inflamatórias (PCR e VHS), radiografias de colunas e bacia; Espondiloartrite Axial não Radiográfica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182941](#)

Questão 44 Reumatologia Avaliação dos pacientes com monoartrite Artrite séptica

Mulher de 65 anos, apresentou há 7 dias queda da própria altura com escoriação leve na região anterior de joelho esquerdo. Há 1 dia evoluiu com artralgia intensa, edema, rubor, calor, limitação de movimento e um pico febril (39 °C). Nega episódios prévios de artralgias. AP: diabética, hipertensa, etilista. Exame físico do joelho: rubor, calor, sinal da tecla presente, posição fletida com bloqueio articular. Exames laboratoriais: leucocitose sem desvio escalonado, PCR 30 mg/dL, VHS 60 mm/hora. A hipótese diagnóstica e conduta correta são:

- A Artrite gotosa. A artrocentese diagnóstica não é necessária. Prescrever prednisona em dose baixa, AINE e colchicina por 10 dias. Após a crise, solicitar ácido úrico sérico e urinário e iniciar alopurinol.
- B Artrite séptica. Realizar hemoculturas, artrocentese diagnóstica e análise do líquido sinovial com celularidade, culturas, Gram e cristais. Iniciar antibioticoterapia parenteral de largo espectro e, após confirmação, drenagem articular.
- C Artrite séptica. Realizar artrocentese diagnóstica e na ausência de líquido macroscópico purulento está descartada a hipótese infecciosa. Alta com anti-inflamatórios e analgésicos.
- D Artrite gotosa. Realizar artrocentese diagnóstica e análise do líquido sinovial com celularidade, culturas, Gram e cristais. Cultura do líquido sinovial negativa exclui o diagnóstico infeccioso. Alta com AINE, colchicina e alopurinol.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182937](#)

Questão 45 Complicações da cirrose Tratamento da cirrose Manifestações clínicas

Homem de 62 anos com cirrose hepática por álcool é admitido no hospital pela terceira vez em um mês com ascite tensa. Faz dieta com restrição de sódio. AP: encefalopatia hepática persistente. Uso diário de furosemida 160 mg e espironolactona 400 mg. Exames laboratoriais: Na 135 mEq/L e K 4,2 mEq/L; Na urinário baixo (40 mmol/dia). A conduta inicial é

- A administrar furosemida intravenosa.
- B realizar paracentese de alívio e adicionar amilorida.
- C indicar shunt intra-hepático portossistêmico por via transjugular.
- D realizar paracentese de alívio e se necessário repor albumina intravenosa.

4000182934

Questão 46 Hepatologia Complicações da cirrose Hemorragia Digestiva Alta Varicosa HDA Varicosa

Homem de 50 anos é trazido ao hospital após dois episódios de vômitos com sangue e perda da consciência. Chega sonolento e não colaborativo e tem novo episódio de hematêmese, bem como melena. AP: etilista de mais de 100g de álcool há 30 anos. EF: FC 128 bpm, PA 70/50 mmHg, icterícia, ginecomastia e ascite tensa. Deve-se

- A acionar imediatamente a equipe de endoscopia para Endoscopia Digestiva Alta (EDA).
- B iniciar infusão de cristalóide, pedir EDA urgente e aguardar confirmação de rotura de varizes esofágicas para iniciar vasoconstritor.
- C iniciar infusão de cristalóide, fazer dose de ataque de vasoconstritor e começar antibiótico.
- D passar balão gastroesofágico imediatamente para controle do choque hemorrágico.

4000182932

Questão 47 Pneumologia Asma

Homem 32 anos com histórico de tosse e chiado na infância com necessidade de inalações com broncodilatadores. Em consulta ambulatorial refere sintomas de tosse e chiado que ocorrem 1 a 2 vezes no mês, nega despertar noturno por sintoma, nega limitação de atividades do dia a dia, desde a infância não precisa procurar atendimento médico por crise, ultimamente tem feito treinos de corrida quando apresenta chiado e tosse seca leves. De acordo com as recomendações atuais para tratamento de asma, a melhor orientação terapêutica nesse caso é:

- A Salbutamol spray 2 jatos 30 min antes do exercício e caso tenha sintomas.
- B Formoterol 6 mcg / budesonida 200 mcg spray 1 jato 30 min antes do exercício e caso tenha sintomas.
- C Formoterol 6 mcg / budesonida 200 mcg spray 1 jato de 12/12h diariamente.
- D Não necessita tratamento medicamentoso.

4000182930

Questão 48 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica DPOC Pneumologia

Homem de 61 anos retorna em consulta ambulatorial com queixa de dispneia aos moderados esforços e pouca tosse seca. Relata exacerbação do quadro há 2 meses com necessidade de internação por 1 semana. Atualmente sem suplementação de oxigênio. AP: tabagismo prévio de 30 anos-maço. Em uso regular de formoterol 12 mcg de 12/12h. Espirometria (valores após broncodilatador): VEF1/CVF = 62 e VEF1 = 49%. A melhor conduta é

- A manter monoterapia com formoterol 12 mcg de 12/12h.
- B associar budesonida 400 mcg de 12/12h.
- C associar tiotrópio 2,5 mcg 2 jatos 1 vez ao dia.
- D associar salbutamol spray 2 jatos na crise.

4000182927

Questão 49 Introdução à hemólise

Mulher de 24 anos apresenta cansaço, fraqueza e taquicardia aos mínimos esforços há 2 dias. EF: FC 110 bpm, FR 18 ipm, PA 100/60mmHg, mucosas descoradas, baço palpável sobre o rebordo costal direito, aftas orais. Exames laboratoriais: Hb 5,7 g/dL, Ht 22%, VCM 108 fL, plaquetas 212.000/mm³, GB 4.800/mm³ com diferenciais normais, reticulócitos 5,6%, BT 4,5 mg/dL, BI 3,8 mg/dL, DHL 4 vezes o valor de normalidade, Cr 0,6 mg/dL. O exame que auxiliará no diagnóstico é a(o)

- A teste da antiglobulina direta.
- B imunofenotipagem de sangue periférico.
- C dosagem de vitamina B12.
- D eletroforese de hemoglobina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182923](#)

Questão 50 Demências Neurologia Avaliação Cognitiva

Sobre o diagnóstico das queixas cognitivas em idosos, é correto afirmar que

- A o diagnóstico de demência exige a presença de prejuízo de memória.
- B pacientes com comprometimento cognitivo leve não possuem prejuízo funcional ou social claro como aqueles com demência.
- C o diagnóstico de demência requer um exame de neuroimagem (TC ou RNM).
- D a pesquisa de sorologia para HIV faz parte dos exames de rotina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182920](#)

Questão 51 Neurologia Síndrome da Fragilidade

Em relação aos instrumentos utilizados para o diagnóstico da síndrome de fragilidade, assinale a alternativa correta.

- A O instrumento SOF (*Study of Osteoporotic Fractures*) tem como um de seus itens a avaliação da velocidade de marcha.
- B O instrumento FRAIL incorpora a avaliação da força de preensão palmar.
- C O instrumento FRAIL incorpora a avaliação do índice de massa corporal.
- D O instrumento SOF incorpora a avaliação da força dos membros inferiores através do teste de levantar da cadeira 5 vezes sem usar os braços para apoio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182918](#)

Questão 52 Infectologia Sepses Choque séptico

Mulher de 42 anos iniciou disúria há 4 dias, apresenta febre com dor lombar há um dia e hoje prostração intensa, sendo levada ao PS. EF: regular estado geral, sonolenta (Glasgow 11), PA 75/50 mmHg, FC 135 bpm, SatO₂ 93%, FR 26 ipm, tempo de enchimento capilar de 5 segundos. Sobre a abordagem desse caso na emergência, além da ressuscitação volêmica e noradrenalina, assinale a correta.

- A Deve-se iniciar a dobutamina na dose intermediária, visando o efeito alfa e beta-adrenérgico concomitante.
- B Recomenda-se que a administração de antibiótico empírico deve ser idealmente realizada dentro de 1 hora do reconhecimento clínico.
- C O escore q-SOFA (*quick Sequential Organ Failure Assessment*) é a melhor ferramenta diagnóstica para essa situação devido à sua praticidade e especificidade.
- D Caso disponível, recomenda-se fortemente a dosagem de procalcitonina para decidir quanto ao início de antibiótico.

Questão 53 Endocrinologia

Homem de 65 anos é encontrado caído no chão da sua casa. Segundo o filho, o paciente tinha boa funcionalidade prévia e morava só. AP: HAS há 15 anos e DM há 10 anos, sem acompanhamento regular, em uso de clortalidona 25mg/dia, metformina 1500mg/dia e empagliflozina 25mg/dia. EF: torporoso (escala de coma de Glasgow 9), desidratado 3+/4, PA 98/66 mmHg, FC 128 bpm, FR 26 ipm, SatO₂ 95%, tempo de enchimento capilar 3 segundos. Exames laboratoriais: Hb 16 g/dL, Ht 51%, GB 14.000/mm³, Plaquetas 380.000/mm³, Na 153 mEq/L, K 5,0 mEq/L, glicose 660 mg/dL, Cr 2,5 mg/dL (basal 0,7 mg/dL), Ur 245 mg/dL, PCR 1,4 mg/dL. Gasometria arterial: pH: 7,57; pCO₂ : 36 mmHg; Bic: 32 mEq/L; cloreto: 96 mEq/L, lactato 1,8 mmol/L. Considerando a principal hipótese diagnóstica, o tratamento inicial é

- A antibiótico de amplo espectro.
- B terapia renal substitutiva.
- C cristalóide intravenoso.
- D água livre via enteral.

4000182916

Questão 54 Infectologia

Considerando pacientes elegíveis à profilaxia antimicrobiana contra endocardite infecciosa antes da realização de procedimentos dentários de alto risco, assinale a alternativa que apresenta a droga de escolha.

- A Ciprofloxacino.
- B Claritromicina.
- C Metronidazol.
- D Amoxicilina.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182915
Acesse t.me/medicinavivre**Questão 55** Anticoagulantes Antiplaquetários Cardiologia

Sobre o tratamento antitrombótico preconizado pela diretriz brasileira de síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento de segmento ST, assinale a correta.

- A Nos raros casos de pacientes com hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, para dupla antiagregação, recomenda-se a combinação de clopidogrel com ticagrelor, ou clopidogrel com prasugrel, todos sem dose de ataque.
- B O período de tratamento com enoxaparina em dose plena é por 5 dias. Após esse período, caso o paciente permaneça internado, deve ser reduzida para dose profilática de tromboembolismo venoso.
- C Não há indicação rotineira de se iniciar inibidor do receptor P2Y₁₂ como pré-tratamento em pacientes indicados para estratégia invasiva precoce (< 24h).
- D Caso disponível no serviço, deve-se dar preferência ao fondaparinux como anticoagulante de escolha em pacientes de baixo risco hemorrágico e disfunção renal com clearance de creatinina < 20mL/min.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182914

Questão 56 Tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária Cardiologia

Considere um paciente com diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) por cardiomiopatia dilatada. O paciente está em uso de medicações modificadoras da doença ICFER (bisoprolol, valsartana e espironolactona), em doses máximas com boa tolerância e atualmente encontra-se sem edema e na classe funcional NYHA 1. Realizou um ecocardiograma recente que demonstrou recuperação da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (prévio 32% e atual 52%), com hipocinesia anterior, sem demais alterações marcantes. Não apresenta diabetes ou hipertensão arterial sistêmica. Para esse caso, assinale a conduta correta.

- A Mesmo com a recuperação da função sistólica e ausência de sintomas, recomenda-se a manutenção das medicações em uso.
- B Devem ser reduzidas progressivamente a valsartana e a espironolactona até a suspensão, mas mantido o betabloqueador.
- C A valsartana deve ser substituída por sacubitril/valsartana respeitando o intervalo de *washout* de 36h e mantendo--se as demais drogas.
- D Como houve recuperação da disfunção sistólica, recomenda-se redução pela metade da valsartana e espironolactona, e introdução de inibidor de SGLT-2.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182913](https://www.4000182913.com.br)

Questão 57 Diagnóstico **Neurologia** Doença de Parkinson

Homem de 60 anos apresenta há dois anos tremor no braço direito e dificuldade para fazer os movimentos devido a rigidez, com piora progressiva. Queixa-se de dor no membro superior direito, perda de olfato e constipação intestinal. Acompanhante relatou que ele se movimenta muito e fala durante o sono. EF: leve bradicinesia, tremor de repouso e rigidez do lado direito (mais evidente no membro superior); hipomimia facial e anosmia; marcha com arrasto da perna direita e diminuição do balanço passivo do braço direito, sem instabilidade postural. É correto afirmar.

- A Hipomimia facial, alteração da marcha, dor e hipotensão postural são classificados como sintomas não motores da doença.
- B Os sintomas motores cardinais da doença de Parkinson apresentados pelo paciente são: rigidez unilateral ou assimétrica e bradicinesia.
- C Esse paciente apresenta alguns sintomas não motores da doença de Parkinson, tais como: hipotensão postural, dor, anosmia, transtorno comportamental do sono REM.
- D A constipação intestinal, o transtorno comportamental do sono REM e a anosmia são classificados como sintomas pré-motores da doença de Parkinson.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182913](https://www.4000182913.com.br)

Questão 58 Dermatologia **Herpes orolabial e corporal**

Homem de 39 anos, motorista de táxi, solteiro, refere dor do tipo queimação há 3 dias no glúteo direito com surgimento local de lesões cutâneas há 1 dia. Nega febre, linfadenopatia ou prostração. EF: múltiplas vesículas de conteúdo hialino e base eritematosa agrupadas apenas na região glútea à direita (imagem).



A principal hipótese diagnóstica e o exame para a sua confirmação são, respectivamente:

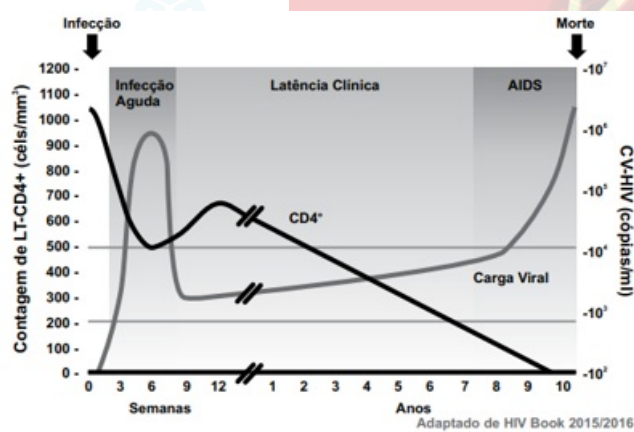
- A herpes simples; citodiagnóstico de Tzanck.
- B varíola do macaco; pesquisa viral pelo PCR da lesão.
- C sífilis primária; pesquisa do treponema em campo escuro.
- D molusco contagioso; exame histopatológico do material curetado.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182911

Questão 59 Infectologia Tratamento História natural da doença

O gráfico a seguir mostra a história natural da infecção pelo HIV:



Acesse t.me/medicinalivre

Fase 1: contágio (infecção); fase 2: infecção aguda; fase 3: latência clínica; fase 4: aids – doença avançada.

O melhor momento para introdução do tratamento antirretroviral é na fase

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

4000182910

Questão 60 **Hanseníase dimorfa** **Hanseníase indeterminada** **Hanseníase virchowiana**

Mulher de 45 anos refere surgimento de mancha hipocrômica na bochecha direita com 4 cm de diâmetro, assintomática, há 6 meses. EF: mácula hipocrômica na face e lesão semelhante na região lombar, na qual esta apresenta redução de pelos. A forma clínica de hanseníase desse caso é a

- A indeterminada.
- B tuberculoide.
- C lepromatosa.
- D dimorfa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182909](https://www.4000182909.com.br)

Questão 61 **Tratamento**

Homem de 19 anos foi submetido a orquiectomia radical direita por via inguinal devido massa testicular direita. No primeiro retorno ambulatorial queixou-se de parestesia em face medial da coxa e bolsa testicular à direita. O nervo provavelmente lesado durante a cirurgia foi o

- A genitofemoral.
- B obturador.
- C femoral.
- D ilioinguinal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182908](https://www.4000182908.com.br)

Questão 62 **Tratamento** **Tratamento Cirúrgico**

Homem de 65 anos relata piora gradual do jato miccional nos últimos meses, acompanhada de hesitação para iniciar micção e necessidade de prensa abdominal para ajudar no esvaziamento vesical. Apresentou três episódios de retenção urinária aguda nos últimos quatro meses. AP: hiperplasia prostática benigna, em uso de doxazosina 2mg por dia. Exame digital retal da próstata: glândula de aproximadamente 50g, simétrica, fibroelástica, indolor e sem nódulos palpáveis. PSA (colhido há dois meses): 1,2ng/mL. A melhor proposta terapêutica é

- A aumentar dose do alfabloqueador para 4mg por dia.
- B ressecção transuretral de próstata.
- C associar medicação inibidora da 5-alfa-redutase.
- D instituir cateterismo intermitente limpo a cada quatro horas.

Questão 63 Lesão da Árvore Traqueobrônquica Pneumotórax Hipertensivo

Homem de 37 anos colidiu seu automóvel contra um muro em alta velocidade. Durante o atendimento inicial foi diagnosticado um pneumotórax hipertensivo à direita, sendo realizada punção de alívio seguida por drenagem torácica. Dreno de tórax: pequeno débito hemático e grande escape aéreo. Após a drenagem torácica, o paciente evoluiu com enfisema de subcutâneo que foi aumentando progressivamente. Rx de tórax realizado no PS após drenagem torácica: imagem.



Dentre as condutas a seguir, a mais adequada nesse momento é a:

- A colocação de segundo dreno torácico.
- B realização de toracotomia exploradora.
- C realocação do primeiro dreno torácico.
- D realização de fisioterapia respiratória.

Contra preços abusivos
na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182906

Questão 64 Derrame Pleural Infectologia Análise do líquido pleural

Mulher de 54 anos encontra-se no 4º dia de tratamento de pneumonia comunitária com antibiótico, mantendo febre, leucocitose e PCR elevada. AP: DM tipo II e ICC. Rx de tórax: imagem. Exames séricos: glicose: 120 mg/dL; DHL: 875 UI/L; proteína: 6,7 g/dL. Exames do líquido pleural de toracocentese diagnóstica: aspecto amarelado; pH: 7,21; glicose: 30 mg/dL; DHL: 1895 UI/L; proteína: 4,2 g/dL e cultura em andamento.



A conduta mais adequada é:

- A aguardar cultura.
- B broncoscopia flexível para coleta de lavado.
- C drenagem torácica à esquerda.
- D decorticação pulmonar.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

4000182905

Questão 65 **Laceração Aórtica**

O achado radiológico mais sugestivo de lesão traumática de aorta é:

- A derrame extrapleural apical.
- B pneumomediastino.
- C pneumotórax à esquerda.
- D hemotórax à direita.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182904

Questão 66 **Anatomia Vascular do Trato Gastrointestinal**

Com relação à anatomia vascular abdominal, é correto afirmar que

- A a veia cava inferior está localizada à esquerda da aorta.
- B a artéria cística normalmente é ramo da artéria hepática comum.
- C os ramos do tronco celíaco são: artéria esplênica, artéria gástrica direita e artéria hepática comum.
- D a veia mesentérica inferior geralmente drena para a veia esplênica.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000182903

Questão 67 Exames de Imagem Exames Diagnósticos Apresentação Clínica

Homem de 76 anos apresenta icterícia progressiva, colúria e acolia fecal há 15 dias, associadas à inapetência e emagrecimento de 6 kg nesse período. Exame físico: ictérico 2+/4+. Hb 13,4 g/dl; Ht 38%; GB 9500/mm³; Plaquetas 220.000/mm³; TGO 121 U/L; TGP 96 U/L; FA 388 U/L; GGT 678 U/L; BT 12 mg/dl (BD = 9 mg/dl). US de abdome: dilatação de vias biliares intra e extra-hepáticas, sem evidência de fator obstrutivo. A melhor conduta a ser tomada é:

- A colecistectomia videolaparoscópica com colangiografia intraoperatória.
- B tomografia de abdome total com contraste.
- C colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.
- D laparoscopia para biópsia hepática.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182902](#)

Questão 68 Reparo laparoscópico

Com relação às patologias herniárias de localização inguino-crural, é correto afirmar que

- A nas mulheres, o tipo mais prevalente são as femorais.
- B as técnicas laparoscópicas necessitam obrigatoriamente do uso de próteses.
- C a técnica de Lichtenstein permite a correção das hérnias inguinais e crurais, com mínimo dano tecidual e sem tensão.
- D nos casos de encarceramento, a abordagem inicial é preferencialmente por laparotomia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182901](#)

Questão 69 Diagnóstico Tratamento

Mulher de 32 anos queixa-se da presença de sangue vivo no papel higiênico após a evacuação, acompanhada por dor anal há 2 semanas. Exame proctológico: botão hemorroidário em parede lateral esquerda, com origem acima da linha pectínea, prolapsado pelo canal anal, não sendo possível redução manual. O diagnóstico da hemorroida e a melhor conduta são:

- A externa trombosada; trombectomia.
- B mista; ligadura elástica.
- C interna grau IV; hemorroidectomia.
- D interna grau III; hemorroidectomia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182900](#)

Questão 70 Comunicação interatrial

Em relação à comunicação interatrial (CIA), é correto afirmar que:

- A o tipo de maior ocorrência é o seio venoso, geralmente associado à drenagem anômala de veias pulmonares.
- B o tipo de maior ocorrência é o ostium primum, relacionado com defeito da formação dos coxins endocárdicos.
- C o tipo ostium secundum leva precocemente à hipertensão arterial pulmonar exigindo correção cirúrgica de urgência.
- D no tipo ostium secundum, a CIA está localizada na lâmina da fossa oval.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182899](https://www.4000182899.com)

Questão 71 Oftalmologia

A manifestação ocular observada na imagem é característica de uma enfermidade osteometabólica com graves repercussões ortopédicas.



Contra preços abusivos
na medicina.

A doença em questão é o(a):

- A raquitismo hipofosfatêmico.
- B síndrome de Morquio.
- C osteogênese imperfeita.
- D osteodistrofia renal.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000182898

Questão 72 Anestésicos Locais Toxicidade Farmacodinâmica

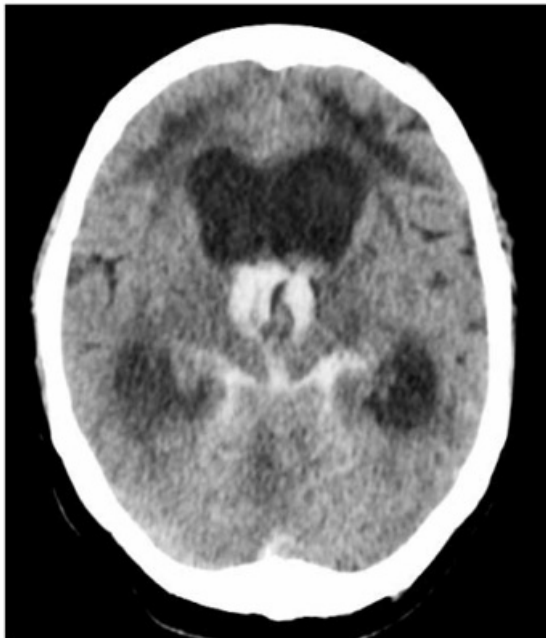
Homem de 70 kg, será submetido a anestesia infiltrativa para exérese de pequeno lipoma em abdome. A dose máxima permitida de lidocaína que pode ser utilizada durante o procedimento é:

- A 17,5 ml de lidocaína 2% sem vasoconstrictor.
- B 30 ml de lidocaína 2% com vasoconstrictor.
- C 21 ml de lidocaína 1% sem vasoconstrictor.
- D 17,5 ml de lidocaína 2% com vasoconstrictor.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182899](https://www.4000182899.com)

Questão 73 Hemorragia Subaracnoidea HSA Neurologia Quadro Clínico

Mulher de 70 anos, apresentou quadro súbito de cefaleia, vômitos e rebaixamento do nível de consciência há 4 horas. AP: tabagismo e hipertensão arterial descontrolada. Exame físico: mau estado geral, Glasgow 7, PA 170x100 mmHg, FC 80 bpm, FR 18 irpm. Realizada tomografia de crânio (a seguir).



A conduta é:

- A craniectomia descompressiva.
- B terceiroventriculostomia endoscópica.
- C derivação ventricular externa.
- D manitol em bolus.

Contra preços abusivos
na medicina.

Medicina Livre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182896](https://www.facebook.com/medicinalivre)

Questão 74 Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono

Sobre a apneia obstrutiva do sono, é correto afirmar que:

- A são fatores de risco: sexo feminino, obesidade e idade acima de 40 anos.
- B a prevalência estimada no Brasil é de 8-10 %.
- C é considerada fator de risco independente para HAS, DM e síndrome metabólica.
- D o tratamento com CPAP normaliza HAS noturna.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182896](https://www.facebook.com/medicinalivre)

Questão 75 Aneurismas Rotos

Mulher de 74 anos, apresentou síncope após queixar-se de dor abdominal súbita em pontada, com irradiação dorsal. Exame físico: pressão arterial inaudível, perfusão periférica lentificada, massa pulsátil no mesogastro facilmente palpável e abdome doloroso à palpação. A hipótese diagnóstica e a conduta são respectivamente:

- A aneurisma de aorta roto; laparotomia exploradora.
- B aneurisma de aorta com dor; angiotomografia e planejamento de abordagem endovascular.
- C aneurisma de aorta roto; confirmação diagnóstica com angiotomografia e posterior laparotomia.
- D aneurisma de aorta com dor; exames laboratoriais (função hepática, DHL, PCR), Rx abdome, ultrassonografia abdominal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182894](#)

Questão 76 Reumatologia Arterite de Takayasu

Mulher de 34 anos, refere dor e formigamento no membro superior esquerdo há cerca de 2 anos, principalmente ao esforço intenso. Não há limitação a atividades habituais ou surgimento de lesões espontâneas. AP: nega tabagismo e hipertensão. Exame físico: pulsos radial e ulnar palpáveis em membro superior direito, não palpáveis no esquerdo; dor e m antebráço esquerdo à elevação dos membros e manobras repetidas de preensão palmar; perfusão lentificada em MSE em relação ao MSD; pulsos femorais, poplíteos, tibiais anteriores e posteriores palpáveis bilateralmente; ausência de edema em extremidades. A provável hipótese e a conduta são, respectivamente:

- A Doença de Kawasaki; iniciar corticóide em altas doses e indicar internação hospitalar para realizar coronariografia.
- B Tromboangite obliterante sem necrose; anticoagulação.
- C Arterite de Takayasu; realizar desobstrução a fogarty.
- D Arterite de Takayasu; tratamento medicamentoso e acompanhamento periódico.

4000182893

Questão 77 Anticoagulação

Mulher de 68 anos, refere edema que se iniciou em membro inferior direito há 2 dias. Exame físico: dor à palpação e empastamento de panturrilha direita, 4cm de diferença na circunferência em relação à esquerda. Assinale a alternativa correta.

- A O tratamento anticoagulante lisa o trombo e permite evitar síndrome pós-trombótica.
- B O tratamento antiagregante é preferível à anticoagulação por evitar a progressão do trombo e consequente embolia.
- C A varfarina é usada como ponte para estabilização do coágulo até o início de ação dos anticoagulantes de ação direta.
- D A heparina é usada como anticoagulante até que a varfarina atinja seu nível terapêutico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182892](#)

Questão 78 Parafimose

Menino de 6 anos apresenta dor e edema no pênis há 4 horas, após mãe realizar “massagem para tratamento de fimose” (sic). Exame físico: imagens.



Fonte: Clifford et al. (2016)

O diagnóstico é:

- A fimose secundária.
- B parafimose.
- C balanopostite.
- D hipospádia glandar.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182891](https://www.4000182891.com.br)

Questão 79

Tratamento

Diagnóstico

Menino de 7 meses apresenta ausência de testículo direito na bolsa escrotal desde o nascimento. Exame físico: testículo esquerdo tópico, hemiescroto direito vazio e testículo direito palpável na região do canal inguinal direito. A conduta é:

- A realizar orquidopexia direita em caráter eletivo, o mais breve possível.
- B realizar ultrassonografia.
- C expectante até os 2 anos de idade.
- D expectante até os 4 anos de idade.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182890](https://www.4000182890.com.br)

Questão 80

Dermatologia

Tratamento

Mulher de 43 anos, trabalhadora rural, apresenta lesão na face, que iniciou como uma descamação há cerca de 1 ano, que desde então vem crescendo e não dá sinais de cicatrizar. Relata que a lesão apresenta sangramentos ocasionais. Exame físico: pele, olhos e cabelos claros. Presença de lesão na região zigomática esquerda, de 1,7 cm de diâmetro, com bordas elevadas, ulceração central, coberta com crostas sobre secreção purulenta. A conduta correta é:

- A antibioticoterapia sistêmica e retorno em 30 dias caso não haja melhora do quadro.
- B biópsia excisional com margens.
- C tratamento tópico com 5-fluorouracil por 3 meses e retorno para reavaliação.
- D limpeza com água e sabonete 3x ao dia, pomada antibiótica e retorno caso não haja melhora do quadro.

Questão 81 Medicina Preventiva

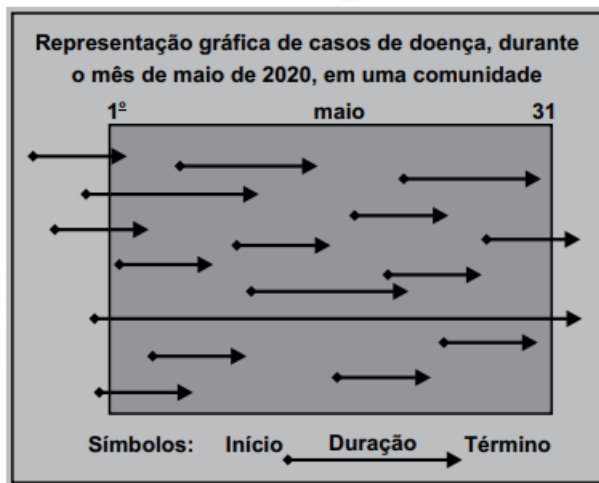
O coeficiente de fecundidade de uma população é calculado pela seguinte fórmula:

- A $\frac{\text{Nascidos vivos em determinada área e período}}{\text{Mulheres de 15 a 49 anos da mesma área, no meio do período}} \times 1000$
- B $\frac{\text{Nascidos vivos em determinada área e período}}{\text{População da mesma área, no meio período}} \times 1000$
- C $\frac{\text{Total de nascimentos em determinada área e período}}{\text{População de mulheres da mesma área, no meio período}} \times 1000$
- D $\frac{\text{Número de mulheres com um ou mais filhos}}{\text{Mulheres de 12 anos ou mais da mesma área, no meio do período}} \times 100$

4000182888

Questão 82 Medicina Preventiva

A figura abaixo representa a ocorrência de casos de uma determinada doença em uma comunidade.



Contra preços abusivos
na medicina.

Com base nessas informações, os coeficientes de incidência e prevalência dessa doença, durante o mês de maio de 2020, na referida comunidade, foram, respectivamente, de

- A 10 e 14.
- B 11 e 16.
- C 11 e 14.
- D 16 e 10.

4000182887

Questão 83 Medicina Preventiva

Nos termos do Código de Ética Médica, o médico poderá revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão

- A quando o paciente tenha falecido.
- B quando o fato seja de conhecimento público.
- C quando der seu depoimento como testemunha.
- D por dever legal.

4000182886

Questão 84 Medicina Preventiva

Dentre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), mencionado no Artigo 7º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990), está incluído o seguinte:

- A financiamento com recursos da seguridade social, complementados pelos estados e municípios, dentro de suas possibilidades orçamentárias.
- B atenção secundária como núcleo ordenador das redes regionais de serviços de saúde.
- C centralização normativa (DIR - Diretoria Regional) e descentralização executiva (secretarias municipais) das ações de saúde.
- D descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

4000182885

Questão 85 Medicina Preventiva

Nos termos da Lei nº 8142, de 28/12/1990, os conselhos de saúde, em caráter permanente e deliberativo, deverão ter suas decisões homologadas pelo

- A chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
- B dirigente de saúde (ministro, secretário ou diretor, quando for o caso).
- C poder legislativo em cada esfera de governo.
- D Ministério Público.

4000182884

Questão 86 Medicina Preventiva

Com relação ao texto a seguir, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

“O Decreto nº 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, estabelece em seu artigo 2º o seguinte: Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a _____ da assistência à saúde”.

- A equidade
- B integralidade
- C universalidade
- D regionalização

Questão 87 Medicina Preventiva

A organização da Atenção Básica à Saúde (Portaria nº 2436/2017, do Ministério da Saúde) inclui a oferta de cuidado, “reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade”. Esta orientação está associada ao seguinte princípio do SUS:

- A equidade.
- B integralidade.
- C universalidade.
- D controle social.

4000182882

Questão 88 Medicina Preventiva

Num estudo publicado no *Lancet Regional Health Americas* demonstrou-se que municípios que apoiaram o atual presidente nas eleições de 2018 foram os que apresentaram as piores taxas de mortalidade por covid-19, principalmente na segunda onda epidêmica de 2021, mesmo quando consideradas as desigualdades estruturais entre as cidades. Nesse estudo, o desfecho foi a taxa de mortalidade por covid-19 padronizada por idade, e o apoio ao candidato presidencial foi representado pelo percentual de eleitores de cada município que votaram nesse candidato.

O desenho de estudo dessa pesquisa foi

- A coorte retrospectiva.
- B transversal.
- C ecológico.
- D descritivo.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000182881

Questão 89 Medicina Preventiva

O objetivo da randomização dos participantes em um ensaio clínico randomizado, duplo cego e placebo controlado é controle do

- A viés de memória.
- B efeito placebo.
- C viés de atrito.
- D confundimento.

4000182880

Questão 90 Medicina Preventiva

Para saber se o consumo habitual da dieta mediterrânea está associada a um menor risco de acidente vascular cerebral (AVC), um grupo de 23.232 indivíduos foi selecionado. O grau de adesão à referida dieta foi verificado e os

indivíduos foram seguidos por 17 anos para identificar casos novos de AVC. Trata-se de

- A estudo transversal, pois a adesão à dieta mediterrânea é avaliada em um momento específico no tempo (no início do seguimento).
- B ensaio clínico, porque pode orientar a prevenção na prática clínica.
- C estudo de coorte, pois segue os sujeitos classificados de acordo com sua exposição para identificar o desenvolvimento de uma determinada doença.
- D estudo ecológico, porque segue um grupo de sujeitos.

4000182879

Questão 91 Medicina Preventiva

Um ensaio clínico de fase IV tem como objetivo

- A estabelecer segurança, tolerabilidade e farmacocinética do produto.
- B detectar novas reações adversas e confirmar a frequência das já conhecidas.
- C determinar a relação risco/benefício a curto e longo prazo e o valor terapêutico do produto.
- D estabelecer segurança, dose-resposta e eficácia do produto.

4000182878

Questão 92 Medicina Preventiva

Entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2020 ocorreram 180 acidentes fatais no trânsito em um determinado município. A medida de frequência de acidentes utilizada foi

- A letalidade.
- B prevalência pontual.
- C prevalência no período.
- D incidência.

4000182877

Questão 93 Medicina Preventiva

Os casos de covid-19 que acometeram trabalhadores da saúde na vigência da pandemia envolvem

- A aumento de risco associado a longas jornadas de trabalho, privação de sono e problemas no acesso a proteções individuais evoluindo com risco de *burnout* e covid longa.
- B contaminações acontecidas, predominantemente, em interações que não envolviam pacientes justificando que não sejam reconhecidas como relacionadas ao trabalho.
- C procedimentos geradores de aerossóis em UTI acometendo a equipe de cuidados mesmo em situação de uso de EPI como máscara N95 e equivalentes.
- D contaminações em contexto de transmissão comunitária em situações similares as dos casos que acometeram outras populações trabalhadoras de atividades emergenciais.

Questão 94 Medicina Preventiva

Antes da COP26 (26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), a carta aberta “Prescrição de Clima Saudável” foi assinada por mais de dois terços dos profissionais da saúde em todo o mundo. Sobre os danos à saúde causados pelas mudanças climáticas, assinale a alternativa correta.

- ☐ A Eventos climáticos extremos (ondas de calor, tempestades e inundações) devem ser responsabilidade dos gestores municipais e não dos serviços de saúde.
- ☐ B Transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão não pioraram com as mudanças climáticas, esses foram somente agravados pela pandemia do covid-19.
- ☐ C A poluição do ar está levando a muitas doenças pulmonares e cardíacas, mas ainda não tem sido responsável por mortes prematuras.
- ☐ D Os sistemas alimentares são cada vez mais perturbados pelo clima extremo que está exacerbando a insegurança alimentar, a fome e a desnutrição.

4000182875

Questão 95 Medicina Preventiva

Homem de 58 anos, deu entrada em uma UPA, em estado grave (choque hemorrágico) e história de vômitos sanguinolentos. A família informou que o mesmo tinha “pressão alta, diabetes e era alcoolista”, que teve episódio semelhante há dois meses e na ocasião foi informado que tinha “varizes no estômago e cirrose”. Cerca de 20 minutos depois, o paciente veio a falecer a despeito dos tratamentos instituídos pelo médico plantonista.

Assinale a alternativa correta:

- ☐ A O preenchimento correto da Declaração de Óbito deve ser:

PARTE I

a) Choque hipovolêmico por ruptura de varizes gástricas

b) Cirrose Hepática

c) Hipertensão Arterial

d) -----

PARTE II

Alcoolismo crônico

B O preenchimento correto da Declaração de Óbito deve ser:

PARTE I

a) Rotura de varizes gástricas

b) Cirrose Hepática

c) -----

d) -----

PARTE II

Alcoolismo crônico

Hipertensão Arterial

C O preenchimento correto da Declaração de Óbito deve ser:

PARTE I

a) Choque hipovolêmico

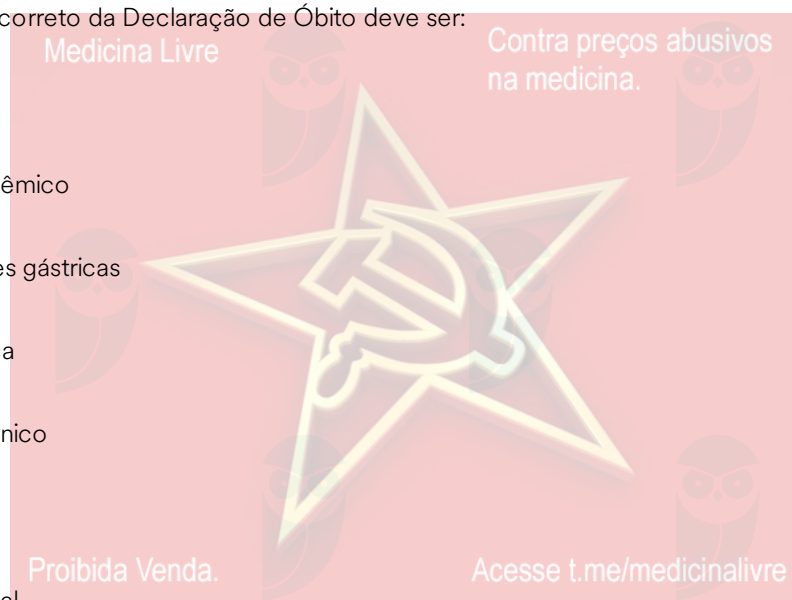
b) Rotura de varizes gástricas

c) Cirrose Hepática

d) Alcoolismo Crônico

PARTE II

Hipertensão Arterial

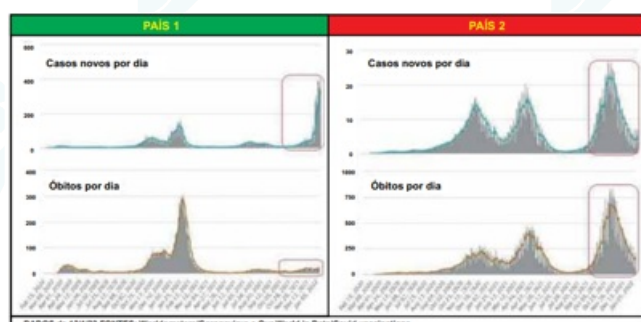


D Como o paciente permaneceu menos de 24 horas na UPA, a Declaração de Óbito deverá ser emitida pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbito).

4000182874

Questão 96 Medicina Preventiva

A figura a seguir apresenta a evolução (número de casos e óbitos) da covid-19 em dois países, desde o início da pandemia até 12 de janeiro de 2022, na vigência da variante Ômicron.



Com relação à vacinação contra a covid-19 nos dois países e baseados nestes perfis de ocorrência de casos e óbitos, é possível inferir que

- A as coberturas vacinais dos países 1 e 2 são, respectivamente, alta e baixa.
- B as coberturas vacinais dos países 1 e 2 são, respectivamente, baixa e alta.
- C nos países 1 e 2 foram aplicadas, respectivamente, vacinas de RNA mensageiro e vacinas de vírus inativado.
- D não há elementos suficientes para se inferir a cobertura vacinal e tipo de vacina utilizada.

4000182873

Questão 97 Infectologia

Homem de 50 anos, hipertenso, foi encontrado em óbito em sua residência. Na autópsia foram identificadas lesões brancacentas no parênquima pulmonar (imagem) e em linfonodo hilar. O processo patológico que é classicamente descrito na doença causadora das lesões pulmonares é a necrose



- A coagulativa.
- B liquefativa.
- C caseosa.
- D gangrenosa.

4000182872

Questão 98 Dermatologia Manifestações clínicas

Homem de 35 anos, morador de área rural, refere lesão intranasal com saída discreta de secreção hemática, pouco dolorosa, há 4 meses. AP: lesão ulcerada na região do queixo de 1,5 cm de diâmetro há três anos, com cicatrização espontânea após alguns meses. Exame físico: ulceração no septo nasal anterior. A principal hipótese diagnóstica é

- A carcinoma espinocelular.
- B tuberculose.
- C cromomicose.
- D leishmaniose tegumentar americana.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000182871](#)

Questão 99 COVID 19 Infectologia

Sobre as vacinas contra a covid-19, assinale a alternativa correta.

- A A vacina da Janssen® em dose única é tão imunogênica e eficaz quanto aquela produzida pela Pfizer® (de duas doses).
- B A efetividade da vacina AztraZeneca® se mantém estável por nove a doze meses após segunda aplicação.
- C Esquemas de reforço com vacina diferente da originalmente utilizada são recomendados especialmente para aqueles que receberam Coronavac.
- D Entre todas as variantes do SARS-Cov-2, a gama é a mais efetivamente prevenida por vacinas de vírus quiméricos.

4000182870

Questão 100 Pneumologia

Com relação aos dispositivos eletrônicos para fumar – DEFs (cigarros eletrônicos) é verdadeiro afirmar que

- A a venda no Brasil é permitida e regulada pela RDC 46/2009 da ANVISA.
- B pessoas que nunca fumaram que usam DEFs tem probabilidade três vezes maior de iniciar o fumo de cigarros convencionais.
- C o aerossol liberado pelos cigarros eletrônicos é constituído apenas por vapor de água e nicotina, são considerados seguros e não causam dependência.
- D a maioria dos usuários dos DEFs no Brasil são fumantes de cigarros convencionais, com idade maior que 40 anos.

4000182869

Respostas:

1	A	2	A	3	C	4	D	5	B	6	C	7	B	8	D	9	B	10	C	11	D
12	B	13	B	14	A	15	C	16	A	17	B	18	B	19	D	20	B	21	A	22	B
23	C	24	A	25	D	26	A	27	D	28	C	29	A	30	C	31	D	32	C	33	B
34	A	35	B	36	B	37	C	38	A	39	D	40	B	41	D	42	B	43	C	44	B
45	D	46	C	47	B	48	C	49	A	50	B	51	D	52	B	53	C	54	D	55	C
56	A	57	D	58	A	59	A	60	A	61	D	62	B	63	A	64	C	65	A	66	D
67	B	68	B	69	C	70	D	71	C	72	A	73	C	74	C	75	A	76	D	77	D
78	B	79	A	80	B	81	A	82	B	83	D	84	D	85	A	86	B	87	A	88	C
89	D	90	C	91	B	92	D	93	A	94	D	95	C	96	A	97	C	98	D	99	C
100	B																				

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.



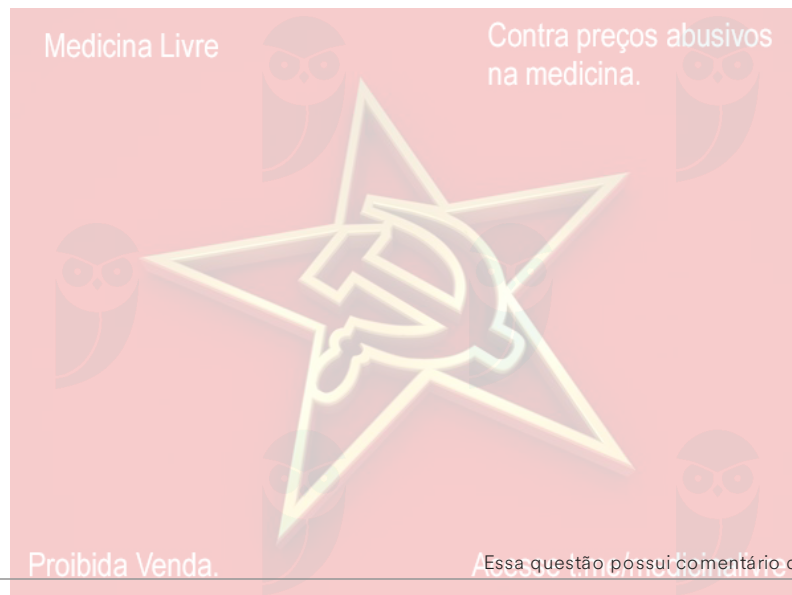
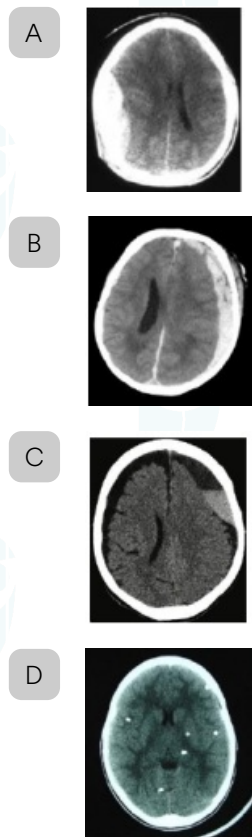
Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Questão 1 Quadro Clínico e Indicações de Tomografia de Crânio

Mulher, 34a, vítima de atropelamento, com perda da consciência, chega a Unidade de Emergência. Exame físico: PA= 118x69 mmHg, FC= 87bpm, FR= 16 irpm, Oximetria de pulso (ar ambiente)= 99%, Escala de Coma *Glasgow* (ECG)= 15. Enquanto aguardava exames apresentou redução de 4 pontos na ECG e anisocoria.

O ACHADO TOMOGRÁFICO ESPERADO É:

**Questão 2** Atributos gerais da Atenção Primária à Saúde APS

A Atenção Primária em Saúde (APS) representa o primeiro nível de atenção, é uma estratégia de organização dos sistemas de saúde e também um modelo de mudança da prática clínico-assistencial dos profissionais de saúde.

SÃO ATRIBUTOS ESSENCIAIS DA APS:

- A Orientação familiar e comunitária e competência cultural.
- B Participação social e equidade.
- C Clínica ampliada e compartilhada.
- D Integralidade e coordenação.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000130445

Questão 3 Declaração de óbito DO Atestado de óbito

Você é chamado para constatar o óbito de um vizinho de 92 anos de idade. Trata se de pessoa conhecida acompanhada

no Centro de Saúde por hipertensão arterial crônica, obesidade e diabetes mellitus.

NESTA SITUAÇÃO, VOCÊ:

- A Pode receber honorários pela constatação do óbito, mas não pela emissão da Declaração de Óbito.
- B Pode receber honorários pela constatação do óbito e pela emissão da Declaração de Óbito.
- C Não pode receber honorários pela constatação do óbito, mas pode receber pela emissão da Declaração de Óbito;
- D Não pode receber honorários pela constatação do óbito, nem pela emissão da Declaração de Óbito.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130423](#)

Questão 4 **Política Nacional de Atenção Básica PNAB**

A unidade de saúde da família é definida como unidade ambulatorial pública de saúde destinada a realizar assistência contínua nas especialidades básicas, por intermédio de equipe multiprofissional.

A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ORGANIZA-SE DA SEGUINTE FORMA:

- A Adscrição de população e territorialização.
- B Equipe composta por generalista, pediatra, ginecologista, enfermeiro e agente comunitário de saúde.
- C Cada equipe responsabiliza-se por até 4.500 famílias.
- D Programação e planejamento centralizados.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130421](#)

Questão 5 **Incidência e Prevalência**

O relatório de exames periódicos de uma indústria têxtil com 1000 funcionários registrou 150 indivíduos com hipertensão arterial, em 2016. Após 12 meses o relatório foi atualizado com 170 casos. Não houve demissões, aposentadorias, falecimentos e admissões no período.

A PROPORÇÃO DE INCIDÊNCIA DA DOENÇA EM 2017 É:

- A 5,1%.
- B 2%.
- C 17%.
- D 13%.

4000130419

Questão 6 **Ética Médica** **Direitos humanos**

A atenção à violência sexual contra a mulher requer uma abordagem intersetorial, multiprofissional e interdisciplinar, com interface nas questões de direitos humanos, de segurança pública e de justiça. EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS, É CORRETO AFIRMAR QUE:

- A** A assistência à saúde da pessoa que sofre violência sexual é prioritária e a recusa infundada e injustificada de atendimento pode ser caracterizada como imprudência.
- B** A apresentação de documentos policiais, a gravidade da circunstância e os riscos da violência sexual exigem o rigoroso cumprimento da atenção integral em saúde.
- C** Os dados sobre a violência sofrida e suas circunstâncias, bem como os achados do exame físico e as medidas instituídas, devem ser registrados em prontuário detalhadamente.
- D** No atendimento imediato após a violência sexual caberia a alegação do médico de objeção de consciência, na medida que se trata de um direito assegurado no Código de Ética Médica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130417](#)

Questão 7 Doenças relacionadas ao trabalho Medicina Preventiva
Pneumoconiose devida à Poeira de Sílica Silicose

A importância da anamnese ocupacional é identificar situações e/ou fatores de risco e/ou agentes que possam provocar doenças relacionadas ao trabalho.

A ALTERNATIVA QUE CARACTERIZA ESTA ASSOCIAÇÃO É:

- A** Radiação de infravermelho e ceratoconjuntivite.
- B** Inseticidas organofosforados e dermatite alérgica.
- C** Fumos de chumbo e hidrarginismo.
- D** Poeira de sílica cristalina e câncer de pulmão.

4000130416

Questão 8 Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

Homem, 30a, assalariado com carteira de trabalho. Procura atendimento médico em Unidade Básica de Saúde por dor no ombro direito há um ano, com piora há seis meses.

História ocupacional: operador industrial há 20 anos, seu trabalho consiste em retirar 1200 peças (de 2 a 8 Kg) por turno, de um carrinho abaixo da cintura e colocá-las em uma máquina brunidora acima dos ombros. Exame físico: arco doloroso de Simmonds positivo a 90°; teste de Jobe positivo à direita.

PARA A ABERTURA DE CAT VOCÊ DEVE:

- A** Encaminhar para o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador.
- B** Encaminhar ao INSS.
- C** Emitir relatório médico para a empresa.
- D** Solicitar ultrassonografia de ombro direito.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130414](#)

Questão 9 Diagnóstico Dermatite de contato alérgica Dermatite de contato por irritante primário

Mulher, 32 a, técnica de enfermagem há três anos. Refere o aparecimento de lesões nas mãos há 4 meses, que melhoram com uso de pomada de corticoide. Retornaram há dois meses após as férias. Exame físico: Pele: lesões eritemo-

descamativas em região dorsal das mãos e regiões interdigitais bilaterais.

O DIAGNÓSTICO E O EXAME A SER SOLICITADO SÃO:

- A Dermatite por sensibilização; teste de puntura.
- B Dermatite irritativa; teste de puntura.
- C Dermatite por sensibilização; teste epicutâneo.
- D Dermatite irritativa; teste epicutâneo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130412](https://www.4000130412.com)

Questão 10 Ensino e pesquisa médica

Segundo um levantamento cerca de 30% de todos os formandos em Medicina relatam ter passado por humilhação pública durante a formação. Esta experiência impacta negativamente na qualidade do aprendizado e, consequentemente, pode resultar em danos aos pacientes e prejuízos à qualidade assistencial.

É CORRETO AFIRMAR QUE:

- A Há uma cultura disseminada de que sofrer assédio seria algo necessário para que um indivíduo se torne médico, inerente à socialização secundária e, portanto, há poucos meios efetivos de evitá-lo.
- B A posição hierárquica de subordinação ao assediador, o consequente medo de represálias pode representar uma importante barreira para se denunciar o episódio, minimizadas com recursos institucionais.
- C Apesar de inúmeras tentativas institucionais de coibir comportamentos antiprofissionais que envolvam assédio na formação, a questão do anonimato é impossível de ser garantida, o que inibe as denúncias.
- D As atitudes do abusado em relação ao abusador constituem os mecanismos principais de enfrentamento de situações de assédio, esperando um momento adequado para conversar individualmente com o superior.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130410](https://www.4000130410.com)

Questão 11 Vigilância Sanitária

A Equipe de Saúde da Família percebe que várias pacientes do bairro procuram atendimento com sintomas e sinais sugestivos de onicomicose. As pacientes frequentam o mesmo salão de manicure.

A INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO É ATRIBUIÇÃO DA VIGILÂNCIA:

- A Epidemiológica.
- B Sanitária.
- C Ambiental.
- D Do Trabalho.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130408](https://www.4000130408.com)

Questão 12 Projeto Terapêutico Singular

Equipe de Saúde da Família recebe solicitação da escola do bairro para que providencie consulta com psicólogo para menina de 9 anos de idade que apresenta dificuldade de aprendizagem. A equipe conhece a família da criança. Pai está recluso, mãe trabalha como doméstica e irmão de 16 anos abandonou o colégio.

A EQUIPE DEVE:

- A Elaborar um Projeto Terapêutico Singular.
- B Encaminhar a criança ao psicólogo.
- C Encaminhar o caso ao Conselho Tutelar.
- D Denunciar a mãe por negligência.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000130406

Questão 13 Vacina contra raiva

Menino, 8a, manipulou morcego que encontrou morto na escola. Foi constatado que o morcego era de espécie frugívora.

A CONDUTA EM RELAÇÃO AO RISCO DE RAIVA É:

- A Expectante e descartar morcego.
- B Iniciar vacinação e descartar morcego.
- C Iniciar sorovacinação e encaminhar morcego para análise.
- D Expectante e encaminhar morcego para análise.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000130404

Questão 14 Mortalidade Infantil e Perinatal Indicadores especiais de mortalidade

Em uma região com população de 1.000.000 habitantes, registraram-se 12.000 óbitos na população total e 10.000 nascidos vivos no ano. Entre os óbitos, 80 crianças morreram antes de completar 28 dias e 20 com idade de 28 dias a 1 ano.

SOBRE INDICADORES NA REGIÃO PODE- SE AFIRMAR QUE:

- A A mortalidade proporcional de menores de 1 ano na região é maior que 12%.
- B O coeficiente de mortalidade infantil tardia é de 20%.
- C O coeficiente de mortalidade geral é de 120 por 1000 habitantes.
- D A mortalidade infantil é de 10 por 1000 nascidos vivos.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000130402

Questão 15 Curva ROC

Na bula de um teste de imunoensaio de terceira geração (A) foi apresentada a curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*), em comparação com a de outro teste diagnóstico (B).

PARA AFIRMAR A SUPERIORIDADE DO TESTE “A” EM RELAÇÃO AO “B” É PRECISO OBSERVAR QUE:

- A A área sob a curva do teste (A) é maior que a do teste (B).
- B O teste (A) apresenta ponto de corte com maior sensibilidade, independente da taxa de falsos positivos comparado com o teste.
- C Não é possível avaliar os testes sem conhecer a prevalência da doença na população.
- D O teste (A) deve apresentar maior simetria entre especificidade e sensibilidade que o teste (B).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130400](#)

Questão 16 Transição Demográfica

Nas últimas décadas, o aumento da proporção de idosos em relação à população jovem no Brasil caracteriza a chamada transição demográfica.

ESSE CENÁRIO É EXPLICADO POR:

- A Estagnação das taxas de mortalidade e fecundidade.
- B Quedas nas taxas de mortalidade e fecundidade.
- C Queda na taxa de mortalidade e estagnação da taxa de fecundidade.
- D Estagnação na taxa de mortalidade e queda da taxa de fecundidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130397](#)

Questão 17 Tipos de Estudos Epidemiológicos

Prontuários de dois grupos de recém-nascidos (RN) de gestantes de baixo risco foram acessados para acompanhar a ocorrência de taquipneia transitória e hipertensão pulmonar persistente do RN, durante as quatro primeiras semanas de vida. Os grupos foram divididos conforme a via de parto: vaginal e cesárea eletiva.

O DELINEAMENTO UTILIZADO FOI:

- A Inquérito sobre a gravidade de problemas respiratórios no RN.
- B Ensaio clínico para avaliar prognóstico do RN nas primeiras semanas de vida.
- C Estudo ecológico sobre o diagnóstico de problemas respiratórios precoces no RN.
- D Estudo de coorte para comparar riscos de quadros respiratórios precoces em RN.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130394](#)

Questão 18 Diagnóstico de distocias no partograma Parada secundária da dilatação Distocia de dilatação

Mulher. 25a, G2P1C0A0, com idade gestacional de 39 semanas procura o pronto atendimento com queixa de contrações. Exame obstétrico à admissão: altura uterina de 39cm, batimentos cardíacos fetais= 144bpm e dinâmica uterina: 3 contrações de moderada intensidade e duração média de 45 segundos em 10 minutos. A evolução do trabalho de parto está representada no partograma:

zona de transformação do colo do útero aos 28 anos. Anatomopatológico: lesão intraepitelial de alto grau/neoplasia intraepitelial cervical grau 3 com margem endocervical livre e ectocervical positiva. Recebeu alta após três anos de seguimento, sem evidências de recidiva.

A CONDUTA É:

- ☐ A Encaminhar para colposcopia.
- ☐ B Encaminhar para histerectomia.
- ☐ C Encaminhar para nova exérese de zona de transformação.
- ☐ D Repetir citologia em seis meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130386](#)

Questão 21 **Critérios diagnósticos da pré-eclâmpsia** **Conduta obstétrica** **Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade**

Adolescente, 15a, G1POCOA0, comparece à consulta pré-natal, com idade gestacional 35 semanas, queixa-se de dor em hipocôndrio direito, náuseas e ganho de 1 kg em 1 semana. Exame físico: PA= 130x90 mmHg, Exame ginecológico: altura uterina de 32 cm, batimentos cardíacos fetais= 130 bpm.

A CONDUTA É:

- ☐ A Internação para cesárea de emergência.
- ☐ B Internação, exames e avaliação de vitalidade fetal.
- ☐ C Retorno em 7 dias com exames e avaliação vitalidade fetal.
- ☐ D Orientar dieta, repouso, controle de pressão e retorno em pré-natal em 7 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130385](#)

Questão 22 **Tratamento**

Adolescente, 18a, G1P1, vem ao pronto socorro referindo corrimento vaginal e dor em baixo ventre há 2 dias. Antecedentes pessoais: método anticoncepcional: DIU de cobre há 1 ano, Data última Menstruação: 7 dias. Exame físico: bom estado geral, PA=120x80 mmHg, FC=72 bpm; abdome: plano, flácido, doloroso à palpação superficial em baixo ventre, sem descompressão brusca dolorosa; exame especular: presença de secreção endocervical em moderada quantidade, com hiperemia leve do colo uterino, cauda do DIU 2 cm. Toque vaginal: útero anteversofletido de tamanho normal, com dor à mobilização do colo e à palpação anexial.

A CONDUTA É:

- ☐ A Ceftriaxona 500 mg IM dose única, doxiciclina 200 mg/dia e metronidazol 1 g/dia, ambos por 14 dias.
- ☐ B Retirar DIU e reavaliar em 7 dias.
- ☐ C Ciprofloxacina 500 mg e azitromicina 1 grama dose única.
- ☐ D Retirar o DIU e azitromicina 1 grama dose única.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130382](#)

Questão 23 **Fatores de risco**

Mulher, 63a, G2P2C0A0, menopausa há 9 anos. Retorna com o resultado de biópsia aspirativa por cânula de Pipelle: hiperplasia endometrial complexa com atipia.

É CORRETO AFIRMAR QUE:

- A É lesão precursora de câncer de endométrio do tipo II.
- B Está associada a hiperestrogenismo e obesidade na pós-menopausa.
- C A taxa de progressão para câncer de endométrio é de 90%.
- D Está associada a tabagismo e multiparidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130379](https://www.4000130379.com.br)

Questão 24 Microbiologia e patogênese

Puérpera, 42a, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de febre, que começou há dois dias, dor em baixo ventre e o sangramento vaginal, que estava quase parando, aumentou muito, com odor fétido e muitos coágulos. Antecedente pessoal: oitavo dia de puerpério, parto cesárea, após 18 horas de trabalho de parto, com bolsa rota por 10 horas. Exame físico: FC= 110 bpm, T= 38°C, PA= 110x70 mmHg; toque vaginal: colo 1 polpa folgada de dilatação, útero globoso, aumentado para 14 semanas; mamas: lactantes, sem alterações.

A ETIOLOGIA É:

- A Streptococcus do grupo A.
- B Staphylococcus aureus.
- C Clostridium perfringens.
- D Infecção polimicrobiana.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130377](https://www.4000130377.com.br)

Questão 25 Diagnóstico

Mulher, 20a, procura atendimento com queixa de feridas dolorosas em vulva e dor para urinar há 2 dias. Exame ginecológico: pequenas vesículas, aproximadamente 3 mm, com base eritematosa, dolorosas ao toque, em grandes lábios.

O DIAGNÓSTICO É:

- A Herpes genital.
- B Sífilis primária.
- C Cancro de Ducrey.
- D Linfgranuloma venéreo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130375](https://www.4000130375.com.br)

Questão 26 Morte fetal óbito fetal OF Etiologia e fisiopatologia Indicações

Mulher, 42a, G3P2C2A0, idade gestacional 35 semanas comparece ao Pronto Socorro com queixa de redução de movimentos fetais. Refere múltiplos episódios de hipoglicemia embora mantenha padrão alimentar e a mesma dose de insulina. Antecedentes pessoais: diabetes e hipertensão gestacionais em uso de insulina NPH 30 unidades ao dia e metildopa

750mg/dia. Exame físico: PA= 110x80 mmHg. Fita urinária: proteína: negativa.

ESSA INTERCORRÊNCIA PODE SER EXPLICADA POR:

- A Desenvolvimento fisiológico da gestação.
- B Pré-eclampsia sobreposta.
- C Insuficiência placentária.
- D Malformação fetal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130373](#)

Questão 27 Coagulopatias

Adolescente, 12a, refere menstruações com ciclos regulares com fluxo aumentado, desde a menarca há 1 ano. Antecedentes Pessoais: nega procedimentos cirúrgicos.

A CONDUTA É:

- A Investigar malformações Mullerianas.
- B Investigar presença de endometriose.
- C Orientar que é normal nessa fase da vida.
- D Investigar Doença de Von Willebrand.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130371](#)

Questão 28 Clínico

Mulher, 28a, G2P0A1 refere corrimento vaginal em borra de café, leves dores na fossa ilíaca esquerda e atraso menstrual. Exame físico: abdome: doloroso à palpação do baixo ventre; toque vaginal: colo embebido e fechado e útero de difícil delimitação. Ultrassonografia transvaginal: útero vazio, ausência de líquido livre na pelve e presença de tumoração anexial esquerda, de ecogenicidade heterogênea, medindo 3,0 cm de diâmetro, sugestivo de prenhez ectópica. Beta hCG urinário: positivo.

A CONDUTA É:

- A Metotrexato intramuscular seguido de laparotomia exploradora e preservação da trompa.
- B Laparotomia exploradora com salpingectomia e metotrexato intramuscular.
- C Metotrexato intramuscular e seguimento do Beta hCG sérico.
- D Conduta expectante e seguimento do Beta hCG sérico.

4000130369

Questão 29 Tratamento não hormonal dos sintomas climatéricos

Mulher, 54a, G2P2C2A0, em amenorreia há 8 meses queixando-se de fogacho, dormindo mal, não consegue se concentrar nas atividades diárias e tem ressecamento vaginal. Antecedentes Pessoais: asma em uso de corticosteroide via oral e trombose venosa profunda em uso de varfarina.

A CONDUTA É:

- A Terapia hormonal combinada.
- B Isoflavona.
- C Inibidor de recaptação de serotonina.
- D Tibolona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130367](#)

Questão 30 Trabalho de parto prematuro TPP Acima de 34 semanas
Intercorrências obstétricas obstetrícia patológica

Mulher, 28a, G1P0A0, com idade gestacional de 34 semanas e 5 dias, chega à Maternidade com queixa de dor em baixo ventre em cólica há 6 horas com piora progressiva, saída de secreção mucosa da vagina e boa movimentação fetal. Antecedente Gestacional: diabetes gestacional controlada com dieta. Exame físico: FC= 90 bpm, FR=18 irpm, T= 36,5°C; exame ginecológico: altura uterina de 32 cm, 2 contrações de 40 segundos em 10 minutos, Batimentos Cardíofetais= 140 bpm; Toque vaginal: colo uterino 100% esvaecido, 4 cm de dilatação, apresentação cefálica, bolsa íntegra.

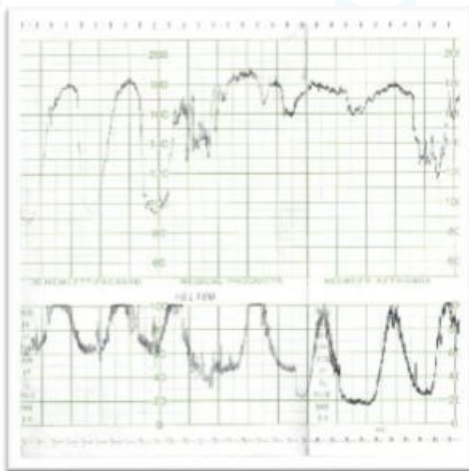
ALÉM DA INTERNAÇÃO E TRIAGEM INFECCIOSA, A CONDUTA É:

- A Corticoide para maturação pulmonar fetal e inibição do trabalho de parto por 48 horas.
- B Sulfato de magnésio para neuro proteção fetal e inibição do trabalho de parto por 48 horas.
- C Antibioticoprofilaxia para estreptococo do grupo B e inibição do trabalho de parto por 48 horas.
- D Antibioticoprofilaxia para estreptococo do grupo B e assistência ao trabalho de parto

4000130366

Questão 31 Primeiro periodo dilatação Métodos de avaliação da vitalidade fetal
Avaliação da vitalidade fetal intraparto

Mulher, 25a, G2P1C0A0, idade gestacional de 41 semanas. Trabalho de parto induzido com ocitocina, queixando-se de muita dor. Toque vaginal: colo com 8 cm de dilatação, cefálico, plano -1 de De Lee, bolsa rota espontânea líquido claro com grumos grossos. Cardiotocografia:



A CONDUTA NO MOMENTO É:

- A Suspende ocitocina, analgesia e monitorização contínua dos batimentos cardíacos fetais.
- B Hidratação e cesárea de urgência sob raqui-anestesia.
- C Manter ocitocina e parto fórceps Simpson com bloqueio pudendo bilateral.
- D Aumentar ocitocina, analgesia e monitorização intermitente dos batimentos cardíacos fetais.

4000130363

Questão 32 Diagnóstico Câncer de ovário

EM RELAÇÃO AO USO DO EXAME CA125 NO CÂNCER DE OVÁRIO, É CORRETA A AFIRMAÇÃO:

- A Apresenta alta sensibilidade e pode ser utilizado para rastreamento.
- B Apresenta alta especificidade e pode ser utilizado para o diagnóstico inicial
- C Apresenta baixa especificidade e pode estar elevado na miomatose e endometriose D)
- D Apresenta baixa frequência de falso positivo e pode ser utilizado para planejamento cirúrgico.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000130360

Questão 33 Cistos mamários

Mulher, 52a, G3C3A0, comparece no Centro de Saúde por nódulo indolor em mama esquerda, há três meses. Refere irregularidade menstrual, e fogachos. Mamografia: BIRADS® 0. Ultrassonografia mamária: lesão cística em mama esquerda, com conteúdo predominantemente anecoico, sem debris ou áreas sólidas, com reforço acústico posterior, BIRADS® 2. Exame físico: mama esquerda com discreto abaulamento da pele na junção dos quadrantes superiores à inspeção estática; à palpação, identificada nodulação única, bem delimitada e móvel, aproximadamente 25 mm de diâmetro. Mama direita normal. Expressão das árvores ductais negativas bilateralmente. Axilas e fossas supraclaviculares bilateralmente livres.

A CONDUTA É:

- A Excisão cirúrgica.
- B Acompanhamento ginecológico de rotina anual.
- C Estadiamento para câncer de mama.
- D Punção aspirativa com agulha fina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000130358

Questão 34 Tratamento

Menino, 11a, hígido, com febre baixa e adenomegalia cervical não dolorosa. Foram colhidas sorologias com orientação para voltar em 30 dias. Retorna sem sintomas. Sorologia para toxoplasmose: IgM e IgG reagentes.

A CONDUTA É:

- A Realizar controles de hemograma e imunoglobulinas semestralmente.
- B Não há necessidade de tratamento medicamentoso.
- C Repetir o exame devido reações cruzadas.
- D Prescrever a associação pirimetamina e sulfadiazina.

4000130354

Questão 35 Hepatites na gestação

Gestante com 39 semanas de gestação, apresenta sorologia para hepatite B com HBsAg reagente e HBeAg reagente.

A CONDUTA É:

- A Parto cesárea e administração de imunoglobulina humana anti-hepatite B ao neonato ainda na sala de parto ou dentro das primeiras 12 a 24 horas.
- B Contra-indicação da amamentação e administração de imunoglobulina humana anti hepatite B ao neonato ainda na sala de parto ou dentro das primeiras 12 a 24 horas.
- C Administração ao neonato de imunoglobulina humana anti-hepatite B na sala de parto ou dentro das primeiras 24 horas e a vacina hepatite B na sala de parto ou nas primeiras 12 horas após o nascimento.
- D Realizar no neonato banho em água corrente ainda na sala de parto, imediatamente após o nascimento e administração da imunoglobulina humana anti-hepatite B e a vacina Hepatite B dentro das primeiras 24 horas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130353](https://www.4000130353.com.br)

Questão 36 Bronquiólite Pediatria

Menino, 3m, é internado na Emergência com diagnóstico de bronquiólite viral aguda. *Exame físico: FR= 68 rpm, FC= 168 bpm, oximetria (ar ambiente)= 90%, choroso, reativo, com retração subcostal, Pulmões: murmúrio vesicular simétrico, com sibilos difusos.*

A OFERTA DE OXIGÊNIO DEVE SER ESTABELECIDADA POR:

- A Cateter nasal simples.
- B Oxitenda.
- C Máscara não reinalante.
- D Cânula nasal de alto fluxo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130350](https://www.4000130350.com.br)

Questão 37 Pediatria Traumatismo Cranioencefálico na Criança

Menino, 9 meses, sofreu queda do colo do pai (cerca de 1m de altura) há cerca de 1 hora, com trauma na região parietal da cabeça. Teve 2 episódios de vômito. Exame físico: choroso, consolável, Glasgow 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes; crânio: deformidade compatível com fratura e afundamento.

A INDICAÇÃO DE REALIZAR TOMOGRAFIA DE CRÂNIO É DEVIDO A:

- A Altura da queda maior de 90 cm.
- B Presença de vômitos.
- C Idade da criança.
- D Presença da deformidade de crânio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130349](#)

Questão 38 Emergências Pediátricas Parada Cardiorrespiratória PCR e Arritmias na Emergência **Pediatria**

Menina, 5a, chega ao Pronto Socorro em parada cardiorrespiratória (PCR) em assistolia. Ao final de um ciclo de reanimação cardiopulmonar (RCP), checa-se o ritmo, sendo identificado ritmo sinusal. Exame físico: FC= 50 bpm; pulso periférico: fino e tempo de enchimento capilar = 5 segundos.

A CONDUTA É:

- A Manter RCP de alta qualidade por mais um ciclo de 2 minutos.
- B Administrar atropina.
- C Administrar epinefrina (1:1000).
- D Suspender a RCP e observar a monitorização, com ênfase na ventilação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130348](#)

Questão 39 Diagnóstico

Menino, 4a, é trazido a consulta por estar com queixa de dor abdominal há 4 dias. Hábito urinário: urina mais escurecida. Hábito intestinal: sem evacuar há 3 dias. Exame físico: Pressão Arterial acima do limite superior para idade, estatura e sexo; Abdome: massa palpável em flanco esquerdo.

O DIAGNÓSTICO É:

- A Neuroblastoma.
- B Fecaloma.
- C Cisto renal.
- D Tumor de Wilms.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130346](#)

Questão 40 Reanimação neonatal **Pediatria** Reanimação neonatal em maiores de 34 semanas

Durante recepção de um recém-nascido a termo com líquido amniótico meconial espesso, observa-se apneia, respiração irregular e frequência cardíaca menor que 100 bpm.

A CONDUTA É:

- A Laringoscopia para aspiração sob visualização direta do mecônio da hipofaringe e traqueia antes de iniciar a ventilação com pressão positiva
- B Ventilação com pressão positiva com máscara facial e ar ambiente nos primeiros 60 segundos de vida.
- C Ventilação com pressão positiva com máscara facial e concentração de oxigênio 30% nos primeiros 60 segundos de vida.
- D Ventilação com pressão positiva com tubo traqueal e ar ambiente nos primeiros 60 segundos de vida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130344](#)

Questão 41 **Pediatria** **Imunizações** **Vacinação**

Menina, 2 meses, chega à Unidade Básica de Saúde para vacinação. Antecedentes Pessoais: Parto com 31 semanas de idade gestacional e peso de 1345g, permaneceu internada na unidade neonatal por 6 semanas, recebendo alta com 2155g em aleitamento materno exclusivo. Exame físico: Peso= 2595g e exame físico normal.

DE ACORDO COM O CALENDÁRIO NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A CRIANÇA DEVE RECEBER TODAS AS VACINAS DE ACORDO COM:

- A A idade cronológica pós-natal, nas mesmas doses das crianças a termo.
- B A idade corrigida, nas mesmas doses das crianças a termo.
- C A idade cronológica pós-natal, na metade das doses das crianças a termo.
- D A idade corrigida, na metade das doses das crianças a termo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130341](#)

Questão 42 **Complicações** **Encefalopatia por hiperbilirrubinemia** **Icterícia neonatal**

O QUADRO CLÍNICO INICIAL DA ENCEFALOPATIA BILIRRUBÍNICA CARACTERIZA-SE POR:

- A Letargia, hipotonia e sucção débil.
- B Hipertonia, hipertermia e choro agudo de alta intensidade.
- C Tetraparesia espástica, paresia vertical do olhar e convulsões.
- D Apneia, coma e convulsões.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130339](#)

Questão 43 **Fibrose Cística** **Pediatria** **Tratamento**

Menino, 12a, vem à Emergência com febre, tosse produtiva com secreção espessa e piora do padrão respiratório habitual. Antecedente Pessoal: fibrose cística.

A ANTIBIOTICOTERAPIA VISA COBERTURA PARA OS SEGUINTE AGENTES ETIOLÓGICOS:

- A Haemophilus influenzae e Staphylococcus aureus.
- B Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa.
- C Haemophilus influenzae e Klebsiella pneumoniae.
- D Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130337](https://www.4000130337.com)

Questão 44 Tratamento

Menino, 7a, é trazido a Unidade de Emergência após picada de escorpião no pé direito há cerca de 50 minutos. Refere dor intensa com formigamento no hálux e dorso do pé. Nega vômitos, refere batadeira no peito. *Exame físico: FC= 108 bpm; FR= 22 irpm, PA= 110x60 mmHg*, pulsos cheios, perfusão periférica de 2 segundos. Coração: Bulhas rítmicas, em 2 tempos, normofonéticas, sem sopros; Pulmões: roncosparsos, sem desconforto.

ALÉM DA ANALGESIA, A CONDUTA É:

- A Observação por pelo menos 6 horas.
- B Soro antiescorpiônico 2 ampolas e observação por 24 horas.
- C Soro antiescorpiônico 4 ampolas e observação por 24 horas.
- D Soro antiescorpiônico 6 ampolas e observação em UTI.

4000130336

Questão 45 Sinais e sintomas

À recepção pós-parto, recém-nascido encontra-se hidrópico, com lesões de pele papuloescamosas, algumas vesiculosas, difusas, inclusive nas palmas das mãos e planta dos pés.

O AGENTE ETIOLÓGICO É:

- A Parvovírus B19
- B Vírus da Rubéola.
- C Treponema pallidum.
- D Toxoplasma gondii.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130334](https://www.4000130334.com)

Questão 46 Febre amarela Amamentação Aleitamento Materno

Família residente em área onde foram confirmados casos de febre amarela foi orientada a comparecer à Unidade Básica de Saúde para receber a vacina da febre amarela. Entre os familiares há uma nutriz que está amamentando uma criança de 4 meses. ALÉM DA VACINA DE FEBRE AMARELA, A ORIENTAÇÃO PARA A NUTRIZ É:

- A Manter a amamentação.
- B Suspender a amamentação por 10 dias.
- C Suspender a amamentação por 30 dias.
- D Inibir a lactação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130330](#)

Questão 47 **Pediatria** **DDS46XX hiperplasia adrenal congênita**

Menina, 5a, é trazida à Unidade de Emergência com queixa de febre e tosse há 3 dias. Antecedentes pessoais: Hiperplasia adrenal congênita forma perdedora de sal, em uso de hidrocortisona e fludrocortisona. A CONDUTA É:

- A Manter as mesmas doses da hidrocortisona e da fludrocortisona.
- B Aumentar a dose da hidrocortisona e manter a dose da fludrocortisona.
- C Manter a dose da hidrocortisona e aumentar a dose da fludrocortisona.
- D Aumentar as doses da hidrocortisona e da fludrocortisona.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130327](#)

Questão 48 **Pediatria** **Eritema Infeccioso**

Criança, 4a, é trazida a Unidade de Emergência com queixa de tosse, coriza nasal e manchas vermelhas pelo corpo. As manchas começaram há 3 dias no rosto, na região das bochechas, confluentes, progredindo para o tronco e membros. Pioram com o calor. Relata vacinação em dia. Exame físico: T= 36,6°C, FC= 98 bpm, FR= 22 irpm, Pele: exantema maculopapular em tronco e membros superiores, mais intenso em áreas descobertas e face extensora dos braços. Rosto com eritema intenso nas bochechas, poupando região perioral, nariz e testa. O AGENTE ETIOLÓGICO É:

- A Streptococcus pyogenes.
- B Paramyxoviridae.
- C Parvovírus B19.
- D Herpesvírus grupo 6.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130324](#)

Questão 49 **Pediatria** **Corpo EstranhoEngasgo**

Menino, 3 anos ingeriu prego há 1 dia. Criança está assintomática.

Radiograma:



A CONDUTA É:

- A Trânsito intestinal.
- B Colonoscopia se não eliminado em 48h.
- C Observação clínica domiciliar, monitorar a eliminação nas fezes.
- D Observação clínica hospitalar, clister glicerinado de 12/12h até eliminação.

4000130321

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina

Questão 50 Estimativa da Superfície Corpórea Queimada e Circulação **Cirurgia**

Homem, 21a, é levado ao Pronto Socorro por sofrer queimaduras por fogo. Exame físico: Consciente, orientado, PA= 132x76 mmHg, FC= 87 bpm, FR= 16 irpm, Oximetria de pulso (em ar ambiente)= 100%, P= 70kg. Pele: lesões térmicas distribuídas nas faces anteriores do tórax, abdome, membros inferiores; primeiro grau= 11% e segundo grau= 25%. CONSIDERANDO A FÓRMULA DE PARKLAND O VOLUME CORRETO PARA REPOSIÇÃO É:

- A 10080 ml em 24 horas
- B 2520 ml em 8 horas.
- C 1750 ml em 12 horas.
- D 3500 ml em 24 horas.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000130319

Questão 51 **Apresentação Clínica** **Diagnóstico**

Lactente, 18m, é levado pelos pais ao Pronto Socorro devido a episódios recorrentes de choro acompanhados de vômitos amarelados, com flexão das pernas em direção do abdome quando deitada, com período de acalmia. Exame físico: T= 36,7°C, FC= 125 bpm, FR= 32 irpm, mucosas úmidas, corada; Abdome: plano, normotenso, massa palpável em hipocôndrio direito e presença de depressão em fossa ilíaca direita. Ultrassonografia do abdome= presença do sinal do alvo e do "Pseudo-rim". A CONDUTA É:

- A Enema opaco.
- B Antibioticoterapia.
- C Urografia excretora.
- D Protoparasitológico.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000130316

Questão 52 **Filtro de Veia Cava**

Mulher, 43a, internada há 4 dias por hemorragia subaracnóide não traumática apresenta edema em pé e panturrilha direitos há 1 dia. Antecedentes pessoais: tabagismo 30 maços/ano. Ultrassonografia com doppler de membros inferiores: trombose venosa profunda no membro inferior direito. A CONDUTA É:

- A Proclive.
- B Rivaroxabana.
- C Enoxaparina.
- D Filtro de veia cava.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130315](https://www.4000130315.com.br)

Questão 53 **Preparo para a intubação traqueal**

Homem, 21a, vítima de projétil de arma de fogo em abdome é trazido à Unidade de Pronto Atendimento. Exame físico: PA= 60x38 mmHg, FC= 144 bpm, FR= 28 irpm, oximetria de pulso (sob máscara 100%)= 90%, letárgico, pele fria, enchimento capilar maior que 2 segundos, descorado +++/4+, Escala de Coma de Glasgow= 10 e pupilas isofotorreagentes. A MEDICAÇÃO A SER EVITADA DURANTE A INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL É:

- A Succilcolina.
- B Etomidato.
- C Midazolan.
- D Fentanil.

4000130313

Questão 54 **Isquemia Mesentérica Aguda** **Cirurgia**

Homem, 68a, procura o hospital por dor súbita de forte intensidade em todo abdome há 2 horas. Relata dor abdominal periumbilical de moderada intensidade pós prandial há 2 meses. Antecedentes pessoais: tabagismo 50 maços/ano, diabetes mellitus há 28 anos e stent em coronária há 2 anos. Exame físico: PA= 100x70 mmHg, FC= 112 bpm, FR= 20 irpm, Oximetria de pulso (ar ambiente)= 93%; Pulmão: murmúrio vesicular diminuído globalmente com sibilos esparsos; Abdome: plano, flácido, ausência de sopro e ruídos hidroaéreos, dor a palpação profunda e sem massa, ausência de irritação peritoneal. A CONDUTA É:

- A Ultrassonografia de abdome superior.
- B Angiotomografia de tórax e abdome.
- C Radiograma de abdome agudo.
- D Ecocardiograma com doppler colorido.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130310](https://www.4000130310.com.br)

Questão 55 **Síndrome de Pancoast** **Síndrome de ClaudeBernardHorner**

Homem, 70a, procura Unidade de Pronto Atendimento com queixa de dor em pontada no peito à direita, há três meses, de intensidade progressiva, que exacerba com a respiração e com irradiação para região do ombro direito, cansaço aos grandes esforços, associados com náusea e fadiga. Antecedente Pessoal: tabagismo; 50 maços/ano. Exame físico: PA=

136x82 mmHg, FC= 88 bpm, FR= 20 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 92%; face: ptose à direita; pescoço: gânglios supraclaviculares e face anterior; pulmão: murmúrio vesicular globalmente diminuído; neurológico: Escala de Coma de Glasgow= 15 e pupilas anisocóricas, miótica à direita. Radiograma de toráx: O ACHADO NO EXAME FÍSICO ESPERADO NESSA SITUAÇÃO É:



- A Enoftalmia a direita.
- B Exoftalmia a esquerda.
- C Enoftalmia a esquerda.
- D Exoftalmia a direita.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130307](https://www.4000130307.com)

Questão 56 Declaração de óbito DO Atestado de óbito

Homem, 19a, chega em hospital por trauma grave de crânio, internado em UTI. No vigésimo dia foi diagnosticado choque séptico por S. aureus e evoluiu para óbito, quatro dias após. O ATESTADO MÉDICO DEVERÁ SER EMITIDO PELO:

- A Médico assistente da UTI.
- B Serviço Verificação de Óbito.
- C Neurocirurgião.
- D Instituto Médico Legal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130305](https://www.4000130305.com)

Questão 57 Instrumental Cirúrgico Cirurgia

Você foi chamado para auxiliar um cirurgião e um assistente e será o instrumentador em uma cirurgia de uma apendicite aguda. VOCÊ POSICIONARÁ A MESA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO À:

- A Esquerda do paciente e à esquerda do primeiro assistente.
- B Esquerda do paciente e à direita do primeiro assistente.
- C Direita do paciente e do lado direito do cirurgião principal.
- D Direita do paciente e do lado esquerdo do cirurgião principal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130304](https://www.4000130304.com)

Questão 58 **Pneumotórax Simples** **Cirurgia**

Mulher, 35a, vítima de queda de motocicleta em alta velocidade, trazida por familiares para hospital. Exame físico: consciente, orientada, com escoriações na região toracoabdominal à esquerda, estável hemodinamicamente. Radiograma de tórax: normal. Tomografia computadorizada de tórax e abdome: pneumotórax à esquerda, menor que 2 cm, e sem lesões abdominais. A CONDUTA É:

- A Drenagem torácica à esquerda com dreno laminar.
- B Toracocentese de alívio.
- C Caso permaneça estável, repetir radiograma em 6 a 12 horas.
- D Alta hospitalar caso persista assintomática.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130303](#)

Questão 59 **Escroto Agudo**

Adolescente, 14a, admitido no Pronto Atendimento com dor inguinal a direita com irradiação escrotal, de início súbito há cerca de 3 horas, com melhora parcial há cerca de 1 hora. O paciente referia ter participado de atividades esportivas na manhã do mesmo dia. Exame físico: Genital: testículo esquerdo elevado no escroto e fora do eixo longitudinal habitual, aumento de volume e da consistência com discreta hiperemia. A CONDUTA É:

- A Trauma testicular; analgesia e seguimento ambulatorial.
- B Torção testicular; ultrassonografia escrotal.
- C Orquite; analgesia e antibioticoterapia.
- D Neoplasia; biópsia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130302](#)

Questão 60 **Vias Aéreas Definitivas Cirúrgicas** **Cirurgia**

Homem, 22a, vítima de colisão frontal de carro a 90 km/hora, em banco dianteiro, sem usar cinto de segurança, colidindo a cabeça contra o para brisas. Exame físico na cena: inconsciente, FR= 30 irpm, FC= 110 bpm PA= 130x80 mmHg; oximetria (máscara de oxigênio 10 litros/minuto) = 90%, trauma de face, sangue em cavidade oral e anisocoria. Após duas tentativas frustradas de intubação orotraqueal com o uso de medicações apropriadas, optou-se pela ventilação através de máscara laríngea. Admitido após 20 minutos, em ambiente hospitalar, mantinha boa saturação de oxigênio e estabilidade hemodinâmica após receber 500 ml de Ringer lactato. A CONDUTA É:

- A Manter a ventilação pela máscara laríngea e tomografia computadorizada de crânio.
- B Providenciar uma via aérea definitiva e tomografia computadorizada de corpo inteiro.
- C Manter a ventilação pela máscara laríngea e tomografia computadorizada de corpo inteiro.
- D Realizar cricotireoideostomia por punção e tomografia computadorizada de crânio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130301](#)

Questão 61 **Trauma Abdominal Fechado** **Cirurgia**

Homem, 18a, vítima de queda de motocicleta, trazido pelo SAMU para hospital terciário. Exame físico: FR= 22 irpm, FC= 112 bpm, PA= 94x62 mmHg, consciente, orientado, com escoriações na região toracoabdominal à direita; Membros:

deformidade e edema na coxa direita. Radiograma de tórax e bacia: sem alterações; *Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST)*: líquido em moderada quantidade no espaço de Morrison. Após receber 1 litro de Ringer lactato aquecido os sinais vitais: FR= 20 irpm, FC= 98 bpm, PA= 106x74 mmHg. A CONDUTA É:

- A Laparotomia exploradora, pois o FAST evidenciou hemorragia interna.
- B Repetir o FAST em uma hora, para observar progressão do sangramento, que pode cessar espontaneamente.
- C Realizar um lavado peritoneal diagnóstico, para descartar lesão de víscera oca.
- D Realizar tomografia de abdome com possibilidade de tratamento não operatório de lesão de vísceras maciças.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130299](https://www.4000130299.com.br)

Questão 62 Tratamento da Síndrome Compartimental Abdominal Cirurgia

Homem, 26a, vítima de múltiplos ferimentos penetrantes foi submetido à laparotomia exploradora por choque hemorrágico, recebeu 8 unidades de concentrados de hemácias e 6 litros de solução cristaloide aquecidas no intraoperatório. Interna na Unidade de Terapia Intensiva e após 12 horas apresenta-se com os seguintes parâmetros: PA= 90x65 mmHg, FC= 114 bpm, sob ventilação mecânica de FiO₂= 0.80, PEEP =10 cmH₂O, Oximetria de pulso= 95%, Pressão intra-abdominal (inicial)= 20mmHg, Diurese= 0,6 ml/kg/h. A CONDUTA É:

- A Hidratação rigorosa e monitorização da pressão venosa central.
- B Tomografia computadorizada de abdome e controle da creatinina e ureia.
- C Diminuir conteúdo intraluminal e sedo analgesia adequada.
- D Ultrassonografia point-of-care e aumentar PEEP se veia cava inferior colabada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130299](https://www.4000130299.com.br)

Questão 63 Cisto Tireoglossso Cirurgia

Menina, 13a, em acompanhamento na Unidade Básica de Saúde devido a uma lesão nodular na região do pescoço há 8 anos, que apresenta, após quadros infecciosos respiratórios, aumento de tamanho, com dor, inchaço e saída de secreção purulenta. Ultrassonografia de região cervical: lesão cística de conteúdo anecóico de paredes finas e regulares, localizado na linha média na topografia do osso hioide. A LESÃO ORIGINA- SE:

- A No tecido subcutâneo.
- B Na glândula tireoide.
- C No esôfago.
- D Na glândula submandibular.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130299](https://www.4000130299.com.br)

Questão 64 Retocolite Ulcerativa

Mulher, 35a, retorna à Unidade Básica de Saúde para resultado de exames por quadro de dor abdominal, perda de peso e evacuações com sangue. Exame físico: emagrecida, descorada +/4+; restante sem alterações. Colonoscopia: aspecto granular da mucosa de forma contínua, com perda do padrão vascular e presença de erosões no segmento retosigmóide. FATORES DE RISCO PARA CÂNCER ASSOCIADOS AO QUADRO SÃO:

- A Doença pan-colônica; uso de imunobiológicos.
- B Intensidade da inflamação; uso de aminossalicilatos.
- C Duração prolongada da doença; presença de colangite esclerosante primária.
- D Emagrecimento; uso de imunossupressores.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130295](#)

Questão 65 Tratamento

Homem, 22a, trabalhador da coleta de lixo, procurou a Unidade de Pronto Atendimento com febre alta há 5 dias acompanhada de cefaleia e mialgia intensa. Evoluiu há 2 dias com exantema maculopapular, cansaço e icterícia. Exame físico: T= 38,4°C, icterício ++/4+; olhos: hiperemia conjuntival; membros: dor à palpação das panturrilhas. A CONDUTA É:

- A Levofloxacina.
- B Cefepima.
- C Cloranfenicol.
- D Penicilina cristalina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130293](#)

Questão 66 Medicamentos que provocam glicosúria inibidores de SGLT2

Medicamentos que diminuem a absorção intestinal de glicose inibidores da alfa glicosidase Fatores precipitantes

Homem, 57a, procura atendimento médico com episódios de vômitos e sonolência. Antecedentes pessoais: diabetes mellitus tipo 2 com diagnóstico há uma semana. Glicemia= 220 mg/dL, bicarbonato= 18 mEq/L, anion gap= 20 mEq/L, pH= 7,21. A CLASSE FARMACOLÓGICA COM POTENCIAL PARA DESENCADEAR O QUADRO CLÍNICO É:

- A Inibidores de SGLT2.
- B Análogos do GLP-1.
- C Inibidores das alfa glicosidases.
- D Inibidores da dipeptidilpeptidase 4.

4000130291

Questão 67 Epinefrina

Mulher, 26 anos, trazida ao Pronto Socorro com dispneia súbita há 10 minutos acompanhada de prurido no corpo e inchaço dos lábios e língua. Nega comorbidades. Exame físico: PA= 100x80 mmHg, oximetria de pulso (ar ambiente)= 93%, rubor facial e edema em lábios. A ABORDAGEM INICIAL É:

- A Máscara laríngea.
- B Epinefrina 1:1000, na dose de 0,5 mg (0,5 ml), via intramuscular.
- C Difenidramina, na dose de 50mg, via intravenosa.
- D Hidrocortisona, na dose de 5 a 10 mg/kg, via intravenosa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130289](#)

Questão 68 Edema Agudo Pulmonar

Mulher 60a, é atendida no domicílio pelo SAMU apresentando intensa falta de ar e tosse com expectoração clara há 20 minutos. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial sistêmica e cardiopata em uso losartana, furosemida e AAS. Exame físico: PA= 240x130mmHg; FC= 115bpm; FR= 30irpm; pulmões: estertores crepitantes nas bases e campo médio. Realizada avaliação primária, suporte ventilatório, posicionamento adequado do paciente e acesso venoso. A CONDOTA MEDICAMENTOSA A SEGUIR É:

- A Nitroprussiato de sódio, clonidina e furosemida.
- B Dinitrato de isossorbida, sulfato de morfina e furosemida.
- C Nitroprussiato de sódio, sulfato de morfina e cedilanide.
- D Dinitrato de isossorbida, nitroglicerina e digoxina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130286](https://www.facebook.com/4000130286)

Questão 69 Interpretação dos parâmetros do exame

Critérios diagnósticos de osteoporose critério densitométrico eou critério clínico

Quatro mulheres, acima dos 60 anos, retornam ao Centro de Saúde com exames laboratoriais (hemograma, vitamina D, PTH, creatinina e cálcio) dentro dos valores de normalidade. Apresentam as seguintes densitometrias ósseas e radiogramas da coluna:

Paciente 1: Densitometria L1-L4=-1,9; fêmur total= -0,7; antebraço direito=-1,2. 	Paciente 2: Densitometria L1-L4=-2,6; fêmur total= -0,9; antebraço direito=-2,0. 
Paciente 3: Densitometria L1-L4=+1,2; fêmur total= -0,5; rádio distal direito=-2,7. 	Paciente 4: Densitometria L1-L4=-2,1; fêmur total= -0,5. 

OS DIAGNÓSTICOS DAS PACIENTES 1, 2, 3 E 4 SÃO, RESPECTIVAMENTE:

- A Osteopenia; osteoporese; osteopenia, osteopenia.
- B Osteopenia; osteoporese; osteoporese, osteopenia.
- C Osteoporese; osteoporese; osteopenia; osteopenia.
- D Osteoporese; osteoporese; osteoporese; osteopenia.

4000130285

Questão 70 Hematologia Talassemias

Homem, 29a, retorna a consulta com exames solicitados por apresentar sonolência às atividades laborais. Antecedentes pessoais: anemia em diversas ocasiões na infância e adolescência, tratada com reposição de ferro, de forma irregular, sem melhora completa.

Hemácias= $5,80 \times 10^9/L$; hemoglobina= 10,3g/dL, volume corpuscular médio= 57 fL, RDW= 12,8%; contagem de reticulócitos= $162 \times 10^9/L$; leucócitos= $5,7 \times 10^9/L$ (sem alterações no diferencial); plaquetas= $189 \times 10^9/L$; Eletroforese de hemoglobina= HbA= 93,5%, HbA₂= 4,5% e HbF= 2,0%; ferritina= 35 ng/ml e ferro sérico= 65µg/dL.

O DIAGNÓSTICO É:

- A Anemia por deficiência de ferro.
- B Anemia da doença crônica.
- C Traço talassêmico.
- D Traço falciforme.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000130283

Questão 71 Critérios diagnósticos Tratamento medicamentoso

Homem, 63a, assintomático, retorna à Unidade Básica de Saúde para resultado de exames. Exame físico: PA= 140x90 mmHg e IMC= 24 kg/m². Glicemia= 191 mg/d; HbA_{1c}= 7,1%. A CONDUTA É: me/medicinalivre

- A Metformina associada a agonista SGLT2.
- B Agonista SGLT2.
- C Metformina em mono terapia.
- D Agonista do receptor de GLP1.

4000130280

Questão 72 Tuberculose

Homem, 36a, procurou ambulatório com tosse seca há três semanas, acompanhada de dispneia na última semana. Relata perda ponderal de cinco quilos em dois meses, diminuição do apetite e queda de cabelo. Antecedentes pessoais: usuário de substâncias psicoativas. Exame físico: emagrecido, FR= 18 irpm, oximetria (ar ambiente)= 89%, orofaringe: gengivite e leucoplasia pilosa; Pulmões: estertores subcrepitantes difusos. O TRATAMENTO ANTIMICROBIANO EMPIRICO É:

- A Claritromicina e etambutol.
- B Isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol.
- C Sulfametoxazol e trimetoprima.
- D Cefepima.

4000130279

Questão 73 Diagnóstico da púrpura trombocitopênica imunológica PTI Hematologia

Mulher, 51a, procedente de São Luís (MA), procura Unidade Básica de Saúde após mudança para região de Campinas para retomar seguimento ambulatorial devido a plaquetopenia, diagnosticada há 6 meses em hemograma de rotina. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial sistêmica controlada com losartana há 5 anos. Exame físico: abdome: baço percutível, mas não palpável; pele: raras petéquias em membros inferiores. Hemoglobina= 13,8 g/dL, volume corpuscular médio= 91fL, leucócitos = $8,6 \times 10^9/L$ (segmentados= 69%, linfócitos 22%, monócitos 6%, eosinófilos 3%), plaquetas= $30 \times 10^9/L$. O DIAGNÓSTICO É:

- A Hiperesplenismo por hipertensão portal.
- B Púrpura trombocitopênica imune.
- C Plaquetopenia relacionada ao uso de losartana.
- D Plaquetopenia transitória relacionada a infecção viral subclínica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130279](https://www.4000130279.com)

Questão 74 Tratamento

Homem, 23a, estudante, procurou o Pronto Socorro com dor de cabeça intensa, febre não medida e vômitos há um dia. Exame físico: T= 38,9°C; neurológico: rigidez de nuca presente. Líquor: leucócitos= $3.305/mm^3$ (78% de neutrófilos, 21% de linfócitos e 1% de monócitos), proteínas= 250 mg/dL glicorraquia= 10mg/dL; glicemia= 85 mg/dL. A TERAPEUTICA ANTIMICROBIANA INTRAVENOSA É:

- A Ceftriaxona.
- B Cefepima.
- C Penicilina cristalina.
- D Cloranfenicol.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000130279](https://www.4000130279.com)

Questão 75 Esteatose hepática

Homem, 57a, assintomático, traz exames solicitados para admissão em seguro de saúde. Antecedente pessoal: uso de suplementos nutricionais há 2 meses; ingestão de 3 a 4 latas de cerveja/dia. Exames: AST= 106 U/L ; ALT= 51 U/L ; fosfatase alcalina= 98 U/L; gamaGT= 260 U/L ; bilirrubina= 1,0 mg/dL ; albuminemia= 3,9 g/dL ; RNI= 1,03; sorologia anti-HCV e Ag-HbS e anti-Hbc negativas; Ultrassonografia abdominal: esteatose leve. ALÉM DE SUSPENDER A INGESTA ALCOÓLICA A CONDUTA É:

- A Elastografia hepática e reavaliação laboratorial em dois meses.
- B Tomografia de abdome e reavaliação laboratorial em quatro semanas.
- C Realizar reação em cadeia da polimerase para hepatite B e C.
- D Suspender suplementos e reavaliação laboratorial em quatro semanas

4000130274

Questão 76 Espirometria Espirometria

Mulher, 71a, retorna ao Ambulatório para resultado de exames. Antecedente pessoal: tabagismo 40 maços/ano. Espirometria com teste com broncodilatador (salbutamol spray): BASEADO NA ESPIROMETRIA O DIAGNÓSTICO É:

	Pré-broncodilatador		Pós-broncodilatador		Valor previsto	% variação
CVF	1,54 L	52%	1,89L	63%	2,98 L	22
VEF1	0,62L	25%	0,83L	33%	2,45L	33
VEF1/CVF	40	48	44	52	82	

- A Distúrbio ventilatório restritivo grave com resposta ao broncodilatador.
- B Distúrbio ventilatório obstrutivo grave com resposta de fluxo e volume ao broncodilatador, CVF reduzida.
- C Distúrbio ventilatório misto (obstrutivo grave e restritivo grave) com resposta parcial ao broncodilatador.
- D) Distúrbio ventilatório obstrutivo grave com resposta parcial ao broncodilatador.

4000130272

Questão 77 Tratamento Clínico da DRGE Doença do Refluxo Gastroesofágico DRGE

Homem, 32a, procura a Unidade Básica de Saúde com queixa de queimação retroesternal há vários meses, do estômago à base do pescoço, de intensidade moderada, principalmente à noite, de 2-3 vezes por semana. Também refere tosse crônica e rouquidão. Endoscopia digestiva alta: sem alterações. A CONDUTA É:

- A Realizar pH metria para definição diagnóstica.
- B Realizar broncoscopia.
- C Repetir endoscopia digestiva alta com biópsia da mucosa esofágica.
- D Prescrever inibidor de bomba de prótons, medidas dietéticas e comportamentais.

4000130271

Questão 78 Tratamento

Homem, 35a, procura Unidade de Pronto Atendimento por picada de cobra há 2 horas, tendo realizado torniquete local. Relata dor intensa no local, sudorese e ansiedade. Durante a consulta, apresentou epistaxe e hematemese. Exame físico: Membros: perna direita com 2 orifícios pequenos de centro necrótico, intenso edema em panturrilha direita, 5 bolhas com centros enegrecidos e pequenas áreas de necrose. A CONDUTA É:

- A Soro antibotrópico 6 ampolas intravenoso.
- B Soro anticrotático 20 ampolas intravenoso.
- C Soro anticrotático 10 ampolas intravenoso.
- D Soro antibotrópico 12 ampolas intravenoso.

4000130269

Questão 79 **Apresentações Clínicas** **Manifestações clínicas** **Apresentação clínica**

Mulher, 42a, em tratamento de hipertensão arterial sistêmica, de difícil controle, em uso de enalapril 40 mg/dia, nifedipina 40 mg/dia e hidroclorotiazida 12,5 mg/dia. Antecedente pessoal: acromegalia em tratamento com cabergolina. Exame físico: IMC = 28 kg/m², PA= 160x110 mmHg. Glicemia de jejum= 101 mg/dL; colesterol total= 190 mg/dL; triglicerídeos= 152 mg/dL; creatinina= 0,9 mg/dL; sódio= 133 mEq/L, potássio= 2,6 mEq/L. DEVE-SE INVESTIGAR:

- A Hiperaldosteronismo.
- B Doença de Addison.
- C Feocromocitoma.
- D Macroadenoma de hipófise.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

4000130268

Questão 80 **Tratamento** **Cardiologia**

Homem, 62a, comparece à Unidade de Emergência com queixa de palpitação torácica durante a última semana. Nega dor torácica, falta de ar, náusea ou vômito. Conta episódios semelhantes há um mês que melhoraram espontaneamente. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial essencial há 20 anos. Exame físico: PA= 120x80 mmHg; FC= 139 bpm; FR= 17 irpm e saturação de oxigênio (ar ambiente)= 97%. O ECG: A CONDUTA É:



Acesse t.me/medicinalivre

- A Administrar metoprolol e iniciar anticoagulação.
- B Cardioversão elétrica sincronizada (120J) e posteriormente, anticoagulação.
- C Reverter ritmo com adenosina e, se refratário, cardioversão elétrica sincronizada.
- D Administrar amiodarona e iniciar anticoagulação.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000130267

Questão 81 **Declaração de Astana**

Na comemoração dos 40 anos da Declaração de Alma-Ata, realizou-se a Conferência Global sobre Atenção Primária à Saúde (APS) em Astana, em 2018. A DECLARAÇÃO DE ASTANA:

- A Reforça a importância dos sistemas universais de saúde de financiamento eminentemente público.
- B Enfatiza a cobertura universal em saúde (universal health coverage – UHC).
- C Supera a de Alma-Ata, em seus princípios de justiça social e de concepção de APS integral.
- D Tem como lema “Saúde para todos no ano 2050”.

4 000102120

Questão 82 Declaração de óbito DO Atestado de óbito

Homem, 44a, chega ao Pronto Socorro com quadro de hipotensão arterial, extremidades frias e pulso rápido. A esposa refere que o paciente caiu de bicicleta no mesmo dia pela manhã e bateu o tronco sobre a quina da calçada, apresentando dor intensa na região hipocôndrio esquerdo. Antecedentes pessoais: soropositivo para HIV, internação por pneumonia intersticial, com alta há 8 dias. Evolui para óbito em menos de duas horas. O MÉDICO RESPONSÁVEL POR ESTE ATENDIMENTO DEVE:

- A Orientar a família a procurar o médico assistente do Centro de Saúde.
- B Preencher a Declaração de Óbito.
- C Encaminhar o corpo para o Serviço de Verificação de Óbitos.
- D Encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal.

4 000102114

Questão 83 Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS

O avanço da biotecnologia e suas aplicações na prática médica tornou-se um novo paradigma na assistência à saúde. Avanços tecnológicos como: de suporte de vida; de diagnóstico, de técnicas cirúrgicas, de transcendência, de nanotecnologia, de telemedicina foram desenvolvidos por um complexo médico-industrial. A saúde como área de negócio, atrativa por sua alta lucratividade, é geradora de conflitos de interesse. O PRINCÍPIO DO SUS COMPROMETIDO NESTE CENÁRIO É O DA:

- A Acessibilidade.
- B Equidade.
- C Integralidade.
- D Universalidade.

4 000102106

Questão 84 Sífilis congênita

O Brasil é país signatário da resolução da Organização Pan-Americana da Saúde que recomenda a eliminação da sífilis congênita, importante causa de perda fetal e mortalidade perinatal. SOBRE ESTA DOENÇA É CORRETO AFIRMAR QUE:

- A Com as medidas adequadas durante o pré natal, é uma doença evitável.
- B O maior número de casos ocorre nas regiões Norte e Nordeste do país.
- C A remissão espontânea é frequente.
- D O uso de penicilina benzatina reduziu sua incidência no Brasil.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000102096](#)

Questão 85 **Asma ocupacional x asma relacionada ao trabalho** **Asma ocupacional**

Homem, 48a, relata dispneia aos grandes esforços há dois anos e chiado no peito há seis meses. Nega episódios semelhantes anteriormente. Atualmente faz móveis por encomenda na garagem de sua residência, local pouco ventilado. Trabalhou como carpinteiro uma fábrica de móveis por 12 anos. O DIAGNÓSTICO É:

- A Asma brônquica.
- B Asma relacionada ao trabalho.
- C Asma ocupacional.
- D Pneumonite alérgica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000102085](#)

Questão 86 **Previdência Social**

Notificação em Saúde do Trabalhador no Sistema Nacional de Agravos de Notificação SINAN
Comunicação de Acidente de Trabalho CAT

Homem, 43a, trabalhador autônomo há 10 anos. Procura atendimento médico com queixa de dor lombar há dois meses, de início súbito, após levantar uma peça de 35 kg no trabalho. Não conseguiu trabalhar durante esse período devido à dor. Exame físico: contratura paravertebral à direita; sinal de Lasègue: positivo membro inferior direito. DO PONTO DE VISTA DE DIREITOS DO TRABALHADOR VOCÊ DEVE:

- A Solicitar abertura de CAT e fazer relatório médico para auxílio acidente.
- B Solicitar abertura de CAT e fazer relatório médico para auxílio previdenciário.
- C Notificar no SINAN e fazer relatório médico para auxílio acidente.
- D Notificar no SINAN e fazer relatório médico para auxílio previdenciário.

4000102072

Questão 87 **Estado de Estresse PósTraumático Transtorno de Estresse PósTraumático TEPT**
Transtorno do Estresse PósTraumático TEPT

Homem, 53a, procura serviço médico com queixas de tonturas, zumbidos e insônia há seis meses. Relaciona os sintomas com a função de motorista de ônibus urbano há 15 anos. Diz que o trabalho é cansativo e relatou que há um ano foi vítima de um assalto a mão armada e desmaiou. Desde então, não consegue trabalhar devido os zumbidos e tampouco dormir, pois acorda com lembranças daquele episódio. O DIAGNÓSTICO É:

- A Síndrome vestibulo coclear relacionada ao trabalho.
- B Transtorno de estresse pós-traumático.
- C Depressão.
- D Síndrome de pânico.

4000102063

Questão 88 Outras Resoluções Pareceres e Recomendações do Conselho Federal de Medicina CFM

Com o crescente uso das novas tecnologias de informação e comunicação, incluindo inúmeras mídias sociais (Facebook, Twitter, WhatsApp e similares), o Conselho Federal de Medicina (CFM) deliberou resoluções normativas e atualizou o Manual da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. É CORRETO AFIRMAR QUE:

- A A normatização busca impedir os excessos do sensacionalismo, da autopromoção e da mercantilização do ato médico.
- B As resoluções do CFM constituem mecanismos normativos que orientam a prática profissional, sem comprometer a autonomia dos médicos.
- C O “Manual de publicidade médica” é um instrumento normativo que busca aplicar os fundamentos e preceitos éticos da profissão.
- D Ainda que não seja a principal motivação, as resoluções citadas contêm caráter de censura e visam cercear o direito do médico.

4000102051

Questão 89 Ortotanásia

A manifestação da vontade do paciente, expressa antecipadamente, garantindo-lhe o direito de decidir como deseja conduzir os últimos momentos de sua vida busca resgatar sua dignidade e sua autonomia. De acordo com Conselho Federal de Medicina, nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas da vontade. TAIS MEDIDAS PODEM SER CONSIDERADAS COMO UMA PRÁTICA DE:

- A Eutanásia.
- B Distanásia.
- C Ortotanásia.
- D Calotanásia.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000102041

Questão 90 Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS

O Núcleo de Saúde Coletiva constatou que nos últimos cinco anos 67,5% entre as mulheres analfabetas ou com ensino fundamental incompleto e 91,4% entre mulheres com ensino superior completo da população alvo realizaram coleta de Exame de Citologia Oncológica de Colo Uterino. ESSES DADOS MOSTRAM:

- A Ação de promoção de saúde.
- B Desigualdade social em saúde.
- C Ação local da vigilância sanitária.
- D Ação de prevenção.

4000102032

Questão 91 Prevenção Quaternária

Mulher, 90a, foi levada ao Pronto Socorro por episódio único de vômito e desidratação. Realizados tomografia de abdome, exames laboratoriais, endoscopia e colonoscopia, com resultados normais. Antecedentes pessoais: síndrome demencial avançada. Após a internação, não foi mais capaz de deambular. A PROTEÇÃO CONTRA INTERVENÇÕES DESNECESSÁRIAS CORRESPONDE À PREVENÇÃO:

- A Quaternária.
- B Terciária.
- C Primária.
- D Secundária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099827](#)

Questão 92 Estudos Ecológicos

Um estudo analisou a tendência temporal das taxas de internação de maiores de 60 anos por doenças respiratórias em uma região, antes e após a implantação das campanhas de vacinação contra a influenza. O DELINEAMENTO UTILIZADO FOI:

- A Estudo de prevalência.
- B Ensaio clínico.
- C Estudo de coorte prospectivo.
- D Estudo ecológico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099815](#)

Questão 93 Mortalidade Materna

O COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA É:

- A Total de mortes de mulheres durante a gravidez e o parto dividido pelo total denascidos vivos, vezes 100 mil.
- B Total de mortes de mulheres durante a gravidez, parto e/ou ao período pós-parto imediato (7 dias) dividido pela totalidade das mulheres em idade fértil, vezes 100 mil.
- C Total de mortes de mulheres durante pré-natal, parto e/ou puerpério (42 dias) dividido pelos nascidos vivos, vezes 100 mil.
- D Total de mortes durante a gravidez, parto e/ou período pós-parto imediato (10 dias) dividido pela totalidade de mulheres grávidas, vezes 10 mil.

4000099804

Questão 94 Odds Ratio ou Razão de Chances

Em área endêmica para hepatite C, foi realizado um estudo para verificar a associação entre hepatocarcinoma e infecção pelo vírus da hepatite C. Utilizando os dados da tabela abaixo: A CHANCE DE UM INDIVÍDUO INFECTADO PELO VÍRUS DA HEPATITE C APRESENTAR HEPATOCARCINOMA, EM RELAÇÃO AO NÃO INFECTADO É DE:

	Hepatocarcinoma		Total
	Sim	Não	
Infecção pelo vírus da hepatite C			
Presente	80	20	100
Ausente	20	60	80

- A 4 vezes maior.
- B 2,5 vezes maior.
- C 12 vezes maior.
- D 8 vezes maior.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina

4000099791

Questão 95 Estudos de Coorte

Um estudo investigou a associação entre o primeiro registro do índice de massa corporal (IMC) e a sobrevida até o diagnóstico de 22 tipos de cânceres de localização mais comuns, em população registrada em banco de dados de atendimento clínico. A sobrevida foi comparada entre os grupos de pacientes com diferentes faixas de IMC. Observaram-se resultados da associação entre IMC e incidência de alguns tipos de câncer: fígado (Razão de Riscos =1,12; IC95% 1,12–1,27), cólon (Razão de Riscos =1,10; IC95% 1,07–1,13), mama pré-menopausa (Razão de Riscos =0,89; IC95% 0,86–0,92), e melanoma (Razão de Riscos =0,99; IC95% 0,96–1,02), bexiga (Razão de Riscos =1,03; IC95% 0,99–1,06), ovário (Razão de Riscos =1,09; IC95% 1,04–1,14). A heterogeneidade dos efeitos sugere diferentes mecanismos associados a diferentes tipos e locais de cânceres. O DELINEAMENTO UTILIZADO FOI:

- A Ensaio clínico sobre o risco de mortalidade entre tipos de câncer.
- B Estudo Caso (cânceres) Controle (não cânceres).
- C Estudo Transversal sobre cânceres e IMC.
- D Estudo de Coorte sobre ocorrência de cânceres entre expostos e não expostos.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000099776

Questão 96 Sarampo

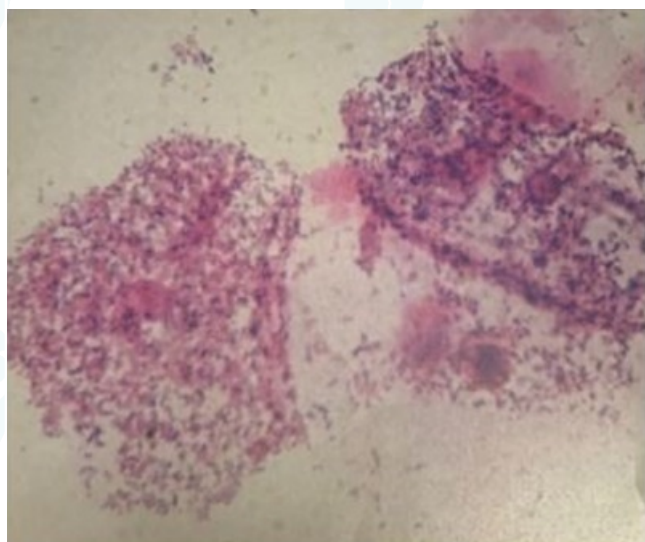
A vacinação contra sarampo tem sido revisada no país devido ao crescente número de casos. ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

- A Os menores de 6 meses de idade tem maior susceptibilidade à infecção pelo vírus dosarampo devido à baixa cobertura vacinal.
- B A ampliação da vacinação para maiores 6 meses de idade em campanhas se deve ao acesso precário da população carente às unidades de saúde.
- C A vacinação para os maiores de 6 meses de idade não substitui a vacinação aos 12 meses de idade em crianças.
- D A maior parte dos adolescentes e adultos jovens já apresentam imunidade contra sarampo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099765](https://www.4000099765.com)

Questão 97 Vulvovaginites

Mulher, 35a, vem com queixa de corrimento vaginal abundante há 30 dias. Exame ginecológico: secreção branco-acinzentado em pequena quantidade, pH=4,5, teste das aminas positivos e ausência de hiperemia de paredes vaginais. Bacterioscopia vaginal (ANEXO A): OS ACHADOS HISTOLÓGICOS QUE CONFIRMAM O DIAGNÓSTICO SÃO:



- A Hifas e leveduras.
- B Excesso de lactobacilos e células-guia (clue cells).
- C Células-guia (clue cells) e ausência de leucócitos
- D Excesso de bactérias e de lactobacilos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099765](https://www.4000099765.com)

Questão 98 Diagnóstico Controle glicêmico

Mulher, 24a, G1POCOA0, vem para segunda consulta pré-natal com idade gestacional de 10 semanas. Antecedente pessoal: obesidade grau 3. Glicemia de jejum= 97 mg/dL. ALÉM DE ORIENTAÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS, A CONDUTA É:

- A Curva glicêmica gestacional.
- B Perfil glicêmico.
- C Repetir glicemia de jejum.
- D Iniciar insulina.

Questão 99 Indicações e contraindicações

Mulher, 30a, G2P1C1A0, idade gestacional 40 semanas e 3 dias procura maternidade porque realizou ecografia que evidenciou índice de líquido amniótico (ILA) de 30 mm, peso fetal estimado de 3780g, feto cefálico, Doppler normal. Nega perda de líquido por via vaginal. Exame ginecológico: especular: pH= 4,5, teste de esforço e prova de cristalização negativos, toque vaginal: colo impérvio. A CONDUTA É REALIZAR:

- A Preparo de colo com sonda Foley e indução de parto com ocitocina
- B Coleta de cultura para Estreptococos do Grupo B e parto cesárea.
- C Retorno em 4 dias para indução de parto.
- D Indução de parto com misoprostol.

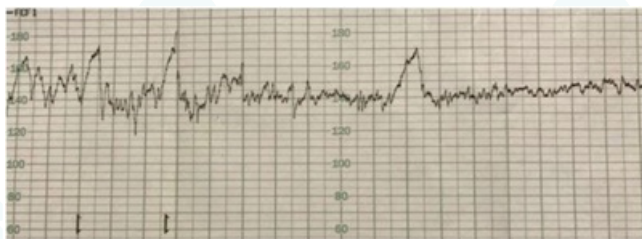
Essa questão possui comentário do professor no site [4000099719](https://www.site4000099719.com)**Questão 100** Insuficiência istmocervical

Mulher, 36a, G4P1A2C0, idade gestacional de 14 semanas. Antecedentes Obstétricos: parto prematuro às 26 semanas e abortos com 18 e 15 semanas. Ultrassonografia com 12 semanas: avaliação morfológica fetal normal e colo uterino medindo 35 mm, sem sinais de afunilamento ou sludge. A CONDUTA É:

- A Amoxicilina clavulanato por 7 dias e repetir ecografia com 20 semanas.
- B Amoxicilina clavulanato por 7 dias e pré-natal de rotina.
- C Progesterona vaginal e pré-natal de rotina.
- D Progesterona vaginal e cerclagem de colo uterino.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099714](https://www.site4000099714.com)**Questão 101** Eclâmpsia

Mulher, 33a, G3P2C0A0, idade gestacional de 37 semanas, chega à Maternidade após crise convulsiva há 1 hora (tônico-clônica generalizada). Refere dor de cabeça de forte intensidade há 3 dias. Antecedentes pessoais: primeiro filho com o atual parceiro, nega complicações em gestações anteriores. Exame físico: PA= 142x86 mmHg, FC= 86 bpm, FR= 22 irpm; Edema em face, mãos, membros inferiores, exame neurológico: normal. Exame ginecológico: altura uterina 35cm, ausência de contrações, feto cefálico. Plaquetas= 230.000 mm³, RNI= 1,02, creatinina= 0,9mg/dL, AST= 15 UI/L, bilirrubina total= 0,8 mg/dL, relação proteína/creatinina urinária= 0,4. Cardiotocografia: A CONDUTA É:



- A Sulfato de magnésio e parto cesárea imediato.
- B Tomografia computadorizada de crânio e parto cesárea imediato.
- C Sulfato de magnésio e indução de parto.
- D Tomografia computadorizada de crânio e indução de parto.

4000099701

Questão 102 BIRADS 5

Mulher, 55a, procura atendimento médico por alteração de exames de rotina. Mamografia: nódulo na mama esquerda, irregular e microlobulado, medindo 18mm. Ultrassonografia: nódulo hipoeecóico, irregular e microlobulado, BIRADS® 5. A CONDUTA É:

- A Punção aspirativa por agulha fina.
- B Biópsia percutânea de fragmento “core-biopsy”.
- C Biópsia incisional com avaliação intra-operatória
- D Biópsia excisional seguida de congelção

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099686](https://www.4000099686.com)

Questão 103 Aborto legal no Brasil

Mulher, 40a, procura o serviço para orientação sobre aborto legal. Refere estar na sétima semana de gestação, após estupro, sem registro de Boletim de Ocorrência. Antecedente pessoal: profissional do sexo, faz uso de preservativos em todas as relações profissionais. A ORIENTAÇÃO É QUE ELA:

- A Não tem direito ao aborto legal, por impossibilidade da confirmação do estupro.
- B Deve registrar queixa na Delegacia de Defesa da Mulher para o aborto legal.
- C Deve obter autorização judicial para ter direito ao aborto legal.
- D Tem direito ao aborto legal mesmo sem a realização do Boletim de Ocorrência.

Proibida Venda

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099676](https://www.4000099676.com)

Questão 104 Fatores de proteção Prevenção

Mulher, 41a, G4P4C0A0, comparece ao Centro de Saúde na campanha Outubro Rosa solicitando orientações para prevenção do câncer de mama. Antecedentes pessoais, obstétricos e ginecológicos: menarca aos 13 anos, amamentou cada filho por pelo menos seis meses, laqueada, consumo de quatro latas de cerveja aos finais de semana. Antecedentes familiares: nega antecedente de doenças neoplásicas. Exame físico: IMC= 30Kg/m², exame de mamas e axilas: sem alterações. ALÉM DO CONTROLE DE GANHO PONDERAL E DAS ORIENTAÇÕES SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL, EM CONSONÂNCIA COM O PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, A CONDUTA É:

- A Acompanhamento clínico anual.
- B Mamografia bienal.
- C Ressonância magnética bienal.
- D Ultrassonografia de mamas para o retorno em 2 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099665](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 105 Tratamento na HPP

Mulher, 32a, G5P4C0A0, idade gestacional= 39 semanas + 5 dias, evoluiu para parto normal, sob analgesia peridural, com recém-nascido de 4100g. Revisão de canal de parto sem lacerações. A dequitação ocorreu após 60 minutos e, nesse momento, iniciou sangramento abundante via vaginal. Exame físico: PA= 108x62 mmHg; FC= 115 bpm, pulsos finos e mucosas descoradas ++/4+. DIANTE DESTES QUADRO, ALÉM DA REPOSIÇÃO VOLÊMICA, A CONDUTA IMEDIATA É:

- A Realizar manobra de Taxe, uterotônicos e ácido tranexâmico.
- B Massagem uterina, uterotônicos, ácido tranexâmico e curagem/curetagem uterina.
- C Realizar manobra de Taxe e inserção de balão intrauterino.
- D Realizar laparotomia exploradora para sutura de B-Lynch.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099653](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 106 Abortamento completo

Mulher, 22a, primigesta, com idade gestacional de oito semanas (conforme data da última menstruação e ultrassonografia precoce transvaginal de seis semanas). Refere sangramento via vaginal abundante há 2 horas, associado a cólica intensa. Exame especular: moderada quantidade de sangue coletado em fórnice posterior. Toque vaginal: útero intrapélvico sem dor a palpação anexial; colo grosso, posterior e impérvio. Ultrassonografia transvaginal: útero de 140 cm³, linha endometrial de 10 mm, anexos sem alterações. O DIAGNÓSTICO É:

- A Gestação incipiente.
- B Abortamento incompleto.
- C Gestação ectópica.
- D Abortamento completo.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099637](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 107 Quadro clínico Critérios diagnósticos

Mulher, 18a, nuligesta, procura atendimento médico com ciclos menstruais irregulares de 90 -120 dias desde a menarca. Antecedente pessoal: menarca aos 11 anos.

Exame físico: IMC= 26,7Kg/m², índice Ferriman-Gallwey= 9. PARA REALIZAR O DIAGNÓSTICO É NECESSÁRIO:

- A Elevação sérica de insulina e teste de tolerância à glicose alterado.
- B Presença da relação LH/FSH > 2 e medida da circunferência abdominal > 88 cm.
- C Padrão menstrual de anovulação crônica e hiperandrogenismo clínico e/ou bioquímico.
- D Aumento do volume ovariano com presença de folículos periféricos à ultrassonografia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099628](#)

Questão 108 Rotura uterina

Mulher, 35a, G5P4C1A0, com último parto há 10 anos. É admitida em trabalho de parto, com dilatação de 8 cm, bolsa rota e polo cefálico apoiado. Antecedente pessoal: diabetes gestacional controlado com dieta. Após 3 horas, evoluiu com dilatação total, apresentação no plano -3 de De Lee e 5 contrações fortes em 10 minutos. O exame clínico evidencia a situação abaixo: Subitamente, apresenta quadro de sangramento vaginal em moderada quantidade e queda da pressão arterial acompanhada de taquicardia. O DIAGNÓSTICO É:



- A Descolamento prematuro de placenta.
- B Rotura uterina.
- C Placenta prévia marginal.
- D Laceração de trajeto.

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099615](#)

Questão 109 HCVRNA Obstetrícia

Gestante de 11 semanas inicia pré-natal e realiza teste rápido para hepatite C com resultado positivo e ELISA anti HCV também positivo. A CONDUTA É:

- A Repetir a sorologia para hepatite C com 28 semanas.
- B Iniciar tratamento antiviral após 12 semanas.
- C Realizar reação de cadeia de polimerase para hepatite C.
- D Indicar cesárea eletiva com 39 semanas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099605](#)

Questão 110 Interações medicamentosas

Mulher, 35a, G5P4C0A1, vem à Unidade Básica de Saúde para orientação de anticoncepção. Antecedente pessoal: tuberculose em tratamento com rifampicina e isoniazida. Paciente não deseja uso de método contraceptivo intrauterino. O

MÉTODO INDICADO É:

- A Injetável combinado mensal.
- B Implante de etonogestrel.
- C Anticoncepcional oral de progestágeno.
- D Anticoncepcional oral combinado.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099594](https://www.me/medicinalivre)

Questão 111 Métodos hormonais combinados

Mulher, 20a, comparece à Unidade Básica de Saúde para esclarecer dúvidas com relação ao uso de anticoncepcional oral combinado (ACO). Refere fazer uso regular de etinilestradiol 0,02 mg e levonorgestrel 0,10 mg há 6 meses, porém esqueceu de iniciar nova cartela há 3 dias. Refere relação sexual 3 vezes na semana e não deseja engravidar. A CONDUTA É:

- A Retornar uso do ACO habitual, pois ainda não ocorreu a ovulação (primeira fase do ciclo).
- B Prescrever etinilestradiol 0,03 mg e levonorgestrel 0,15 mg por dia por 21 dias, pois aumentando a dosagem do ACO pode-se prevenir a ovulação.
- C Prescrever os três comprimidos de ACO esquecidos (dose única) para evitar a ovulação.
- D Prescrever levonorgestrel 15 mg dose única para inibir possível ovulação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099583](https://www.me/medicinalivre)

Questão 112 Incontinência urinária

Mulher, 40a, G2P2C0A0, vem encaminhada da Unidade Básica de Saúde com queixa de perda urinária precedida de urgência há 3 anos. Refere frequência urinária de 9 vezes durante o dia e 1 vez à noite. Nega enurese noturna. Realizou fisioterapia perineal e mudanças comportamentais sem melhora significativa do quadro. Antecedentes pessoais: glaucoma e diabetes mellitus há 3 anos. Medicamentos em uso: Metformina e colírio de pilocarpina. Exame ginecológico: não apresenta prolapso genitais ou perdas urinárias durante a manobra de valsava. A CONDUTA É:

- A Beta 3 adrenérgico oral.
- B Anticolinérgico oral.
- C Cirurgia de Sling.
- D Cirurgia de Burch.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099573](https://www.me/medicinalivre)

Questão 113 Clampeamento tardio do cordão

Criança a termo, nasce com boa vitalidade, chorando, tônus muscular em flexão. O recém-nascido é colocado sobre o abdome da mãe. O CLAMPEAMENTO DO CORDÃO DEVE SER REALIZADO:

- A Imediatamente após o nascimento.
- B Até 30 segundos após o nascimento.
- C Entre 30 a 60 segundos após o nascimento.
- D De um a três minutos após o nascimento.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099564](https://www.4000099564.com)

Questão 114 **Apresentação e Diagnóstico Clínicos**

Menina, 3 meses, em consulta de rotina de puericultura. Mãe refere que há uma semana vem tendo dificuldade progressiva para trocar as fraldas. Antecedente gestacional: pré-natal sem intercorrências, parto cesárea por apresentação pélvica. Exame físico: assimetria de pregas glúteas, limitação da abdução da articulação do quadril esquerdo. O DIAGNÓSTICO É:

- A Displasia do desenvolvimento do quadril.
- B Artrogripose.
- C Sequela de toco-traumatismo.
- D Epifisiolistese.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099555](https://www.4000099555.com)

Questão 115 **Tratamento Tratamento da anemia ferropriva**

Lactente, 11 meses, apresenta-se com mucosas descoradas e palidez cutânea. Está inapetente e com geofagia. Dieta essencialmente láctea e baixa ingestão de alimentação sólida. Hb= 9,5 g/dL Htc= 29%; Reticulócitos= 1,7%; VCM= 62fl; HCM= 22pg; RDW= 18%; Ferritina= 8ng/mg. A CONDUTA É:

- A Investigar alergia à proteína do leite de vaca.
- B Investigar parasitose.
- C Solicitar eletroforese de hemoglobina.
- D Prescrever sulfato ferroso.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099546](https://www.4000099546.com)

Questão 116 **Diagnóstico**

Lactente, 10 meses, com febre, tosse e coriza há 4 dias e aparecimento de exantema maculopapular morbiliforme com início nas orelhas descendo para o tronco hoje. Vacinas: todas as indicadas até os 6 meses de idade. Exame físico: T= 39°C; Orofaringe: lesões de 2 a 3 mm de diâmetro, discretamente elevadas, de cor branca com base eritematosa, localizadas na região interna da mucosa oral. AO INTERNAR, DEVERÁ SER ESTABELECIDO A SEGUINTE PRECAUÇÃO:

- A Padrão.
- B Aerossóis.
- C Gotículas.
- D Contato.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099536](https://www.4000099536.com)

Questão 117 Agente etiológico **Pediatria**

Menino, 4ª queixa de prurido perianal, exacerbado a noite com sono intranquilo e irritabilidade. O irmão mais velho já teve sintomas semelhantes há mais ou menos um mês. Exame físico: sem alterações. O AGENTE ETIOLÓGICO É:

- A Trichuris trichiura.
- B Enterobius vermicularis.
- C Ancylostoma duodenalis.
- D Strongyloides stercoralis.

4000099526

Questão 118 Intertrigo por cândida **Dermatite de fraldas**

Lactente, 3 meses, há 15 dias com eritema intenso em nádegas e porções internas das coxas. Há dois dias com piora do eritema e aparecimento de lesões-satélite papulovesiculares minúsculas. A CONDUTA É:

- A Limpeza da área com água bicarbonatada, utilizar oxido de zinco a cada troca de fraldas e suspensão do uso de fraldas descartáveis.
- B Limpeza da área com água, deixar a criança o maior tempo possível sem fraldas e corticosteroide tópico.
- C Limpeza da área com água, deixar a criança o maior tempo possível sem fraldas e agente antifúngico tópico.
- D Limpeza da área com água bicarbonatada, corticosteroide tópico e suspensão do uso de fraldas descartáveis.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099517](#)**Questão 119** Abordagem

Menino, 9a, é atendido na Unidade Básica de Saúde. Os pais referem que é o mais baixo da classe e que não está crescendo. É hígido, ativo e tem uma alimentação saudável. Exame físico: estatura está abaixo do percentil 3 da curva de crescimento adotada pelo Ministério da Saúde. A CONDUTA É:

- A Verificar a velocidade de crescimento nos últimos 6 meses, canal de crescimento e solicitar radiograma de mão e punho para avaliação de idade óssea.
- B Verificar o canal parental e orientar os pais para retorno em 6 meses.
- C Confirmar a baixa estatura para idade e a partir dos dados antropométricos, tranquilizar a mãe que no futuro isto será corrigido.
- D Confirmar a baixa estatura abaixo do percentil 3 para idade, solicitar retorno em 6 meses e pedir para trazer dosagem de TSH e T4 livre.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099509](#)**Questão 120** Tratamento

Menina, 2a, é trazida pela mãe à Unidade de Emergência por febre há 7 dias, aparecimento de feridas na boca e secreção ocular não purulenta há 3 dias. Vacinação em dia. Exame físico: FR= 22 irpm, FC= 132 bpm, T=38,9°C, descorado+/4+, anictérico; pescoço: linfonodo palpável em cadeia cervical direita 3-4 cm; pele: exantema polimorfo principalmente em tronco; olhos: hiperemia ocular não purulenta bilateralmente; orofaringe: língua em framboesa e queilite; membros: eritema em palmas de mão e plantas de pé. A CONDUTA É:

- A Penicilina benzatina.
- B Hidratação.
- C Imunoglobulina humana.
- D Vitamina A.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099497](#)

Questão 121 Plano A

Menino, 5a, é levado a Unidade Básica de Saúde com cinco a seis evacuações/dia, fezes líquidas sem sangue ou muco há dois dias. Exame físico: FC= 96 bpm, FR= 18 irpm, PA= 98x64 mmHg, T= 38,4°C, perfusão de dois segundos, mucosas úmidas. O TRATAMENTO DO QUADRO É:

- A O uso de probióticos.
- B A correção da alcalose metabólica.
- C A reposição das perdas hidroeletrólíticas.
- D O uso de antibióticos.

4000099484

Questão 122 Epidemiologia

Menino, 2a, apresenta dor abdominal e 5-6 evacuações líquidas por dia, com muco e sangue, há 5 dias. Há 24 horas evoluiu com piora progressiva do estado geral, palidez e diminuição da diurese. Exame físico: apático, irritado, mucosas úmidas, perfusão de 3 segundos, descorado +++/4+, palidez intensa, icterícia +/4+; FR= 56 irpm, FC= 140 bpm, T= 36,8° C, PA= 122x76 mmHg; edema de membros inferiores ++/4+. O AGENTE ETIOLÓGICO DESENCADEANTE DO QUADRO É:

- A Escherichia coli.
- B Rotavírus.
- C Salmonella spp.
- D Streptococcus do Grupo B.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099475](#)

Questão 123 Etiologia e Epidemiologia

Menino, 18 meses, é trazido à Unidade de Emergência por estar com febre há 2 dias, associada a coriza e tosse de “cachorro” que piorou esta noite. Exame físico: T=38,2°C; FC= 120 bpm; FR = 54 irpm; perfusão periférica menor que dois segundos; irritado, com hiperextensão do pescoço, estridor inspiratório aos esforços, retração de fúrcula e tiragem intercostal; pulmão: murmúrio vesicular diminuído globalmente. O AGENTE ETIOLÓGICO É:

- A Metapneumovírus.
- B Adenovírus.
- C Haemophilus influenzae não tipável.
- D Parainfluenza.

Questão 124 Diagnóstico

Menino, 3a, é trazido ao Pronto Socorro por dor no membro inferior direito e dificuldade para deambular há 1 dia. Nega febre. Antecedente familiar: irmão com quadro de resfriado há 10 dias. Exame físico: T= 36,8°C; FR= 16irpm; FC= 90bpm; membros: limitação a rotação interna e externa do quadril direito, não realiza extensão completa do membro inferior direito. O DIAGNÓSTICO É:

- A Febre reumática.
- B Doença de Legg-Calve-Perthes.
- C Sinovite transitória.
- D Artrite idiopática juvenil.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099458](https://www.4000099458.com.br)

Questão 125 Estenose Hipertrófica do Píloro Diagnóstico

Menino, 60 dias de vida, é trazido para consulta de puericultura. A mãe refere que há cinco dias o filho está irritado, mamando mais vezes, com aumento das regurgitações e parece estar sempre com fome. Relata diminuição da diurese e das evacuações. Antecedentes pessoais: aleitamento materno exclusivo com bom ganho ponderal até a última consulta. Exame físico: ganho ponderal de 10g/dia no último mês, com altura e perímetro cefálico dentro do esperado; corado, hidratado, irritado; abdome: distendido. Durante o exame, quando mamou, regurgitou rapidamente. A CONDUTA É:

- A Solicitar ultrassonografia de abdome.
- B Solicitar urocultura.
- C Reavaliar a técnica de amamentação.
- D PHmetria esofágica de 24 horas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099448](https://www.4000099448.com.br)

Questão 126 Intoxicações Exógenas

Menina, 13a, é encaminhada à Unidade de Emergência Pediátrica com sonolência, fala sem nexo, movimentos irregulares e dificuldade de marcha há 3 dias, sempre no mesmo horário, por volta de meio dia e melhora ao longo do dia. Antecedentes familiares: irmão de 5 anos em tratamento de epilepsia. Exame físico: FC= 110 bpm; FR= 24 irpm; PA= 100x60 mmHg. Neurológico: sonolenta, desorientada, nistagmo bilateral, força muscular avaliação prejudicada, reflexos presentes; marcha de base alargada, cambaleante.

- A Tumor de cerebello.
- B Intoxicação exógena.
- C Epilepsia.
- D Transtorno neurovegetativo somatoforme.

4000099439

Questão 127 Refluxo Gastroesofágico RGE Pediatria

Menina, cinco meses, é levada à Unidade Básica de Saúde pela avó por apresentar 15 episódios de regurgitações/dia de

leite. Peso ao nascimento = 3.250g. Peso atual = 6.850g. A REGURGITAÇÃO DESSA LACTENTE É UMA CONDIÇÃO:

- A Que deve ser tratada com ranitidina ou omeprazol.
- B Que pode levar a baixo ganho ponderal e requer decúbito elevado.
- C Decorrente de relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico.
- D Frequente e inócua até os 12 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099429](#)

Questão 128 **Síndrome de Loffler** **Pneumonia de origem parasitária** **Pediatria**

Menino, 4a, é atendido por história de cinco pneumonias, todas com resolução total. Os episódios foram caracterizados por febre baixa, cansaço e tosse seca que durava uma semana e dificultava o sono. Os radiogramas de tórax no diagnóstico evidenciavam opacidade heterogênea (alvéolo-intersticial) em diferentes campos pulmonares a cada episódio. Radiogramas de tórax de controle normais. OS EXAMES PARA A CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA SÃO:

- A Prova tuberculínica e cultura de escarro.
- B Hemograma e parasitológico de fezes.
- C IgE total e tomografia de tórax.
- D Sorologia para Bordetella pertussis e Mycoplasma pneumoniae.

4000099417

Questão 129 **Diagnóstico**

Mulher, 32a, procura Unidade de Pronto Atendimento por dor em pontada, contínua e progressiva no quarto e quinto dedos da mão direita há 1 mês, com piora há 3 dias associada a palidez e parestesia ao estender roupas no varal, sem melhora com analgésicos. Exame físico: PA= 124x76 mmHg, FC= 87 bpm, FR= 17 irpm, Oximetria de pulso (ar ambiente)= 99%. PARA O DIAGNÓSTICO DEVE-SE REALIZAR A MANOBRA DE:

- A Adson.
- B Phalen.
- C Neer.
- D Cattell Braasch.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099408](#)

Questão 130 **Fisiopatologia** **Conduta** **Definição**



Homem, 29a, está internado devido a fraturas fechadas de fêmur e tíbia, com tala em membro inferior. No segundo dia de internação evolui com rebaixamento do nível de consciência, petéquias em região esternal no tórax, T= 39°C, PA= 80x45 mmHg, FC= 130 bpm, FR= 32 irpm, Oximetria de pulso (máscara 2L/min)= 95%. Tomografia computadorizada de tórax: O DIAGNÓSTICO É:

- A Tromboembolismo pulmonar.
- B Pneumonia intra-hospitalar.
- C Síndrome da embolia gordurosa.
- D Pneumotórax bilateral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099400](#)

Questão 131 Diagnóstico e Estadiamento

Homem, 57a, procura Unidade Básica de Saúde referindo sangue na urina há 3 semanas. Nega dor abdominal, disúria ou urgência miccional. Antecedentes Pessoais: diabetes mellitus, tabagismo 40 maços/ano, trabalha há 30 anos em fábrica de tinta. Exame físico: PA= 119x76mmHg, FC= 89bpm, FR= 18irpm. Abdomen: plano, normotenso, descompressão brusca dolorosa negativa, ausência de massas palpáveis, Sinais de Murphy e Giordano ausentes. Exame sumário de urina: Hemácias= 1.000.000/ml, leucócitos= 10/ml; nitrito= negativo. A CONDUTA É SOLICITAR:

- A Cintilografia renal estática com DMSA.
- B Radiograma simples de abdome.
- C Proteinúria de 24 horas.
- D Ultrassonografia de bexiga.

4000099380

Questão 132 Cálculos de estruvita Cirurgia

Mulher, 36a, procura Pronto Socorro com dor e urgência para urinar há 1 dia. Antecedente Pessoal: Nefrolitíase. Exame sumário de urina: pH= 7,8; Nitrito= positivo; Leucócitos= 740.000/ml; Hemácias= 20.000/ml; Bactérias= numerosas; Cristais= em forma de “tampa de caixaão”. Radiograma de abdome: O CRISTAL É COMPOSTO POR:



- A Cálcio.
- B Ácido úrico.
- C Estruvita.
- D Uratos amorfos.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

4000099370

Questão 133 Manejo Clínico

Mulher, 22a, foi trazida ao hospital devido a traumatismo de crânio grave. Encaminhada à UTI após procedimento cirúrgico. Exame físico: PAM= 73 mmHg, FC= 112 bpm, Pressão intracraniana = 22 mmHg, ventilação mecânica $\text{FiO}_2 = 0,60$, PEEP= 8 cmH₂O, oximetria de pulso 100%. Sódio= 147mEq/L, Potássio= 4,1mEq/L, hemoglobina= 9,7g/dL, RNI= 1,3, R=1,1. A CONDUTA É:

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

- A Manter decúbito em proclive.
- B Manter sódio entre 130 e 135 mEq/L.
- C Prescrever corticosteroide.
- D Prescrever noradrenalina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000099348

Questão 134 PréRequisitos

Homem, 19a, interna na Unidade de Terapia Intensiva por traumatismo craniano grave. Exame físico: PA= 123x84 mmHg, FC= 104bpm, T= 36,8°C, oximetria de pulso (FiO_2 100%)= 100%; Neurológico: Escala de Coma de Glasgow 3, pupilas midriáticas e não fotorreagentes. PARA INICIAR O PROTOCOLO DE MORTE ENCEFÁLICA É NECESSÁRIO QUE:

- A O médico pertença a equipe de transplante.
- B O intervalo entre os dois exames clínicos seja de seis horas.
- C Haja observação em hospital pelo período mínimo de seis horas.
- D No teste de apneia, a PaCO_2 permaneça abaixo 35mmHg.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099334](#)

Questão 135 Tipos de Sutura e Suas Principais Características

Homem, 62a, procura a Unidade de Pronto Atendimento devido a mordedura por primata há 8 horas. Antecedente pessoal: diabetes mellitus. Exame físico: antebraço direito: lesão em torno de 4 cm de extensão, sangrante. Realizada limpeza local e sorovacinação antirrábica. A CONDUTA É:

- A Desbridamento da lesão e sutura com pontos Donati.
- B Aproximação das bordas sem efeito hermético e curativo oclusivo.
- C Irrigação suplementar com solução alcoólica de iodopovidona.
- D Curativo oclusivo com antibiótico tópico, com troca em 7 dias.

4000099322

Questão 136 Colonoscopia

Homem, 63a, veio ao Pronto Socorro referindo dor abdominal em cólica e um episódio de evacuação com sangue vivo há 1 dia. Exame físico: PA= 130x80 mmHg, FC= 78bpm, FR= 14irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 98%; abdome: plano, normotenso, sem visceromegalia e sem irritação peritoneal; toque retal: sem sangue em dedo de luva ou massa. Hematócrito= 36%, hemoglobina= 11,8g/dL, RNI= 1,02 e R= 0,97. Endoscopia digestiva alta: normal. A CONDUTA É:

- A Pesquisa de sangue oculto nas fezes.
- B Radiograma de abdome ortostático e decúbito.
- C Colonoscopia.
- D Ultrassonografia de abdome.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099305](#)

Questão 137 Laceração Aórtica Cirurgia

Homem, 27a, motociclista, trazido à Unidade de Pronto Atendimento referindo que colidiu em alta velocidade contra anteparo fixo. PA= 148x92 mmHg, FC= 87bpm, FR= 17irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 98%. Radiograma de tórax: O DIAGNÓSTICO É:



- A Contusão pulmonar.
- B Ruptura traumática da aorta.
- C Tórax instável.
- D Contusão cardíaca.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099288](https://www.4000099288.com)

Questão 138 Fraturas do Úmero Lesão Nervosa

Homem, 22a, é trazido ao Pronto Socorro após queda do telhado. Exame físico: PA= 130x75 mmHg, FC= 84 bpm, FR= 16 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 99%; neurológico: Escala de Coma de Glasgow= 15 e pupilas isofotorreagentes; membro superior esquerdo: deformidade e dor intensa na transição entre terço médio e distal do braço, com incapacidade de estender o punho e os dedos nas articulações metacarpofalângicas. O NERVO LESIONADO É:

- A Ulnar.
- B Radial.
- C Mediano.
- D Musculocutâneo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099265](https://www.4000099265.com)

Questão 139 Trauma Cervical Cirurgia

Homem, 22a, procura atendimento médico por acidente na região cervical anterior com linha de cerol. Exame físico: PA= 124x78 mmHg, FC= 80bpm, FR= 16irpm, Oximetria de pulso (ar ambiente)= 97%; neurológico: Escala de Coma de Glasgow= 15 e pupilas isofotorreagentes; região cervical: lesão cortante horizontal em torno de 2,5 cm abaixo da cartilagem tireoide, com entrada e saída de ar conforme movimento respiratório e mínimo sangramento. A CONDUTA INICIAL É:

- A Via aérea definitiva.
- B Sutura do ferimento.
- C Curativo compressivo.
- D Radiograma de região cervical.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099245](#)

Questão 140 Classificação Quadro Clínico e Indicações de Tomografia de Crânio Classificação

Mulher, 70a, chega ao Pronto Socorro após queda da própria altura. Antecedente pessoais: hipertensão arterial sistêmica em uso de losartana 50mg/dia e acidente vascular isquêmico transitório em uso de ácido acetilsalicílico 100mg/dia. Exame físico: PA= 152x87 mmHg, FC= 72bpm, FR= 16irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 99%; Face: ferimento em torno 2,0 cm na região do supercílio esquerdo; neurológico: Escala de Coma de Glasgow= 15 e pupilas isocóricas fotorreagentes. Realizou-se sutura. A CONDOTA É:

- A Radiograma de crânio.
- B Alta médica.
- C Antibiótico por 48 horas.
- D Observação clínica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099225](#)

Questão 141 Diagnósticos Diferenciais

Homem, 40a, procura atendimento médico referindo dor em andar superior do abdome, com irradiação para flancos, associada a náusea e vômitos. Antecedentes pessoais: etilismo há 15 anos, 1 garrafa de destilada/dia. Amilase= 854UI/L, Lipase= 378UI/L, AST= 308UI/L, ALT= 674UI/L. Ultrassonografia de abdome: colelitíase e coledocolitíase, sem dilatação de vias biliares extra-hepáticas. AS ALTERAÇÕES DA AMILASE E LIPASE ESTÃO ASSOCIADAS A:

- A Cirrose hepática.
- B Colangite.
- C Obstrução do ducto cístico.
- D Obstrução do ducto pancreático.

4000099211

Questão 142 Via Aérea Dispositivos de Ventilação Extraglóticos e Supraglóticos Cirurgia

Mulher, 27a, trazida para Unidade de Pronto Atendimento, vítima de incêndio, resgatada de ambiente fechado com muita fumaça, queixando-se de náusea e dor de cabeça. Exame físico: PA= 125x85 mmHg, FC= 94bpm, FR= 18irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 99%; neurológico: Escala de Coma de Glasgow= 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes. A CONDOTA É:

- A Oxigênio 100% em máscara sem reinalação.
- B Tratamento sintomático; hidratação.
- C Radiograma de tórax.
- D Hemograma, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina ativada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099195](#)

Questão 143 **Epidemiologia e Fisiopatologia** **Traumatismo Cranioencefálico** **Traumatismo Cranioencefálico**

Homem, 28a, vítima de agressão física é trazido ao Pronto Socorro pelo SAMU. Exame físico: PA= 127x82 mmHg, FC= 68bpm, FR= 16irpm, oximetria de pulso (ar ambiente) 98%; Neurológico: Escala de Coma de Glasgow= 15, pupilas isofotorreagentes, paralisia dos movimentos da hemiface direita. A ESTRUTURA LESIONADA É:

- A Osso temporal do crânio.
- B Nervo auriculotemporal.
- C Nervo Acessório.
- D Osso Maxilar da face.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099182](#)

Questão 144 **Outras Causas de Abdome Agudo Perfurativo**

Mulher, 36a, procura o Pronto Socorro com queixa de dor abdominal, náusea e inapetência há 2 dias, após realização de endoscopia digestiva alta. Realizada polipectomia, na segunda porção do duodeno face posterior. Exame físico: PA= 89x68 mmHg, FC= 126bpm, FR= 20irpm, T= 37,8°C, anictérica; Abdome: plano, flácido, dor a palpação profunda em epigástrio, sem descompressão brusca dolorosa, Sinais de Murphy e Blumberg ausentes. O EXAME COMPLEMENTAR DO ABDOME E O RESULTADO ESPERADO SÃO:

- A Colangiopancreatografia; edema de pâncreas.
- B Exame radiográfico simples; pneumoretroperitônio.
- C Tomografia computadorizada; pneumoperitônio.
- D Esôfago-estômago-duodeno contrastado; área cicatricial com estenose.

Proibida Venda
simples;

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099168](#)

Questão 145 **Exames complementares** **Diagnóstico** **Artrite gonocócica**

Mulher, 38a, procura o Centro de Saúde com história de febre e queda do estado geral há 5 dias. Refere dor articular no período da manhã que melhora ao longo do dia, acometendo cotovelo direito, punho esquerdo e joelho direito. Há dois dias evoluiu com dificuldade de fletir o quarto dedo da mão direita e manchas pelo corpo. Antecedentes pessoais: atraso menstrual há duas semanas. Exame físico: T=38°C, PA=110x70 mmHg, FC=95 bpm; Membros: joelho direito: aumento da temperatura e sinal da tecla positivo. Pele e mão (ANEXO A). A BACTERIOSCOPIA ESPERADA NA ANÁLISE DA SECREÇÃO ARTICULAR É:



Contra preços abusivos
na medicina.

- A Diplococcus Gram negativos intra e extracelulares.
- B Bacilo Gram negativo.
- C Hifas septadas.
- D Coco bacilo Gram negativo.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000099153

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Questão 146 Diagnóstico e tratamento de erisipela e celulite

Homem, 40a, refere hiperemia, dor e edema em tornozelo e pé direito há três dias. Ausência de comorbidades e internações prévias. Exame físico (ANEXO A): EM RELAÇÃO AO USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS A CONDUTA É ADMINISTRAR:



- A Vancomicina ou teicoplanina.
- B Clindamicina ou um macrolídeo em pacientes alérgicos à penicilina.
- C Ceftriaxona.
- D Antibiótico baseado no resultado do swab da lesão.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

4000099118

Questão 147 **Complicações da DRC Doença Mineral e óssea** **Manejo de sintomas**

Mulher, 56a, retorna para consulta de rotina referindo dores ósseas e fraqueza de membros inferiores. Antecedentes pessoais: doença renal crônica secundária a doença policística autossômica dominante e hipertensão arterial controlada com bloqueador de canal de cálcio. Cálcio= 8,3 mg/dL, fósforo= 6,5 mg/dL; fosfatase alcalina= 600 UI/L; taxa de filtração glomerular= 17ml/min/1,73m², PTH= 300 pg/mL. A CONDUTA É:

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

- A Suspender o bloqueador de canal de cálcio, iniciar vitamina D₃.
- B Iniciar restrição dietética de fósforo e suplementar carbonato de cálcio.
- C Aumentar o aporte de cálcio na dieta e iniciar reposição de vitamina A.
- D Iniciar calcitonina e carbonato de cálcio e programar paratireoidectomia.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000099096

Questão 148 **Síndrome nefrótica** **Glomerulonefrite membranoproliferativa**

Homem, 60a, procura Unidade Básica de Saúde com edema progressivo, urina espumosa e redução do volume urinário há dois meses. Exame físico: PA= 124x78 mmHg; edema palpebral bilateral, edema sacral ++/4+, ascite, edema de membros inferiores ++/4+ até raiz de coxas. Pulmões: murmúrio vesicular diminuído em bases pulmonares. Albuminemia= 2,4g/dL; glicemia= 78mg/dL, creatinina= 1,4mg/dL, proteinúria de 24 horas= 10 gramas/24horas; Exame sumário de urina: hemácias= 2/campo, leucócitos= 1/campo, proteína +++/4+. OS DIAGNÓSTICOS SINDRÔMICO E NOSOLÓGICO SÃO:

- A Síndrome nefrótica; glomerulonefrite membranosa.
- B Síndrome nefrótica; nefropatia diabética.
- C Síndrome nefrítica; glomerulonefrite de lesões mínimas.
- D Síndrome nefrítica; glomeruloesclerose focal e segmentar.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099084](#)

Questão 149 Tratamento não medicamentoso

Homem, 51a, retorna à Unidade Básica de Saúde assintomático, com exames. Exame físico: PA= 138x88 mmHg, IMC= 26 kg/m². Glicemia= 90 mg/dL; triglicérides=182 mg/dL e colesterol total= 195 mg/dL. A CONDUTA É:

- A Terapia não farmacológica.
- B Diurético tiazídico.
- C Inibidor da enzima conversora da angiotensina.
- D Betabloqueador.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099072](#)

Questão 150 Tratamento Complicações Quadro clínico

Mulher, 30a, procurou a Unidade de Pronto Atendimento com febre, mal-estar, náuseas, dor nas pernas e cefaleia holocraniana há três dias. Refere um episódio de vômito e 4 evacuações amolecidas hoje. Antecedentes epidemiológicos: casos semelhantes na vizinhança. Exame físico: FC= 78 bpm, PA= 110x70 mmHg; pele: discreto exantema macular em tórax, abdome e extremidades; prova do laço negativa. Hematócrito= 51%. A CONDUTA É:

- A Liberar com orientações.
- B Coletar sorologia para dengue.
- C Prescrever ciprofloxacina.
- D Hidratar e repetir hematócrito.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000099062

Questão 151 Tratamento

Homem, 45a, procurou a Unidade Básica de Saúde com história de lesões em palmas das mãos há duas semanas. Fez uso de anti-histamínico, com subsequente piora das lesões. Exame físico (ANEXO A): É CORRETO AFIRMAR:



- A Nesse estágio, há intensa produção de anticorpos contra o patógeno e os títulos não deverão ser utilizados para o seguimento.
- B As lesões observadas são resultantes de mecanismo imune e com ausência do agente etiológico nos exames específicos.
- C As lesões apresentarão remissão com o tratamento antimicrobiano específico.
- D Nos últimos 10 anos observou-se aumento da resistência antimicrobiana do agente etiológico.

4000099051

Questão 152 Farmacológico

Homem, 64a, comparece ao Pronto Socorro com dificuldade respiratória há 2 dias acompanhada de tosse seca, nega febre ou edema de membros. Antecedente pessoal: tabagismo 30 maços/ano, parou de fumar há 2 anos, diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica há 6 meses e iniciou uso inalatório de formoterol e brometo de tiotrópio. Exame físico: agitado, FR=26 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 86%; cianose de extremidades, pulmões: redução global do murmúrio vesicular, com raros sibilos. A CONDUTA É:

- A Gasometria arterial, radiograma de tórax, hemograma, oxigenioterapia, corticosteroides sistêmico e broncodilatadores.
- B Angiotomografia de tórax, eletrocardiograma, oxigenoterapia e anticoagulação plena.
- C Espirometria, radiograma de tórax, hemograma, corticosteroide inalatório, broncodilatadores e antibioticoterapia.
- D Broncoscopia para coleta de lavado brônquico, antibioticoterapia, corticosteroide inalatório e broncodilatadores.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099026](#)

Questão 153 Diagnóstico Tratamento

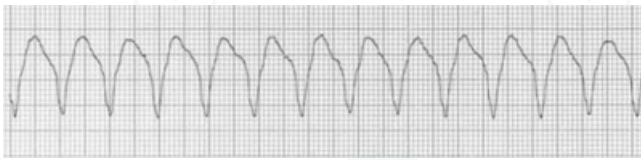
Homem, 48a, procura o Pronto Socorro com queixa de desconforto abdominal e diminuição do volume urinário há 10 dias, sem febre. Antecedente pessoal: cirrose hepática por hepatite C. Exame físico: abdome: ascite presente; membros inferiores: edema ++/4+. Bilirrubina total= 4,2 mg/dL; RNI= 1,55; creatinina= 0,9 mg/dL, albuminemia= 2,8 g/dL; líquido ascítico: proteína= 1,2 g/dL, albumina= 0,8 g/dL, glicose= 88 g/dL, LDH= 182 UI/L, leucócitos= 480/mL (neutrófilos:68%; linfócitos: 20%; monócitos: 8%; células mesoteliais: 4%), hemácias= 570/mL, cultura em andamento. O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO SÃO:

- A Peritonite bacteriana espontânea; antibiótico de amplo espectro, sem necessidade de albumina humana.
- B Aguardar resultado da cultura para diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea; iniciar antibiótico dirigido.
- C Peritonite bacteriana espontânea; cefalosporina de terceira geração e albumina humana.
- D Hipertensão portal; diurético de alça e dieta hipossódica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000099015](#)

Questão 154 Abordagem inicial História clínica e anamnese Eletrocardiograma

Homem, 63a, procura o Pronto Socorro queixando-se de dor no peito em aperto com irradiação para face medial de ambos os braços, sudorese e cansaço. No eletrocardiograma de entrada foi detectado supradesnivelamento do segmento ST em derivações anterolaterais. Após abordagem inicial o monitor mostrou o traçado a seguir: A CONDUTA IMEDIATA É:



- A Desfibrilação.
- B Checar pulso.
- C Amiodarona 300 mg endovenosa.
- D Cardioversão elétrica sincronizada.

4000099004

Questão 155 **Síndrome Narcótica** **Intoxicação por Opióides** **Intoxicações Exógenas**

Homem, 43a, encontrado em sua casa pelos familiares, desacordado e ao lado de embalagens vazias e de comprimidos. Tem antecedente de uso de drogas ilícitas e etilismo. Exame físico: letárgico, abertura ocular à estímulo doloroso; balbucia palavras quando estimulado; localiza a dor; olhos: miose bilateral. O TRATAMENTO É:

- A Flumazenil.
- B Fisostigmina.
- C Glicose e tiamina.
- D Naloxona.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000098977

Questão 156 **Manifestações clínicas**

O ACHADO CLÍNICO MAIS CONFIÁVEL PARA AVALIAR INSUFICIÊNCIA VENTRICULAR DIREITA É:

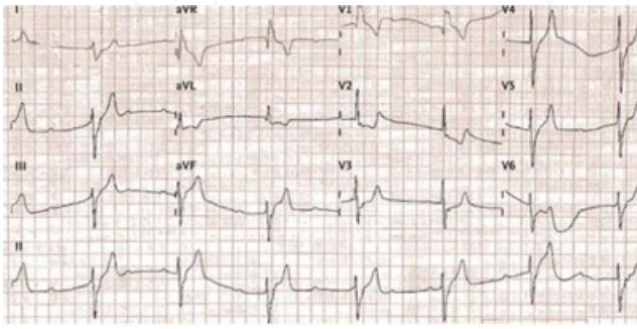
- A Estertores de bulhas finas em bases.
- B Perfusão periférica diminuída.
- C Estase jugular pulsátil a 45°.
- D Edema de membros inferiores.

Acesse t.me/medicinalivre

4000098966

Questão 157 **Infarto Agudo do miocárdio com supra de ST IAMCSST**

Homem, 44a, procura o Pronto Atendimento com precordialgia intensa há 20 minutos. ECG: O DIAGNÓSTICO É:



- A Dissecção de aorta.
- B Isquemia miocárdica.
- C Derrame pericárdico.
- D Pericardite aguda.

4000098951

Questão 158 Abordagem terapêutica

Homem, 75a, internado com insuficiência cardíaca. Exame físico: FC= 118 bpm, PA= 96x60 mmHg, T=36,5°C, pulsos cheios; pulmões: estertores crepitantes em bases pulmonares; membros inferiores: edema +++/+4. O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO INICIAL VISA:

- A Elevar a pressão arterial para evitar a má perfusão de órgãos vitais como rins e fígado.
- B Reduzir a frequência cardíaca para diminuir o consumo de oxigênio no miocárdio.
- C Promover broncodilatação para facilitar o aporte de oxigênio para circulação arterial.
- D Reduzir a pré e a pós carga para melhorar o desempenho do ventrículo esquerdo.

4000098920

Questão 159 Quadro clínico Tratamento da hiponatremia Nefrologia

Homem, 60a, procura atendimento médico por fadiga e dificuldade de concentração. Antecedente pessoal: câncer de pulmão de pequenas células em tratamento. Exame físico: PA= 130x80 mmHg, FC= 80 bpm. Sódio= 125 mEq/L, creatinina= 1,0 mg/dL, ureia= 15 mg/dL, osmolaridade urinária= 350 mmol/kg. A CONDUTA É:

- A Solução salina isotônica.
- B Sais de lítio.
- C Espironolactona.
- D Restrição de ingesta hídrica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000098904](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 160 Diagnóstico da policitemia vera PV

Homem, 48a, retorna a consulta ambulatorial para resultado de exames após acidente vascular cerebral isquêmico há 4 semanas, com boa evolução da fase aguda. Antecedente pessoal: cirurgia bariátrica há 5 anos, sem acompanhamento ou medicações regulares. Hemoglobina= 19,g/dL, VCM= 63fL, hemácias= 7.000.000/ μ L; leucócitos= 18.000/ μ L (segmentados

76%, linfócitos 10%, monócitos 5%; eosinófilos 6%, basófilos 3%), plaquetas= 550.000/ μ L. Ferritina: 4ng/mL. Exame físico: baço palpável a 2 cm do rebordo costal esquerdo. O DIAGNÓSTICO É:

- A Traço talassêmico.
- B Anemia ferropriva.
- C Policitemia Vera
- D Trombofilia hereditária.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000098888](#)

Respostas:

[illegible]

Questão 1 Lei n 8142/1990

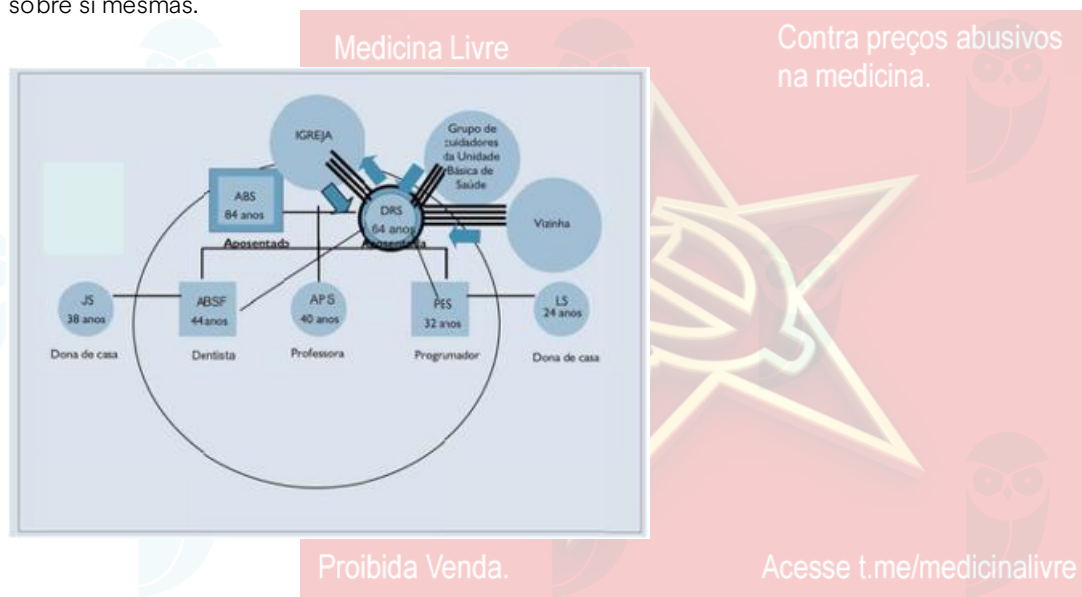
Instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, cuja missão é fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde nas suas mais diferentes áreas, levando as demandas da população ao poder público, por isso é chamado de controle social na saúde. Suas atribuições estão regulamentadas pela Lei nº 8.142/1990.

TRATA-SE DO:

4000141247

Questão 2 Ecomapa

Tem por objetivo a representação dos relacionamentos dos membros da família com os sistemas mais amplos. Desenvolvido como dispositivos de avaliação, planejamento e intervenção familiar, pode ser utilizado para reestruturar comportamentos, relacionamentos e vínculos no tempo com as famílias bem como modificar as percepções das famílias sobre si mesmas.



O INSTRUMENTO DESCRITO E REPRESENTADO PELA IMAGEM É:

4000141246

Questão 3 Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS

O processo saúde-doença é influenciado por uma série de fatores que têm sido estudados e considerados para promover a saúde coletiva.



O MODELO REPRESENTADO NA FIGURA É:

4000141245

Questão 4 **Política Nacional de Humanização**

Segundo a Política Nacional de Humanização (PNH), “as decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva”.

ESTE PRINCÍPIO DA PNH É CONHECIDO COMO:

4000141244

Questão 5 **Projeto Terapêutico Singular**

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família atua de maneira integrada para apoiar as equipes da Atenção Básica, utilizando diversas estratégias. Uma delas é a organização do cuidado em saúde construída entre equipe e usuário, considerando as singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso, onde a identificação das necessidades de saúde, a discussão do diagnóstico e a definição do cuidado são compartilhadas, o que leva a aumento da eficácia dos tratamentos, pois a ampliação da comunicação traz o fortalecimento dos vínculos e o aumento do grau de corresponsabilização.

ESTE INSTRUMENTO É O:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141243](https://www.4000141243.com)

Questão 6 **Intoxicação por Agrotóxicos**

Em 2020, uma multinacional de origem alemã fez um acordo de US\$ 10,9 bilhões para encerrar processos nos Estados Unidos, relacionados ao uso de um herbicida, considerado como provavelmente carcinogênico pela Agência Internacional para Pesquisa do Câncer (2015). O produto é o agrotóxico mais vendido no Brasil, onde seu uso é permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

O HERBICIDA ENVOLVIDO É:

4000141242

Questão 7 **Outras Resoluções Pareceres e Recomendações do Conselho Federal de Medicina CFM**

A Resolução nº 2.110/2014 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre a normatização dos serviços pré-hospitalares móveis de urgência e emergência no território nacional, determina no Art. 14. “Vaga zero é prerrogativa e responsabilidade exclusiva do médico regulador de urgências, e este é um recurso essencial para garantir acesso imediato aos pacientes com risco de morte ou sofrimento intenso, devendo ser considerada como situação de exceção e não uma

prática cotidiana na atenção às urgências”.

DIANTE DA SUPERLOTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA, CASO O MÉDICO DEIXE DE RECEBER UM PACIENTE, PODERÁ SER RESPONSABILIZADO POR:

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141241

Questão 8 Mistanásia

Considerando a relevância da temática da morte no campo da Bioética para o meio acadêmico, para a prática assistencial e de pesquisa no campo da saúde, é necessário diferenciar o direito à deliberação acerca dos modos de morrer.

O CONCEITO PROPOSTO PARA DESIGNAR UMA MORTE INFELIZ, INDIGNA E PRECOCE EM RAZÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E DA OMISSÃO DO ESTADO EM COMBATER AS VIOLÊNCIAS E AS INÚMERAS MANIFESTAÇÕES DE PRECONCEITOS DE RAÇA, CLASSE, GÊNERO, ETNIA, ORIENTAÇÃO SEXUAL QUE VULNERABILIZAM PARCELAS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, EXPONDO-AS A MAIORES RISCOS DE MORTE PREMATURA É:

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141240

Questão 9 Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora PNSTT

O COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE ABRANGE A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOS AGRAVOS (ACIDENTES, INTOXICAÇÕES, ENTRE OUTROS) E DOENÇAS RELACIONADOS AO TRABALHO E A VIGILÂNCIA DOS AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, EM ESTABELECIMENTOS E ATIVIDADES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO, URBANOS E RURAIS, É A:

4000141239

Questão 10 Odds Ratio ou Razão de Chances

Um estudo de prevalência investigou fatores associados à asma (referida e com espirometria) em amostra representativa de indivíduos maiores de 20 anos de uma região. A tabela abaixo apresenta Odds Ratio entre alguns fatores investigados e asma, por meio de análise logística múltipla:

Fatores investigados	Odds Ratio	Intervalo de confiança 95%
Morador zona rural	1,03	0,67-1,57
Tabagismo	1,89	1,26-2,84
IMC (kg/m ²)		
< 18,5	1,40	0,84-2,35
18,5-24,9	1,00	
≥ 25	1,35	0,79-2,28
Antecedente familiar	1,44	1,02-2,04
Mofo visível na residência	1,47	0,96-2,25

Acesse t.me/medicinalivre

CITE OS FATORES ESTATISTICAMENTE ASSOCIADOS À ASMA NO ESTUDO:

4000141238

Questão 11 Probabilidade préteste e valor preditivo positivo Valor Preditivo Positivo

Sabendo-se que a prevalência de uma doença na população é de 10%, um teste com sensibilidade de 80% e especificidade de 90% foi aplicado em uma população de 1.000 pessoas.

O NÚMERO DE INDIVÍDUOS FALSO-POSITIVOS É:

4000141237

Questão 12 Valor Preditivo Positivo

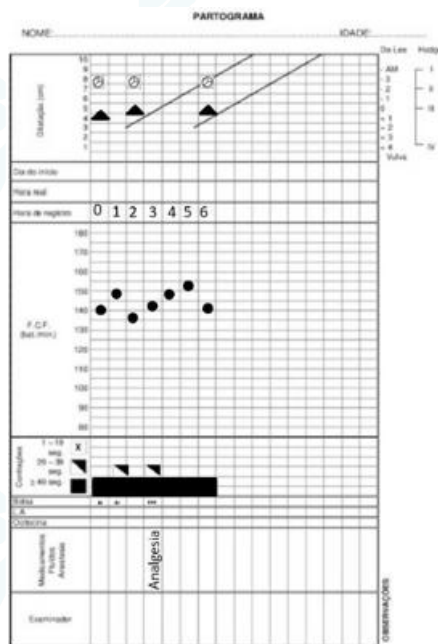
Sabendo-se que a prevalência de uma doença na população é de 10%, um teste com sensibilidade de 80% e especificidade de 90% foi aplicado em uma população de 1.000 pessoas.

O VALOR PREDITIVO POSITIVO DO TESTE É:

4000141236

Questão 13 Obstetrícia Partograma

Mulher, 39a, G3P2C0A0, idade gestacional de 40 semanas e 2 dias e sem comorbidades, interna para assistência ao parto. Apresenta evolução de seu trabalho de parto representada no seguinte partograma:



A CONDUTA MEDICAMENTOSA É:

4000141235

Questão 14 Assistência pré-natal Obstetrícia Imunização na gestação

Mulher, 19a, G2P1A0C0, comparece a Unidade Básica de Saúde no dia 15 de abril de 2020 para consulta de pré-natal. Data da última menstruação de certeza 15 de novembro de 2019. Traz carteira vacinal: tríplice viral (reforço há 3 anos), HPV (2 doses), febre amarela (1 dose há 3 anos), antitetânica (3 doses, última há 10 anos), DTPa (1 dose há 2 anos, na sua primeira gestação), influenza (última dose há 1 ano), Hepatite B (três doses há 2 anos, na sua primeira gestação).

AS DUAS VACINAS A SEREM REALIZADAS NESTA CONSULTA DE PRE NATAL SÃO:

4000141234

Questão 15 Prolapsos de órgãos pélvicos

Mulher, 69a, G5P5C2, comparece ao ambulatório com queixa de “bola na vagina” há 3 anos, com aumento progressivo. Antecedente pessoal: menopausa há 19 anos. O exame ginecológico e a classificação segundo o Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) estão abaixo:



Classificação segundo *Pelvic Organ Prolapse Quantification*

Aa +3	Ba +6	C -8
Hiato Genital 5 cm	Corpo Perineal 2 cm	Comprimento Vaginal 9 cm
Ap -3	Bp -3	D -9

O DIAGNÓSTICO É:

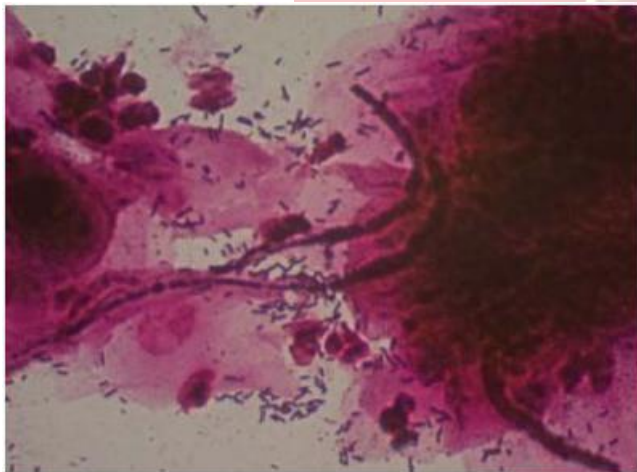
Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141233](https://www.4000141233.com)

Questão 16 Abordagem da paciente com queixa de corrimento vaginal **Candidíase**

Mulher, 35a, G1P1, procura atendimento com queixa de corrimento vaginal há dois meses. Nega odor e refere prurido leve. Em uso de anticoncepcional oral combinado. À bacterioscopia da secreção vaginal:



Acesse t.me/medicinalivre

O DIAGNÓSTICO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141232](https://www.4000141232.com)

Questão 17 Células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas ASCUS

Mulher, 26, retorna para consulta na Unidade Básica de Saúde para resultado de exame de colpocitologia oncológica colhido há um mês: amostra adequada, alterações celulares inflamatórias. A coleta anterior realizada há 1 ano tinha resultado de ASCUS- atipias de células escamosas de significado indeterminado.

ALÉM DAS ORIENTAÇÕES DE SEXO SEGURO E ANTICONCEPÇÃO SUA ORIENTAÇÃO QUANTO AO

Questão 18 Herpes genital

Mulher, 30a, G2P2, comparece ao pronto atendimento com queixa de lesões dolorosas em região genital há 2 dias, associadas a disúria. Nega episódios anteriores. Antecedentes pessoais: última menstruação há 15 dias; nega uso de condom e refere última relação sexual há 6 dias. Em uso de anticoncepcional oral combinado. À inspeção genital:

**O DIAGNÓSTICO É:**Essa questão possui comentário do professor no site [4000141230](https://www.4000141230.com)**Questão 19** Tratamento

Mulher, 26a, com queixa de infertilidade primária há 2 anos, procura atendimento em serviço de referência, com desejo de engravidar. Nega outras queixas. Refere ciclos menstruais regulares que duram 3 dias com intervalo de 30 dias. Exame físico: IMC= 24 Kg/m². Sorologias de HIV e sífilis negativas; dosagem de prolactina e TSH normais. Espermograma do parceiro: sem alterações. Histerossalpingografia com trompas pérvias bilateralmente. Ultrassonografia: sinais de adenomiose, endometriose profunda acometendo reto e ligamentos uterossacros, com suspeita de pelve bloqueada.

O TRATAMENTO INDICADO PARA A INFERTILIDADE DO CASAL É:Essa questão possui comentário do professor no site [4000141229](https://www.4000141229.com)**Questão 20** Síndrome dos ovários policísticos

Mulher, 23a, com queixa de aumento de pilificação em face. Menarca aos 13 anos com ciclos irregulares há cinco anos. Data da última menstruação há 4 meses. Exame físico: IMC= 24kg/m², PA= 100x60 mmHg, Índice de Ferriman e Gallwey= 10. Dosagem de FSH, LH, Prolactina, TSH, 17- alfa-hidroxiprogesterona e testosterona total normais; Beta- hCG= negativo. Ultrassonografia transvaginal: sem alterações.

A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:Essa questão possui comentário do professor no site [4000141228](https://www.4000141228.com)**Questão 21** Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade Obstetrícia Eclâmpsia

Mulher, 25a, G2A1, 34 semanas e 5 dias, comparece à Unidade de Emergência com cefaleia nual, escotomas cintilantes, hiper-reflexia. PA= 170X110 mmHg persistente. Recebeu como tratamento imediato 4g de sulfato de magnésio e anti-hipertensivo, com estabilização clínica. Hb= 11,1mg/dL, Ht= 33%, Plaquetas 180.000 mm³, exame sumário de urina sem alterações, glicemia de jejum= 90mg/dL, AST= 35 U/L, ALT= 32 U/L, proteinúria= 150 mg/24h, creatinina= 0,8 mg/dL. Ultrassonografia obstétrica: peso fetal estimado no percentil 2, ILA= 40 mm e Doppler normal.

O DIAGNÓSTICO É

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141227](https://www.4000141227.com)

Questão 22 Hemorragias pós parto HPP e rotura uterina Puerpério Diagnóstico de HPP

Mulher, 35a, G5P4C0A0, evolui para parto taquitócico e recém-nascido pesou 4100g. Após 45 minutos apresentou dequitação placentária e imediatamente evoluiu para sangramento aumentado por via vaginal. Índice de choque: 1,5. Exame físico: presença de massa palpável arredondada se exteriorizando pela vagina, dolorosa à manipulação.

O DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141226](https://www.4000141226.com)

Questão 23 Sangramento uterino anormal

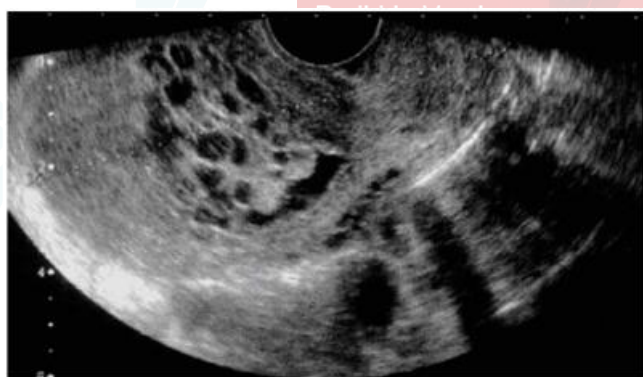
Mulher, 49a, G2P2C2A0, procura atendimento médico com queixa de sangramento vaginal aumentado e irregular há um ano. Nega outras queixas. Antecedente pessoal: hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellito controlados e cirurgia de laqueadura tubária. Exame físico: descorada +/-4, hidratada, afebril, PA= 143x91mmHg, FC= 84 bpm, FR= 15 irpm, Peso= 90kg, Estatura= 1,55m. Exame ginecológico: sem alterações. Ultrassonografia transvaginal: útero de volume 102cm³, eco endometrial 25mm e ovários sem anormalidades. Hemoglobina= 9,8 g/dL e hematócrito= 28%; RNI= 1,0; TSH e T4 livre: normais.

A CONDUTA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141225](https://www.4000141225.com)

Questão 24 Intercorrências obstétricas obstetrícia patológica Doença trofoblástica gestacional Obstetrícia

Primigesta, 16a, com idade gestacional de 10 semanas e 3 dias procura o serviço médico referindo dor abdominal e sangramento vaginal. Nega comorbidades, tabagismo e uso de medicações. Exame físico: FR= 14 irpm, FC= 98 bpm, PA=148x96mmHg, descorada +/-4+, afebril, hidratada; exame especular: sangramento discreto pelo orifício externo do colo; toque vaginal: colo fechado com útero aumentado para 14 semanas. Beta-hCG= 230.000UI/ml e ultrassonografia transvaginal com a imagem:



O CASO ACIMA É COMPATÍVEL COM:

[4000141224](https://www.4000141224.com)

Questão 25 Emergências Pediátricas Pediatria

Menina, 2a, é trazida à Unidade de Emergência com história de vômitos e dor abdominal há 3 dias, com piora progressiva. Nega febre, tosse, diarreia. Refere diurese presente e abundante. Nega comorbidades. Exame físico: regular estado geral, descorada +/-4+, mucosas secas, FC=112bpm; FR=37irpm; T=36,2°C; Enchimento capilar=2 segundos; Pulsos cheios;

Ausência de sinais meníngeos; Oroscofia: sem lesões, tonsilas palatinas sem eritema ou placas purulentas; Otoscopia: membranas timpânicas translúcidas e sem abaulamentos; Pulmões: murmúrio vesicular presente bilateralmente sem ruídos adventícios; Abdome: ruídos hidroaéreos presentes, flácido, indolor, fígado e baço não palpáveis; sem edema.

O PRIMEIRO EXAME COMPLEMENTAR A SER REALIZADO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141223](#)

Questão 26 Tratamento

Menino, 4a, é trazido hoje ao pronto-socorro por febre, cefaleia e vômitos há dois dias. Nega comorbidades. Exame físico: regular estado geral, orientado, corado, eupneico; T=36,3°C; FC=102bpm; FR=26irpm; PA=87x51mmHg; Enchimento capilar=2 segundos; pulsos cheios; rigidez de nuca presente. Líquor: leucócitos=610/mm³ (65% neutrófilos e 35 % linfócitos); hemácias=10.000/mm³; proteína=73mg/dL; glicorraquia=17mg/dL (glicemia=102mg/dL).

A MEDICAÇÃO A SER PRESCRITA É:

4000141222

Questão 27 Doença de Hirschsprung Pediatria

Menina, 11 meses, com história de constipação intestinal desde o nascimento com piora progressiva e necessidade frequente de clister glicerinado para evacuar. Não apresenta controle esfinteriano. Antecedente pessoal: primeira evacuação no quarto dia de vida. Exame físico: hidratada, IMC abaixo do P10; Abdome: distendido; Períneo: ânus tópico, genitália sem anormalidades; Toque retal: esfíncter normotônico e ausência de massas, com eliminação explosiva de fezes.

A PRINCIPAL HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141221](#)

Questão 28 Sinovite Transitória do Quadril

Menina, 2a, é trazida ao pronto-socorro com história de dor e dificuldade para andar há 1 dia. Refere ainda tosse e coriza há 10 dias, com melhora progressiva. Nega febre, trauma ou outras queixas. Nega comorbidades. Exame físico: bom estado geral, corada, hidratada, acianótica, FC=104bpm, FR=27irpm, T=36,5°C. Pulmonar: murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios. Quadril e membros inferiores: ausência de lesões ou hematomas, mobilidade articular preservada, ausência de edema ou eritema. Marcha claudicante, criança evita apoiar o membro inferior direito no chão.

A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141220](#)

Questão 29 Pediatria Escarlatina

Menino, 4a, apresenta febre há 4 dias acompanhada de vômitos e odinofagia. Refere que há 3 dias apareceram lesões avermelhadas na pele, que se iniciaram no tórax e se espalharam por todo o corpo deixando a pele áspera. Exame físico: FC=123 bpm, T=38°C, corado, hidratado, acianótico e anictérico; Pele: descamação em face, pescoço, troncos e membros; ausência de hiperemia e secreção conjuntival; linfonodos cervicais anteriores de 2 cm, indolores e fibroelásticos; Cavidade oral:



O DIAGNÓSTICO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141219](#)

Questão 30 **Pediatria** **Choque em Pediatria**

Menino, 8 meses, previamente hígido, é trazido à Unidade de Emergência com quadro de febre há 4 dias, tosse e coriza, com piora nas últimas 6 horas. Exame físico: FR=65 irpm, FC=183 bpm, T=36,3°C, PA= 82x65mmHg, pulsos cheios, enchimento capilar de dois segundos, oximetria de pulso (ar ambiente)=93%; Pulmões: murmúrio vesicular presente com estertores subcrepitantes nas bases; Coração: bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros, Abdome: flácido, fígado a 5 cm do rebordo costal direito; membros inferiores: sem edemas. Radiograma de tórax:



O DIAGNÓSTICO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141218](#)

Questão 31 **Glomerulonefrite pósestreptocócica** **Síndrome nefrítica**

Menino, 10a, previamente hígido, é trazido ao pronto atendimento por estar com os olhos inchados há dois dias e refere que está urinando menos e de cor bem escura. Exame físico: Bom estado geral; Pulmões: murmúrio vesicular presente, diminuído em bases; abdome: semicírculo de Skoda 2 cm acima da cicatriz umbilical; membros inferiores: edema pré-tibial ++/4+.

O DADO SEMIOTÉCNICO NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR O DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141217](#)

Questão 32 **Estenose Hipertrófica do Píloro** **Alcalose metabólica** **Vômitos**

Menino, 47 dias de vida, é trazido a consulta por quadros de vômitos de cor esbranquiçada, logo após as mamadas. Aleitamento materno exclusivo. Mãe refere que desde o nascimento mantem o mesmo peso. Exame físico: regular estado geral, mucosas secas, irritado, choroso.

O DISTÚRBIO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO ESPERADO NA GASOMETRIA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141216](#)

Questão 33 Epilepsias

Adolescente, 11a, em tratamento de enurese noturna com acetato de desmopressina (DDAVP) intranasal há uma semana, é trazido à emergência por apresentar, subitamente, crise convulsiva tônico-clônica generalizada com perda de consciência. Exame físico: Escala de Coma de Glasgow= 15, sem déficit motor, pares cranianos: sem alteração.

O EXAME LABORATORIAL PARA INVESTIGAR A ETIOLOGIA DA CRISE CONVULSIVA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141215](#)

Questão 34 Intoxicação por Vitamina D Vitamina D Colecalciferol Pediatria

Menino, 7m, internado para recuperação nutricional. Exame físico: regular estado geral, intensa hipotrofia muscular, fâneros quebradiços, diminuição acentuada do tecido celular subcutâneo; Cabeça: fronte olímpica; Tórax: nodosidades ao longo da parede anterior da caixa torácica ao nível das articulações condrocostais.

O QUADRO CLÍNICO ESTÁ ASSOCIADO À DEFICIÊNCIA DE QUAL VITAMINA?

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141214](#)

Questão 35 Divertículo de Meckel Diagnóstico e Tratamento

Menino, 19m, é trazido ao pronto socorro com história de 4 episódios de evacuação com sangue vermelho vivo com coágulos de sangue em grande quantidade nas últimas 10 horas. Nega febre, vômitos e diarreia. Antecedente pessoal: nega sangramentos prévios. Exame físico: regular estado geral, descorado 3+/4+, FC=144bpm, FR=30irpm, PA=78x38mmHg; Abdome: dor leve à palpação abdominal, fígado e baço não palpáveis; Pele: sem alterações; Toque retal: presença de sangue vivo em dedo de luva. Hb=6,3 g/dL; Leucócitos=8760/mm³, Plaquetas= 234.000/mm³; R=0,83, RNI=0,95.

O DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO MAIS FREQUENTE É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141213](#)

Questão 36 Pneumonia afebril do lactente

Menina, 72 dias, é trazida ao pronto socorro com queixa de que há cinco dias apresenta tosse em crise e falta de ar. Nega febre. Antecedentes Pessoais: parto normal, peso de 3000g e estatura de 50 cm; conjuntivite com 45 dias de vida. Exame físico: bom estado geral, FR=73irpm, FC=165bpm, afebril, acianótica, anictérica, retração intercostal presente; Pulmões: estertores crepitantes em bases pulmonares. Hb=12,5g/dL, Leucócitos=15.280/mm³ (bastões 3%, segmentados 36%, eosinófilos 10%, linfócitos 48%, monócitos 3%). Radiograma de tórax:



O ANTIBIÓTICO A SER INICIADO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141212](#)

Questão 37

Trauma Uretral

Cirurgia

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Homem, 43a, foi admitido no Pronto Socorro após queda de motocicleta. Exame físico: Abdome: palpação dolorosa e abaulamento em região suprapúbica, dor e crepitação à palpação dos trocanteres e abertura da sínfise púbica de 4 cm; Genitais: sangue em meato uretral externo e equimose perineal. Radiograma de bacia: presença de fratura.

A PORÇÃO DA URETRA LESADA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141211](#)

Questão 38

Cefaleias Secundárias

Cefaleia por Hipotensão Liquórica

Neurologia

Mulher, 28a, procura Pronto Socorro por cefaleia intensa que melhora quando deita e piora em pé. Antecedente pessoal: segundo pós-operatório de cirurgia ortopédica sob raquianestesia. Exame físico: PA= 116x78 mmHg, FC= 89 bpm, FR= 18 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 99%.

Proibida venda.

Acesse t.me/medicinalivre

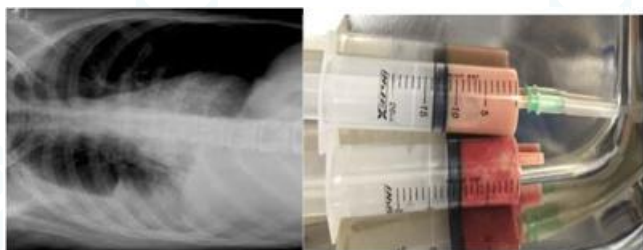
APÓS ANALGESIA E HIDRATAÇÃO ENDOVENOSA POR 36 HORAS, SEM MELHORA, A CONDUTA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141210](#)

Questão 39

Empiema

Homem, 34a, no terceiro dia de tratamento para pneumonia com amoxicilina com clavulanato de potássio, procura Pronto Socorro referindo dor torácica direita e febre contínua. Radiograma de tórax em decúbito lateral direito e punção torácica:



Paciente é encaminhado para internação em Enfermaria e material é enviado para análise laboratorial

A CONDUTA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141209](#)

Questão 40 Escroto Agudo

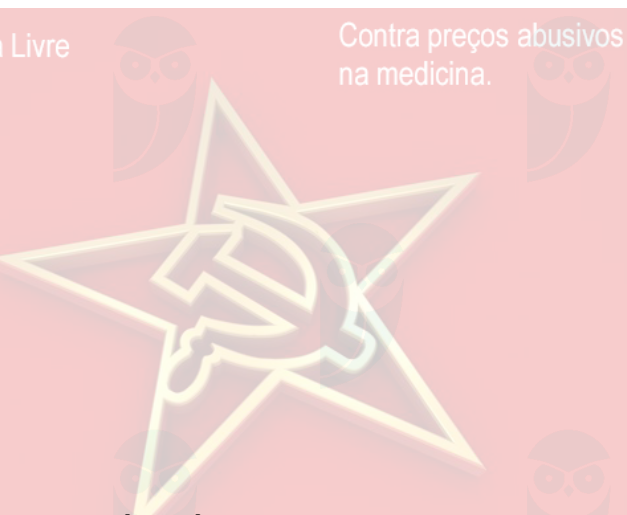
Menino, 7a, procura serviço de emergência terciária por intensa dor testicular esquerda há 4 horas, com 2 episódios de vômitos, sem nenhuma queixa prévia. Exame físico: bolsa escrotal: testículo esquerdo endurecido, hiperemia da pele, reflexo cremastérico duvidoso.

O EXAME A SER REALIZADO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141208](#)

Questão 41 Diagnóstico Atresias e Estenoses Duodenais

Recém-nascido com 6 dias de vida, sexo masculino, apresentando vômitos biliosos desde o 2º dia de vida. Gestação com polidrâmnio. Radiograma de abdome:



O DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO MAIS PROVÁVEL É:

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141207](#)

Questão 42 Medidas Auxiliares na Avaliação Secundária Cirurgia

Homem 27a, trazido ao hospital após queda de escada de 2 metros de altura. Exame físico: descorado +/4+, PA= 102x78 mmHg, FC= 101 bpm, FR= 16 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 98%; Abdome: dor e crepitação à palpação sobre o gradil costal inferior, Glagow= 15. Hematócrito= 38%, Hb= 12,5 g/dL. Ultrassonografia de abdome: lesão de fígado e líquido perihepático.

PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO DEVE-SE REALIZAR:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141206](#)

Questão 43 Protocolo de transfusão maciça Cirurgia

Mulher, 25a, vítima de atropelamento, é trazida por populares ao Pronto Socorro. Exame físico: PA= 83x57 mmHg, FC= 147 bpm, FR= 32 irpm; Abdome: escoriação e hematoma à direita; Neurológico: Glasgow = 7 e anisocoria; Extremidades: deformidade e edema na coxa esquerda. FAST (focused assessment with sonography for trauma) positivo nos espaços hepatorenal e esplenorenal. Realizada intubação orotraqueal, iniciada ventilação mecânica e reposição volêmica de 1000mL de solução de Ringer com lactato aquecido.

ALÉM DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E DA PRESSÃO ARTERIAL, O OUTRO FATOR QUE COMPÕE O “ABC SCORE” PARA PROTOCOLO DE TRANSFUSÃO MACIÇA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141205](#)

Questão 44 **Pseudocisto Pancreático** **Cirurgia** **Pseudocisto**

Homem 41a, procura atendimento médico referindo dor abdominal em andar superior persistente, náusea, plenitude pós prandial há 13 dias. Nega febre. Refere perda de 7Kg em 1 mês. Antecedente Pessoal: tabagista 1 maço/dia há 23 anos, etilista 8 doses/dia há 21 anos, pancreatite aguda há 6 semanas. Exame físico: PA= 113x76 mmHg, FC= 91bpm, FR= 16 irpm, T= 36,2oC, anictérico; Abdome: plano, massa palpável em região epigástrico, fixa e em torno de 8 cm, descompressão brusca indolor. Amilase= 321 U/L, antígeno carcinoembrionário= 3,9 ng/mL. Tomografia abdome:



O DIAGNÓSTICO É:

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141204](#)

Questão 45 **Fraturas e luxações do escafoide e do carpo**

Homem, 21a, tropeça em um degrau na calçada e cai sobre a mão esquerda estendida. Exame físico: eixo do polegar doloroso à compressão; tabaqueira dolorosa à palpação durante desvio ulnar do punho. Radiograma punho:

Proibida Venda.

Acesse [t.me/medicinalivre](#)



O DIAGNÓSTICO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141203](https://www.4000141203.com.br)

Questão 46 Principais fraturas associadas

Homem, 26a, motorista, vítima de acidente automobilístico por colisão frontal contra anteparo fixo. O resgate de dentro das ferragens do veículo demorou 30 minutos pelo aprisionamento dos membros inferiores. Exame físico: PA= 112x73mmHg, FC= 82 bpm, FR= 18 irpm; membro inferior direito: deformidade no joelho e ausência de pulso arterial no dorso do pé. Radiograma:



A LESÃO VASCULAR OCORREU NA ARTÉRIA:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141202](https://www.4000141202.com.br)

Questão 47 Pneumotórax Simples Cirurgia

Homem, 62a, vítima de explosão, é trazido ao Pronto Socorro. Exame físico: PA= 112x67mmHg, FC= 101bpm, FR= 24 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 91%; Vias aéreas: pervias e sem alterações; Pulmão: murmúrio vesicular diminuído à direita; Pele: 13% de queimadura de primeiro grau. Conduta inicial: dois acesos venosos, monitorização cardíaca, oxigênio suplementar (máscara) 12L/min e analgesia. Após as primeiras condutas, exame físico: PA= 121x72mmHg, FC= 88 bpm, FR= 20 irpm, oximetria de pulso 96%. Radiograma de tórax simples anteroposterior:



A CONDUTA É:

Questão 48 Volvo de Sigmoido Cirurgia

Homem, 59a, procura Pronto Socorro com dor bdominal há 5 dias e piora há 12 horas, associada a náuseas e parada de eliminação de fezes e flatos. Nega febre, vômitos e sintomas respiratórios. Antecedente Pessoal: constipação crônica. Radiograma de abdome em decúbito dorsal:



Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.**CONSIDERANDO O QUADRO CLÍNICO O EXAME RADIOLÓGICO EVIDENCIA:**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141200

Questão 49 Síndrome de Realimentação

Homem, 41a, está internado em Unidade de Terapia Intensiva há cinco dias devido a insuficiência respiratória aguda por síndrome do desconforto respiratório agudo secundária a choque séptico de foco pulmonar. Antecedentes pessoais: etilismo: uma garrafa de aguardente/dia. Encontra-se em ventilação mecânica com PEEP= 14 cmH₂O, FiO₂= 60%, em sedação com bloqueio neuromuscular e uso de noradrenalina 0,3 mcg/kg/min. Recebe dieta enteral 2000 Kcal/dia há 2 dias. Exame físico: RASS -5; edema de extremidades ++/4+, pupilas mióticas e fotorreagentes, Ecocardiograma à beira-leito: depressão miocárdica difusa. Exames laboratoriais: fósforo= 1,4 mg/dL; magnésio= 1,1 mg/dL, potássio= 3,1 mg/dL, sódio= 141 mg/dL, CPK= 567U/L, CKMB=13U/L; PCR para SARS-CoV-2= negativo.

COM BASE NOS EXAMES SUBSIDIÁRIOS A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

4000141199

Questão 50 Embolia Gordurosa

Mulher, 25a, internada imediatamente após queda de moto, na qual teve fratura fechada da diáfise do fêmur e da fíbula direitos, há 18 horas. Evolui há 20 minutos com confusão mental e agora com insuficiência respiratória, com necessidade de uso de máscara não reinalante com reservatório. Exame físico: PA= 104x72 mmHg, FC= 124 bpm, FR= 28 irpm, T= 37,9°C e oximetria de pulso (ar ambiente)= 90%. Ausculta cardíaca e pulmonar normais. O membro inferior direito está edemaciado com diversas escoriações. Você é chamado para avaliação, indica a intubação orotraqueal e, quando estão expondo a paciente para o procedimento, identifica essa alteração em axila direita:



A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141198](#)

Questão 51 **Urticária**

Mulher, 22a, admitida no setor de emergência relatando náuseas, dor abdominal, vômitos e surgimento de placas eritematosas e pruriginosas por todo o corpo, iniciados 30 minutos após a ingestão de castanhas. Nega doenças prévias. PA= 112x72 mmHg, FC= 104 bpm, FR= 20 irpm, T= 36,9 °C e oximetria de pulso (ar ambiente)= 97%. Abdome levemente doloroso à palpação, ausculta pulmonar normal.

A CONDUTA IMEDIATA É:

[4000141197](#)

Questão 52 **Marcadores sorológicos**

Homem, 30a, hígido, realizou exames laboratoriais admissionais onde foi encontrado ALT= 60 UI/L (normal < 50 UI/L). Antecedente pessoal: ingestão de bebida alcoólica diária (2-3 cervejas/dia). Foi orientado a parar a ingestão de bebida alcoólica. Exames laboratoriais: AgHBs= reagente; Anti-HBs= não reagente; Anti-HBc= reagente; AgHBe= não reagente; Anti-HBe= reagente; sorologia Hepatite C= não reagente; sorologia Hepatite A: IgG= reagente não reagente.

A CONDUTA INICIAL É:

[4000141196](#)

Questão 53 **Tipos de cálculos renais Cirurgia Fatores de risco para formação do cálculo renal**

Homem, 44a, procura atendimento por dor lombar em cólica à direita, acompanhada de escurecimento da urina e eliminação de dois cálculos pequenos. Refere três episódios semelhantes nos últimos dois anos, com eliminações de cálculos. Antecedentes pessoais: cirurgia bariátrica há três anos.

A COMPOSIÇÃO MAIS PROVÁVEL DO CÁLCULO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141195](#)

Questão 54 **Osteoartrite OA**

Homem, 65a, comparece à consulta em Unidade Básica de Saúde com queixa de dor nos joelhos há um ano, que pior com atividade e melhora ao repouso. Exame físico: PA= 134x84 mmHg, FC= 80 bpm, IMC= 30,2 kg/m², T= 36,2°C; joelhos: presença de discreto derrame articular, sem sinais inflamatórios, com movimentos levemente limitados por dor, limitação da extensão em aproximadamente 10 graus e flexão preservada. Radiogramas de joelhos:



O DIAGNÓSTICO MAIS PROVÁVEL É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141194](#)

Questão 55 Reumatologia Artropatia de Charcot

6. Homem, 60a, refere perda progressiva de sensibilidade em pés, com calosidades frequentes e feridas que demoram para cicatrizar, além de inchaço permanente no pés. Refere dor e dificuldade para apoiar o pé direito no chão há um ano. Antecedente Pessoal: diabetes melito há 25 anos e hipertensão há 15 anos, m uso de insulina, metformina, losartana, carvedilol, furosemida, sinvastatina e cilostazol. Exame físico das extremidades e radiograma de pé:



Contra preços abusivos na medicina.

COM BASE NAS IMAGENS A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141193](#)

Questão 56 Bradiarritmias Eletrocardiograma

Homem, 60a, procura atendimento médico com queixa de dor torácica e tontura. ECG:



Proibida Venda

Acesse t.me/medicinalivre

O DIAGNÓSTICO ELETROCARDIOGRÁFICO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141192](#)

Questão 57 Rabdomiólise

Homem, aparentando 30 anos, é trazido ao setor de emergência de hospital geral por policiais que o contiveram ao encontrá-lo gemente, agressivo, e ameaçando transeuntes. O médico que o recebe tem a impressão de que o paciente tem alucinações visuais e auditivas. Exame físico: desorientado, pálido, T= 36,3°C, com mucosas pouco úmidas e coradas,

sem edemas, FC= 114 bpm, PA= 114x68 mmHg, e a urina tem cor de chá. Exame sumário de urina: cor acastanhada, hemoglobina +++/4+, proteína +++/4+, hemácias 1/campo e leucócitos 5/campo.

A CONDUTA TERAPÊUTICA INICIAL É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141191](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 58 Hematologia Mieloma múltiplo MM

Homem, 68a, queixa-se de dor de intensidade crescente em coluna cervical e lombar. Refere que no último mês a dor tornou-se intensa, piorando com movimento. Refere cansaço e fraqueza. Perda de peso progressiva, cerca de 5 kg em três meses. Exame físico: descorado, PA= 158x90 mmHg, FC= 68 bpm; membros inferiores: edema maleolar +/4+. Exames laboratoriais: cálcio= 11,2 mg/dL, creatinina= 3,5 mg/dL, Hb= 9,5 g/dL, Ht=29,4%, leucócitos= 9.450/mm³, plaquetas= 200.000/mm³. Radiograma de coluna: osteopenia difusa, lesões osteolíticas em vértebras e bacia.

O EXAME COMPLEMENTAR CONFIRMATÓRIO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141190](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 59 Paracoccidioidomicose

Homem, 45a, queixa-se de lesões ulceradas em mucosa de orofaringe com seis meses de evolução, além de lesão ulcerada em membro superior há dois meses. Queixa-se de fadiga, tosse com expectoração mucoide, disfagia e odinofagia, perda ponderal de 6 kg. Exame físico: emagrecido, afebril, PA= 124x74 mmHg, FC= 94 bpm; linfonodos bem delimitados, móveis e pouco dolorosos em região cervical direita; cavidade oral: lesão ulcerada em lábio, com pontos hemorrágicos em fundo, granular; Pulmões: murmúrio vesicular presente com roncos difusos, estertores em bases. Lesão de dorso e radiograma de tórax abaixo:



A HIPOTESE DIAGNÓSTICA É:

[4000141189](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 60 Doença de Graves Tireoide Endocrinologia

Mulher, 26a, procurou atendimento com queixa de irritabilidade há um mês, acompanhada de ansiedade, insônia, agitação, palpitação e tremores. Relatava bom apetite, mas perdendo peso progressivamente. Antecedentes pessoais: tabagismo ativo. Exame físico: FC= 112 bpm, PA= 132x68 mmHg, FR= 18 irpm, afebril, bom estado geral; tireoide: palpável e difusamente aumentada; membros superiores: tremor fino de extremidades; pele: quente e úmida, olhos: proptose ocular, sinal de "lid lag".

O DIAGNÓSTICO MAIS PROVÁVEL É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141188](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 61 Política Nacional de Humanização

Mulher, 29a, procura equipe de saúde da família e quer realizar mamografia. Relata que sua mãe foi tratada de câncer de

mama há 8 anos, com diagnóstico recente de recidiva.

A EQUIPE DE SAÚDE BUSCA CONHECER A HISTÓRIA DE VIDA DA PACIENTE E SUA EXPERIÊNCIA ANTERIOR COM O CÂNCER DE MAMA NA FAMÍLIA PORQUE A CLÍNICA AMPLIADA E COMPARTILHADA:

- A Não é suficiente para cuidar de câncer de mama.
- B Baseia-se na clínica do sujeito.
- C Se ocupa da experiência com a doença e não propriamente pela doença.
- D Considera que a experiência com a doença é fator determinante para a ocorrência de câncer de mama nessa paciente.

4000141187

Questão 62 Sigilo profissional

Médico atende homem de 45 anos que apresenta exame positivo para sífilis. Paciente está preocupado com a saúde da parceira, acompanhada pela mesma equipe de saúde da família, e pede que o médico solicite o exame da parceira sem que ela saiba o resultado do exame dele.

EM RELAÇÃO À SOLICITAÇÃO DO EXAME DE INVESTIGAÇÃO DE SÍFILIS PARA A PARCEIRA, A CONDUTA É:

- A Solicitar exame e contar sobre o exame do marido, se resultado positivo.
- B Não investigar a parceira e tratar o marido.
- C Pactuar com o paciente que ele conte o seu resultado e depois solicitar o exame.
- D Atender ao pedido do paciente e solicitar o exame.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141186

Questão 63 Projeto Terapêutico Singular

Em reunião da Equipe de Saúde da Família, a agente comunitária de saúde apresenta caso de família composta por mulher de 25a, com 4 filhos, moradora do território há 6 anos, atualmente desempregada, com relato de uso de drogas ilícitas. Filho de 6 meses de idade não é trazido para consulta na unidade básica de saúde desde o primeiro mês de vida, apesar do agendamento proposto.

A CONDUTA É:

- A Transferir o seguimento da família para o Centro de Atenção Psicossocial.
- B Elaborar um Projeto Terapêutico Singular.
- C Agendar consulta da mãe e criança com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
- D Agendar consulta da mãe e criança com a Psicóloga.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141185

Questão 64 Program Saúde da Família PSF e Estratégia Saúde da Família ESF

Pacientes com diabetes melito têm procurado as Unidades Básicas de Saúde com queixas de ansiedade, muita preocupação, tristeza e medo, condição conhecida como Sofrimento Mental Específico da Diabetes (SMED).

CABE À EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA:

- A Considerar a possibilidade de SMED principalmente em pacientes idosos do sexo masculino com diabetes melito.
- B Iniciar o uso de antidepressivos para pacientes jovens com diabetes melito.
- C Realizar rastreamento de SMED na população com diabetes melito sob responsabilidade da equipe.
- D Realizar abordagem individualizada a respeito de dúvidas e angústias relativas à doença e seu tratamento.

4 00014 1184

Questão 65 Determinação Social da Saúde Determinantes Sociais da Saúde DSS

Em 2012, um estudo britânico avaliou os efeitos de uma campanha massiva para informar e persuadir as pessoas a terem uma vida mais saudável. O estudo concluiu que reduções no comportamento de risco foram observadas principalmente entre aqueles grupos socioeconômicos e educacionais mais elevados. Entre as pessoas com menor qualificação profissional a prevalência de comportamentos de risco era cinco vezes maior do que entre aquelas com ensino superior.

A PARTIR DOS RESULTADOS DESTA PESQUISA ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

- A Enfrentamento da iniquidade em saúde depende de um conjunto de políticas públicas sociais.
- B Quanto menor a desigualdade econômica, piores as condições de saúde da população.
- C A causa do grupo mais pobre não aderir aos comportamentos saudáveis é a falta de informação.
- D No Brasil, o arcabouço jurídico do SUS não recomenda a divulgação dos determinantes sociais de saúde.

Essa questão possui comentário do professor no site 4 00014 1183

Questão 66 Emenda constitucional n 952016

Em fevereiro de 2020 o Conselho Nacional de Saúde publicou em sua página a seguinte informação: “Saúde perdeu R\$ 20 bilhões em 2019”. Em relação às perdas mencionadas no orçamento anual do SUS,

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

- A Deve-se à compra de planos de saúde privados para funcionários públicos nas diversas instâncias de governo e empresas públicas.
- B Deve-se aos efeitos da Emenda Constitucional 95.
- C Deve-se ao subsídio do estado brasileiro aos serviços privados de saúde.
- D Deve-se ao não ressarcimento ao SUS pelo atendimento de pessoas que pagam planos de saúde e são atendidas no SUS.

4 00014 1182

Questão 67 Bioética

A Resolução CFM 1995/2012 define as diretivas antecipadas de vontade (DAV) como o conjunto de desejos manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade.

ACERCA DA DAV, É CORRETO AFIRMAR QUE:

- A Assim como na autorização para doação de órgãos, o cumprimento das DAV do paciente requer a anuência dos familiares.
- B As DAV somente terão efeito legal quando devidamente registradas em cartório e anexadas ao prontuário médico.
- C O médico levará em consideração as DAV nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram capazes de expressar de maneira livre e independente de suas vontades
- D Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141181

Questão 68 Telessaúde

A Portaria no 467 de 20 de março de 2020 dispõe sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas para o período de emergência de saúde pública de importância internacional. Esta portaria reconhece a possibilidade e a eticidade da utilização da Telemedicina, em caráter de excepcionalidade e enquanto durarem as medidas de enfrentamento da pandemia por SARS-CoV-2.

É CORRETO AFIRMAR:

- A Os médicos que realizarem as ações de Telemedicina deverão atender aos preceitos éticos de beneficência, não-maleficência, sigilo das informações e autonomia.
- B Devido à gravação do atendimento por meio de tecnologia da informação e comunicação, o médico estará dispensado do registro em prontuário clínico do paciente.
- C As ações de interação à distância contemplam o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico no âmbito do sistema público de saúde.
- D A emissão de receitas e atestados médicos à distância será válida em meio eletrônico, mediante uso de assinatura eletrônica comum do profissional.

4 00014118 0

Questão 69 Projeto Terapêutico Singular Política Nacional de Atenção Básica PNAB

Um ambulatório para doenças crônicas não transmissíveis funciona um período por semana com equipe multiprofissional composta por três médicas, três enfermeiras, um nutricionista e uma psicóloga. Atualmente, o ambulatório tem 2.700 pacientes cadastrados. A fila de espera para atendimento com o nutricionista e com a psicóloga é de cinco e seis meses, respectivamente. Embora a maior parte dos pacientes seja acompanhada há vários anos, uma pesquisa recente com usuários demonstrou que a maioria dos entrevistados não se lembrava do nome dos profissionais que o acompanhavam.

ASSINALE A ESTRATÉGIA INDICADA PARA QUE SE OBTENHA SIMULTANEAMENTE O FORTALECIMENTO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO ENTRE PROFISSIONAIS E PACIENTES, A DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS COM NUTRICIONISTA E PSICÓLOGO E A MAIOR FACILIDADE PARA MONITORAMENTO DE RESULTADOS CLÍNICOS E DISCUSSÃO DE CASOS:

- A Equipe de Referência e Apoio Matricial
- B Realização de grupos de apoio com pacientes e familiares.
- C Projeto Terapêutico Singular.
- D Reuniões periódicas com participação dos trabalhadores do ambulatório.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141179](#)

Questão 70 Toxicologia ocupacional

Mulher, 26a, procurou pronto atendimento com quadro de tonturas, dores de cabeça, cansaço e náuseas há duas semanas. Foi medicada com sintomáticos e encaminhada para consulta com Equipe de Saúde da Família, onde refere que o quadro se mantém apesar da medicação analgésica e os sintomas são piores no final do dia. O médico de família e comunidade pergunta sobre a ocupação e condições de trabalho, solicita exames, afasta a paciente do trabalho por uma semana e notifica o caso no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

A OCUPAÇÃO DA PACIENTE E A NOTIFICAÇÃO NO SINAN SÃO, RESPECTIVAMENTE:

- A Trabalhadora em fábrica de colchões; intoxicação por isocianatos.
- B Trabalhadora rural; intoxicação por agrotóxicos.
- C Manicure; intoxicação por solventes.
- D Montadora em fábrica de celulares; intoxicação por fumos metálicos.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141178](#)

Questão 71 Bases legais de Saúde do Trabalhador

A Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) que consta do Anexo LXXX da Portaria de Consolidação no. 5, de 28 de setembro de 2017, tem por finalidade orientar os profissionais de saúde sobre a possível relação do adoecimento com a exposição a riscos para a saúde presentes no trabalho.

Nela, as leucemias (C91-C95) estão associadas aos seguintes agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional:

- A Isocianatos orgânicos, aminas aromáticas e campos eletromagnéticos.
- B Agentes antineoplásicos, acrilatos e aldeído fórmico.
- C Radiações ionizantes, agrotóxicos clorados e óxido de etileno.
- D Benzeno, radiação ultravioleta e agrotóxicos fosforados.

4000141177

Questão 72 Vigilância em Saúde do Trabalhador

Em agosto de 2019, as praias do Nordeste brasileiro foram tomadas por cinco mil toneladas de petróleo cru, que matou animais marinhos, poluiu praias e prejudicou mais de 300 mil pescadores. Entre trabalhadores formais e voluntários que se dedicaram a retirar o óleo das praias, centenas de milhares de pessoas foram expostas sem a devida proteção.

EM LONGO PRAZO, A EXPOSIÇÃO AO PETRÓLEO CRU PODE PROVOCAR DIVERSOS EFEITOS À SAÚDE

COMO:

- A Desmielinização do sistema nervoso central.
- B Pneumonite por hipersensibilidade.
- C Danos hepáticos e/ou renais.
- D Dermatites de contato.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141176](#)

Questão 73 Mortalidade Proporcional

Um município notificou os seguintes indicadores ao analisar grupos de causas básicas: mortalidade proporcional devido a doenças cardiovasculares de 30% e de causas externas de 11%; percentual de anos potenciais de vida perdidos de 11% por causas cardiovasculares e 30% por causas externas.

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

- A As causas externas e as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no município.
- B Os indicadores mostram o risco de morrer tanto por doenças cardiovasculares como por causas externas no município.
- C A cidade tem grande percentual de idosos que se expõem a causas externas.
- D Há grande contingente de óbitos precoces.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141175](#)

Questão 74 Mortalidade Geral Medicina Preventiva Letalidade

Em uma cidade de 1.000.000 habitantes, foram notificados 1.000 casos e 50 mortes de uma doença aguda X no ano. O total de mortes de todas as causas foi 150.

CALCULE O COEFICIENTE DE MORTALIDADE DA DOENÇA X POR 100 MIL HABITANTES, A MORTALIDADE PROPORCIONAL PELA DOENÇA E A LETALIDADE DA DOENÇA EM PORCENTAGEM, RESPECTIVAMENTE:

- A 150; 15; 0,05.
- B 150; 33; 0,5.
- C 5; 33; 5.
- D 5; 15; 33,3.

4000141174

Questão 75 Estudos de fase III Medicina Preventiva Estudos de fase II

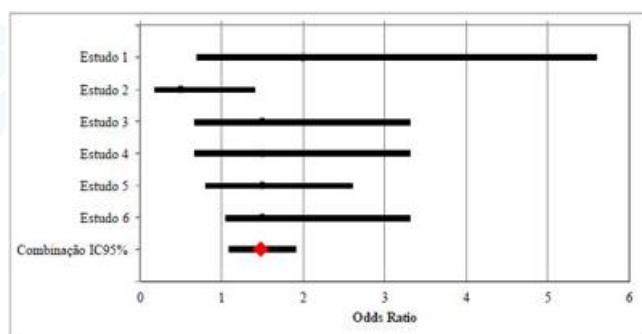
SOBRE ENSAIOS CLÍNICOS PARA OBTENÇÃO DE UMA NOVA VACINA CONTRA UMA DOENÇA, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

- A A fase IV é a que permite a liberação da vacina para comercialização e uso para a população.
- B Ensaios clínicos de fase III avaliam a segurança e as doses mais eficazes da vacina.
- C O monitoramento do perfil de segurança de curto prazo é realizado na fase II do ensaio.
- D Ensaios clínicos de fase I necessitam aleatorização de pacientes para avaliar eficácia inicial da vacina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141173

Questão 76 Metanálises

Uma metanálise sobre a associação de uma exposição X ao risco de piora do prognóstico de uma doença Y incluiu seis estudos a partir de critérios pré-definidos. Os resultados de medidas de associação são apresentados na figura abaixo:



A ALTERNATIVA CORRETA É:

- A A maioria dos estudos não apresenta associação significativa individualmente.
- B O estimador global apresenta maior variabilidade que os estudos isolados.
- C O resultado da metanálise descarta a associação entre a exposição e a piora do prognóstico da doença devido ao pequeno Odds Ratio.
- D O estudo 1 é o de maior peso nos resultados.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141172

Questão 77 Climatério

Mulher, 52a, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de ondas de calor, dificuldade para dormir e diminuição da libido há 1 ano. Refere que acorda a noite por causa das ondas de calor, com grande impacto na qualidade de vida. Não apresenta antecedentes mórbidos, nega cirurgias prévias e a data da última menstruação foi há 14 meses. Antecedentes familiares: mãe e pai hipertensos e diabéticos. Resultados dos exames: TSH= 3,5 μ UI/mL; colesterol total= 158 mg/dL; HDL colesterol= 45 mg/dL; triglicérides= 310 mg/dL, glicemia= 85 mg/dL; Hb= 13,6 g/dL; Ht= 42,1%.

A CONDUTA É PRESCREVER:

- A Estradiol 0,05mg por dia transdérmico e progestágeno oral.
- B Estradiol 1mg por dia transdérmico.
- C Estradiol 1mg por dia e progestágeno orais.
- D Estradiol 2mg por dia oral.

Questão 78 **Complicações** **Prematuridade** **Gestação monoamniótica**

Primigesta de 34 semanas, sem pré-natal, chega à maternidade com quadro de sangramento vaginal intenso. Exame obstétrico: altura uterina: 39 cm; toque: colo fechado e com apresentação inatingível. Submetida a cesárea de urgência. A foto apresenta um momento do intraparto:

**A CONDIÇÃO APRESENTADA NA FOTO ESTÁ ASSOCIADA À GESTAÇÃO:**

- A Gemelar monocoriônica e monoamniótica.
- B Pré-termo complicada por rotura de vasa prévia.
- C Gemelar monocoriônica e diamniótica.
- D Pré-termo com polidrâmnio e prolapso de cordão.

4000141170

Questão 79 **Corioamnionite** **Rotura prematura de membranas ovulares RPM****Intercorrências obstétricas obstetrícia patológica**

Mulher, 29a, G3P2C0A0, 33 semanas e 4 dias de gestação, vem à Unidade de Emergência com queixa de contrações uterinas dolorosas e redução da movimentação fetal há 4 horas. Nega queixas nos demais aparelhos e não tem comorbidades. Exame físico: regular estado geral, Temp= 39°C, FC= 117 bpm, FR=18 irpm, PA= 100x60 mmHg; exame obstétrico: altura uterina 31 cm, dinâmica uterina 3 contrações de 30 segundos em 10 minutos, batimentos cardíacos fetais 166 bpm, toque vaginal: colo 70% esvaecido, medianizado, 4 cm de dilatação, bolsa íntegra, feto cefálico. Exame sumário de urina: normal, Leucócitos= 22.570 mm³ (20% de bastões). Foram coletadas: cultura para estreptococo do grupo B, hemocultura e urocultura.

ALÉM DA ANTIBIOTICOTERAPIA DE AMPLO ESPECTRO E SUPORTE A CONDUTA É:

- A Aguardar resultado de culturas para definir via de parto.
- B Realizar neuroproteção fetal.
- C Assistir ao trabalho de parto vaginal.
- D Inibir trabalho de parto por 48 horas, até maturação pulmonar fetal.

Questão 80 Diagnóstico diferencial

Mulher, 29a, procurou Unidade Básica de Saúde por irregularidade menstrual há dois anos. Encontra-se em amenorreia há cinco meses com teste de gravidez negativo. Refere menarca aos 12 anos. Método contraceptivo: condom. Antecedente pessoal: fibromialgia em tratamento com amitriptilina há três anos.

A ETIOLOGIA MAIS PROVÁVEL DA IRREGULARIDADE MENSTRUAL É:

- A Hiperprolactinemia.
- B Adenomiose.
- C Síndrome dos ovários policísticos.
- D Hiperplasia adrenal congênita de manifestação tardia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141168](https://t.me/medicinalivre)

Questão 81 Endometriose

Mulher, 30a, nuligesta, com quadro de dismenorreia incapacitante e dispareunia de profundidade há cinco anos. Refere ciclos menstruais regulares sem uso de método contraceptivo. Ressonância magnética de pelve: lesão retrátil em região retrocervical que envolve a camada serosa/muscular do reto alto e a parede posterior do útero/colo, medindo 1,4 x 1,0 cm. Ovários medianizados, com lesões císticas de conteúdo hemorrágico multiloculadas com septos finos de permeio e paredes finas, com grumos depositados no interior das lesões que medem respectivamente 1,6 x 0,9 cm e 1,1 x 0,8 cm; ausência de ascite.

A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

- A Carcinomatose peritoneal.
- B Doença inflamatória pélvica.
- C Endometriose profunda.
- D Cisto hemorrágico ovariano.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141167](https://t.me/medicinalivre)

Questão 82 Obstetrícia Prevenção

Mulher, 33a, G3P2A1, em alojamento conjunto com 24h de puerpério, tipo sanguíneo A e Rh negativo, com Coombs indireto positivo anti-D (coletados na admissão hospitalar para o parto). Recém-nascido (RN): tipo sanguíneo O e Rh positivo. Antecedente pessoal: Imunoglobulina anti-Rh após o primeiro parto, após o aborto e às 28 semanas desta gestação.

A CONDUTA É:

- A Contra indicar nova gestação, pois paciente isoimunizada.
- B Solicitar Coombs direto para orientar uso de Imunoglobulina anti-Rh.
- C Imunoglobulina anti-Rh não indicada por Coombs indireto positivo.
- D Prescrever Imunoglobulina anti-Rh, por RN Rh positivo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141166](https://t.me/medicinalivre)

Questão 83

Doenças associadas à gestação

Diabetes na gestação DMG

Obstetrícia

Primigesta de 37 semanas e 2 dias, com diabetes gestacional, retorna ao pré-natal com queixa de redução de movimentação fetal há 3 dias (mobilograma: 4 movimentos fetais em 1 hora). Perfil glicêmico: jejum= 68 mg/dL, 1 hora pós café= 116 mg/dL, 1 hora pós almoço= 105 mg/dL, 1 hora pós jantar= 118 mg/dL, 23:00 horas = 70 mg/dL, 3:00 horas= 60 mg/dL. Refere manter a mesma dieta com ganho de 300 gramas em 7 dias. Realizou cardiotocografia: ativa e ultrassonografia: feto cefálico, peso fetal estimado de 3600g (>p90), ILA= 180 mm e Doppler normal, no dia de hoje.

A CONDUTA É:

- A Realizar cardiotocografia semanal e indução de parto às 40 semanas.
- B Realizar cardiotocografia a cada três dias e parto cesárea às 39 semanas.
- C Induzir parto com vigilância de vitalidade fetal.
- D Realizar parto cesárea urgência.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141165](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 84

Métodos moleculares para o diagnóstico

Medicina Livre
Contra preços abusivos
na medicina.

O uso de testes de biologia molecular para pesquisa de HPV de alto risco oncogênico no colo uterino pode ser utilizado como estratégia de rastreamento de câncer de colo.

No Brasil, o principal motivo desta estratégia não ser utilizada é:

- A Alta incidência de câncer em mulheres abaixo de 40 anos
- B Uso da vacinação para HPV para meninos e meninas
- C Alto custo dos testes moleculares para detecção de HPV
- D Necessidade de migração para sistema de rastreamento organizado

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141164](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 85

Outras lesões proliferativas da mama

Mulher, 42a, retorna para resultado de biópsia excisional de nódulo de mama esquerda BI- RADS® 4: fibroadenoma simples, com achados no parênquima adjacente ao nódulo de hiperplasia estromal pseudo-angiomatosa, metaplasia apócrina e hiperplasia lobular atípica.

É CONSIDERADA LESÃO PRECURSORA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER DE MAMA COM RISCO MODERADO:

- A Metaplasia apócrina.
- B Hiperplasia lobular atípica.
- C Fibroadenoma simples.
- D Hiperplasia estromal pseudoangiomatosa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141163](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 86 **Hormonioterapia** **Imunoterapia**

Mulher, 34a, G1P1C0A0, mastectomizada há 40 dias por carcinoma ductal invasor, com receptores negativos para estrogênios e progestagênios e *status* HER-2 negativo. Nega outras comorbidades.

O MÉTODO CONTRACEPTIVO INDICADO É:

- ☐ A Dispositivo intrauterino com cobre.
- ☐ B Anticoncepcional oral combinado de baixa dosagem.
- ☐ C Implante liberador de levonorgestrel.
- ☐ D Acetato de medroxiprogesterona de depósito.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141162

Questão 87 **Doenças associadas à gestação** **Doenças infecciosas na gestação HIV sífilis hepatites herpes**

Sífilis na gestação

Primigesta, 18a, com idade gestacional de 10 semanas comparece à primeira consulta de pré-natal. Sorologia sífilis: teste rápido= positivo, CMIA= positivo, TPHA= positivo e VDRL= 1/4. Não se recorda de ter tomado penicilina previamente. Os exames físico e ginecológico são normais. Prescrita Penicilina Benzatina 4.800.000 UI, dose única, aplicada após a consulta.

É CORRETO:

- ☐ A Trata-se de sífilis recente e o tratamento da gestante está adequado.
- ☐ B O tratamento deve ser ajustado para 3 doses semanais de 2.400.000UI de Penicilina Benzatina.
- ☐ C A titulação do VDRL indica cicatriz sorológica e não exige conduta complementar.
- ☐ D Trata-se de provável caso de sífilis terciária e há indicação de avaliação líquórica.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141161

Questão 88 **Infectologia Pediátrica** **Pediatria** **Neonatologia**

Mulher, 22a, G1POAO, idade gestacional de 38 semanas, procura o pronto atendimento obstétrico com queixa de perda de líquido há uma hora. Realizou duas consultas de pré-natal, com abandono após as 20 semanas. Sorologias realizadas com 15 semanas de gestação: HIV, hepatite C e sífilis negativas; hepatite B: AgHBs não reagente, anti-HBs reagente, anti-HBc reagente. Exame especular: saída de líquido claro com grumos de colo impérvio; dinâmica uterina ausente. Vitalidade fetal adequada. Na internação apresenta teste rápido positivo para HIV.

CONSIDERANDO O CASO ACIMA, APÓS CONFIRMAÇÃO SOROLÓGICA DE HIV MATERNO, ALÉM DE PRESCREVER FÓRMULA LÁCTEA DE PARTIDA, A CONDUTA PARA O RECÉM-NASCIDO É PRESCREVER:

- ☐ A Imunoglobulina humana anti-hepatite B intramuscular e AZT xarope e nevirapina via oral.
- ☐ B Vacina para hepatite B intramuscular e AZT xarope e nevirapina via oral.
- ☐ C Imunoglobulina humana anti-hepatite B intramuscular e AZT xarope via oral.
- ☐ D Vacina para hepatite B intramuscular e AZT xarope via oral.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141160

Questão 89 Parto Obstetrícia

Mulher, 22a, G1P0A0, idade gestacional de 38 semanas, procura o pronto atendimento obstétrico com queixa de perda de líquido há uma hora. Realizou duas consultas de pré-natal, com abandono após as 20 semanas. Sorologias realizadas com 15 semanas de gestação: HIV, hepatite C e sífilis negativas; hepatite B: AgHBs não reagente, anti-HBs reagente, anti-HBc reagente. Exame especular: saída de líquido claro com grumos de colo impérvio; dinâmica uterina ausente. Vitalidade fetal adequada. Na internação apresenta teste rápido positivo para HIV.

A CONDUTA É:

- A Indicar cesárea após 18 horas de AZT intravenoso.
- B Indicar cesárea após 3 horas de AZT intravenoso.
- C Realizar cesárea imediatamente, com técnica hemostática.
- D Indicar indução de parto, após o início do AZT intravenoso.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141159

Questão 90 Hormonioterapia Imunoterapia

Mulher de 66 anos, antecedente pessoal de tratamento de câncer de mama há três anos, em uso atual contínuo de inibidor de aromatase. Refere ter sido previamente submetida à quimioterapia com taxanos e à imunoterapia com trastuzumabe.

O SUBTIPO INTRÍNSECO DO CARCINOMA MAMÁRIO CONSIDERADO É:

- A Triplo negativo.
- B Luminal B HER-negativo.
- C Luminal A.
- D Luminal HER-positivo.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141158

Questão 91 Intercorrências obstétricas obstetrícia patológica

Gestante de 34 semanas é transferida a serviço terciário após parada cardiorrespiratória revertida com 4 ciclos de RCP. Chega em ventilação mecânica (FIO₂= 70%, PEEP= 12 cm H₂O, VC= 345mL, FR= 28 irpm, Ppico= 38 cm H₂O, Pplato=32 cm H₂O), PA= 112x57 mmHg, FC= 121 bpm, em uso de noradrenalina (0,2 mcg/kg/min). Batimentos cardíacos fetais=162 bpm, sem variabilidade. Antecedente Pessoal: sintomas gripais há 3 dias, prostração, com piora hoje.

ALÉM DO ISOLAMENTO POR PROVÁVEL COVID-19 E CUIDADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, A CONDUTA É:

- A Aguardar resultado rt-PCR de COVID-19 para realizar parto cesárea.
- B Induzir parto vaginal após estabilização do quadro materno.
- C Realizar parto cesárea imediato.
- D Administrar corticoide para maturação pulmonar fetal e indicar parto após 48 horas.

4000141157

Questão 92 **Predição e prevenção** **Obstetrícia**

Mulher, 28a, G2P1C1A0, vem para primeira consulta de pré-natal às 14 semanas de gestação. Antecedente Pessoais: hipertensão arterial crônica e eclampsia às 28 semanas da primeira gestação, há 3 anos.

A CONDUTA É:

- ☐ A Programar parto cesárea eletiva às 36 semanas desta gestação.
- ☐ B Prescrever corticosteroide a partir de 26 semanas de gestação.
- ☐ C Prescrever heparina de baixo peso molecular em dose profilática durante a gestação.
- ☐ D Prescrever AAS e carbonato de cálcio durante a gestação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141156](https://www.4000141156.com)

Questão 93 **Bronquiolite** **Pediatria** **Tratamento**

Menino, 6 meses, comparece ao pronto-socorro com história de febre, obstrução nasal, coriza e tosse há 3 dias, e cansaço há um dia. Nega vômitos ou inapetência. Exame físico: bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, dispneico, T=36,2°C, FC=163bpm, FR=71irpm, PA=80x45 mmHg, oximetria (ar ambiente)=91%, capilar=2 segundos; Otoscopia: membranas timpânicas translúcidas, pulsos cheios, enchimento as e sem hiperemia; Pulmão: murmúrio vesicular diminuído à direita com raros sibilos bilateralmente; Coração: ritmo duplo regular sem sopros, bulhas normofonéticas. Radiograma de tórax:



ALÉM DE INTERNAR E OFERTAR OXIGÊNIO, A CONDUTA É:

- ☐ A Azitromicina.
- ☐ B Beta2 agonista.
- ☐ C Dexametasona.
- ☐ D Penicilina cristalina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141156](https://www.4000141156.com)

Questão 94 Icterícia neonatal Pediatria

Menino, 35 dias, comparece para consulta de puericultura e mãe nega queixas. Refere aleitamento materno exclusivo, diurese oito vezes ao dia e evacuações em dias alternados. AP: RNT AIG, alta com 48 horas de vida. Situação vacinal atualizada e ganho ponderal diário de 35 gramas desde a última consulta. Exame físico: bom estado geral, corado, acianótico, icterício (zona 2 de Kramer), FR= 45 irpm. Abdome: fígado a 1cm do rebordo costal direito com consistência fibroelástica, borda lisa e superfície aguda, baço não palpável.

A CONDOTA É:

- A** Coleta de hemograma e reticulócitos.
- B** Coleta de bilirrubina total e frações.
- C** Orientar banho de sol e tranquilizar a família.
- D** Suspender leite materno por 48 horas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141154](#)

Questão 95 Diagnósticos diferenciais Pediatria Sarampo

Menina, 7 meses, comparece hoje no pronto-socorro com tosse, coriza e manchas vermelhas pelo corpo há dois dias. Nega comorbidades e contactantes com sintomas semelhantes Exame físico: bom estado geral, corada, anictérica, FR= 28 irpm, hiperemia conjuntival bilateral, coriza e obstrução nasal, linfonodos fibroelásticos móveis e indolores de até um centímetro em cadeias cervicais, Pulmões: murmúrio vesicular presente bilateralmente com roncos de transmissão; Pele: exantema macular em face e tronco. A carteira de vacina inclui as seguintes doses (ANEXO A):

[illegible]

A CONDUTA É:

- A Hidratação, higiene nasal com soro fisiológico e reavaliação em 48 horas.
- B Notificação de evento adverso à vacina e contraindicar doses subsequentes.
- C Internação para administração de imunoglobulina.
- D Coleta de sorologia e RT-PCR para o vírus do sarampo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141153](#)

Questão 96 **Pediatria** **Pneumonias** **Broncopneumonias BCP na Infância**

Menina, 8a, é trazida para atendimento por febre e tosse há 2 dias, com piora progressiva. Hoje com cansaço e falta de ar. Antecedente pessoal: asma em uso de beclometasona via inalatória 200 mcg 2x/dia. Exame físico: FR= 43 irpm, FC=120 bpm, T= 39°C, pálido, retração intercostal e subcostal; oximetria de pulso (ar ambiente) = 90%; Pulmão: murmúrio vesicular diminuído em base esquerda, com estertores subcrepitantes à esquerda. Radiograma de tórax:



TRATA-SE DE UMA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA:

- A Alta e mista.
- B Alta e obstrutiva.
- C Baixa e restritiva.
- D Baixa e obstrutiva.

4000141152

Questão 97 Febre Reumática FR Reumatologia Pediátrica Tratamento e prevenção

Menino, 10a, refere que há duas semanas tem apresentado dificuldades para escrever e para se alimentar (levar o alimento à boca). Além disso refere desequilíbrio ao andar, que piora quando fica nervoso. Nega febre, cefaleia ou perda de consciência. Antecedentes: quadro de febre, cansaço e dor em tornozelo D e ombro E há dois meses. Exame físico: corado, hidratado, acianótico, irrequieto, consciente. Exame neurológico: reflexos e força muscular normais; articulações sem alterações, com movimentos assimétricos de face e de língua.

O TRATAMENTO INICIAL É:

- A Psicoterapia.
- B Piridoxina.
- C Penicilina benzatina.
- D Vigabatrina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141151

Questão 98 Emergências Pediátricas Parada Cardiorrespiratória PCR e Arritmias na Emergência Pediatria

Menino, 2a, é trazida à Emergência em parada cardiorrespiratória (PCR). A checagem de ritmo identifica assistolia.

O PRINCIPAL BENEFÍCIO EM INTUBAR O PACIENTE NESTE TIPO DE PCR, NO QUE DIZ RESPEITO AO RETORNO DA CIRCULAÇÃO ESPONTÂNEA, É:

- A Permitir que as compressões torácicas sejam realizadas sem interrupções, otimizando a perfusão coronariana.
- B Evitar a distensão gástrica e restrição de expansibilidade pulmonar secundárias ao uso do ressuscitador manual.
- C Oferecer oxigenação e ventilação de forma mais eficiente, visto que a hipóxia é a causa mais frequente de PCR pediátrica.
- D Ter uma via para administração de medicações (endotraqueal) rápida e segura.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141150](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 99 **Pediatria** **Corpo EstranhoEngasgo**

Menino, 2 a, é levado ao pronto-socorro com história de um episódio de vômito após engasgo enquanto brincava sem supervisão. No momento assintomático. Última mamadeira de 200 ml de leite há duas horas. O acompanhante acredita que faltam peças do brinquedo e que a criança pode ter ingerido algo. Radiograma de tórax:



A CONDUTA É:

- A Realizar endoscopia digestiva alta após 8 horas de jejum.
- B Realizar endoscopia digestiva alta de emergência.
- C Aguardar migração do corpo estranho por até 24 horas.
- D Realizar broncoscopia após 8 horas de jejum.

Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141149](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 100 **Pediatria** **Suporte Avançado de Vida**

Menino, 4a, foi encontrado em casa desacordado após ingestão acidental de 1 frasco de fenobarbital. Exame físico: FC= 67 bpm FR 9 irpm, Oximetria de pulso (ar ambiente) = 78%.

A ABORDAGEM INICIAL PARA ESSE PACIENTE É:

- A Iniciar ventilação positiva com dispositivo bolsa-válvula-máscara.
- B Iniciar oferta de oxigênio com máscara de Venturi 15L/minuto.
- C Oferecer oxigênio com máscara de alto fluxo não reinalante.
- D Cateter nasal de oxigênio 2L/minuto.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141148](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 101 **Icterícia neonatal** **Pediatria** **Neonatologia**

Recém-nascido com 40 semanas de idade gestacional nasceu com 3450 gramas. Com 15 horas de vida está em alojamento conjunto em aleitamento materno em livre demanda, diurese clara, evacuação normal e apresenta icterícia moderada até região umbilical.

A CAUSA A SER INICIALMENTE INVESTIGADA É:

- A Infecções congênitas.
- B Icterícia pelo leite materno.
- C Icterícia fisiológica.
- D Icterícia de causa hemolítica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141147](https://www.4000141147.com.br)

Questão 102 **Sífilis congênita** **Conduta** **Mães inadequadamente tratadas**

Mãe com 39 anos, G6P5C0A0, não realizou pré-natal e não usou nenhuma medicação na gravidez. No dia do parto apresenta teste treponêmico reagente e teste não treponêmico reagente 1:1024. Evoluiu para parto vaginal com recém-nascido do sexo feminino, 39 semanas e 3 dias, com peso de nascimento de 2475 gramas e hepatoesplenomegalia ao exame físico. Sorologias da criança: teste treponêmico reagente e teste não treponêmico reagente 1:512. Liquor: Leucócitos= 234/mm³ (78% neutrófilo, 22% linfócitos) proteína = 540 mg/dL, glicose= 12 mg/dL; glicemia 75 mg/dL.

O TRATAMENTO PARA O RECÉM-NASCIDO É:

- A Benzilpenicilina benzatina 50.000 UI/kg/dose, intramuscular, semanal, por 3 semanas.
- B Benzilpenicilina cristalina 50.000 UI/kg/dose, endovenosa, por 10 dias.
- C Benzilpenicilina cristalina 50.000 UI/kg, endovenosa, dose única.
- D Benzilpenicilina procaína 50.000 UI/kg/dose, intramuscular, uma vez ao dia, por 10 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141146](https://www.4000141146.com.br)

Questão 103 **Anemia ferropriva na infância** **Picacismo** **Tratamento**

Menina, 11 meses, é trazida a unidade Básica de Saúde com história de picacismo há um mês. Alimentação: leite Materno, leite de vaca, baixa ingesta de alimentação sólida (carne e frutas raramente). Nega antecedente de anemia na família. Exame físico: mucosas descoradas ++/4+ e palidez cutânea. Hb=8,5g/dL; Htc=29%; Rtc=1,7%; VCM=62fl; HCM=22pg; RDW=19%; Ferritina=8ng/mg.

A CONDUTA É PRESCREVER:

- A Ferro elementar 1mg/Kg/dia via oral.
- B Sacarato de hidróxido férrico 3 mg/kg endovenoso.
- C Ferro elementar 5mg/Kg/dia via oral.
- D Sulfato ferroso 5mg/Kg/dia via oral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141145](https://www.4000141145.com.br)

Questão 104 **Tratamento** **Pediatria**

Menina, 2a e 6 meses, apresentando desde os 8 meses de idade, dor e distensão abdominal acompanhadas às vezes de fezes líquidas. Refere inapetência e perda de peso.

APÓS INVESTIGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA, DEVEM SER EXCLUÍDOS DA DIETA:

- A Trigo, centeio e cevada.
- B Cará, batata e grão de bico.
- C Arroz, polvilho e amaranto.
- D Amendoim, chia e tapioca.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141144](#)

Questão 105 Programa Nacional de Imunizações

Menina, 12a, foi à Unidade Básica de Saúde para vacinação com sua carteira. Estava com a vacinação adequadas para a idade até 5 anos. Recebeu hoje as vacinas Papilomavirus humano (HPV) e meningocócica ACWY.

A CONDUTA É:

- A Repetir HPV em seis meses.
- B Repetir meningocócica ACWY em seis meses.
- C Repetir HPV e meningocócica ACWY em seis meses.
- D Considerar imunizado para HPV e meningocócica ACWY.

4000141143

Questão 106 Diagnóstico e tratamento Candidíase

Menina, 8 meses, retorna em consulta na Unidade Básica de Saúde para reavaliação de tratamento da otite média aguda com amoxicilina com boa evolução. Relata que há cinco dias surgiram lesões hiperemiadas na região perineal. Nega outras queixas. Exame físico da pele (ANEXO A):



A CONDUTA É:

- A Banho com cloridrato de benzidamina.
- B Neomicina e banho de sol.
- C Corticoide tópico e banho de sol.
- D Creme antifúngico e limpeza local.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141142](#)

Questão 107 Reanimação neonatal Pediatria Neonatologia

Recém-nascido de 41 semanas de idade gestacional, com líquido amniótico meconial, nasce chorando, com tônus muscular em flexão, boa vitalidade.

OS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE A RECEPÇÃO DESSE RECÉM-NASCIDO SÃO:

- A Clampeamento do cordão umbilical entre 1 e 3 minutos, adiar o contato pele a pele com a mãe para realizar aspiração de vias aéreas superiores.
- B Clampeamento do cordão umbilical antes de 1 minuto, adiar o contato pele a pele com a mãe para realizar aspiração de vias aéreas superiores.
- C Clampeamento do cordão umbilical entre 1 e 3 minutos, contato imediato pele a pele com a mãe, não realizar aspiração de vias aéreas superiores.
- D Clampeamento do cordão umbilical antes de 1 minuto, contato imediato pele a pele com a mãe, não realizar aspiração de vias aéreas superiores.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141141](#)

Questão 108 COVID 19 Amamentação Aleitamento Materno

Gestante saudável, sem morbidades pregressas, 39 semanas de idade gestacional. No momento do parto está clinicamente bem e com infecção pelo SARS-CoV-2.

A CONDUTA COM O RECÉM-NASCIDO (RN) APÓS O PARTO É:

- A Separar mãe do RN por 14 dias e contraindicar o aleitamento materno.
- B Separar mãe do RN por 14 dias e oferecer leite materno ordenhado.
- C Manter mãe e RN em quarto privativo e contraindicar o aleitamento materno.
- D Manter mãe e RN em quarto privativo e promover o aleitamento materno.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141140](#)

Questão 109 Hematologia Deficiência de vitamina B12

Homem, 54a, com história de estar deprimido e com diarreia, queda de cabelo, parestesias nos membros e fraqueza há 2 meses. Retorna à Unidade Básica de Saúde com resultados dos exames. Antecedente pessoal: cirurgia bariátrica em Y de Roux (Fobi-Capella) há 12 anos. Hematócrito= 25%, hemoglobina= 6,9 g/dL, VCM= 114fL, HCM= 29,7pg, Leucócitos= 3.100/mm³, plaquetas= 158.000/mm³, série vermelha: anisopoiquilocitose, série branca: neutrófilos hipersegmentados, sem reticulocitose.

A CONDUTA É PRESCREVER:

- A Vitamina B12.
- B Eritropoetina.
- C Sacarato de hidróxido férrico.
- D Filgrastim.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141139

Questão 110 Bioética

Homem, 34a, vítima de acidente motociclístico é levado à Unidade de Emergência Referenciada pelo SAMU devido a TCE grave, com via aérea definitiva e acessos venosos. Foi realizada abordagem pela equipe de neurocirurgia. No quinto pós-operatório na UTI, evoluiu com pupilas midriáticas e fixas. Foi suspensa a sedoanalgesia para início do Protocolo de Morte Encefálica. A sequência da avaliação do Protocolo foi: primeiro teste clínico, exame complementar e segundo teste clínico. O Protocolo foi positivo para morte encefálica. A família decidiu por não doar os órgãos. Após esta decisão, os meios artificiais de suporte orgânico foram suspensos e o paciente foi retirado da ventilação mecânica, evoluindo com queda da saturação de oxigênio, bradicardia e linha isoeletrica no monitor cardíaco.

A HORA DE ÓBITO QUE DEVE CONSTAR NA DECLARAÇÃO DE ÓBITO É A DO:

- A Exame complementar.
- B Momento da linha isoeletrica no monitor.
- C Primeiro teste clínico.
- D Segundo teste clínico.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141138

Questão 111 Doença hepática gordurosa não alcoólica DHGNA Esteatohepatite não alcoólica NASH Hepatologia Outras Hepatopatias

Homem 43a, retorna à Unidade Básica de Saúde com resultados de exames. Antecedente pessoal: Nega tabagismo e etilismo. Exame físico: IMC= 23 kg/m², circunferência abdominal= 115 cm, PA= 135x92 mmHg. Ultrassonografia abdominal: fígado hiperecogênico com contraste hepatorenal moderado; triglicérides= 210 mg/dL, Colesterol HDL= 31 mg/dL, glicemia em jejum= 113 mg/dL, PCR ultrasensível= 4mg/dL, HOMA= 3,5.

A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

- A Resistência periférica à insulina e dislipidemia mista.
- B Síndrome da resposta inflamatória associada a esteatose hepática.
- C Doença do fígado gorduroso associado à disfunção metabólica.
- D Dislipidemia por triglicérides com diabetes melito tipo 2 secundário.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141137

Questão 112 Agentes de Indução Bloqueadores Neuromusculares Princípios da Anestesiologia

O bloqueador neuromuscular indicado para intubação em sequência rápida em paciente com estômago cheio é:

- A Succinilcolina.
- B Vecurônio.
- C Pancurônio.
- D Atracurio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141136](#)

Questão 113 Hiperplasia Prostática Benigna HPB Cirurgia

Homem, 62a, procura Unidade de Pronto Atendimento com queixa de não conseguir urinar há 14 horas. Exame físico: abdome: palpa-se globo vesical 1 cm abaixo da cicatriz umbilical; toque retal: próstata aumentada (3 vezes), consistência fibroelástica, sem nódulos.

A PRIMEIRA CONDUTA É:

- A Prescrever bloqueador alfa e solicitar exame sumário de urina.
- B Realizar cateterismo vesical de demora.
- C Realizar punção suprapúbica.
- D Solicitar ultrassonografia de vias urinárias.

4000141135

Questão 114 Apresentação Clínica

Mulher, 58a, retorna à Unidade Básica de Saúde com resultado de ultrassonografia pélvica, solicitada por quadro de dor abdominal há 20 dias, e emagrecimento de aproximadamente 10 Kg em 3 meses. Ultrassonografia pélvica: massa em ovário esquerdo e ascite. Exame físico no dia do retorno: linfonodos: endurecidos em torno 1,0 cm nas regiões supraclavicular e axilar esquerdas; toque retal: nodulações endurecidas comprimindo a ampola retal.

A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É NEOPLASIA DO:

- A Reto.
- B Estômago.
- C Ovário.
- D Sistema reticulo endotelial.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141134](#)

Questão 115 Neoplasias das Glândulas Salivares

Mulher, 23a, procura atendimento médico com dor na região submandilar esquerda quando mastiga. Nega febre. Exame físico: Cavidade oral: tumefação de consistência fibroelástica, de 2 cm, no assoalho da boca; em região da desembocadura do ducto de Wharton palpa-se nódulo endurecido de 3 mm.

A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

- A Sialolítase.
- B Pilomatrixoma.
- C Linfoma.
- D Lipoma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141133](#)

Questão 116 Trauma Esplênico Cirurgia

Menino, 8a, vítima de atropelamento, trazido à Unidade de Emergência. Exame físico: descorada++/+4, PA= 93x65 mmHg; FR= 18 irpm; FC= 100 bpm; oximetria de pulso (ar ambiente)= 97%; abdome: distendido; Glasgow= 15. Hb= 9,4 g/dL; Ht= 28%. Ultrassonografia abdominal: traumatismo esplênico grau III e moderada quantidade de líquido na cavidade.

A CONDUTA INICIAL É:

- A Reposição volêmica com coloides, tomografia de abdome e paracentese abdominal.
- B Reposição hidroeletrólítica, internação em UTI e controle de hemoglobina.
- C Concentrado de hemácias e laparotomia exploradora.
- D Cateter venoso central, concentrado de hemácias e esplenectomia de urgência.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141132](#)

Questão 117 Tipos Especiais de Úlcera péptica

Mulher, 28a, com queixa de queimação no andar superior do abdome, retorna para avaliação de resultado de endoscopia digestiva alta (EDA), realizada há 3 semanas. Antecedentes pessoais: uso regular de inibidor da bomba de prótons (IBP) há 2 anos e tabagismo 10 maços/ano. EDA: uma úlcera duodenal ativa e pesquisa de *Helicobacter pylori* negativa.

A CONDUTA É:

- A Indicar pesquisa de sangue oculto.
- B Substituir por sucralfato por 2 semanas e repetir EDA.
- C Indicar pHmetria e ajustar dose IBP.
- D Manter IBP até a úlcera duodenal cicatrizar.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141131](#)

Questão 118 Enterocolite necrosante e dieta no prétermo Pediatria

Recém-nascido de 32 semanas teve inserção de cateter umbilical na sala de parto. Evoluiu com dificuldade respiratória e necessidade de ventilação mecânica. Com três dias de vida apresentou vômitos biliosos, distensão abdominal global que foi se acentuando; a seguir eliminou secreção mucossanguinolenta pelo reto. Radiograma simples do abdome na incidência anteroposterior na posição ortostática mostra níveis hidroaéreos em todo o abdome, sinais de pneumatose intestinal.

O DIAGNÓSTICO MAIS PROVÁVEL É:

- A Ileó meconial.
- B Enterocolite necrotizante.
- C Doença de Hirschsprung.
- D Invaginação intestinal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141130](#)

Questão 119 Trauma Abdominal Fechado Cirurgia

Homem, 25a, vítima de colisão frontal de carro a 100 km/hora, ocupante no banco dianteiro e com cinto de segurança. Atendido pelo SAMU no local. Exame físico: PA= 130x80 mmHg; FC= 110 bpm, FR= 30 irpm, oximetria de pulso (máscara de oxigênio 10 litros/min)= 90%; neurológico: Glasgow= 5, an socoria (direita maior que esquerda). Foram realizados intubação orotraqueal, 1.000 mL de solução de Ringer com lactato e transferido para um hospital. Na admissão realizaram-se: exames radiográficos simples do tórax e de bacia e FAST (focused assessment with sonography for trauma), na sala de emergência, sendo respectivamente: sem alterações e negativo.

A CONDUTA A SEGUIR É:

- A Lavado peritoneal diagnóstico.
- B Tomografia de coluna cervical.
- C Tomografia computadorizada de crânio.
- D Tomografia computadorizada de corpo inteiro.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141129](#)

Questão 120 Fratura exposta

Mulher, 22a, é levada à Unidade de Pronto Atendimento pelo Resgate, após queda de motocicleta. Exame físico: consciente, orientada, PA= 114x76mmHg, FC= 95bpm, FR= 16 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 99%; Membro inferior esquerdo: fratura exposta de tíbia e fíbula, sem sangramento ativo, com ausência de pulso pedioso.

A CONDUTA EM SALA DE EMERGÊNCIA EM RELAÇÃO À FRATURA É:

- A Alinhamento para reposicionamento e imobilização.
- B Profilaxia para trombose venosa e imobilização.
- C Aplicar curativo compressivo e tala gessada.
- D Limpar com solução fisiológica, curativo compressivo e tala gessada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141128](#)

Questão 121 Trauma Abdominal Fechado Cirurgia

Homem, 21a, chega ao Pronto Socorro vítima de acidente motociclístico. Exame físico: Consciente, orientado, PA= 117x78mmHg, FC= 92 bpm, FR= 16 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 99%; Abdome: escoriações em pared anterior periumbilical. Realizado FAST (focused assessment with sonography for trauma):



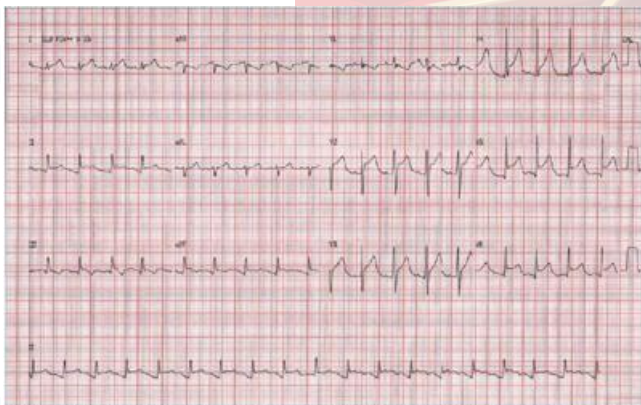
AS INTERPRETAÇÕES DAS IMAGENS ACIMA: 1 (ESPAÇO HEPATORRENAL), 2 (ESPAÇO ESPLÉNORRENAL) E 3 (FUNDO DE SACO) SÃO, RESPECTIVAMENTE:

- A Negativo, positivo, positivo.
- B Negativo, negativo, positivo.
- C Positivo, negativo, negativo.
- D Positivo, positivo, negativo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141127](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 122 Exames complementares Cardiologia Quadro clínico

Homem, 42a, procurou o pronto atendimento com queixa de dor precordial há duas horas, ventilatório-dependente, piora quando se deita e melhora quando fica em pé. Refere também febre e mal-estar há quatro dias, com melhora após uso de paracetamol. Exame físico: = 38o C, PA= 112x86 mmHg; FC= 112 bpm, FR= 21 irpm; Coração: rangido de alta frequência, mais audível no final da expiração. Troponina= 123 ng/mL; ECG:



O DIAGNÓSTICO É:

- A Tromboembolismo pulmonar.
- B Endocardite bacteriana aguda.
- C Pericardite aguda.
- D Infarto agudo miocárdio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141126](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 123 Gestante

Mulher, 27a, primigesta, com 38 semanas de gestação, vítima de acidente automobilístico, chega à Unidade de Pronto Atendimento, trazida pelo SAMU em prancha rígida. Exame físico: PA= 88x56mmHg, FC= 124 bpm, FR= 23irpm.

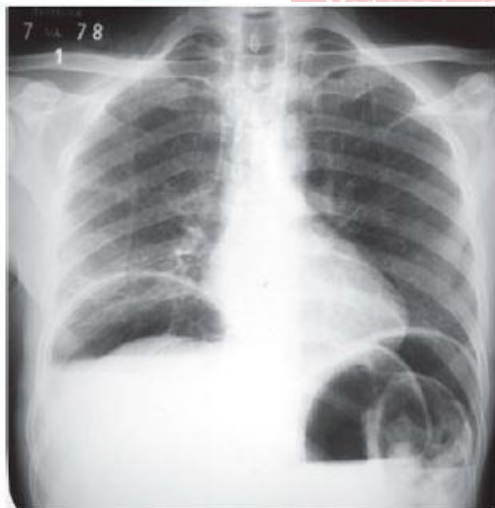
ALÉM DA REANIMAÇÃO VOLÊMICA A CONDUTA É DESVIAR MANUALMENTE O ÚTERO PARA A:

- A Esquerda ou elevar o lado esquerdo do dorso.
- B Direita ou elevar o lado direito do dorso.
- C Esquerda ou elevar o lado direito do dorso.
- D Direita ou elevar o lado esquerdo do dorso.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141125

Questão 124 Abdome Agudo Perfurativo Cirurgia

Homem, 41a, relata que há 1 hora apresentou dor súbita de forte intensidade, tipo pontada, no epigástrio, que irradiou para todo abdome. Refere náusea. Nega febre ou sintomas respiratórios. Exame físico: PA=128x76mmHg, FC= 102bpm, FR= 16irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 99%, corado, hidratado e acianótico; Abdome: plano, tenso, doloroso à digitopercussão e à palpação superficial e profunda, com descompressão brusca dolorosa presente. Radiograma simples de abdome ortostático:



Contra preços abusivos
na medicina.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

A CONDUTA É:

- A Endoscopia digestiva alta terapêutica.
- B Laparotomia exploradora.
- C Ultrassonografia de abdome total.
- D Reavaliar após hidratação.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000141124

Questão 125 Tratamento do choque séptico Choque séptico

Mulher, 62a, procura atendimento com disúria há uma semana e febre há três dias. Antecedente pessoal: diabetes melito. Exame físico: FC= 108 bpm, FR= 24 irpm, PA= 72x50 mmHg, T= 37,2°C, oximetria de pulso (ar ambiente)= 95%; corada, desidratada ++/4+, pulsos regulares e simétricos; ausculta cardiopulmonar sem alterações; abdome normotenso, demonstra desconforto à palpação profunda de flanco esquerdo, sem sinais de peritonite; neurológico: sonolenta, responde a estímulos verbais, sem déficits neurológicos focais. Glicemia capilar= 128 mg/dL. Solicitada a dosagem de lactato sérico e a

coleta de duas hemoculturas por sítios diferentes de punção. Prescritas ceftriaxona intravenosa e expansão volêmica com solução salina isotônica (30ml/kg= 2.100ml). Após a infusão de 800 ml em 40 minutos, apresenta melhora da sonolência e FC= 94 bpm, FR= 22 irpm, PA= 80x52 mmHg.

A CONDUTA EM RELAÇÃO AO MANEJO HEMODINÂMICO É:

- A Prescrever hidrocortisona.
- B Manter apenas a infusão de soro fisiológico.
- C Prescrever dobutamina e suspender a expansão volêmica.
- D Prescrever noradrenalina e manter a expansão volêmica.

4 00014 1123

Questão 126 **Pediatria** **Programa Nacional de Imunizações** **Calendário dos adolescentes**

Adolescente, 16a, saudável, necessita atualizar a carteira vacinal para poder cumprir seis meses de intercâmbio estudantil para a Bélgica. Há comprovação de ter recebido três doses da vacina de hepatite B na infância.

A ORIENTAÇÃO SERÁ:

- A Refazer três doses da vacina.
- B Administrar uma dose de reforço.
- C Verificar título de anti-HBs para conduta.
- D Não há necessidade de doses adicionais.

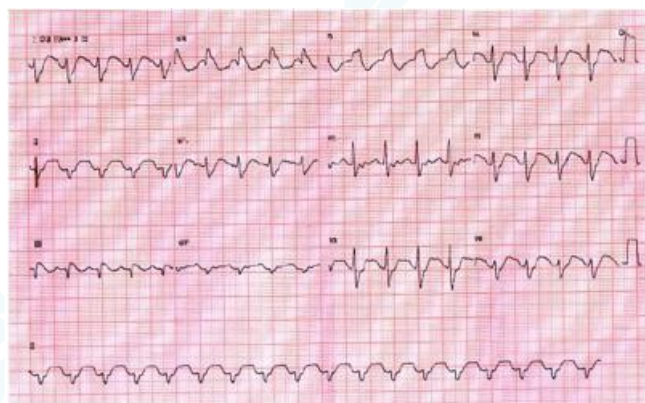
Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141123](https://www.4000141123.com.br)

Questão 127 **Eletrocardiograma**

Homem, 27a, é trazido pelo SAMU, que o encontrou confuso em seu carro, onde relatava palpitações. Chega ao pronto socorro com rebaixamento do nível de consciência. Não se sabe sobre seus antecedentes. Exame físico: PA= 104x72 mmHg, FC= 114 bpm, FR= 27 irpm, T= 37,5oC, Oximetria de pulso (ar ambiente) = 96%, extremidades frias; abdome: ausência de ruídos hidroaéreos; neurológico: Glasgow= 11, pupilas isocóricas e fotorreagentes, midríaticas, com movimentação ocular normal, sem déficits neurológicos focais evidentes. Glicemia capilar= 106mg/dL. ECG:



A CONDUTA INICIAL É:

- A Amiodarona.
- B AAS, clopidogrel, sinvastatina.
- C Bicarbonato de sódio.
- D Cardioversão elétrica sincronizada.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141121](#)

Questão 128 Diagnóstico

Mulher, 61a, vem com queixa de sangue vivo nas fezes há cerca de quatro meses. O sangue é em pequena quantidade e não há dor ao evacuar. Nega náusea, vômitos ou perda de peso. Nega história familiar de neoplasia. Antecedente pessoal: diabetes melito tipo 2, em uso de metformina. Exame físico: descorada +/-.

PARA O PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA DEVE REALIZAR:

- A Tomografia computadorizada de abdome e sangue oculto nas fezes.
- B Tomografia computadorizada de abdome e enema opaco.
- C Toque retal e pesquisa de sangue oculto nas fezes.
- D Toque retal e colonoscopia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141120](#)

Questão 129 Diagnóstico

Mulher, 62a, comparece para consulta médica com queixa de dispneia aos moderados esforços (NYHA II), fadiga crônica, sonolência diurna. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial e diabetes há 20 anos, em uso de metformina 850mg/dia e losartana 50 mg/dia. Nega tabagismo, etilismo ou doença pulmonar prévia. Exame físico: Peso= 106 kg, altura= 1,60 m, oximetria de pulso (ar ambiente)= 88%, FC= 90 bpm, PA= 156x98 mmHg. Pletórica; Pulmões: murmúrio vesicular reduzido globalmente. Gasometria arterial (ar ambiente): pH= 7,38; paO_2 = 52 mmHg, paC_2 = 56 mmHg, HCO_3 = 30 mmol/L, sat O_2 = 88%. Espirometria= distúrbio misto de grau leve.

A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

- A Síndrome de hipoventilação associada à obesidade.
- B Tromboembolismo pulmonar crônico.
- C Hipertensão pulmonar.
- D Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141119](#)

Questão 130 Características dos sopros cardíacos

Mulher, 36a, queixa-se de dispneia em repouso, ortopneia e tosse seca. Exame físico: Coração: sopro diastólico +++/6+ em segundo espaço intercostal esquerdo, aspecto aspirativo, sopro diastólico em ruflar +++/6+, hiperfonese de B1 e final de B2, extremidades: pulsos periféricos simétricos, amplitude normal.

A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

- A Estenose aórtica e insuficiência tricúspide.
- B Dupla lesão mitral e estenose aórtica.
- C Insuficiência pulmonar e estenose mitral
- D Insuficiência aórtica e insuficiência mitral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141118](#)

Questão 131 Interação com Outras Drogas

Inibidores de bomba de prótons são frequentemente prescritos em associação com outros medicamentos. Entretanto, algumas interações medicamentosas podem ser limitantes ou cursar com eventos adversos graves.

EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO COM OMEPRAZOL É CORRETO:

- A Fenobarbital; redução de ação anticonvulsivante.
- B Fluconazol; aumento de toxicidade hepática.
- C Clopidogrel; redução de atividade antiplaquetária.
- D Warfarina; redução de atividade anticoagulante.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141117](#)

Questão 132 Hematologia Crise de sequestro esplênico

Homem, 24a, procura a unidade de emergência com dor intensa em flanco direito, há quatro horas e muita falta de ar. Antecedente pessoal: anemia falciforme, em acompanhamento desde a infância, em uso de hidroxiureia desde os 12 anos de idade. Exame físico: Ictérico +++/4+, T=36°C FC= 97 bpm, abdome: dor à palpação de hipocôndrio direito, descompressão brusca negativa, fígado a 9 cm do RCD, doloroso à palpação, sendo impossível avaliar consistência ou forma. Hb=5 g/dL, VCM= 78 fL, reticulócitos= 25%, Leucócitos= 15.100/mm³(65% neutrófilos segmentados, 10% bastonetes, 5% monócitos, 20% linfócitos), plaquetas= 350.000/mm³, AST= 48 U/L, ALT= 61 U/L, fosfatase alcalina= 229 U/L, GGT= 160 U/L, Bilirrubina direta= 6,9 mg/dL, bilirrubina indireta 1,2 mg/dL.

O DIAGNÓSTICO É:

- A Sequestro hepático.
- B Colecistite aguda.
- C Colestase intra-hepática.
- D Trombose de veia porta.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141116](#)

Questão 133 Alcalose metabólica Nefrologia Vômitos

Homem, 70a, com história de vômitos persistentes há dois dias. Refere fraqueza, tremores, câimbras e confusão mental. Diurese de ontem 400ml. Exame físico: turgor da pele e tensão do globo ocular bastante diminuídos, olhos sem brilho, língua seca e diminuição da perfusão periférica, FC= 110 bpm, PA deitado= 92x60mmHg; sentado 70x50mmHg. Veias jugulares externas permaneciam vazias com o paciente completamente na horizontal, sem travesseiro. Ureia= 140mg/dl, creatinina = 2,0mg/dl, Na= 135 mEq/l, K= 3,0 mEq/l, Cl= 85mEq/l; Gasometria arterial em ar ambiente: pH= 7,58, paCO₂= 51 mmHg,

$\text{HCO}_3^- = 36 \text{ mEq/L}$.

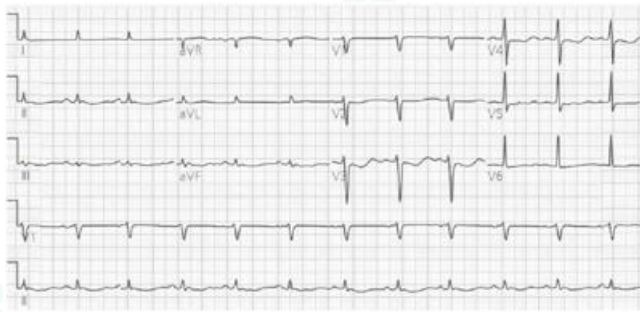
EM RELAÇÃO AO DISTÚRBO METABÓLICO OBSERVADO NESTE CASO É CORRETO:

- A A hipovolemia leva à retenção renal de Na, H e Cl, compensando o equilíbrio metabólico.
- B A hiperventilação alveolar compensatória é interrompida quando paCO_2 atinge 50 mmHg.
- C Com os vômitos, há perda de Na, Cl, K e H, levando a um excesso de bases.
- D Hipocalemia pode ser o fator desencadeador, mas é corrigida por reabsorção em túbulo contornado proximal.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141115](https://www.4000141115.com)

Questão 134 **Cardiovasculares**

Mulher, 44a, deu entrada na emergência com fraqueza muscular intensa. Antecedente pessoal: furosemda 120 mg/dia. Exame físico: Peso 70 Kg, esta ura 1,50m, FC= 64 bpm, PA= 112x68 mmHg. ECG:



O DIAGNÓSTICO É:

- A Hipofosfatemia.
- B Hipocalemia.
- C Hipomagnesemia.
- D Hipocalcemia.



Essa questão possui comentário do professor no site [4000141114](https://www.4000141114.com)

Questão 135 **Dermatologia** **Diagnóstico**

Mulher, 41a, casada, auxiliar de limpeza, procura atendimento médico por aparecimento de lesões no tronco, abdome, mãos e pés há três semanas. Refere febre, mialgia e linfonodomegalia. Antecedente pessoais: epilepsia em uso de fenitoína 200 mg/dia. Membros superiores (ANEXO A):



O DIAGNÓSTICO E A CONDUTA SÃO:

- A Tinha do corpo; antifúngicos sistêmicos.
- B Farmacodermia; substituir droga anticonvulsivante.
- C Psoríase gutata; biópsia de pele.
- D Sífilis secundária; testes treponêmicos e não treponêmicos.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141113](https://www.4000141113.com)

Questão 136 ITU recorrente

Mulher, 35a, apresenta dor para urinar, aumento da frequência, diminuição da quantidade e urgência miccional há dois dias. Nega febre, calafrios, dor lombar e gravidez. Antecedente pessoal: dois episódios semelhantes nos últimos seis meses. Exame sumário de urina: hemácias= 20/campo, leucócitos= > 100/campo, proteína= ausente, nitrito= +++/4+, leucócito esterase= +++/4+; Urocultura: E coli > 10⁵ UFC, sensível a todos os antibióticos testados.

APÓS O TRATAMENTO DESTES EPISÓDIOS, A CONDUTA PARA PREVENIR NOVAS INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO É:

- A Prescrever profilaxia com nitrofurantoína por seis meses.
- B Prescrever profilaxia pós coito com ciprofloxacino.
- C Investigar nefrolitíase.
- D Investigar malformação de trato urinário.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141113](https://www.4000141113.com)

Questão 137 Quadro Clínico do mieloma múltiplo MM

Mulher, 52a, comparece em consulta médica trazendo os seguintes exames. Albumina sérica= 4,0 mg/dL, creatinina= 1,0 mg/dL; Exame sumário de urina: pH= 7,2, densidade= 1020, proteína= +/4+, glicose= negativa, leucócitos= 2/campo, hemácias= 3/campo; proteinúria de 24 horas= 12g/24 horas.

A CLASSIFICAÇÃO QUANTO À ORIGEM E A PROTEÍNA URINÁRIA PREDOMINANTE NO QUADRO CORRESPONDEM A:

- A Tubular, proteínas de baixo peso molecular.
- B Sobrecarga, proteínas de cadeia leve.
- C Glomerular seletiva, predomínio de albumina.
- D Glomerular não seletiva, com albumina e imunoglobulinas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000141111](https://www.4000141111.com)

Questão 138 Urticária

Homem, 54a, procura alergista com histórico de urticária e angioedema há oito anos. Relata episódios recorrentes de início súbito, poucos minutos após o uso de algumas medicações como dipirona, diclofenaco, ibuprofeno, que usa para lombalgia crônica.

A CONDUTA É:

- A Orientar este paciente que o risco de reação grave e morte é quase inexistente e com isso tranquilizá-lo e liberar o uso esporádico de anti-inflamatórios.
- B Liberar o uso de inibidores seletivos da ciclo-oxigenase 2 (cox-2), após teste de provocação oral.
- C Solicitar a dosagem de IgE para drogas anti-inflamatórias e liberar o uso daquelas com IgE específica negativa.
- D Prescrever paracetamol, pois sua estrutura molecular é diversa dos anti-inflamatórios, diminuindo a chance de reação adversa cruzada.

4000141110

Questão 139 Clínica Médica Hepatologia Outras Hepatopatias

Mulher, 42a, encaminhada do dermatologista por alteração de exames laboratoriais que realizou em investigação de alergia de pele com prurido e uso eventual de loratadina. Antecedentes pessoais: nega uso de outras medicações e ingere 4 latas de cerveja nos finais de semana. Exame físico: IMC= 31kg/m². AST= 51 U/L; ALT= 42 U/L; Fosfatase Alcalina= 369 U/L; GGT= 561 U/L; glicemia de jejum= 110 mg/dL.

O DIAGNÓSTICO E A CONDUTA SÃO:

- A Não é possível definir o diagnóstico; prosseguir investigação com biópsia hepática percutânea.
- B Hepatopatia de padrão colestatístico, realizar exame de imagem e pesquisar anticorpo antimitocôndria.
- C Doença hepática gordurosa não alcoólica associada a síndrome metabólica; orientar hábitos alimentares.
- D Toxicidade por álcool e/ou loratadina; suspender o uso e repetir exames após quatro semanas.

4000141109

Questão 140 Tratamento da síndrome hepatorenal tipo I Complicações da cirrose Nefrologia

Mulher, 63a, com diagnóstico de cirrose alcoólica, está internada por descompensação clínica há 3 dias, com piora da ascite, oligúria e início de encefalopatia hepática. Em uso diário de espironolactona 200mg, furosemida 40mg e complexo vitamínico. Creatinina 1,7 mg/dL; (0,8 mg/dL na entrada); Líquido ascítico: hemácias= 1.300/mm³, leucócitos= 420/mm³ (62% de linfócitos, 31% neutrófilos e 7% de monócitos); proteína= 1,4 g/dL, albumina= 0,7 g/dL,

O DIAGNÓSTICO E A CONDUTA SÃO:

- A Lesão renal aguda estágio 2; suspender diuréticos e prescrever albumina humana.
- B Síndrome hepatorenal; prescrever albumina humana e terlipressina.
- C Peritonite bacteriana espontânea com disfunção renal; prescrever ceftriaxona e albumina.
- D Lesão renal aguda estágio 1; reduzir diuréticos e prescrever ceftriaxona empírico.

4 00014 1108

Respostas:

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	
34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55	
56		57		58		59		60		61	B	62	C	63	B	64	D	65	A	66	B
67	D	68	A	69	A	70	B	71	C	72	C	73	D	74	C	75	C	76	A	77	A
78	A	79	C	80	A	81	C	82	D	83	C	84	D	85	B	86	A	87	B	88	B
89	B	90	D	91	C	92	D	93	B	94	B	95	D	96	C	97	C	98	A	99	B
100	A	101	D	102	B	103	C	104	A	105	A	106	D	107	C	108	D	109	A	110	D
111	C	112	A	113	B	114	B	115	A	116	B	117	B	118	B	119	D	120	A	121	C
122	C	123	C	124	B	125	D	126	D	127	C	128	D	129	A	130	C	131	C	132	A
133	C	134	B	135	D	136	A	137	B	138	B	139	B	140	A						

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Questão 1 Projeto Terapêutico Singular

Em geral as profissões de saúde e as respectivas especialidades conseguem definir claramente, cada uma, a sua prioridade em relação a um mesmo paciente. QUANDO UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SE REÚNE PARA CONSTRUIR UM PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR, A PRIMEIRA TAREFA É CHEGAR A UM CONSENSO SOBRE:

4 000167474

Questão 2 Intoxicação pelo chumbo

Homem, 42a, procura atendimento médico com dores abdominais e m cólica há dois dias sem melhora com antiespasmódico. Antecedente profissional: trabalhador de uma cerâmica, com exposição a algumas substâncias químicas, há dois anos. Exame físico: palidez cutânea 2+/4; abdome: dores à palpação abdominal, sem sinais de abdome agudo. Ultrassonografia abdominal sem alterações. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site 4 000167473

Questão 3 Conceitos relacionados à morte

A PRÁTICA DE INTERVENÇÕES QUE FALHAM EM RESTAURAR, CURAR OU QUE SÃO INCAPAZES DE PRODUZIR ALGUM BENEFÍCIO SIGNIFICATIVO PARA O PACIENTE, NÃO CONSIDERANDO A QUALIDADE DE VIDA PRESUMIVELMENTE ALCANÇÁVEL, E QUE DESRESPEITAM A DECISÃO COMPARTILHADA ENTRE PACIENTES E FAMILIARES, É CONHECIDA COMO:

4 000167472

Questão 4 Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS

Mulher, 66a, hipertensa, diabética e dislipidêmica, buscou a Unidade Básica de Saúde para acompanhamento das doenças crônicas e renovação de suas receitas, entre elas a sinvastatina. Paciente assídua, segue as recomendações médicas, participa de grupo de caminhada, toma os fármacos prescritos. Seus pedidos de exames laboratoriais também precisavam ser renovados, pois o laboratório do município estava com falta de insumos e sem previsão de realizá-los nos próximos três meses. Ao ser questionada sobre a possibilidade de ela pagar pelos exames na rede privada, respondeu constrangida que não pode pagar. BASEADO NA CONDUTA ÉTICA O PRINCÍPIO DO SUS A SER SEGUIDO É:

4 000167471

Questão 5 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

Um serviço de saúde tem apresentado problemas de comunicação entre os profissionais, conflitos e baixa responsabilização global pelo paciente. Uma análise do organograma gerencial demonstrou que as funções de coordenação estão associadas às profissões (cada profissão tem sua chefia e o seu sistema de gerenciamento separado). Desta forma, profissionais que trabalham lado a lado com o mesmo paciente, se reportam a coordenações diferentes. A Política Nacional de Humanização propõe a reorganização do organograma de forma que trabalhadores responsáveis pelos mesmos pacientes sejam da mesma equipe e tenham a mesma coordenação. ESSA DIRETRIZ É DENOMINADA:

4 000167470

Questão 6 Saúde do Trabalhador Transtornos do Humor

Homem, 28a, bancário, procurou serviço médico com queixas de desânimo, ideação suicida e insônia há três meses. Conta que há um ano o novo gerente da agência passou a divulgar um ranking dos melhores e piores vendedores de seguros, ameaçando de demissão aqueles que permanecerem na parte de baixo da lista. Relata que, desde então, seu nome é citado como um mau exemplo nas reuniões mensais da equipe. Sente-se humilhado e percebe distanciamento dos colegas de trabalho. AS ATITUDES DO GERENTE E DOS COLEGAS DE TRABALHO SÃO CARACTERIZADAS COMO:

Questão 7 **Síndrome do Esgotamento Profissional Burnout**

Homem, 50a, casado, trabalha na mesma empresa há 20 anos, sendo 15 como técnico em telecomunicações. Há cinco anos, a empresa iniciou processo de reestruturação e o promoveu para o cargo de gerente. As novas atribuições incluem a demissão de muitos funcionários antigos e contratação de novos trabalhadores terceirizados para reduzir os custos da empresa. As sucessivas mudanças de diretrizes e metas da empresa, o levaram a trabalhar até mais tarde praticamente todos os dias, incluindo muitos fins de semana, para dar conta de seu trabalho. Nos últimos meses, tem se sentido extremamente cansado, ansioso, tenso e com episódios de insônia. Além da exaustão física e mental, sente que está sendo exigido além do seu limite emocional, tornando-se irritado e impaciente, ao contrário de como se sentia antes. Percebe que passou a evitar os colegas de trabalho e, até mesmo, alguns clientes. Não sente mais prazer nas atividades de trabalho tem dificuldade em tomar decisões, refere "brancos" de memória, desesperança e sentimento de desvalorização pessoal. Nas últimas semanas, manifestou vontade de morrer, o que o levou a buscar o serviço de saúde. TRATA-SE DE UM CASO DE:

4000167468

Questão 8 **Atenção Primária à Saúde APS no Brasil** **Política Nacional de Atenção Básica PNAB**

Equipe de saúde da família responsável por comunidade com famílias vulneráveis, com alta taxa de desemprego e predomínio de crianças e adultos jovens tem elaborado Projetos Terapêuticos Singulares, durante reuniões semanais, em parceria com pediatria, psicologia, assistência social e terapia ocupacional. O ARRANJO OU DISPOSITIVO COMPOSTO POR EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PARA AMPLIAR AS OFERTAS DE SAÚDE NA REDE DE SERVIÇOS, A RESOLUTIVIDADE, A ABRANGÊNCIA E O ALVO DAS AÇÕES É:

4000167467

Questão 9 **Dermatologia** **Tinea capitis**

Uma universidade realiza atividades de extensão em ocupação caracterizada por barracos de madeira, fornecimento precário de água e eletricidade, ausência de saneamento básico e presença de grande quantidade de cães e gatos. Durante o exame físico de crianças entre quatro e seis anos de idade foram observadas lesões no couro cabeludo com placa de alopecia e sem prurido. As crianças apresentaram melhora após seis semanas de uso de griseofulvina. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Proibida Venda.

Acesso a uma medicina livre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167466

Questão 10 **Medidas de saúde coletiva**

Para avaliar a ocorrência de câncer de próstata em homens com idade > 50 anos, alguns médicos realizaram o atendimento - anamnese e toque prostático - de 600 indivíduos, em um mês. Eles verificaram que a média de idade era de 62 anos; 38,6% relataram história familiar de câncer; 58,4% eram fumantes ou ex-fumantes e 40,5% consumiam bebidas alcoólicas regularmente. No exame foi possível observar que 28,9% apresentaram próstata aumentada; 3,9% superfície prostática irregular; 11,3% assimétrica; 2% com consistência pétrea. Foram solicitadas e realizadas 40 biópsias e 15 apresentaram resultado positivo para adenocarcinoma prostático.

A OCORRÊNCIA DE CASOS POR 1000 HOMENS FOI DE:

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167465

Questão 11 **Estudos Seccionais Transversais**

Para avaliar a ocorrência de câncer de próstata em homens com idade > 50 anos, alguns médicos realizaram o atendimento - anamnese e toque prostático - de 600 indivíduos, em um mês. Eles verificaram que a média de idade era de 62 anos; 38,6% relataram história familiar de câncer; 58,4% eram fumantes ou ex-fumantes e 40,5% consumiam bebidas alcoólicas regularmente. No exame foi possível observar que 28,9% apresentaram próstata aumentada; 3,9% superfície prostática

irregular; 11,3% assimétrica; 2% com consistência pétrea. Foram solicitadas e realizadas 40 biópsias e 15 apresentaram resultado positivo para adenocarcinoma prostático.

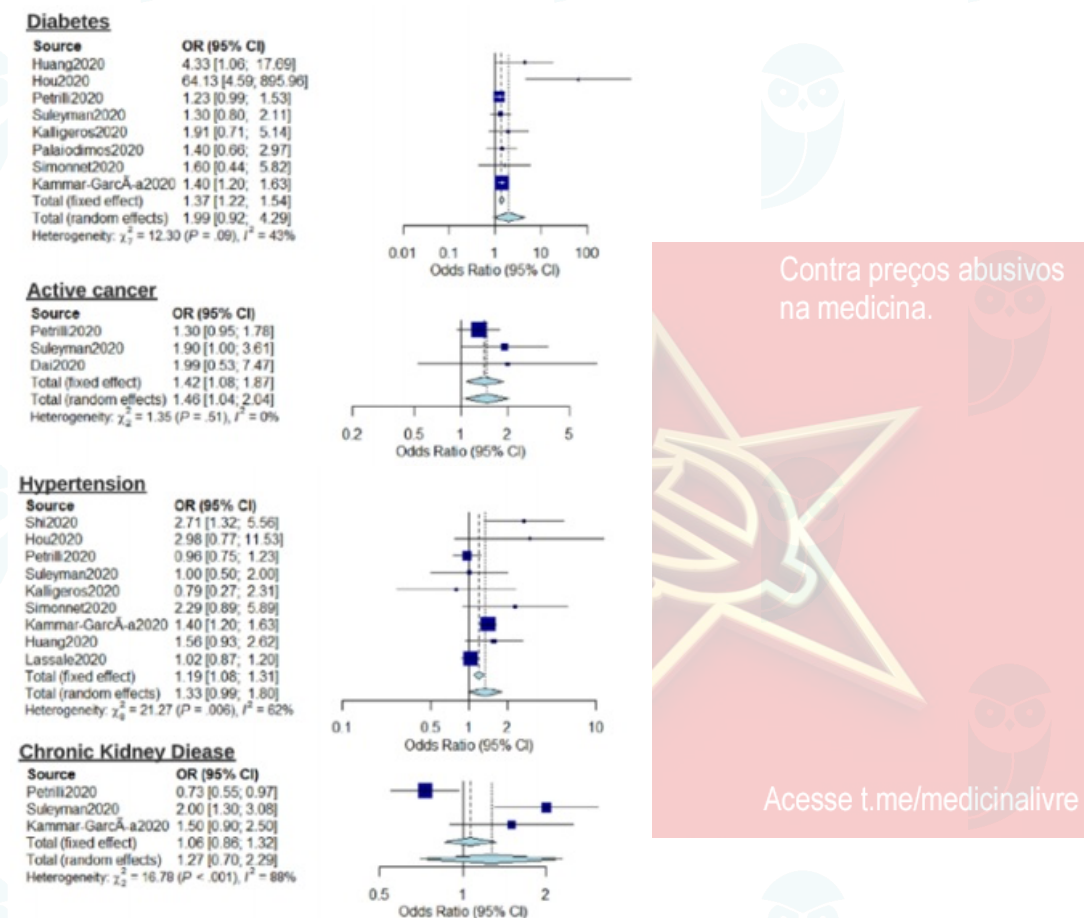
CITE O DESENHO DE ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO:

4000167464

Questão 12 Medicina Preventiva

De acordo com os dados da Figura abaixo:

Forest plot para a associação de comorbidades (diabetes, hipertensão, doença renal crônica e câncer) com desfechos graves de covid-19.



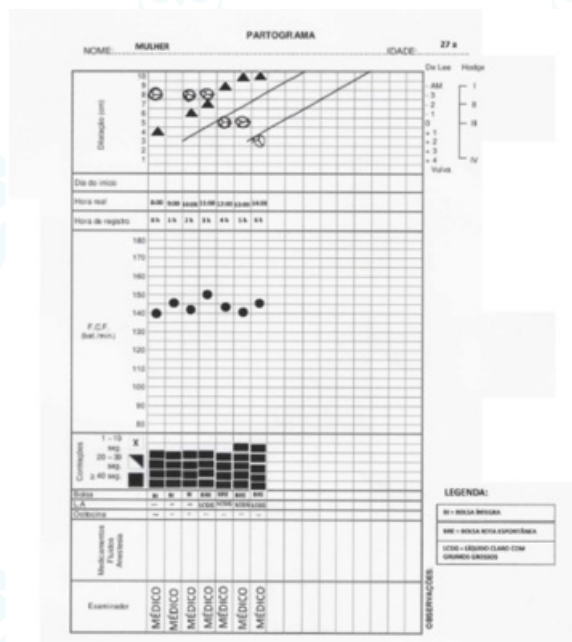
Fonte: adaptado de BOOTH et al. Population risk factors for severe disease and mortality in COVID-19: A global systematic review and meta-analysis. *Plos One*, v 16, n 3, março 2021. DOI: 10.1371 / journal.pone.0247461.

CONSIDERANDO O MODELO DE EFEITOS ALEATÓRIOS, CITE A CONDIÇÃO CRÔNICA ESTATISTICAMENTE ASSOCIADA COM DESFECHOS GRAVES DE COVID-19:

4000167463

Questão 13 Partograma

Mulher, 27a, com gestação de 39 semanas, interna em trabalho de parto espontâneo. Antecedentes obstétricos: primigesta, com pré-natal realizado em Unidade Básica de Saúde e sem intercorrências gestacionais, em uso de sulfato ferroso em dose profilática. Antecedentes pessoais: sem comorbidades, alergias ou cirurgias prévias, nega tabagismo ou uso de outras substâncias. Partograma:



O DIAGNÓSTICO DA EVOLUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO É:

Contra preços abusivos
Essa questão possui comentários
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167462](https://www.4000167462.com.br)

Questão 14 Rastreamento do câncer de colo do útero

Mulher, 25a, retorna à Unidade Básica de Saúde para resultado de primeira colpocitologia oncológica (CO) realizada há um mês. Antecedente pessoal: diagnóstico de infecção pelo HIV há dois anos. CO= células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US). A CONDUTA É:

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167461

Questão 15 **Ginecologia** **Regimes terapêuticos**

Mulher, 42a, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de ondas de calor intensas que dificultam seu sono; tem acordado seis vezes durante a noite com ondas de calor. Antecedentes ginecológicos: cirurgia de câncer de ovário há oito meses, com realização de histerectomia total e anexectomia bilateral, com anatomopatológico de carcinoma epitelial de ovário. Não apresenta outros antecedentes morbidos. A TERAPIA HORMONAL INDICADA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167460](#)

Questão 16 Tratamento

Mulher, 30a, nuligesta, com queixa de sangramento menstrual aumentado há um ano, com ciclos menstruais regulares com duração de sete dias, desejando tratamento. Última menstruação há 10 dias. Método contraceptivo: preservativo masculino. Antecedente pessoal: enxaqueca com aura. Exame físico: IMC= 29Kg/m²; descorada 1+/4. Hb= 9,5g/dL, Ht= 28%. FSH, LH, TSH e prolactina normais. Ultrassonografia transvaginal: útero e ovários de tamanho e forma adequados para a idade, sem anormalidades. A TERAPIA HORMONAL INDICADA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167459](#)

Questão 17 Seguimento

Mulher, 45a, submetida a mastectomia radical à esquerda há cinco anos por carcinoma ductal invasivo, estágio IIA, encontra-se assintomática e sem uso de medicação. A avaliação clínica e mamográfica realizadas hoje não apresentam evidência de doença. EM QUANTO TEMPO DEVERÁ SER REALIZADA A PRÓXIMA MAMOGRAFIA?

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167458](#)

Questão 18 Diagnóstico diferencial

Mulher, 54a, procura atendimento ginecológico na atenção primária por episódios de sangramento via vaginal em pequena quantidade há quatro meses. Antecedente pessoal: menopausa há dois anos, com exames periódicos atualizados com resultados normais. Exame físico: IMC= 27Kg/m². A CAUSA MAIS PROVÁVEL DO SANGRAMENTO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167457](https://www.4000167457.com)

Questão 19 **Ginecologia** **Tumores metastáticos**

Mulher, 42a, G4P3A1, comparece ao serviço de emergência com queixa de aumento do volume abdominal há dois meses com piora progressiva. Há três dias refere inapetência e dificuldade para respirar pelo aumento da barriga. Exame físico: Regular estado geral, descorada 2+/4+, emagrecida. FR= 26irpm, PA= 102x74mmHg, FC= 96bpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 96%; abdome: volumoso com massa palpável de 10cm em mesogastro e sinal de Piparote positivo. Ultrassonografia de abdome= ascite volumosa, omento tumoral, sinais de implantes tumorais em peritônio em região de goteiras parietocólicas, pelve e subdiafragmática. Tumoração ovariana sólida bilateral com superfície irregular e vascularização aumentada (ovário direito= 150cm³ e ovário esquerdo= 210cm³). Antígeno carcinoembrionário = 45ng/mL e CA 125= 220U/mL. A PRINCIPAL HIPÓTESE DIAGNÓSTICA DA TUMORAÇÃO OVARIANA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167456](https://www.4000167456.com)

Questão 20 **Hemorragias pós parto HPP e rotura uterina** **Obstetrícia**

Mulher, 37a, G4PV3A0, em puerpério imediato de parto vaginal, sem episiotomia e sem lacerações. Após uma hora de dequitação apresentou sangramento vaginal intenso. Exame físico: PA= 102x58mmHg, FC= 120bpm, FR= 22ipm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 98%; exame obstétrico: útero de consistência amolecida, palpável a 3cm acima da cicatriz umbilical. Após monitorização, suporte hemodinâmico e administração de uterotônicos e de ácido tranexâmico, mantém sangramento aumentado. A PRÓXIMA CONDUTA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167455](https://www.4000167455.com)

Questão 21 **Restrição de crescimento fetal RCF** **Obstetrícia**

Primigesta com 31 semanas vem encaminhada da Unidade Básica de Saúde a um centro de referência por diminuição de movimentos fetais, sem contrações e sem perdas vaginais. Exame físico: PA= 106X67mmHg, FC= 86bpm, altura uterina= 26 cm, apresentação cefálica, sem rechaço à palpação uterina, BCF= 144bpm; membros sem edema. Ultrassonografia realizada há 7 dias observou feto cefálico, com peso no percentil 1 e índice de líquido amniótico 54mm. Realizada cardiocotografia hoje= normal. A CONDUTA SUBSEQUENTE É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167454](https://www.4000167454.com)

Questão 22 **Toxoplasmose na gestação**

Mulher, 24a, G1P0A0, idade gestacional de 11 semanas e 6 dias, vem para avaliação de exames de rotina pré-natal. Hb= 11,6g/dL, Ht= 33%, glicemia de jejum= 91mg/dL; Exame sumário de urina= normal, Urocultura= negativa, VDRL= não reagente, HIV= não reagente, Toxoplasmose: IgG= reagente e IgM= reagente. PARA ELUCIDAÇÃO DIAGNÓSTICA DEVE-SE SOLICITAR:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167453](https://www.4000167453.com)

Questão 23 **Abortamento habitual Abortamento de repetição e insuficiência istmocervical** **Obstetrícia**

Mulher, 25a, G2P1A0, Idade Gestacional= 22 semanas, com parto espontâneo às 28 semanas em gestação anterior, deu entrada na maternidade com queixa de dor em baixo ventre e secreção vaginal. Exame obstétrico: altura uterina 21 cm, dinâmica uterina ausente, batimentos cardíacos fetais: 140 bpm; especular: ausência de sangramento, presença de muco fisiológico em colo uterino e ausência de leucorreia; toque vaginal: colo medianizado, amolecido, 50% esvaecido, orifício externo entreaberto. Ultrassonografia: colo uterino medindo 20mm, com abertura de orifício interno e herniação de membrana amniótica pelo canal cervical, com aspecto de funil. A CONDUTA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167452](https://www.4000167452.com)

O DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL É:

Questão 27 Dermatologia Apresentação clínica

Menino, 45 dias, vem para puericultura com história de irritabilidade e lesões pelo corpo há 15 dias. Nega febre, vômitos, inapetência e uso de medicamentos. Hábito urinário e intestinal normais. Leite materno exclusivo. Vacinação em dia. Exame físico: bom estado geral, ganho ponderal de 35g/dia desde a última consulta, fontanela normotensa. Pele:



A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167448

Questão 28 Reações adversas

Menino, 4m, hígido, sem uso de medicamentos, é trazido à Unidade Básica de Saúde para atualização do calendário vacinal. Mãe refere que o filho apresentou convulsão em vigência de febre um dia após as vacinas dos dois meses e nega efeitos colaterais após a vacina administrada aos três meses de idade. QUAL VACINA A CRIANÇA DEVE RECEBER EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS?

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167447

Questão 29 Síndrome nefrótica Nefrologia

Menino, 2 anos e 5 meses, previamente hígido, é trazido a Unidade Básica de Saúde, com história de inchaço lento e progressivo nos olhos e pés há 10 dias e redução do volume urinário há um dia. Exame físico: bom estado geral, descorado+/4+; PA no percentil 50 para idade e sexo; abdome: semicírculos de Skoda a 2 cm da cicatriz umbilical, fígado a 1 cm do rebordo costal direito com borda fina, consistência elástica e hepatimetria de 6 cm; baço não percutível; genital: edema de bolsa escrotal sem eritema ou aumento da temperatura; membros inferiores: edema frio e depressível em face interna dos tornozelos até terço médio das pernas, bilateralmente; olhos: edema bupalpebral, sem secreção ou hiperemia. O DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO É:

4000167446

Questão 30 Síndrome Adrenérgica

Lactente, 3m, previamente hígido, é trazido a emergência com história de coriza e obstrução nasal há quatro dias e febre hoje. Medicamentos em uso: descongestionante nasal e antitérmicos. Exame físico: ativo e reativo, FC= 186bpm, PA= 95x52mmHg, FR= 40irpm, T= 40,2°C, sudorese profusa, pulsos cheios, perfusão periférica= 2 segundos, midríase bilateral, hiperreflexia, fontanela normotensa, pele sem lesões. O DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO É:

4000167445

Questão 31 Triagem Neonatal Pediatria

Recém-nascido a termo com peso adequado, apresenta dosagem aumentada do Tripsinogênio Imunorreativo no teste do

pezinho colhido no terceiro dia e na terceira semana de vida. O EXAME A SER REALIZADO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167444](https://www.4000167444.com.br)

Questão 32 Tratamento Pediatria

Menino, 15m, é trazido à consulta médica com história de dificuldade para ganhar peso progressiva após os oito meses de vida. A mãe diz que está mais irritado e inapetente, que apresentou aumento das evacuações, com fezes muito fétidas, pálidas, em grande quantidade. Alimentação: leite materno com introdução da dieta da família a partir do sexto mês. Nega infecções recorrentes. Exame físico: Irritado, pálido com peso e altura e m queda progressiva na curva de referência. Abdômen: distendido, diminuição de gordura subcutânea e da massa muscular com proeminente hipotrofia de glúteos. Biopsia intestinal: relação vilos/cryptas 1:1, linfócitos intraepiteliais e infiltrado de linfócitos e plasmócitos em lâmina própria. O TRATAMENTO A SER INSTITUÍDO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167444](https://www.4000167444.com.br)

Questão 33 Retorno da mulher ao trabalho Pediatria

Ao retornar ao trabalho, após licença maternidade de 120 dias, a mãe solicita orientações de como armazenar o leite ordenhado. PARA GARANTIR SUA QUALIDADE E VALIDADE, O LEITE MATERNO DEVE SER MANTIDO EM REFRIGERAÇÃO (5°C) POR UM TEMPO MÁXIMO DE:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167442](https://www.4000167442.com.br)

Questão 34 Tratamento da hiperbilirrubinemia Hiperbilirrubinemia não fisiológica

Recém-nascido a termo (39 semanas) com duas horas de vida, internado em uma maternidade de referência, encontra-se icterico e a dosagem laboratorial de bilirrubina sérica é de 9mg/dL. Mãe secundigesta com tipagem sanguínea A Rh negativo e teste de *Coombs* indireto positivo nesta gestação. A CONDUTA TERAPÊUTICA IMEDIATA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167441](https://www.4000167441.com.br)

Questão 35 Laringite estridulosa

Criança, 2a, com história de quadro de início súbito de tosse seca e “metálica”, rouquidão e dificuldade para respirar, na madrugada. Mãe nega história de febre, coriza, engasgo e conta melhora do quadro no trajeto ao serviço. Vacinação atualizada. Exame físico: Bom estado geral, FC= 97bpm, FR= 41rpm T= 36,7°C. Leve estridor laríngeo com retração de fúrcula. Pulmões: Murmúrio vesicular presente simétrico. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167440](https://www.4000167440.com.br)

Questão 36 Reanimação neonatal Pediatria

Criança de 40 semanas de idade gestacional nasce de parto vaginal com líquido amniótico meconial espesso e apresenta-se hipotônico ao nascimento. O cordão umbilical foi clampeado imediatamente e o recém-nascido colocado sobre o berço de calor radiante para avaliação. Dentro dos passos iniciais da reanimação foram realizados, em sequência, posicionamento do pescoço em leve extensão, aspiração de boca e narinas e secagem do paciente. Na reavaliação, recém-nascido encontra-se com respiração irregular e frequência cardíaca de 50bpm. A CONDUTA A SEGUIR É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167439](https://www.4000167439.com.br)

Questão 37 Cirurgia Câncer Colorretal

Mulher teve o diagnóstico de câncer de intestino grosso aos 49 anos. Seus filhos procuram a Unidade Básica de Saúde para orientação sobre riscos e necessidade de rastreamento. NESTA SITUAÇÃO, A COLONOSCOPIA ESTÁ INDICADA A PARTIR DE QUAL IDADE?

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167438](https://www.4000167438.com.br)

Questão 38 Estimativa da Superfície Corpórea Queimada e Circulação Cirurgia

Homem, 34a, vítima de queimaduras ao acender churrasqueira com combustível há uma hora, é trazido por familiares ao Pronto Socorro. Exame físico: consciente, orientado, PA= 132x84mmHg, FC= 112bpm, FR= 16irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 98%; Peso= 70Kg. Área de queimaduras distribuídas nas regiões do tórax anterior (5% de primeiro grau e 13% de segundo grau) e nos membros inferiores (8% de primeiro grau e 9% de segundo grau). O VOLUME DE SOLUÇÃO CRISTALOIDE A SER ADMINISTRADO NAS PRÓXIMAS 7 HORAS É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167437](#)

Questão 39 **Neoplasias Malignas do Esôfago** **Cirurgia**

Homem, 57a, refere dificuldade em se alimentar com alimentos sólidos e depois a líquidos há três meses, associada a perda de peso de 5 Kg no período. Há uma semana apresenta tosse todas as vezes que tenta ingerir líquidos e com a própria saliva. Antecedente pessoal: alcoolista e tabagista há longo tempo. A endoscopia mostra uma lesão vegetante e estenosante de esôfago a 22 cm da arcada dentária superior. A COMPLICAÇÃO CLÍNICA DESCRITA HÁ UMA SEMANA ASSOCIADA A ESSE DIAGNÓSTICO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167436](#)

Questão 40 **Via Aérea Definitiva** **Cirurgia**

Homem, 22a, sofreu queda de motocicleta em autoestrada, é trazido pelo Atendimento Pré-Hospitalar Básico com cânula de Guedel e máscara de oxigênio não reinalante com 15L/min. Exame físico na Sala de Emergência: PA= 113x84mmHg, FC= 102bpm, FR= 20irpm, oximetria de pulso= 99%; Neurológico: Escala de Coma de Glasgow= 7 e pupilas anisocóricas (direita > esquerda). Realizados: punção de um acesso venoso periférico calibroso, infusão intravenosa de 500mL de solução cristaloide aquecida e coleta de sangue para tipagem sanguínea. A CONDUTA A SEGUIR É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167435](#)

Questão 41 **Trauma Abdominal Fechado** **Cirurgia**

Mulher, 27a, vítima de colisão frontal de carro contra carro, é trazida pelo SAMU ao hospital terciário. Exame físico: consciente e orientada, PA= 96x68mmHg, FC= 112bpm, FR= 18irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 98%. Cabeça, pescoço, tórax e extremidades sem alterações; abdome: presença de abrasão horizontal linear, ao nível do umbigo, dor a palpação profunda e descompressão brusca indolor. Tomografia de abdome: lesão hepática Grau II sem sinais de extravasamento de contraste, líquido peri-hepático em moderada quantidade e pneumoperitônio. Amilase= 123mg/dL, hematócrito= 38% e hemoglobina= 12,4g/dL. A INDICAÇÃO DA LAPAROTOMIA FOI BASEADA NO ACHADO DE:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167434](#)

Questão 42 **Declaração de óbito DO Atestado de óbito**

Homem, 52a, vítima de atropelamento com traumatismo cranioencefálico grave, foi trazido por populares ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Foram realizados o atendimento inicial e os procedimentos cirúrgicos necessários. RT-PCR SARS-CoV-2: reagente na admissão. Na quarta semana de internação evoluiu para óbito secundário a choque séptico. DE QUEM É A RESPONSABILIDADE PELO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO?

[4000167433](#)

Questão 43 **Estenoses Traqueais** **Pneumologia** **Traqueia**

Mulher, 26a, apresenta-se no Pronto Socorro com história de dispneia progressiva há um mês. Refere vários atendimentos médicos anteriores com a mesma queixa, que melhoraram após uso de inalações com broncodilatadores. Neste atendimento foi repetida a inalação, sem melhora dos sintomas. Antecedente pessoal: traumatismo crânio encefálico há três meses, com internação em Unidade de Terapia Intensiva e ventilação mecânica invasiva por 10 dias. CONSIDERANDO A PRINCIPAL HIPÓTESE DIAGNÓSTICA, O EXAME A SER SOLICITADO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167432](#)

Questão 44 **Cirurgia** **Câncer Colorretal**

Mulher, 68a, procura a Unidade Básica de Saúde com queixa de fraqueza, cansaço e palpitação há quatro meses, principalmente após esforço como caminhada. Refere empachamento e perda ponderal de 5 Kg no período. Nega alteração do hábito intestinal, mas acha que as fezes estão escuras e fétidas. Exame físico: Bom estado geral, descorada 2+/4+, anictérica, acianótica. Abdome: tumoração palpável, endurecida, de limites imprecisos, indolor, em fossa ilíaca direita. Toque retal: sem alterações. A PRINCIPAL HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167431](https://www.4000167431.com)

Questão 45 **Manifestações Clínicas e Exame Físico** **Cirurgia**

Mulher, 62a, é atendida na Unidade Básica de Saúde apresentando queixa de dor abdominal em hipocôndrio direito associada a febre e icterícia há três dias. Tem diagnóstico de colelitíase com indicação de cirurgia eletiva, porém não conseguiu ser operada devido à pandemia de SARS-CoV-2. A ASSOCIAÇÃO DESTES TRÊS SINTOMAS É DENOMINADA:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167431](https://www.4000167431.com)

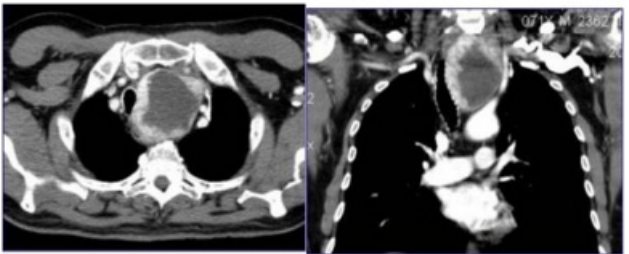
Questão 46 **Oclusão Arterial Aguda OAA** **Cirurgia**

O TEMPO DE ENCHIMENTO VENOSO SUPERIOR A 60 SEGUNDOS E TROMBOSE DE VEIAS SUPERFICIAIS EM UM DOENTE, TEM COMO HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:

[4000167429](https://www.4000167429.com)

Questão 47 **Apresentação Clínica e Avaliação Inicial** **Endocrinologia**

Mulher, 50a, procura atendimento médico com queixa de dispnéia aos esforços que se acentua com o decúbito. Nega disfagia. Tomografia computadorizada: tumor heterogêneo com calcificações em seu interior na transição cérvico torácica à esquerda com desvio contralateral da traqueia e esôfago.



QUAL É A PRINCIPAL HIPÓTESE DIAGNÓSTICA?

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167428](https://www.4000167428.com)

Questão 48 **Complicações** **Cirurgia**

Homem, 70a, refere episódios de infecção urinária há um ano. Apresenta quadro de pneumatúria e fecalúria há 30 dias. A PRINCIPAL ETIOLOGIA DETERMINANTE DESSA CONDIÇÃO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167427](https://www.4000167427.com)

Questão 49 **Quadro clínico**

Mulher, 24a, procura Unidade de Pronto Atendimento com história de febre não aferida, cefaleia retro-orbitária, mialgia, náuseas, vômitos e prostração há quatro dias. Relata vermelhidão no corpo há 12 horas. Antecedente pessoal: vacinação adequada para a idade. Exame físico: Bom estado geral, T= 37,5°C, PA= 122x74 mmHg, FC= 96bpm, FR= 16 irpm, anictérica e acianótica. Exantema em face e tronco, sem adenomegalia:



Exames laboratoriais: Hb= 12,0g/dL; Ht= 39%, leucócitos= 4.200/mm³, plaquetas 150.000/mm³. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

4000167426

Questão 50 Clínica Médica Hepatologia Peritonite bacteriana espontânea PBE

Homem, 47a, chega ao Pronto Atendimento referindo queda do estado geral há três dias, com febre e dor abdominal há um dia, acompanhado de aumento de volume abdominal. Antecedentes pessoais: cirrose hepática alcoólica em uso de espironolactona e furosemida. Exame físico: Regular estado geral, descorado +/4, icteríco ++/4, hidratado: PA= 108x58 mmHg; FC= 88 bpm. Abdome ascítico, doloroso à palpação, descompressão brusca negativa: edema maleolar 2+/4+. Hb= 10,4 g/dL; Ht= 31%; leucócitos= 14.700/mm³ (70% neutrófilos); plaquetas= 124.000/mm³; sódio= 132 mEq/L; potássio= 4,7 mEq/L; ureia= 84 mg/dL; creatinina= 1,2 mg/dL; glicemia de jejum= 94 mg/dL; AST= 48 U/L; ALT= 44 U/L; RNI= 1,6; bilirrubina total= 4,3 mg/dL; albumina= 2,9 g/dL. Líquido ascítico: citologia= 1320 células/mm³, (74% polimorfonucleares); albumina= 0,6 g/dL; glicose= 66 mg/dL; LDH= 102 UI/L. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

4000167425

Questão 51 Biguanida metformina Agonistas de receptor de GLP1

Mulher, 56a, comparece em consulta de rotina, assintomática. Está preocupada pois participou de uma campanha de prevenção de diabetes na comunidade e seu exame de glicemia capilar foi de 222 mg/dL. Desde então reduziu a ingesta de açúcares e passou a fazer caminhadas diárias de 30 minutos. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial há oito anos, em uso regular de bisololol de anlodipino 10 mg/dia e enalapril 10 mg/dia. Exame físico: IMC= 31,6 kg/m²; PA= 132x78mmHg; FC= 78 bpm. Edema maleolar +/4. Glicemia de jejum= 158 mg/dL; sódio= 143 mEq/L; potássio= 4,1 mEq/L; colesterol total= 200 mg/dL; HDL= 73 mg/dL; LDL= 98 mg/dL; triglicérides= 210 mg/dL; HbA_{1c}= 8,1%; relação albumina/creatinina em urina= 14,3 mg/g. A CONDUTA MEDICAMENTOSA É:

4000167424

Questão 52 Testes de Coombs

Mulher, 55a, procura Unidade de Emergência com quadro de fraqueza. Tem diagnóstico de hipertensão arterial há vários anos e na última consulta sua medicação foi trocada de atenolol para metildopa por bradicardia sintomática. Exame físico: PA= 130x82mmHg, FC= 88bpm. Hb= 9,2g/dL; Ht= 28%, VCM= 91,8fL, HCM= 28,2pg, leucócitos= 7.180/mm³, plaquetas= 376.000/mm³; bilirrubina total= 3,4mg/dL; reticulócitos= 12%; Coombs direto positivo. O DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO É:

4000167423

Questão 53 Herpes simples e Herpes zoster

Homem, 68a, queixa-se de dor de ouvido esquerdo, de forte intensidade, irradiada para pavilhão auricular. Relata aparecimento de lesões pruriginosas em orelha, região periauricular, além de vesículas em cavidade oral esquerda, há um dia. Refere embaçamento visual ipsilateral.

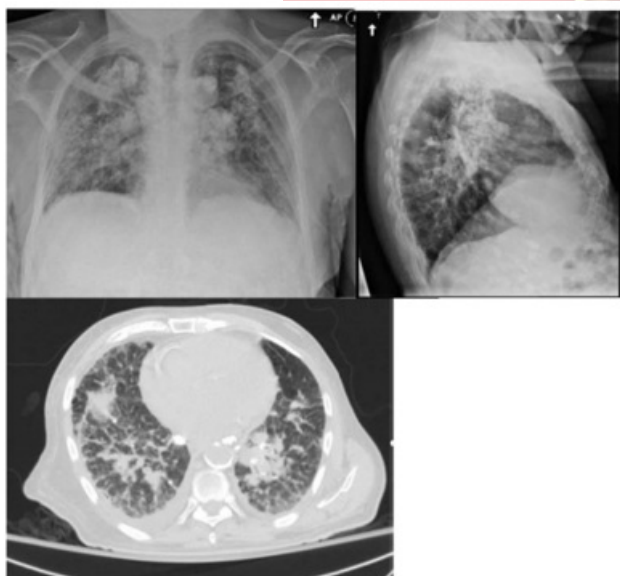


A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

4000167422

Questão 54 Pneumologia

Homem, 60a, procura Unidade Básica de Saúde com queixa de edema progressivo de membros inferiores há três semanas. Refere falta de ar há dois anos com piora progressiva nos últimos quatro meses, associada a perda de peso (6 kg). Antecedentes pessoais: tratamento para tuberculose por duas vezes, sendo o último há quatro anos. Trabalhou por 30 anos em produção de cerâmica, parou há dois anos por “fadiga”. Exame físico: cianose de extremidades; PA=112x74 mmHg; FR= 24 irpm; FC=112 bpm; oximetria de pulso (ar ambiente)= 82% em ar ambiente. Pulmões: murmúrio vesicular presente, estertores crepitantes contínuos e grosseiros; Coração: Bulhas rítmicas normofonéticas, sem sopros, Abdome: fígado palpável a 4 cm do rebordo costal direito; Edema simétrico de membros inferiores 3+/4+. Radiograma e tomografia computadorizada de tórax:



O DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO É:

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167421

Questão 55 Nefrologia Rabdomiólise

Homem, 57a, procura assistência médica, referindo dor muscular e redução do débito urinário há uma semana. Antecedente pessoal: doença coronariana crônica e hipertensão arterial há 15 anos. Há um mês teve diagnóstico de infarto agudo do

miocárdio, submetido a cateterismo cardíaco com colocação de stent farmacológico. Recebeu alta após uma semana de hospitalização com creatinina= 1,2 mg/dL, mantendo-se o uso de: losartana 50 mg, atenolol 50 mg, sinvastatina 40 mg, e iniciado omeprazol 20 mg/dia e ciprofibrato 100 mg. Creatinina= 6,4 mg/dL; ureia= 237mg/dL; AST= 1009 UI/L e ALT= 610UI/L; LDH= 3.090UI/L; K= 6,1mEq/L. O DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DA LESÃO RENAL AGUDA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167420](#)

Questão 56 **Manifestações clínicas**

Homem, 41a, previamente hígido, foi admitido na sala de emergência cerca de 36 horas após ter sentido uma picada pouco dolorosa na coxa direita após vestir o macacão de trabalho de marcenaria, que estava pendurado em um cabideiro de parede. Cerca de 8-12 horas após a picada relatou início de dor local em queimação e pontadas recorrentes, de moderada/forte intensidade (nota 6/7 na escala de notas de dor 0-10), acompanhada de vermelhidão e “inchaço duro” no local da picada. Queixou-se também de cefaleia, indisposição, dores no corpo e febre (38°C). Exame físico: lesão violácea (área de aproximadamente 5x2 cm) com vesículas de conteúdo hemorrágico no centro da lesão, edema endurecido, e uma grande placa eritematosa (14x8 cm).

36h pós-picada



Contra preços abusivos
na medicina.

TRATA-SE DE PROVÁVEL PICADA POR:

[4000167419](#)

Questão 57 **Rastreo Câncer Colorretal Gastroenterologia**

Mulher, 45a, assintomática, procura o serviço médico pois possui antecedentes familiares para câncer de intestino (pai), estômago (tio paterno) e endométrio (mãe). O EXAME PARA RASTREAMENTO NESSA PACIENTE É:

[4000167418](#)

Questão 58 **Nefrologia Inibidores do sistema reninaangiotensinaaldosterona**

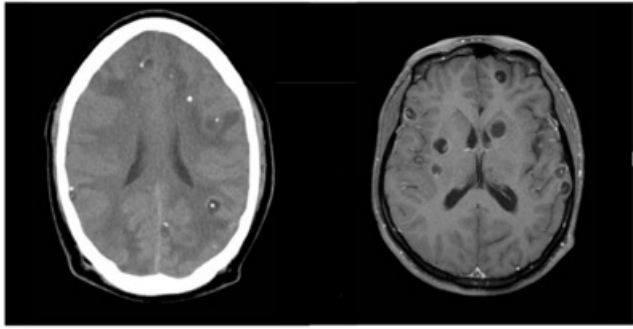
Homem, 64a, queixa-se de fraqueza em membros inferiores há seis meses. Exame físico: PA= 158x112 mmHg; FC= 88 bpm; FR= 16 irpm; Oximetria de pulso (ar ambiente)= 96%; IMC= 32 kg/m²; neurológico: diminuição da sensibilidade vibratória em pés e diminuição do pulso pedioso à direita. Hb= 14,3 g/dL; Ht= 43%; sódio= 141 mEq/L; potássio= 4,1 mEq/L; glicemia jejum= 187 mg/dL; HbA1c= 7,8%, colesterol total = 256 mg/dL; HDL = 24 mg/dL; LDL = 190 mg/dL; triglicérides= 230 mg/dL; ureia= 56 mg/dL; creatinina= 1,0 mg/dL; AST= 17 UI/L; ALT= 21UI/L. Iniciado tratamento com metformina, furosemida, captopril, atenolol e sinvastatina. Retorna após 10 dias com os exames de controle do tratamento coletados no dia: ureia= 80 mg/dL, creatinina= 1,87 mg/dL; K= 3,8 mEq/L; glicemia jejum=126 mg/dL; ALT= 41 UI/L; AST= 37 UI/L; CK= 300 mg/dL. O MEDICAMENTO ASSOCIADO AO DESENVOLVIMENTO DE LESÃO RENAL AGUDA NESTE CASO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167417](#)

Questão 59 **Neurocisticercose**

Homem, 37a, queixa-se de cefaleia persistente há seis meses. Há três meses passou a apresentar episódios de crises convulsivas. Exame físico: PA= 120x82 mmHg sem alterações. Tomografia computadorizada e Ressonância magnética de

crânio:

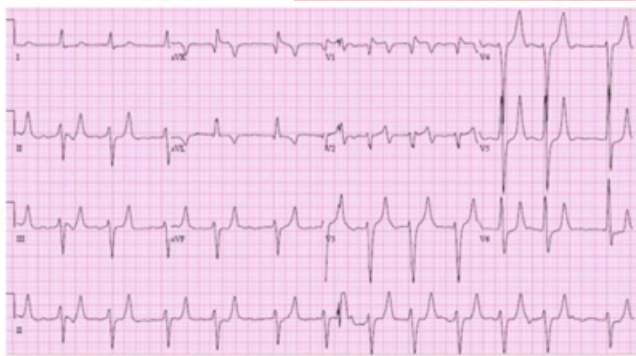


O HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

4000167416

Questão 60 **Nefrologia** **Proteção cardíaca**

Homem, 52a, procura Unidade de Emergência por mal-estar geral e dor precordial. Antecedente pessoal: doença renal crônica em diálise, faltou na última sessão. ECG:



A CONDUTA IMEDIATA É:

Questão 61 **Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN**

Mulher, 42a, comparece em consulta na Unidade Básica de Saúde para trazer os resultados do exame de mamografia e para fazer acompanhamento de rotina. Queixa-se de surto de agressividade há aproximadamente 15 dias. Apresenta várias questões de saúde mental desde a juventude. Relata que teve problemas com álcool há 15 anos, mas não faz uso no momento. Recentemente, vem apresentando sintomas depressivos e ansiosos. É mãe de dois filhos biológicos e um adotivo, reside com os filhos e o parceiro atual, pai dos adolescentes, e trabalha como faxineira em empresa terceirizada. Relata que recentemente vem sofrendo violência doméstica por parte do parceiro, com discussões frequentes e agressões verbais e físicas. Vem tentando fazer com que o companheiro saia da casa, mas ele resiste. Durante esses episódios de violência, sente-se muito mal e nervosa e recorreu ao Pronto Socorro da cidade duas vezes no último mês. Foi medicada devido a dores no peito e aumento da pressão arterial, posteriores às agressões do companheiro. A CONDUTA PROFISSIONAL DO MÉDICO DEVE SER:

- A Promover o acolhimento, registrar no prontuário as violências sofridas relatadas em entrevista e constatadas no exame físico e planejar visita domiciliar para averiguação dos fatos.
- B Fortalecer o vínculo com a paciente, solicitar apoio da equipe no desenho de um plano terapêutico e realizar a notificação compulsória à autoridade sanitária.
- C Realizar visita domiciliar acompanhado por agente comunitário de saúde e assistente social e informar o companheiro que a equipe da UBS irá denunciá-lo para a autoridade policial.
- D Monitorar os parâmetros clínicos da paciente nas visitas domiciliares semanais e não realizar a notificação compulsória à autoridade sanitária, evitando causar mais danos.

4000167414

Questão 62 Direitos dos médicos

Devido à falta de outros tratamentos médicos eficazes, pressão pública e política, autoridades sanitárias de diversos países, incluindo o Brasil, autorizaram o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para covid-19, em março de 2020. A comunidade médica adotou a hidroxicloroquina para o tratamento de covid-19, apesar da falta de evidências convincentes de benefício. Um manuscrito publicado pela *The Lancet*, em maio de 2020, relatou que o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina em pacientes hospitalizados com covid-19 foi associado a uma diminuição de sobrevida hospitalar e a um aumento da frequência de arritmias ventriculares, imediatamente colocando em questão a adoção generalizada destes medicamentos. É CORRETO AFIRMAR:

- A O princípio ético da autonomia deve orientar as prescrições médicas, priorizando a comunicação e o esclarecimento entre riscos e benefícios.
- B As orientações acerca das intervenções médicas podem resultar em danos para os pacientes, demandando reavaliações num contexto dinâmico de riscos e benefícios.
- C Cabe aos gestores públicos garantirem respaldo institucional para que a autonomia médica seja exercida, visando a valorização da relação médico-paciente.
- D É recomendada a administração de um medicamento que não tem efeito comprovado, como alternativa para o tratamento, assumindo que o benefício será maior.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000167413

Questão 63 Psicopatologia e Exame do Estado Mental EEM

Segundo o escritor Oliver Sacks, em seu livro *O homem que confundiu sua mulher com o chapéu*, “Meu trabalho, minha vida estão voltados totalmente para os doentes — mas os doentes e suas doenças conduzem-me a reflexões que, de outro modo, talvez não me ocorressem. Tanto assim que me vejo compelido a indagar, como Nietzsche: ‘Quanto à doença: não somos quase tentados a perguntar se conseguiríamos passar sem ela?’ e a ver as questões que ela suscita como sendo de uma natureza fundamental. Invariavelmente meus pacientes levam-me a questionar, e invariavelmente minhas questões levam-me aos pacientes, assim (...), existe um movimento contínuo de um para o outro”. ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

- A Conhecer a doença é suficiente para dimensionar a experiência do adoecimento.
- B O autor entende a saúde como o completo bem estar físico, mental e espiritual.
- C A doença é uma construção teórica e um instrumento de trabalho do médico.
- D A doença é o objeto de trabalho do médico.

4000167412

Questão 64 Transtornos Somáticos Transtorno dos Sintomas Somáticos

Uma equipe de saúde da família percebe que um homem, antes frequentador ocasional do serviço, torna-se progressivamente frequentador assíduo. Embora sempre se dizendo doente, as queixas eram imprecisas e variadas. Os exames clínicos e laboratoriais não confirmaram nenhuma hipótese diagnóstica. Alguns membros da equipe passaram a classificá-lo como “poliqueixoso”. A RESPEITO DO ENFRENTAMENTO DESTA TIPO DE PROBLEMA, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

- ☐ A Explicações orgânicas confiáveis são encontradas na maior parte das queixas somáticas na atenção primária, com investigação adequada.
- ☐ B A equipe deve solicitar o apoio do Centro Atenção Psicossocial para lidar adequadamente com este tipo de problema.
- ☐ C A fragilidade de alguns dos atributos da atenção primária dificulta o cuidado deste tipo de problema.
- ☐ D O mais provável é que o homem esteja buscando ganhos secundários relacionados ao trabalho.

4000167411

Questão 65 Método Clínico Centrado na Pessoa

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CLÍNICA AMPLIADA E COMPARTILHADA, DA MEDICINA CENTRADA NA PESSOA E DA MEDICINA DAS NARRATIVAS:

- ☐ A São desenvolvidos pela Atenção Primária para qualificar o trabalho médico.
- ☐ B Valorizam a autonomia e autoconhecimento dos pacientes.
- ☐ C Restringem-se ao trabalho da equipe de saúde da família.
- ☐ D Cada um deles é uma etapa do Projeto Terapêutico Singular.

4000167410

Questão 66 Atenção Primária à Saúde APS no Brasil

A equipe gestora de um Pronto Atendimento (PA) detecta uma alta demanda de pacientes que procuram o serviço devido ao controle inadequado de doenças crônicas. CONSIDERANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES ASSISTENCIAIS E OS DIFERENTES PAPEIS DOS SERVIÇOS, A EQUIPE GESTORA DEVE:

- ☐ A Recusar o atendimento desses pacientes, orientando-os a procurar as Unidades Básicas de Saúde.
- ☐ B Estabelecer um fluxo de agendamento dos casos mais graves para os ambulatorios de especialidades.
- ☐ C Criar um grupo para elaborar Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) para os casos que mais procuram o PA.
- ☐ D Estabelecer um fluxo de informações sobre os pacientes junto ao gestor municipal e Unidades Básicas de Saúde.

4000167409

Questão 67 Saúde do Trabalhador

A anamnese ocupacional é importante para identificar os fatores de risco ocupacionais associados a determinadas doenças ou agravos. A ALTERNATIVA QUE CARACTERIZA ESTA ASSOCIAÇÃO É:

- A Soldador e glaucoma.
- B Pedreiro e dermatite de contato.
- C Montador de bateria de veículos e intoxicação por mercúrio.
- D Marceneiro e silicose.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167408](#)

Questão 68 Medicina Preventiva COVID 19

Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças agravos e eventos de saúde pública

CONSIDERANDO A COVID-19 RELACIONADA AO TRABALHO, ASSINALE A CORRETA:

- A Devem ser notificados no SINAN os casos que foram diagnosticados como covid-19 e com exposição que possa ter ocorrido no trabalho.
- B A covid-19 é uma doença pandêmica e, portanto, não é considerada doença relacionada ao trabalho.
- C A possibilidade de contaminação em transporte coletivo afasta a possibilidade de covid-19 relacionada ao trabalho.
- D A suspeita de contaminação em ambiente domiciliar afasta a possibilidade de covid-19 relacionada ao trabalho.

4000167407

Questão 69 Medicina Preventiva

Homem, 30a, é atendido na Unidade Básica de Saúde com queixas de dor no cotovelo direito há um ano, com piora há três meses. Refere trabalhar como forneiro, em setor de fundição de ferro, desde 2015. A atividade principal consiste em retirar impurezas do sobrenadante de ferro fundido, utilizando escumadeira de 50 cm de diâmetro com haste de dois metros, realizando movimentos de extensão e pronação do braço direito, a cada 10 minutos, durante a jornada de oito horas de trabalho. Há seis meses começou a fazer horas extras, toda semana. Exame físico: dor à palpação de epicôndilo lateral direito; teste de Cozen positivo. A CONDUTA É:

- A Notificar no SINAN como doença relacionada a trabalho.
- B Solicitar ressonância nuclear magnética de cotovelo para diagnóstico.
- C Realizar visita a empresa para emissão de CAT.
- D Solicitar ultrassonografia de cotovelo para notificar agravo relacionado ao trabalho.

4000167406

Questão 70 Pediatria Puericultura

Uma equipe de saúde da família recebe notificação da maternidade informando o nascimento de bebê no dia anterior e planeja visita ao binômio, pois se trata de ferramenta potente para prevenção de agravos e promoção de saúde. O MELHOR MOMENTO PARA REALIZAR ESSA VISITA É:

- A Entre o 7º e o 10º dia após o parto, quando a icterícia neonatal é mais acentuada.
- B No momento da vacina BCG, ao final do primeiro mês de vida.
- C Deve-se aguardar a consulta ser agendada pela mãe.
- D Na primeira semana após o parto, a fim de reduzir a mortalidade.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167405](#)

Questão 71 Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS

Atributos gerais da Atenção Primária à Saúde APS

O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA É CARACTERIZADO PELOS SEGUINTES ATRIBUTOS ESSENCIAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE:

- A Atenção no primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado.
- B Universalidade, atenção no primeiro contato, integralidade e equidade.
- C Atenção no primeiro contato, participação social, descentralização e integralidade.
- D Universalidade, integralidade, equidade e participação social.

4000167404

Questão 72 Dependência de Hipnosedativos Níveis de Prevenção e outros conceitos associados

Mulher, 50a, faz acompanhamento na Unidade Básica de Saúde em razão de hipertensão arterial, obesidade, tabagismo, nervosismo. Faz uso de clonazepam, losartana, atenolol e uso irregular de fluoxetina. Procura a UBS com frequência para pedir troca de receitas e tem aumentado o uso de clonazepam por conta própria. CONSIDERANDO A PREVENÇÃO QUATERNÁRIA, A CONDUTA É:

- A Reduzir a dose de benzodiazepínico.
- B Solicitar eletrocardiograma e exames laboratoriais.
- C Inserir a paciente em grupo de tabagismo.
- D Encaminhar ao ambulatório de psiquiatria.

4000167403

Questão 73 Medicina Preventiva

Em um município X com 980.000 habitantes em que a expectativa de vida está acima dos 70 anos, ocorreram 14.210 óbitos por todas as causas entre 2019 e 2020. Na comparação da mortalidade por covid-19 com a mortalidade por doenças cardiovasculares, e usando os dados abaixo:

Tabela. Distribuição dos óbitos segundo faixas etárias e causa. Município X, 2019- 2020.

Faixas etárias	Covid-19	%	Cardiovasculares	%
0-9	3	0,09	4	0,11
10-19	5	0,14	1	0,03
20-29	50	1,42	21	0,60
30-39	165	4,61	51	1,46
40-49	330	9,11	145	4,15
50-59	740	20,51	334	9,55
60-69	606	17,09	682	19,50
70-79	756	21,53	752	21,50
80 e mais	895	25,49	1.510	43,27
Total	3.550		3.500	

EM RELAÇÃO AO INDICADOR QUE CONFERE MAIOR IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A COVID-19, A ALTERNATIVA CORRETA É:

- A Mortalidade proporcional por causa de óbito.
- B Coeficiente de mortalidade por causa específica.
- C Anos potenciais de vida perdidos (APVP).
- D Número absoluto de óbitos para cada causa.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

4000167402

Questão 74 Estudos de CasoControle

Para determinar os fatores sociodemográficos, comportamentais e de assistência à saúde relacionados à ocorrência de sífilis em mulheres atendidas em maternidades públicas, foi realizado um estudo entre julho de 2018 e julho de 2019. Na seleção das participantes foi considerado o resultado da sorologia por ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*) - variável usada para o diagnóstico de sífilis. Todas residiam em Recife e as informações pregressas foram obtidas por meio de entrevista durante a internação hospitalar. O nível de escolaridade fundamental incompleto (Odds Ratio - OR= 2,02), três ou mais parceiros sexuais no último ano (OR= 3,1) entre outros fatores, além de uma a três consultas ao pré-natal (OR= 3,5) e história anterior de infecção sexualmente transmissível (OR= 9,7), aumentaram as chances de ocorrência da doença. O DESENHO DESTE ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO É:

- A Coorte retrospectiva.
- B Transversal ou seccional.
- C Coorte prospectiva.
- D Caso-controle.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000167401

Questão 75 Medicina Preventiva A mortalidade infantil no Brasil Coeficiente ou Taxa de Mortalidade Infantil

COM OS DADOS DA TABELA RESPONDA A ALTERNATIVA CORRETA:

Indicadores	Cidade A	Cidade B
Número de nascidos vivos	10.000	5.000
Número total de óbitos	1.500	2.000
Número total de óbitos em menores de 1 ano	150	100
Número total de óbitos em menores de 28 dias	80	60
Número total de óbitos de 28 a 364 dias	30	22
Número total de óbitos maternos	4	2

Fonte: dados hipotéticos.

- A O coeficiente de mortalidade infantil é maior na cidade A em relação à cidade B.
- B A taxa de mortalidade neonatal é maior na cidade A em relação à cidade B.
- C A razão de mortalidade materna é maior na cidade A em relação à cidade B.
- D A mortalidade infantil proporcional é maior na cidade A em relação à cidade B.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167400](#)

Questão 76 Medicina Preventiva Conceitos fundamentais óbito fetal óbito infantil e óbito na infância

Foi realizado um estudo epidemiológico para conhecer o perfil de mortalidade infantil indígena e observaram-se 254 óbitos em crianças menores de um ano, notificadas ao Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, no estado do Pará, no período de 2013 a 2018. Dos óbitos, 89 ocorreram entre o nascimento e seis dias, 29 foram entre sete e 27 dias, e 136 aconteceram no período de 28 a 364 dias de vida. Cento e trinta e sete óbitos (n=137) ocorreram em hospitais e as três principais causas foram: afecções perinatais (n=69), doenças do aparelho respiratório (n=48) e doenças infecciosas e parasitárias (n=40). O estudo também encontrou diferenciais na distribuição dos óbitos de acordo com as etnias. ASSINALE A ALTERNATIVA EM RELAÇÃO À PROPORÇÃO DE ÓBITOS NO PERÍODO NEONATAL TARDIO, A PROPORÇÃO DE MORTES POR INFECÇÕES PERINATAIS, E A PROPORÇÃO DE ÓBITOS FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR:

- A 11,42%; 18,90% e 53,93%.
- B 53,54%; 27,16% e 46,06%.
- C 11,42%; 27,16% e 46,06%.
- D 53,54%; 27,16% e 53,93%.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167399](#)

Questão 77 Atendimento à vítima de violência sexual

Mulher, 31a, procura o serviço por estar gestante e deseja interrupção da gravidez. Refere ter companheiro e fazer uso de preservativo em suas relações sexuais. Refere que a gestação é fruto de um estupro ocorrido há 9 semanas. Na época, ficou muito traumatizada e não fez boletim de ocorrência, não contou para ninguém sobre o ocorrido e nem procurou atendimento médico. ALÉM DAS PROFILAXIAS INDICADAS, A ORIENTAÇÃO PARA A MULHER NESSE CASO É:

- A Seguir a gestação com apoio psicológico, pois não tem direito ao aborto legal.
- B Registrar queixa na Delegacia de Defesa da Mulher para ter direito ao aborto legal.
- C Obter a anuência do companheiro para ter direito ao aborto legal.
- D Explicar que tem direito ao aborto legal mediante seu próprio relato.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167398](#)

Questão 78 Diretrizes para o rastreamento

Mulher, 23a, procura o Unidade Básica de Saúde para consulta ginecológica de rotina, refere vida sexual ativa há 10 meses. Antecedente pessoal: transplante renal, em terapia imunossupressora. A ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO UTERINO É:

- A** Coleta de colpocitologia oncológica aos 25 anos, com intervalo anual nos dois primeiros exames. Não há indicação de vacinação pela faixa etária.
- B** Coleta de colpocitologia oncológica agora, com intervalo anual. Indicada vacinação para HPV com duas doses tempo 0-6 meses.
- C** Coleta de colpocitologia oncológica aos 25 anos, com intervalo anual nos dois primeiros exames. A vacina é contraindicada para população transplantada.
- D** Coleta de colpocitologia oncológica agora com intervalo semestral no primeiro ano. Vacinação para HPV com três doses tempo 0-3-12 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167397](https://www.4000167397.com.br)

Questão 79 Quadro clínico Exames complementares

Mulher, 60a, procura o ginecologista após segundo episódio de sangramento vaginal em pequena quantidade. Antecedentes pessoais: obesidade grau II e menopausa aos 50 anos, sem reposição hormonal. Exame ginecológico: sem particularidades. Ultrassonografia pélvica: espessura endometrial de 10 mm. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA E O EXAME DE INVESTIGAÇÃO SÃO:

- A** Pólipo endometrial; ultrassom pélvico transvaginal.
- B** Carcinoma de endométrio, histeroscopia.
- C** Atrofia endometrial; teste de progesterona.
- D** Sarcoma de útero; biópsia de endométrio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167397](https://www.4000167397.com.br)

Questão 80 Planejamento familiar

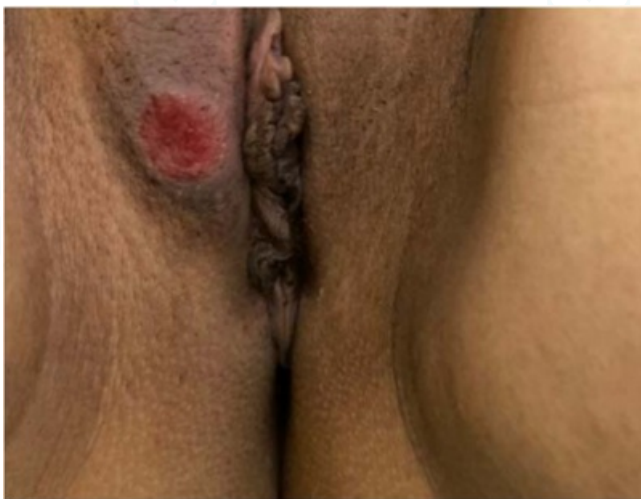
Mulher, 35a, vem encaminhada do ambulatório de gastrocirurgia com queixa de irregularidade menstrual: refere ciclos de 3 a 4 dias de duração, com intervalo de 15 a 40 dias entre os ciclos. Antecedente pessoal: duas gestações prévias, com dois partos vaginais e cirurgia bariátrica disabsortiva há 10 meses, com perda de 30 Kg. Ultrassonografia transvaginal: sem alterações. A CONDUTA É:

- A** Contraceptivo injetável combinado com estradiol e noretisterona.
- B** Pílula de progestagênio isolado com desogestrel.
- C** Contraceptivo oral combinado com etinilestradiol e levonorgestrel.
- D** Pílula de progestagênio isolado com noretisterona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167397](https://www.4000167397.com.br)

Questão 81 Ginecologia Sífilis

Mulher, 25a, comparece ao pronto atendimento com queixa de ferida vulvar indolor há 14 dias. Antecedentes ginecológicos: nuligesta, utiliza anticoncepcional oral combinado como contracepção, última menstruação há 21 dias. Exame físico: lesão única, 2cm de diâmetro, base endurecida e fundo limpo em grande lábio à direita e linfadenopatia inguinal ipsilateral.



O DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO SÃO:

- A Cancro mole. Penicilina G benzatina - 2,4 milhões UI intramuscular em dose única.
- B Sífilis primária. Penicilina G benzatina - 2,4 milhões UI intramuscular em dose única.
- C Sífilis primária. Azitromicina -1 g via oral em dose única.
- D Cancro mole. Azitromicina -1 g via oral em dose única.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167394](#)

Questão 82 Atendimento à vítima de violência sexual

Homem transgênero, 30a, vem ao pronto socorro referindo ter sofrido violência sexual com penetração há 24 horas. Nega comorbidades, uso de medicamentos e cirurgias prévias. A CONDUTA ADEQUADA PARA ESTE PACIENTE É:

- A Anticoncepção de emergência com levonorgestrel 1,5 mg em dose única.
- B Não indicar anticoncepção porque é um homem transgênero.
- C Não indicar anticoncepção de emergência, pois evento ocorreu há mais de 12 horas.
- D Anticoncepção de emergência com desogestrel 0,75 mg duas doses com intervalo de 12 horas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167393](#)

Questão 83 Ginecologia Síndrome de Rokitansky

Adolescente, 16a, vem à consulta por ainda não ter menstruado. Apresenta curva de crescimento de peso e altura dentro da normalidade e idade óssea de acordo com a idade cronológica. Tem uma irmã mais jovem que menstruou aos 12 anos. Exame físico: desenvolvimento mamário e pelos pubianos no estágio IV de Tanner e vulva de aspecto normal. O PROVÁVEL DIAGNÓSTICO É:

- A Amenorreia primária; Síndrome de Asherman.
- B Amenorreia primária; Síndrome de Rokitansky.
- C Amenorreia secundária; Síndrome de Swyer.
- D Amenorreia secundária; Síndrome de Turner.

Questão 84 **Sangramento primeira metade**

Mulher, 22a, G1P0, idade gestacional de 10 semanas procurou o Pronto Atendimento com dor em baixo ventre e sangramento. Exame físico: hidratada, FR=14 irpm, PA= 88x56 mmHg, FC= 112 bpm, descorada +/4+, T=36,4°C. Exame especular: sangramento ativo com coágulos; toque vaginal: colo pérvio para 1 polpa digital com útero aumentado para 8 semanas. A CONDUTA É:

- ☐ A Progesterona.
- ☐ B Ultrassonografia.
- ☐ C Misoprostol.
- ☐ D Curetagem.

4000167391

Questão 85 **Rastreamento do câncer de colo do útero**

Mulher, 32a, G3P2A0, comparece para primeira consulta de pré-natal com 15 semanas de amenorreia. Última citologia oncológica de colo uterino com resultado de lesão intra-epitelial de baixo grau, realizada há dois anos. A CONDUTA É:

- ☐ A Realizar colposcopia após 20 semanas de gestação.
- ☐ B Realizar colposcopia após o parto.
- ☐ C Coletar citologia oncológica de colo uterino em 1 ano.
- ☐ D Coletar citologia oncológica de colo uterino nesta consulta.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167390](https://www.4000167390.com)**Questão 86** **Obstetrícia Infecção puerperal endometrite puerperal**

Puérpera, 20a, G1P1, amamentando recém-nascido de 20 dias de vida, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de dor mamária e febre há dois dias. Exame físico: bom estado geral, FC= 100 bpm, FR= 18 irpm, PA= 125x88 mmHg, T= 38° C. Exame das mamas: ingurgitamento bilateral; mama direita avermelhada e dolorosa à palpação, com edema de pele, sem sinais de abscesso, com fissura mamilar. ALÉM DA ORDENHA DAS MAMAS, A CONDUTA É:

- ☐ A Antibioticoterapia endovenosa; suspensão temporária da amamentação.
- ☐ B Antibioticoterapia oral; manutenção da amamentação.
- ☐ C Analgesia; manutenção da amamentação.
- ☐ D Antibioticoterapia oral; suspensão temporária da amamentação.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167389](https://www.4000167389.com)**Questão 87** **Assistência pré-natal Obstetrícia Pré-natal**

Mulher, 22a, G2P1FV0, vem para primeira consulta de pré-natal em Unidade Básica de Saúde, assintomática. Idade gestacional pela amenorreia: 6 semanas. Antecedente Pessoal: óbito fetal com 32 semanas sem causa conhecida, nega patologias crônicas e nega uso de substâncias psicoativas. Questiona sobre riscos desta gestação e se deverá fazer algo diferente. EM RELAÇÃO ÀS DÚVIDAS DA PACIENTE, ASSINALE A RESPOSTA CORRETA:

- A Risco habitual; seguir pré-natal de rotina em UBS.
- B Alto risco; usar anticoagulação profilática.
- C Alto risco; investigar trombofilias.
- D Risco habitual; ultrassonografia quinzenal no terceiro trimestre.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167388](#)

Questão 88 Diagnóstico Obstetrícia

Mulher, 32a, G2P1A0, idade gestacional de 30 semanas e 2 dias, queixa-se de cefaleia, coriza, dor de garganta e tosse há 3 dias. Nega náuseas, vômitos, febre e contato com pessoas com covid-19. Antecedentes Pessoais: hipertensão arterial crônica, diabetes gestacional controlado com dieta e covid-19 há 5 meses. Medicamentos em uso: sulfato ferroso, carbonato de cálcio 1g/dia, AAS 100mg/dia, metildopa 1g/dia. Recebeu vacina contra covid-19 Pfizer® há 2 meses. Exame físico: IMC= 38Kg/m²; PA= 109x76 mmHg; T= 37,8°C; FR= 26 ipm; FC= 109 bpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 97%. Realizou perfil glicêmico há 6 dias: jejum= 134 mg/dL, pós café= 163mg/dL, pós-almoço= 220 mg/dL e pós-jantar=188mg/dL. A CONDUTA É:

- A Internar para introdução de insulina; realizar RT-PCR covid-19 e isolamento respiratório.
- B Introduzir insulina e seguimento ambulatorial; descartada covid-19 pelo antecedente de infecção prévia e vacinação.
- C Internar para introdução de insulina; sem necessidade isolamento respiratório.
- D Orientar dieta para diabético, realizar RT-PCR covid-19 e isolamento domiciliar.

4000167387

Questão 89 Assistência pré-natal Obstetrícia

Mulher, 19a, G1P0, idade gestacional de 39 semanas e 6 dias, comparece ao pronto atendimento com queixa de perda de líquido via vaginal há 12 horas e contrações a cada 5 minutos (há 6 horas). Refere boa movimentação fetal. Não realizou pré-natal. Exame físico: FC= 88 bpm, PA = 109 x 75 mmHg, T= 36,2°C. Exame obstétrico: altura uterina =35 cm, BCF=150 bpm, dinâmica uterina= 3 contrações moderadas de 40 segundos em 10 minutos. Exame especular: saída de moderada quantidade de líquido claro com grumos grossos pelo orifício externo do colo. Toque vaginal: colo dilatado 5 cm, medianizado, 80% esvaecido, feto cefálico, plano - 2 de DeLee. EM RELAÇÃO AO ESTREPTOCOCO DO GRUPO B, A CONDUTA É:

- A Coletar cultura e, se positiva, iniciar profilaxia.
- B Iniciar imediatamente profilaxia.
- C Iniciar profilaxia em 6 horas.
- D Não tem indicação de profilaxia.

4000167386

Questão 90 Sangramento segunda metade da gestação Obstetrícia

Mulher, 36a, G3P0A2 com idade gestacional de 30 semanas, chega ao Pronto Atendimento de uma Maternidade referindo muita dor abdominal e parada da movimentação fetal há 1 dia. Exame físico: Regular estado geral, descorada 3+/4+, sudoreica, FC= 135bpm, PA= 81x52 mmHg; exame obstétrico: altura uterina 35 cm, útero hipertônico e doloroso à

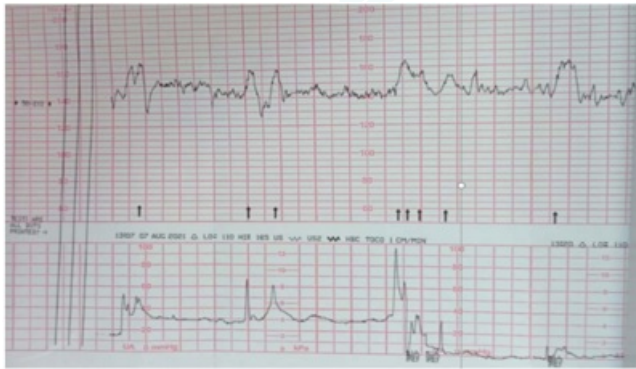
palpação, ausência de batimentos cardíacos fetais, toque vaginal: colo impérvio. A CONDUTA É:

- A Realizar cesárea de urgência.
- B Solicitar ultrassonografia de urgência.
- C Induzir parto vaginal.
- D Aguardar parto espontâneo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167385](https://www.4000167385.com)

Questão 91 Avaliação da vitalidade fetal Obstetrícia

Mulher, 34a, G4P1C1A2, idade gestacional de 38 semanas e 6 dias, procura atendimento por início de contrações ontem e piora da dor hoje. Nega perdas vaginais e sangramento. Refere boa movimentação fetal. Sem comorbidades. Exame obstétrico: dinâmica uterina=2 contrações fracas de 30 segundos em 10 minutos, altura uterina= 38 cm, BCF= 146 bpm, cefálico. Toque vaginal= colo dilatado 1 polpa, grosso, posterior. Cardiotocografia:



A CONDUTA É:

- A Internar para indução de parto.
- B Internar para cesárea.
- C Dar alta com orientações sobre o trabalho de parto.
- D Dar alta e indicar cardiotocografia a cada 3 dias.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167385](https://www.4000167385.com)

Questão 92 Covid na gestação Obstetrícia

Primigesta, 27a, idade gestacional de 33 semanas, procura atendimento médico com queixa de cansaço, dor torácica e febre há quatro dias. Refere tosse seca e prostração há oito dias. Antecedentes pessoais: diabetes mellitus tipo 1 e traço falciforme. Exame físico geral: Regular estado geral, descorada+/4+, T= 38,5°C, PA=134x61 mmHg, FC=110 bpm, FR=50 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 89%, IMC=23,4Kg/m2. Exame obstétrico: Altura uterina= 30 cm, BCF=158 bpm, dinâmica uterina= 2 contrações fracas de 30 segundos em 10 minutos, sem hipertonia uterina, boa movimentação fetal. Toque vaginal: colo 100% esvaecido, dilatado 3 cm. RT-PCR para covid-19= positivo. Além de internação e dos cuidados de suporte com oxigênio, A CONDUTA É:

- A Inibição do trabalho de parto, prescrição de betametasona e de sulfato de magnésio.
- B Ultrassonografia com Doppler e prescrição de sulfato de magnésio.
- C Cardiotocografia, prescrição de dexametasona e assistência ao trabalho de parto.
- D Realização de cesárea de urgência.

4000167383

Questão 93 Quadro Clínico e Indicações de Tomografia de Crânio Neurologia Traumatismo Craniencefálico

Menina, 10a, é trazida pela mãe a Unidade de Emergência, referindo que a filha está sonolenta e apresentou cinco episódios de vômitos após queda da beliche há quatro horas. Exame físico: FC= 56bpm, FR= 12irpm, PA= 144x92mmHg, Escala de Coma de Glasgow= 13. Tomografia de Crânio sem contraste:



- A Hematoma epidural; sem hipertensão intracraniana.
- B Hematoma epidural; com hipertensão intracraniana.
- C Hematoma subdural; com hipertensão intracraniana.
- D Hematoma subdural; sem hipertensão intracraniana.

Contra preços abusivos
na medicina.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167382

Questão 94 Infectologia Diagnóstico Etiologia

Lactente, 2m, chega a Unidade de Emergência Pediátrica com crise convulsiva tônico-clônica generalizada controlada com uma dose de diazepam. Mãe conta que a criança está irritada há oito dias e mais sonolenta nos últimos dois dias. Exame físico: Regular do estado geral, FR= 40irpm, FC= 145bpm; pulmões: murmúrio vesicular simétrico bilateralmente, neurológico: paralisia de sexto par craniano. Tomografia de crânio com contraste: hidrocefalia acentuada e impregnação dos vasos da base. Líquor: Leucócitos= 450/mm³ (72% linfócitos, 38% neutrófilo), proteína= 523mg/dL, glicose= 22mg/dL; glicemia= 68mg/dL. O AGENTE ETIOLÓGICO É:

- A *Haemophilus influenzae* tipo B.
- B *Mycobacterium tuberculosis*.
- C *Aspergillus fumigatus*
- D *Escherichia coli*.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167381](#)

Questão 95 Diagnóstico Tratamento de Manutenção Classificação do controle clínico da asma

Menina 9a, é trazida para consulta de rotina na Unidade Básica de Saúde. Mãe está muito preocupada com as crises de asma. Mãe conta que a filha tosse quando treina natação e que acorda toda manhã com obstrução e prurido nasal. No último ano apresentou seis episódios de asma com necessidade de ir ao Pronto Socorro, sendo a última há três semanas, quando ficou internada por três dias. Antecedentes pessoais: os quadros iniciaram aos dois anos de idade. Medicações em uso: Beta2-agonista de curta duração nas crises de falta de ar e formoterol 12mcg associado à budesonida 200mcg duas vezes ao dia, com uso irregular. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA E A CONDUTA SÃO

- A Asma moderada não controlada; introduzir anti-leucotrieno, orientar adesão e técnica inalatória e retorno em três meses.
- B Asma grave não controlada; otimizar o tratamento da rinite alérgica, orientar adesão e técnica inalatória, manter medicação profilática, retorno em quatro semanas.
- C Asma grave controlada; otimizar o tratamento da rinite alérgica, prescrever dipropionato de beclometasona 200 mcg spray oral a cada 12 horas e retorno em dois meses.
- D Asma moderada controlada; introduzir prednisolona 20mg/dia em dias alternados, orientar adesão e técnica inalatória, manter medicação profilática, retorno em quatro semanas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167380](#)

Questão 96 Bactérias gramnegativas Etiologia

Menino, 16 m, interna na Enfermaria de Pediatria com história de febre há seis dias e dor a mobilização do joelho direito há quatro dias. Nega trauma e comorbidades. Por opção familiar não recebeu nenhuma vacina do Programa Nacional de Imunização. Exame físico: Regular estado geral, FC= 102 bpm, FR= 22 irmp, perfusão 3 segundos, PA= 87x52 mmHg, T= 39°C; joelho direito com bloqueio articular, hiperemia e calor local. Coletado exames e iniciado antibioticoterapia de amplo espectro. O laboratório de microbiologia informa 8 horas após a coleta de hemocultura crescimento de cocobacilo gram negativo pleomórfico. A BACTÉRIA DESCRITA É:

- A *Haemophilus influenzae* tipo B.
- B *Staphylococcus aureus*.
- C *Streptococcus pneumoniae*.
- D *Salmonella* spp.

4000167379

Questão 97 Diagnóstico Pediatria

Lactente, 13m, interna na Enfermaria de Pediatria com história de cansaço há três dias. Nega episódios de engasgo ou cianose. Antecedente pessoal: terceira internação nos últimos oito meses por quadro semelhante, em todos fez uso de antibioticoterapia e inalação com beta2-agonista; vacinação atualizada. Exame físico: Bom estado geral, FC= 110bpm, FR=

39irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 95%; pulmões: murmúrio vesicular: presente diminuído em base direita, anteriormente. Radiograma de tórax: opacidade homogênea em topografia de lobo médio, com adenomegalia peri-hilar ipsilateral. Radiogramas de tórax das internações anteriores com imagens semelhantes. O EXAME A SER REALIZADO COM OBJETIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE ETIOLÓGICO É:

- A Sorologia para *Mycoplasma pneumoniae*.
- B Cultura para *Bordetella pertussis*.
- C Pesquisa de *Mycobacterium tuberculosis* em lavado gástrico.
- D Sorologia para *Chlamydomphila pneumoniae*.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167378](https://www.4000167378.com.br)

Questão 98 Diagnósticos diferenciais Causas

Menino, 1a, é trazido à Unidade Básica de Saúde para consulta de puericultura. Mãe refere que o filho recusa muito os alimentos e, quando come, aceita muito pouco. Nega vômitos, uso de medicamentos. Hábito intestinal: uma evacuação com fezes endurecidas a cada quatro dias. Nega controle esfinteriano. Exame físico: bom estado geral, corado, IMC percentil 3 para a idade; abdome: globoso, flácido, indolor a palpação. O SINAL DE ALARME A SER CONSIDERADO NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL É

- A Recusa alimentar.
- B Saciedade precoce.
- C Retardo de crescimento.
- D Incontinência retentiva.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167377](https://www.4000167377.com.br)

Questão 99 Calendário infantil Vacinas inativadas Vacinas vivas atenuadas

Menino, 4a, é trazido à Unidade Básica de Saúde para atualização do calendário vacinal. Faz uso regular de prednisona e ciclosporina há dois anos para tratamento de síndrome nefrótica. Traz carteira vacinal atualizada até os 15 meses. QUAIS VACINAS ESTÃO CONTRAINDICADAS NESSE MOMENTO?

- A Varicela e febre amarela.
- B VOP e DPT.
- C Febre amarela e DPT.
- D Tríplice virai e DTPa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167376](https://www.4000167376.com.br)

Questão 100 Galactosemia Pediatria Erros inatos do metabolismo

Menino, 40 dias, em aleitamento materno exclusivo, tem diagnóstico de galactosemia, confirmado pela dosagem enzimática da galactose-1-fosfato uridil transferase (GALT). A ORIENTAÇÃO ALIMENTAR BASEADA NO DIAGNÓSTICO É:

- A Leite materno exclusivo.
- B Fórmula infantil de seguimento.
- C Fórmula de soja.
- D Fórmula infantil de partida.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167375](#)

Questão 101 **Profilaxia para HIV**

Menina, 7a, é trazida pela mãe com relato de abuso sexual pelo padrasto há quatro dias. Informa ainda que estes abusos já vêm acontecendo há cerca de seis meses. EM RELAÇÃO À PROFILAXIA DA INFECÇÃO PELO HIV, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

- A Prescrever tenofovir + lamivudina + dolutegravir (TDF+3TC+DTG).
- B Prescrever o esquema TDF+3TC+DTG, se teste rápido do agressor for positivo.
- C Prescrever zidovudina (AZT) por 28 dias.
- D Não há indicação de profilaxia.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167374](#)

Questão 102 **Avaliação do Crescimento** **Pediatria**

Menina, 12a, estatura abaixo do percentil 3 e cresceu 6,5 cm nos últimos três anos, com idade óssea de 11 anos e nega menarca. Nega uso de medicamentos, refere alimentação saudável e atividade física. Exame físico: estágio puberal de Tanner= M1P1 sem outras alterações. O QUE JUSTIFICA A INVESTIGAÇÃO DA ESTATURA NESTE CASO É:

- A Velocidade de crescimento.
- B Estádio Puberal de Tanner.
- C Idade óssea.
- D Ausência de menarca.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167373](#)

Questão 103 **Cardiopediatria e Cardiopatias congênitas** **Pediatria**

Recém-nascido a termo foi submetido ao teste de triagem de cardiopatia congênita com 48 horas de vida. Os valores de saturação de oxigênio encontrados no membro superior direito e no membro inferior esquerdo foram 93%. Exame físico: FR= 52irpm, FC= 147bpm, Pulmões: murmúrio vesicular simétrico bilateralmente, coração: Bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros. A CONDUTA É:

- A Realizar ecocardiografia.
- B Ofertar suplementação de oxigênio por cateter nasal 1L/minuto.
- C Medir a saturação de oxigênio no membro inferior direito.
- D Repetir o teste após uma hora.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167372](#)

Questão 104 Emergências Pediátricas Parada Cardiorrespiratória PCR e Arritmias na Emergência **Pediatria**

Lactente, 3 m, é trazida pelos familiares inconsciente, e m apneia e hipotônica. PARA AVALIAÇÃO DE PARADA CARDIORESPIRATÓRIA, O PULSO A SER EXAMINADO É:

- A Carotídeo.
- B Pedioso.
- C Radial.
- D Braquial.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167371](https://www.4000167371.com.br)

Questão 105 Neurologia Tratamento Estado de Mal Epiléptico

Menina, 5a, chega à Unidade de Emergência em crise convulsiva tônico-clônica generalizada há cerca de 10 minutos segundo os pais. Antecedente pessoal: epilepsia em uso de ácido valpróico. Na sala de emergência, colocado cateter de O2, e não conseguido acesso venoso. A MELHOR ALTERNATIVA PARA A MEDICAÇÃO INICIAL É

- A Fenitoína; via retal.
- B Fenobarbital; via intranasal.
- C Midazolam; via intramuscular.
- D Diazepam; via oral.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167370](https://www.4000167370.com.br)

Questão 106 Parasitoses

As parasitoses intestinais podem afetar até 36% da população brasileira. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE COMPLICAÇÕES DEPENDENTES DO TIPO DE PARASITA, ASSINALE A ALTERNATIVA COM AS ASSOCIAÇÕES CORRETAS:

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

1. *Ascaris lumbricoides*
2. *Taenia solium*
3. *Strongyloides stercoralis*
4. *Giardia lamblia*
5. *Entamoeba histolytica*
6. *Schistosoma mansoni*
7. *Ancylostoma duodenale*
8. *Trichuris trichiura*

- A. Abscesso hepático
- B. Prolapso retal
- C. Suboclusão intestinal
- D. Síndrome de Löeffler
- E. Cisticercose
- F. Desnutrição
- G. Anemia ferropriva
- H. Hipertensão portal

- A 1C, 3D, 5A.
- B 2E, 4G, 8D.
- C 3H, 5A, 7F.
- D 1D, 4F, 6E.

4000167369

Questão 107 Teste do olhinho Oftalmologia

O Teste do Reflexo Vermelho é uma ferramenta de alta sensibilidade para o rastreamento de alterações oculares com risco de causar ambliopia ou deficiência visual. O TESTE DEVE SER REALIZADO:

- A Uma única vez antes da alta da maternidade.
- B Antes da alta da maternidade e uma vez ao ano até cinco anos de vida.
- C Antes da alta da maternidade e uma vez ao ano, nos dois primeiros anos de vida.
- D Antes da alta da maternidade e três vezes ao ano, nos três primeiros anos de vida.

4000167368

Questão 108 Dor e Analgesia Cirurgia

Lactente, 18m, sofreu trauma na face. Exame físico: Escala de Coma de Glasgow= 15; face: ferimento cortocontuso perilabial. A conduta é de sutura simples. A DROGA INDICADA PARA SEDOANALGESIA PARA O PROCEDIMENTO É:

- A Midazolam.
- B Cetamina.
- C Meperidina.
- D Propofol.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167366](https://www.4000167366.com.br)

Questão 109 Cirurgia Tratamento Cirúrgico do Aneurisma de Aorta Abdominal e Complicações Pósoperatórias

EM QUAL DAS SITUAÇÕES ABAIXO ESTÁ SEMPRE INDICADA A CORREÇÃO DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL:

- A Em aneurisma sintomático com 4,5 cm de diâmetro.
- B Em aneurisma justa-renal.
- C Quando houver trombos murais.
- D Em pacientes com hipertensão arterial.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167366](https://www.4000167366.com.br)

Questão 110 Trombose Venosa Profunda TVP Cirurgia

A CONDUTA PARA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA FEMORO-POPLÍTEA É:

- A Vasodilatador e meia de compressão.
- B Anticoagulante e elevação do membro.
- C Flebografia para realização de trombectomia.
- D Repouso e ácido acetilsalicílico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167365](#)

Questão 111 **Pediatria** **Vitaminas**

Menino, 7 meses, chega a enfermaria no pós operatório imediato de cirurgia para correção de intussuscepção intestinal, com ressecção de 30 cm de intestino delgado e da válvula ileocecal. EM DECORRÊNCIA DESTA RESSECÇÃO O PACIENTE PODERÁ DESENVOLVER:

- A Raquitismo.
- B Escorbuto.
- C Anemia ferropriva.
- D Anemia megaloblástica.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167364](#)

Questão 112 **Cirurgia** **Hérnia Inguinal**

Menina, 3 meses, é trazida para Unidade de Emergência por choro incoercível e inchaço em região das virilhas. Exame físico: abaulamento irreduzível bilateralmente em região inguinal. A ESTRUTURA MAIS PROVÁVEL PRESENTE NO ABAULAMENTO É:

- A Intestino delgado.
- B Ovário.
- C Cólon.
- D Epíplon.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167363](#)

Questão 113 **Apendicite Aguda** **Cirurgia**

Homem 18a, procurou Pronto Socorro com dor abdominal que se iniciou em região epigástrica e posteriormente migrou para fossa ilíaca direita, acompanhada de anorexia, há um dia. Nega comorbidades. Exame físico: PA= 114x76 mmHg, FC= 76 bpm, FR =15 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 99%, T= 36,7°C. PARA A INDICAÇÃO CIRÚRGICA É NECESSÁRIO:

- A Hemograma com leucocitose e desvio à esquerda.
- B Dor à descompressão brusca em fossa ilíaca direita.
- C Realização de tomografia computadorizada de abdome.
- D Realização de ultrassonografia de abdome total.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167362](#)

Questão 114 Diagnóstico Cirurgia

Mulher, 43a, procura o Pronto Socorro com queixa de dor epigástrica de forte intensidade, irradiada para o dorso, acompanhada de náusea, vômitos e perda de apetite há dois dias. Realizada hidratação e medicamentos sintomáticos endovenosos, com melhora dos sintomas. Exame físico: FC= 96 bpm, FR= 16 irpm, PA= 125x72 mmHg, T= 36,5°C; Abdome: plano, normotenso, doloroso à palpação profunda em epigástrio e descompressão brusca dolorosa ausente. Amilase= 1.123 U/L, Lipase= 867 U/L e leucometria= 16.400/mm³. O EXAME PARA CONFIRMAÇÃO DA HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

- A Tomografia de abdome sem contraste.
- B Endoscopia digestiva alta.
- C Ultrassonografia de abdome superior.
- D Dosagens seriadas de amilase e lipase.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167361](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 115 Exames de Imagem Cirurgia

Mulher, 77a, procura atendimento médico por apresentar dor abdominal difusa, uma hora após as refeições, de forte intensidade, tipo aperto, há 40 dias, com melhora espontânea. Hoje, três horas após almoço iniciou dor persistente e de maior intensidade, fazendo-a procurar Pronto Socorro. Nega alterações do hábito intestinal e urinário. Antecedentes Pessoais: dislipidemia abagismo= 27 anos/maço; revascularização do membro inferior direito há dois anos; em uso de cilostazol, sinvastatina e AAS diário. Exame físico: descorada +/-4, hidratada, afebril, PA= 123x76 mmHg, FC= 95 bpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 93%; abdome: plano, normotenso, sem distensão, ruídos hidroaéreos presentes, dor à palpação sem visceromegalia e sem irritação peritoneal. O EXAME PARA CONFIRMAÇÃO DA HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

- A Cintilografia com hemácias marcadas.
- B Endoscopia digestiva alta.
- C Ultrassonografia de abdome superior.
- D Angiotomografia de abdome.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167360](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 116 Diagnósticos Diferenciais Cirurgia

Jovem, 23a, submetido a cirurgia com diagnóstico intra-operatório de apendicite grau III. No inventário da cavidade foi observado um divertículo no intestino delgado, a 30 cm da válvula ileocecal. O TIPO DE DIVERTÍCULO E A CONDUTA SÃO:

- A Verdadeiro; ressecção imediata.
- B Adquirido; invaginação cirúrgica.
- C Congênito; ressecção posterior se necessário.
- D Falso; ressecção imediata.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167359](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 117 **Esofagite Corrosiva** **Cirurgia**

Homem 56a, é trazido à Unidade de Pronto Atendimento com história de ingestão de soda cáustica há 30 minutos. Antecedentes pessoais: depressão e dois episódios prévios de tentativa de suicídio (40 comprimidos de AAS e 60 comprimidos de antidepressivo respectivamente). A última tentativa foi há uma semana. APÓS PROTOCOLO DO ATLS®, A CONDUITA É:

- ☐ A Analgesia; tratamento das lesões orais.
- ☐ B Antidepressivo em altas doses; sonda nasointestinal.
- ☐ C Analgesia; ácido forte via oral.
- ☐ D Bloqueador de bomba de próton; lavagem gástrica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167358](#)

Questão 118 **Quadro Clínico e Indicações de Tomografia de Crânio** **Avaliação Inicial** **Cirurgia**

Homem, 68a, tem queda da própria altura, sofrendo ferimento corto-contuso em região do supercílio direito. Nega perda de consciência, amnésia lacunar e ingestão de bebida alcoólica prévia. Antecedente pessoal: tabagista 45 maços-ano e hipotireoidismo, sem acompanhamento adequado. Durante a sutura evidenciou-se que o ferimento alcançava o osso frontal. A INDICAÇÃO DE OBSERVAÇÃO CLÍNICA E/OU TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO É DEVIDO A(O):

- ☐ A Idade do paciente
- ☐ B Profundidade do ferimento.
- ☐ C Tabagismo.
- ☐ D Hipotireoidismo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167357](#)

Questão 119 **PréRequisitos** **Morte Encefálica** **Cirurgia** [Acesse t.me/medicinalivre](#)

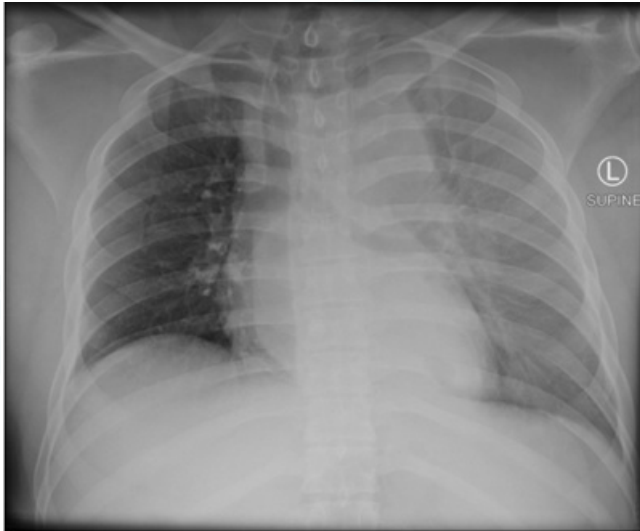
Homem 31a, recebeu golpe de estrangulamento (“mata leão”) durante uma briga, até apresentar parada cardiorrespiratória (PCR). O atendimento pré- hospitalar realiza aquisição de uma via aérea definitiva e um acesso venoso, e inicia manobras de reanimação cardiopulmonar cerebral, obtendo retorno dos pulsos centrais. O tempo da PCR foi de 8 minutos. É levado a um hospital terciário, onde após 20 horas de Unidade de Terapia Intensiva, sob cuidados clínicos e ventilação mecânica evoluiu com: Escala de Glasgow= 3, sem sedação, pupilas midriáticas sem reação ao estímulo luminoso, T= 35,8°C, PA média= 68mmHg. Sódio sérico= 148mEq/L. OS PRÉ-REQUISITOS QUE IMPEDEM O INÍCIO DO PROTOCOLO DE MORTE ENCEFÁLICA SÃO

- ☐ A Sódio sérico e pressão arterial média.
- ☐ B Tempo de tratamento e observação.
- ☐ C Temperatura axilar e tempo de PCR.
- ☐ D Pressão arterial média e temperatura axilar.

4000167356

Questão 120 **Laceração Aórtica** **Cirurgia**

Homem 34a, motorista, sem uso do cinto de segurança quando houve colisão frontal com outro veículo de passeio a 60km/h. Estava preso nas ferragens, e a Unidade Pré Hospitalar demorou em torno de 30 minutos para retirá-lo e em seguida foi levado à Unidade de Pronto Atendimento com queixa de dor no tórax. Na sala de emergência apresentava-se: PA= 121x83 mmHg, FC= 111bpm, FR= 18 irpm, oximetria de pulso (com máscara não reinalante 12L/min de O2)= 97%; Tórax: murmúrio vesicular presente bilateralmente, diminuído posteriormente à esquerda; membros sem alterações. Radiograma de tórax simples na sala de emergência:



O DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO É:

- A Hérnia diafragmática esquerda traumática.
- B Pneumotórax simples à esquerda.
- C Atelectasia esquerda por compressão.
- D Lesão traumática de aorta torácica.

Contra preços abusivos
na medicina.

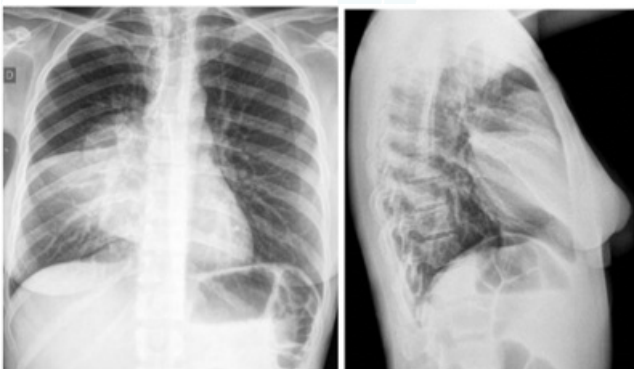
Essa questão possui comentário do professor no site [4000167355](https://www.4000167355.com)

Questão 121 Radiológico

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Homem, 58a, procura atendimento médico com queixa de tosse e emagrecimento de 5 Kg há dois meses. Broncoscopia: lesão endoscopicamente visível e obstrutiva à direita. Radiograma do tórax:



A LESÃO ENCONTRA-SE NO BRÔNQUIO:

- A Principal.
- B Intermediário.
- C Lobo inferior.
- D Lobo médio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167354](#)

Questão 122 Hepatologia Diagnóstico

Mulher, 33a, retorna à consulta na Unidade Básica de Saúde, para resultado de exames. Antecedentes pessoais: nega comorbidades, G3P3; método contraceptivo: oral combinado. Nega etilismo e tabagismo. Ultrassonografia abdominal: nódulo único, levemente hiperecoico, bem delimitado, medindo 3cm, localizado no segmento VIII hepático. O DIAGNÓSTICO MAIS PROVÁVEL É:

- A Adenoma hepático.
- B Hiperplasia nodular focal.
- C Hemangioma hepático.
- D Carcinoma hepatocelular.

4000167353

Questão 123 Tratamento Tratamento Intervencionista Cirurgia

Homem, 45a, procurou Pronto Socorro com queixa de dor lombar à esquerda de forte intensidade há 2 horas, repentina e com hematúria macroscópica. Foi realizado exame de ultrassonografia de abdome com diagnóstico de cálculo ureteral de 6mm no ureter distal esquerdo a 1 cm da junção ureterovesical e associado à hidronefrose ipsilateral. ALEM DE INTERNAÇÃO E ANALGESIA INTRAVENOSA A CONDUTA INICIAL É:

- A Realizar ureteroscopia para extração de cálculo com Sonda Dormia.
- B Realizar tomografia computadorizada de abdome.
- C Iniciar terapia expulsiva com doxasozina ou tansulozina.
- D Prescrever inibidores da 5-alfa-redutase.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167352](#)

Questão 124 Trauma Uretral Cirurgia

Homem, 25a, deu entrada no Pronto Socorro, após trauma por acidente automobilístico, com quadro de retenção urinária, fratura de bacia e uretrorragia. A PRINCIPAL HIPÓTESE DIAGNÓSTICA, O EXAME A SER SOLICITADO E A MELHOR CONDUTA, RESPECTIVAMENTE, SÃO:

- A Trauma de uretra posterior (membranosa), uretrocistografia retrógrada e sondagem vesical.
- B Trauma de uretra anterior (bulbar), tomografia de abdome e sondagem vesical.
- C Trauma de uretra posterior (membranosa), uretrocistografia retrógrada e cistostomia.
- D Trauma de uretra anterior (bulbar), tomografia de abdome e cistostomia.

Questão 125 Etiologia

Homem, 45a, hígido, é trazido ao Pronto Socorro com quadro de febre, agitação psicomotora e confusão mental. Familiar refere que estava com quadro de sinusite há uma semana, com febre, tosse com expectoração purulenta, dor de ouvido e cefaleia, tratada com antitérmicos e descongestionante nasal. Exame físico: confuso, agitado, PA= 118x69 mmHg; FC= 102 bpm; T= 38,9°C; rigidez de nuca presente. O AGENTE ETIOLÓGICO DA MENINGITE É:

- A *Streptococcus pneumoniae*.
- B *Cryptococcus neoformans*.
- C *Neisseria meningitidis*.
- D *Mycobacterium tuberculosis*.

4000167350

Questão 126 Bacteriúria assintomática

Mulher, 60a, comparece na Unidade Básica de Saúde, sem queixas, para resultado de exames. Antecedente pessoal: hipertensão arterial e diabetes mellitus, em acompanhamento regular. Creatinina= 0,9 mg/dL; exame sumário de urina: leucócitos= 20/campo, hemácias= 10/campo, proteína ausente, bactérias presentes; urocultura= E. Coli=W^s UFC/mL. A CONDUTA ADEQUADA É:

- A Manter sem antibioticoterapia.
- B Prescrever ciprofloxacino por 3 dias.
- C Prescrever profilaxia com cefalexina.
- D Prescrever profilaxia com *cranberry*.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167349

Questão 127 Uveítes Reumáticas Uveítes

Homem, 36a, iniciou quadro de dor e vermelhidão ocular à direita, sem perda da acuidade visual, há dois dias. Refere dor lombar pela manhã e após longos períodos em repouso. Faz tratamento de artrite no joelho esquerdo. Antecedente familiar: pai e tio apresentam quadro semelhante. Radiograma e ressonância nuclear magnética evidenciam sacroileíte. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA DO QUADRO AGUDO É:

- A Ceratoconjuntivite seca.
- B Esclerite necrotizante.
- C Uveíte posterior.
- D Uveíte anterior.

4000167348

Questão 128 Exacerbação Aguda da DPOC EADPOC Pneumologia

Homem, 60a, comparece ao atendimento de urgência referindo piora da dispneia há três dias (de mMRC 2 passou para mMRC 4), acompanhada de tosse produtiva com escarro amarelado e raia de sangue. Nega febre. Antecedente pessoal: ex- fumante há quatro anos (carga tabágica de 40 anos/maço), doença pulmonar obstrutiva crônica há quatro anos, em uso

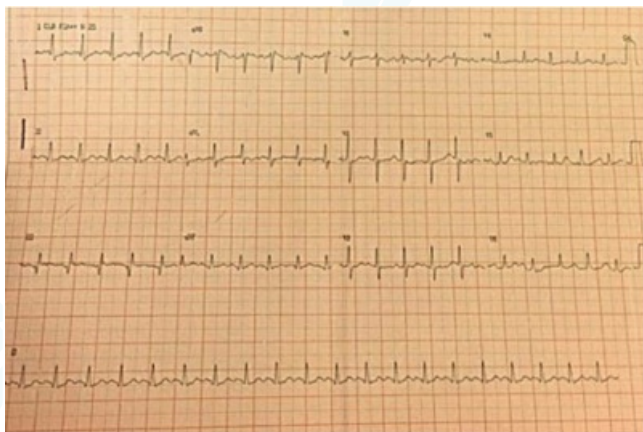
regular de medicações por via inalatória (formoterol e glicopirrônio) e salbutamol spray eventualmente; não teve exacerbações nos últimos 12 meses. Exame físico: orientado, FR= 32 irpm, oximetria de pulso= 86% (ar ambiente), uso de musculatura acessória para respirar. Pulmões: murmúrio vesicular reduzido globalmente, estertores subcrepitantes esparsos. NO MANEJO TERAPÊUTICO DESTE PACIENTE É CORRETO

- A Indicar intubação orotraqueal para ventilação mecânica invasiva, se houve retenção progressiva de CO₂.
- B Iniciar oxigênio por cateter nasal, para manter oximetria de pulso entre 88 a 92%.
- C Iniciar corticoesteroide sistêmico e mantê-lo por um período mínimo de 14 dias.
- D Iniciar teofilina e sulfato de magnésio, para manter oximetria de pulso acima de 92%.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167347](https://www.4000167347.com)

Questão 129 Tromboembolismo Pulmonar TEP COVID 19 Pneumologia

Mulher, 45a, queixa-se de dispneia há três dias, associada a tosse seca. Há uma semana com ageusia. Antecedentes: tabagista (20 anos/maço). Hipertensão arterial em uso de hidroclorotiazida. Exame físico: PA= 112x74 mmHg, FC= 134 bpm, FR= 29 irpm, T= 36,1°C, oximetria de pulso (ar ambiente)= 89%; consciente, alerta, fala normal. Pulmões: murmúrio vesicular presente simétrico; membros: extremidades frias, sem edema. Iniciado catete nasal de O₂ a 3L/min, sem melhora da hipoxemia; aumentado para 6L/min em cateter, mantida a mesma hipoxemia, mas sem aumento do desconforto respiratório. Ultrassonografia à beira do leito evidencia algumas linhas B em bases. Tomografia de tórax sem contraste (evidenciado o corte que apresenta as principais alterações do exame) e eletrocardiograma:



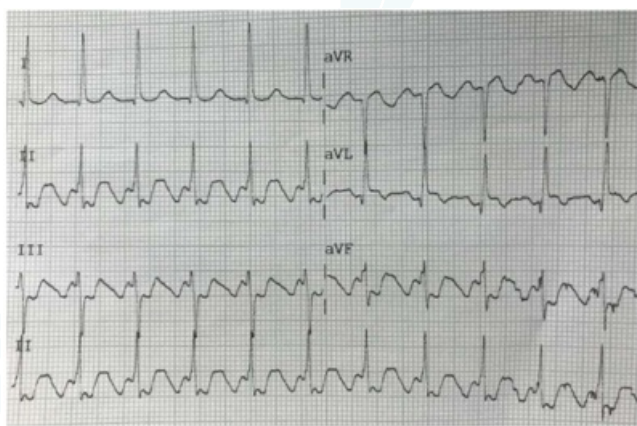
ALÉM DE INICIAR DEXAMETASONA, A CONDUTA IMEDIATA É:

- A Iniciar ventilação não invasiva.
- B Iniciar ceftriaxone e azitromicina.
- C Manter tratamento e internar em UTI-COVID.
- D Solicitar angiotomografia de tórax.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167346](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 130 Outras taquiarritmias

Homem, 62a, procura atendimento médico com queixa de tontura e dispneia de início agudo há 2 horas. Antecedentes: hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, em uso de losartana, bisolito de anlodipino e metformina. Exame físico: FC= 152 bpm, FR= 28 irpm, PA= 96x62 mmHg, oximetria de pulso (ar ambiente) = 88%; consciente, orientado, sonolento; pulmões: murmúrio vesicular presente com estertores crepitantes finos bilaterais até campos médios pulmonares. ECG realizado na sala de emergência:



Contra preços abusivos
na medicina.

O DIAGNÓSTICO E A CONDUTA SÃO:

- A Taquicardia por reentrada nodal; cardioversão elétrica sincronizada.
- B Flutter atrial 2:1; cardioversão elétrica sincronizada.
- C Taquicardia por reentrada nodal; manobra de Valsalva modificada.
- D Flutter atrial 2:1; betabloqueador e anticoagulação.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167346](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 131 Intoxicações Exógenas Neurologia

Homem, 39a, chega à emergência com confusão mental, náuseas e vômitos há 4 horas. Esposa o encontrou sonolento no banheiro, ao lado de carteiras de medicação aparentemente vazias jogadas no vaso sanitário. Antecedentes: depressão; usa amitriptilina. Exame físico: PA=124x78 mmHg, FC=108 bpm, FR=29 irpm, oximetria de pulso (ar ambiente)= 97%, T= 36,5°C. Glasgow 14, pupilas normais, sem déficits focais. Sem sinais de desconforto respiratório e ausculta respiratória normal. Eletrocardiograma: taquicardia sinusal. Glicemia capilar= 110mg/dL. Gasometria arterial: pH= 7,23; pO₂= 91 mmHg; pCO₂= 15 mmHg; HCO₃= 10 mEq/L; BE= -7 mEq/L, SaO₂= 97%; sódio= 135 mEq/L; creatinina=0,92 mg/dL; lactato= 3,0 mmol/L e cloro= 98 mEq/L. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É

- A Intoxicação por salicilatos.
- B Intoxicação por antidepressivo tricíclico.
- C Sepses.
- D Crise tireotóxica.

4000167344

Questão 132 **Síncope**

Mulher, 74a, veio ao Pronto Atendimento acompanhada pelo marido, que relatou que a paciente perdeu subitamente a consciência há três horas, quando ambos estavam assistindo televisão no sofá. O episódio durou dois minutos, e ela recobrou totalmente a consciência. No momento, a paciente está consciente, orientada, e relata apenas desconforto epigástrico leve. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes mellitus. Medicações em uso: losartana 25mg 12/12h, AAS 100mg/dia, metformina 850mg 3 vezes ao dia. Exame físico: PA= 156x98 mmHg, FC= 102 bpm, FR= 22 irpm, T= 36,6°C, glicemia capilar= 102mg/dL; descorada +/4+; ausculta cardíaca, pulmonar e exame do abdome sem alterações; membros inferiores: edema +/4+ simétrico. A CONDUTA INICIAL NO SETOR DE EMERGÊNCIA É:

- A Administrar captopril 25mg sublingual.
- B Realizar tomografia de crânio com contraste arterial e venoso.
- C Realizar eletrocardiograma
- D Realizar tomografia de tórax com contraste.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167343](https://www.4000167343.com)

Questão 133 **Diagnóstico** **Cardiologia**

Homem, 57a, é trazido ao serviço médico após episódio de desmaio ao realizar grande esforço no trabalho. Conta que subitamente perdeu a consciência, sem referir qualquer outro sintoma, e que ao acordar não apresentava déficits. Nas últimas semanas sentiu aperto no peito ao realizar os esforços que desaparecia ao repouso. Exame físico: PA= 110x85 mmHg; FC= 92 bpm; FR= 16 irpm; Oximetria de pulso (ar ambiente)= 97%, corado, hidratado. Pulso carotídeo diminuído e tardio; Coração: ictus no 5o espaço intercostal esquerdo desviado 2 cm para a esquerda da linha hemiclavicular ipsilateral, bulhas rítmicas com sopro mesossistólico ejetivo, rude, audível em focos aórtico, aórtico acessório e mitral, irradiado para o pescoço com B4 presente; extremidades: pulsos de baixa amplitude. O DIAGNÓSTICO É:

- A Insuficiência aórtica.
- B Insuficiência mitral.
- C Estenose aórtica.
- D Estenose mitral.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167343](https://www.4000167343.com)

Questão 134 **Hemorragia Digestiva Alta Varicosa HDA Varicosa**

Mulher, 46a, procura Unidade de Emergência referindo dois episódios de hematêmese, em moderada quantidade há quatro horas. Antecedente pessoal: portadora de vírus da hepatite C. Exame físico: Regular estado geral, descorada 2+/4+; icterícia +/4+; PA= 104x72 mmHg; FC= 104 bpm; FR= 20 irpm; Abdome: flácido, ausência de ascite ou massas palpáveis, fígado palpado a 6cm do RCD indolor, borda romba e lisa, consistência 3+/4+; baço percutível e palpado a 4 cm do RCE. Hb= 8,1

g/dL; Ht= 25,4%; albumina= 3,1 g/dL; bilirrubina total= 2,7 mg/dL; RNI= 2,1. Endoscopia digestiva: ligadura elástica de varizes esofágicas. Prescrito octreotide 50 pg/h em bomba de infusão intravenosa. A CONDOTA É:

- A Realizar transfusão sanguínea até Hb 9g/dL.
- B Prescrever ressuscitação volêmica com solução salina até PA > 120 mmHg.
- C Iniciar propranolol 20 mg/dia via oral.
- D Iniciar vitamina K 10 mg/dia intramuscular.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000167341

Questão 135 **Manifestações clínicas de tireotoxicose** **A influência das medicações na homeostase tireoidiana**
Tireotoxicose induzida pela amiodarona

Homem, 67a, refere dispneia aos esforços, batadeira, ansiedade, queimação retroesternal e emagrecimento não intencional de 5 kg, apesar de bom apetite, há um mês. Refere dificuldade para dormir e aumento do hábito intestinal para três vezes por dia. Antecedente pessoais: infarto do miocárdio há dois anos, em uso regular de captopril 150mg/dia, amiodarona 100 mg/dia, atorvastatina 40 mg/dia e AAS 100 mg/dia. Exame físico: PA= 152x96 mmHg; FC= 96 bpm; T= 37,3°C; FR= 16 irpm; Oximetria de pulso (ar ambiente)= 95%. A CONDOTA É:

- A Realizar ecocardiograma.
- B Dosar hormônio estimulante da tireoide.
- C Realizar cateterismo.
- D Dosar cálcio sérico.

Medicina Livre

Contra preços abusivos na medicina.

4000167340

Questão 136 **Manifestações Clínicas** **Cirurgia**

Mulher, 46a, procura Unidade Básica de Saúde com queixa de dor abdominal frequente, infraumbilical, que ocorre 2-3 vezes/dia, há mais de um ano. Algumas vezes pós-prandiais, melhora com evacuação. As fezes são amolecidas, com presença de muco e sem outras alterações. Refere urgência para defecar, com episódios à noite. Nega emagrecimento e febre. Exame físico: dor à palpação de fossa ilíaca, ausência de massas palpáveis. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

- A Diverticulite.
- B Supercrescimento bacteriano.
- C Síndrome do intestino irritável.
- D Doença cólica.

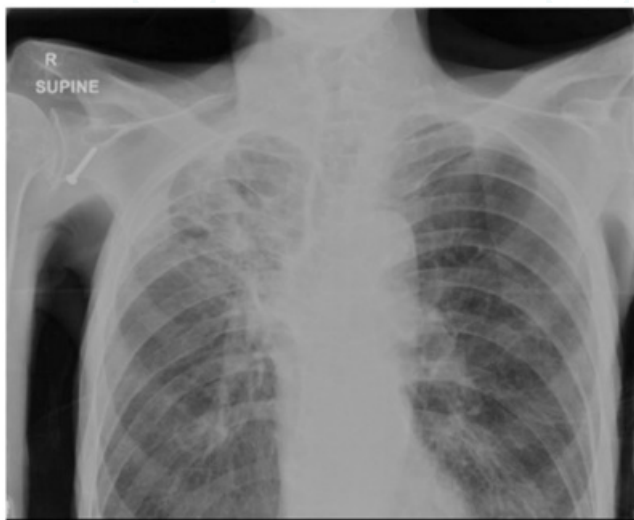
Proibida Venda

Acesse l.me/medicinavivre

4000167339

Questão 137 **Quadro clínico** **Neoplasia pulmonar**

Homem, 50a, é trazido a serviço médico com história de cefaleia há uma semana e confusão mental há dois dias. Nega vômitos ou diarreia. Exame físico: PA= 128x84 mmHg, FC= 56 bpm; neurológico: confuso, sonolento. Ureia= 20 mg/dL; creatinina= 0,8 mg/dL; sódio= 115 mEq/L; potássio= 3,6 mEq/L; Hb= 11 g/dL. Exame sumário de urina: sem alterações. Radiograma de tórax:



A CAUSA MAIS PROVÁVEL DA HIPONATREMIA É:

- A Insuficiência adrenal.
- B Diabetes insipidus central.
- C Nefrite intersticial crônica.
- D Secreção inapropriada de ADH.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167338](https://www.4000167338.com)

Questão 138 Diagnóstico Feocromocitoma Cardiologia

Homem, 50a, procura atendimento em Unidade de Emergência por dor torácica associada a palpitações, tremores e sudorese. Refere episódios prévios semelhantes. Exame físico: PA= 222x124 mmHg; FC= 122 bpm; sudoreico; tremor de extremidades. Fundo de olho: cruzamentos patológicos e papila nítida. ECG: sobrecarga de ventrículo esquerdo. Troponina: normal. A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

- A Dissecção aguda de aorta.
- B Doença de Addison.
- C Hipertensão maligna.
- D Feocromocitoma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000167337](https://www.4000167337.com)

Questão 139 Tratamento da Hipertensão arterial Diagnóstico e classificação

Mulher, 72a, procura atendimento médico referindo dispneia aos grandes esforços habituais. Exame físico: PA= 168x82 mmHg, FC= 88 bpm. ECG: ritmo sinusal e alterações inespecíficas da repolarização ventricular. Ecocardiograma transtorácico: aumento discreto de átrio esquerdo, ventrículo esquerdo com diâmetros normais e espessuras do septo intraventricular e parede posterior de VE aumentadas. Fração de ejeção (Simpson)= 71%. Relaxamento diastólico anormal grau I. A ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA ANTIHIPERTENSIVA PREFERENCIAL NESTE CASO É:

- A Bloqueador de receptor de angiotensina e alfa agonista central.
- B Inibidor de enzima de conversão de angiotensina e diurético tiazídico.
- C Betabloqueador e antagonista de aldosterona.
- D Bloqueador de canal de cálcio e diurético de alça.

4000167336

Questão 140 Diagnóstico da infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* Avaliação dos contatos

Homem, 45a, assintomático, procura Unidade Básica de Saúde por contato com paciente com diagnóstico de tuberculose. Radiograma de tórax: normal. Prova tuberculínica (PPD): 22 mm. A CONDUTA É:

- A Iniciar profilaxia com isoniazida.
- B Iniciar rifampicina, pirazinamida, isoniazida e etambutol
- C Realizar tomografia computadorizada de tórax.
- D Repetir radiograma de tórax em seis meses.

Contra preços abusivos
na medicina.

4000167335

Respostas:

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	
34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55	
56		57		58		59		60		61	B	62	B	63	C	64	C	65	B	66	D
67	B	68	A	69	A	70	D	71	A	72	A	73	C	74	D	75	D	76	C	77	D
78	D	79	B	80	A	81	B	82	A	83	B	84	D	85	D	86	B	87	C	88	A
89	C	90	A	91	C	92	C	93	B	94	B	95	B	96	A	97	C	98	C	99	A
100	C	101	D	102	A	103	D	104	D	105	C	106	A	107	D	108	B	109	A	110	B
111	D	112	B	113	B	114	C	115	D	116	C	117	A	118	A	119	B	120	D	121	D
122	A	123	C	124	C	125	A	126	A	127	D	128	B	129	D	130	B	131	A	132	C
133	C	134	C	135	B	136	C	137	D	138	D	139	B	140	A						

Questão 1 Enxaqueca Tratamento Profilático Neurologia

Mulher, 59a, queixa-se de cefaleia desde os 19 anos caracterizada por dor hemicraniana (mas com variação de lateralidade nas crises), pulsátil, associada a fotofobia e náuseas, piora com esforço. Nega sintomas precedentes, exceto fadiga inespecífica. Refere que os episódios eram muito raros, mas atualmente tem apresentado cerca de seis crises ao mês, sem qualquer mudança de característica, o que tem atrapalhado sua atividade laboral. Antecedentes: constipação intestinal (1 evacuação a cada 15 dias); tabagismo 30 anos-maço e doença pulmonar obstrutiva crônica. Exame físico: PA=112x72mmHg; FC=56bpm; FR=14irpm; IMC=33,2Kg/m²; Exame físico geral e neurológico: sem alterações.

CONSIDERANDO O CASO ACIMA, O MEDICAMENTO INDICADO PARA A PROFILAXIA DAS CRISES É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184444](https://t.me/medicinalivre)

Questão 2 Vitiligo Dermatologia

Mulher, 37a, é avaliada por surgimento de placas brancas nos membros superiores e inferiores, progressivamente maiores nos últimos quatro meses. Nega dor ou prurido associado e não faz uso de medicações. Exame físico: T=36,8°C; PA=116x82mmHg; FC=76bpm; FR=14irpm. Pele: presença de máculas acrômicas circulares e coalescentes em pernas, antebraços e mãos. Este quadro clínico pode estar associado a outras doenças.



Proibida Venda.

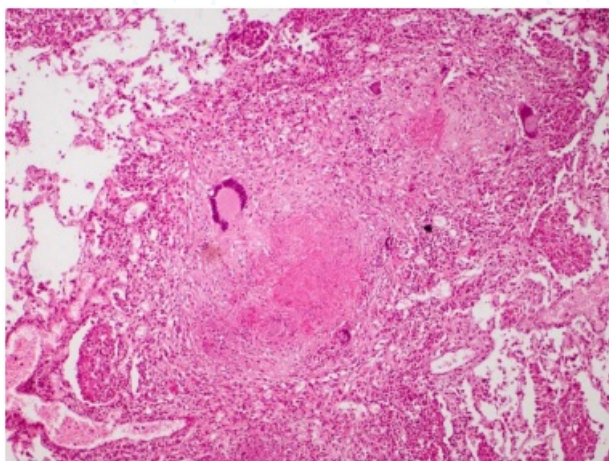
Acesse t.me/medicinalivre

O EXAME COMPLEMENTAR INDICADO PARA INVESTIGAR A COMORBIDADE MAIS FREQUENTE NESTE CASO É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184443](https://t.me/medicinalivre)

Questão 3 Infectologia

Homem, 37a, foi trazido ao Pronto Atendimento com insuficiência respiratória e evoluiu para óbito. Achados da necropsia: ápice do lobo superior pulmonar esquerdo apresentando cavidades, contendo material necrótico nas paredes e múltiplos pequenos nódulos no parênquima subjacente, denotando destruição pulmonar progressiva no sentido do ápice para base.

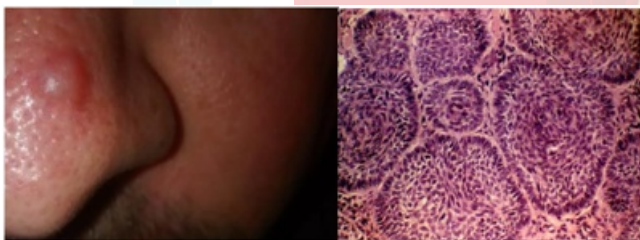


A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

4000184442

Questão 4 Diagnóstico Dermatologia Apresentação clínica

Homem, 62a, apresenta uma lesão pápulo nodular, perlácea, em região de asa nasal esquerda há dois anos, de crescimento lento. Foi realizada uma biópsia e o exame histopatológico está representado na figura anexa.



A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184441

Questão 5 Neurologia PréRequisitos Teste da Apneia

Mulher, 32a, vítima de traumatismo crânio encefálico grave, durante a internação na Unidade de Terapia Intensiva, evoluiu com ausência de reflexos de tronco. Às 23h42 de 05/03/2021 foi feito o primeiro exame clínico do protocolo de morte encefálica, compatível com ausência de atividade encefálica. Às 04h33 de 06/03/2021, o segundo exame clínico manteve os achados. Às 10h15 de 06/03/2021, o eletroencefalograma mostrou inatividade elétrica cerebral. Como a família confirmou que a paciente era doadora de órgãos, às 02h07 de 07/03/2021 foi feita a primeira incisão cirúrgica. Às 04h22 de 07/03/2021, o coração entrou em assistolia. **O DIA E HORÁRIO DO ÓBITO SÃO:**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184440

Questão 6 Infectologia

Mulher, 32a, previamente hígida, internada para investigação de lesões de pele em pernas que surgiram há duas semanas, falta de ar progressiva há uma semana, com escarros hemoptóicos e piora nas últimas 48 horas. Exame físico: T=38,1°C; PA=162x96mmHg; membros inferiores: edema1+/4+ e lesões purpúricas em pele.



Hb=9,2mg/dL; leucócitos=3.320/mm³ (neutrófilos=2.600/mm³, linfócitos=600/mm³ e eosinófilos=120/mm³); plaquetas=102.000/mm³; ureia=88mg/dL; creatinina=3,2mg/dL; C3=42mg/dL; C4=4mg/dL; VHS=102mm/h; proteína C reativa=6,2mg/L; fator antinuclear=1/160, padrão nuclear homogêneo. Exame de urina: hemácias=60/campo, leucócitos=40/campo, proteína=3+/4+, presença de acantócitos e codócitos; proteinúria 24h=3,2g. A história clínica e exames laboratoriais sugerem a hipótese diagnóstica de lúpus eritematoso sistêmico.

O DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL A SER DESCARTADO É:

4000184439

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.
Pneumologia

Questão 7 Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo SDRA

Homem, 61a, foi trazido ao Pronto Atendimento por falta de ar. Referia sete dias de tosse produtiva amarelada, associada a febre e dor torácica. A dispnéia piorou nos últimos dois dias, com dificuldade para completar frases. Exame físico: T=38,2°C; PA=96x64mmHg; FC=122bpm; FR=32irpm; oximetria de pulso=78% em ar ambiente e 89% com máscara não reinalante com 15L O₂/min; peso=110Kg (peso predito=80Kg); ausculta cardíaca normal; ausculta pulmonar com estertores em terço médio à direita. Ultrassonografia pulmonar: presença de linhas B em bases e campos médios bilateralmente. Após pré-oxigenação por cinco minutos, foi realizada intubação orotraqueal. **AO CONFIGURAR O RESPIRADOR, O VOLUME CORRENTE INICIAL MÁXIMO RECOMENDADO PARA ESTE PACIENTE É:**

4000184438

Questão 8 Dermatologia Hidradenite supurativa

Mulher, 32a, procura a Unidade Básica de Saúde por apresentar lesões nas regiões axilares e inguinais há 10 anos, que se iniciam com nódulos e abscessos e drenam secreção purulenta, resolvendo espontaneamente ou com antibióticos em uma a duas semanas. Já teve várias crises de dor e secreção e hoje apresenta fístulas drenantes nas axilas. Antecedentes: obesidade e tabagismo ativo. Cultura da secreção: Staphylococcus aureus multissensível; culturas para fungos e microbactérias: negativas.



A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184437](https://www.4000184437.com)

Questão 9 Outras taquiarritmias

Homem, 46a, admitido na Sala de Emergência após episódio de síncope, ocorrida em um bar há 30 minutos. Exame físico: desnutrido; PA=126x72mmHg; FC=78bpm; FR=18irpm, oximetria de pulso=96% (ar ambiente); parótidas aumentadas. Eletrocardiograma: alargamento do intervalo QT. Após 20 minutos da admissão, apresentou dispneia súbita, com PA=82x46mmHg, FR=30irpm, oximetria de pulso=96% (ar ambiente). Você observa, no monitor, o seguinte traçado eletrocardiográfico:



A CONDUTA IMEDIATA É:

4000184436

Questão 10 Cardiologia Hipertensão renovascular

Homem, 60a, retorna à Unidade Básica de Saúde para controle de hipertensão arterial e resultados de exames. Refere piora dos níveis pressóricos nos últimos meses. Antecedentes: hipertensão arterial e tabagismo, em uso crônico e regular de anlodipina 10mg/dia e furosemida 40mg/dia. Há um mês, em consulta de rotina, apresentava PA=172x98mmHg, quando foi associado enalapril 10 mg/dia. Hoje, PA=152x88mmHg. A creatinina aumentou de 1,2 mg/dL (dosada há 15 dias) para 2,2 mg/dL. **O EXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184435](https://www.4000184435.com)

Questão 11 Intervenção coronariana percutânea no tratamento do IAMCSST Cardiologia

Homem, 51a, é trazido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência à Unidade de Emergência Referenciada com história de dispneia e dor torácica em aperto, iniciadas há duas horas, com irradiação para o membro superior direito. Antecedentes: tabagismo, hipertensão arterial e acidente vascular encefálico hemorrágico há duas semanas. Exame físico: T=36,8°C; PA: membro superior direito=116x92mmHg e membro superior esquerdo=112x84mmHg; FC=84bpm; FR=24irpm e oximetria de pulso=96% (ar ambiente); ausculta pulmonar com crepitações em ambas as bases. Recebeu AAS e clopidogrel no atendimento móvel. Eletrocardiograma na admissão da emergência:



A CONDUTA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184434](https://www.4000184434.com)

Questão 12 Pneumologia Asma

Homem, 42a, refere tosse seca há três meses. Desde o início da tosse está usando budesonida nasal, sem melhora. Nega outras queixas e nega tabagismo. Antecedentes: rinite sazonal. Exame físico: bom estado geral; T=36,4°C; PA=122x82mmHg; FC=84bpm; FR=18irpm; ausculta pulmonar sem alterações. Radiograma de tórax normal. Reação intradérmica de Mantoux=0mm. O EXAME COMPLEMENTAR INDICADO É:

4000184433

Questão 13 Cricotireoidostomia Cirúrgica Cirurgia

Conforme o ATLS®, a cricotireoidostomia cirúrgica é uma das formas de obtenção de via aérea. **ESTE PROCEDIMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DE QUAL ESTRUTURA ANATÔMICA?**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184432

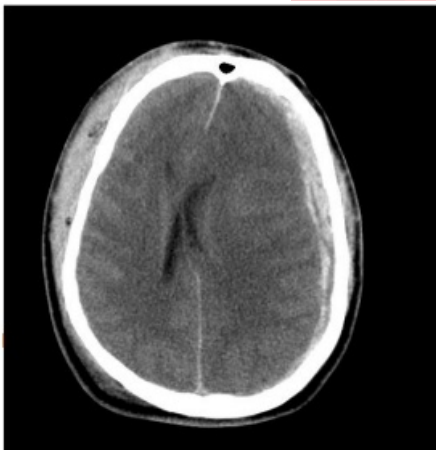
Questão 14 Cisto Tireoglossso

Criança, 4a, é trazida para avaliação de um caroço no pescoço, com aumento progressivo há uma semana, observado após infecção de vias aéreas superiores. Sem outras queixas. Exame físico: nódulo de consistência amolecida, com pouca mobilidade e indolor, localizado em linha média do pescoço, junto ao osso hioide. Restante do exame físico normal. **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

4000184431

Questão 15 Hematoma Subdural Neurologia Hematoma Subdural

Mulher, 31a, sofreu queda de motocicleta em rodovia. Foi socorrida pelo atendimento pré-hospitalar e trazida ao Pronto Socorro com colar cervical, em prancha longa rígida, com cânula de Guedel e máscara de oxigênio não reinalante com 15L/min. Exame físico: PA=143x75mmHg; FC=96bpm; FR=22irpm; oximetria de pulso=97%. Neurológico: Escala de coma de Glasgow=7, pupilas anisocóricas. Após intubação orotraqueal, foi realizado protocolo de exames de imagem. Tomografia computadorizada de crânio.



O TIPO DE HEMATOMA INTRACRANIANO É:

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184430

Questão 16 Síndrome de Polipose Adenomatosa Hereditária

Mulher, 32a, retorna à Unidade Básica de Saúde para avaliar resultado de exame. Colonoscopia: centenas de pólipos colorretais. Anatomopatológico: adenomas tubulares e túbulo-vilosos com displasia de baixo grau. Tem quatro filhos com o mesmo marido (que tem 55 anos e refere colonoscopia normal). **A PROBABILIDADE DE SEUS FILHOS APRESENTAREM A MESMA DOENÇA É:**

4000184429

Questão 17 Infectologia

Homem, 45a, natural da Bahia, refere dificuldade em se alimentar há quatro anos, necessitando ingerir líquidos com a comida. Há seis meses, a dificuldade piorou até para alimentos líquidos e a própria saliva. Acorda à noite com episódios de tosse. Refere perda de 5Kg nos últimos três meses. Antecedentes pessoais: tabagismo=20 anos/maço; etilismo=2 doses destilado/dia há 10 anos; trabalha na lavoura com agrotóxicos. Sorologia para Chagas=1/64; endoscopia digestiva alta=normal. **QUAL EXAME DEVE SER SOLICITADO PARA COMPLEMENTAR A AVALIAÇÃO DA DISFAGIA?**

4000184428

Questão 18 Tratamento da Doença Localizada Cirurgia

Homem, 76a, foi submetido à biopsia prostática por apresentar toque retal com próstata de 50g, com área endurecida no lobo direito, e PSA total=5,6ng/dL. Anatomopatológico: adenocarcinoma de próstata Gleason 3.3, em 2/20 fragmentos. A proporção de tumor nas lâminas foi de 10% e 20%, em cada fragmento. **A MELHOR CONDUTA PARA ESSE PACIENTE É:**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184427

Questão 19 Anticoagulantes antagonistas da vitamina K

Homem, 64a, procura Pronto Socorro queixando-se de sangue na urina. Antecedente pessoal: válvula mitral metálica, hipertensão arterial, uso diário de losartana e warfarina. Exame físico: PA=125x84mmHg; FC=79bpm; oximetria de pulso=97% (ar ambiente). RNI=4,87; Hb=13,1g/dL; Ht=39%; plaquetas=232.000/mm³; exame de urina: hemácias >100/campo, leucócitos 20/campo, proteína +/4. Realizada sondagem vesical com diurese hematúrica, sem coágulos. **PARA CORREÇÃO DO VALOR DO RNI, DEVE-SE:**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184426

Questão 20 Hepatologia

Homem, 57a, é trazido ao Pronto Socorro de hospital de referência por quadro de sangramento digestivo alto com hematêmese volumosa, sendo este o primeiro episódio. Antecedentes pessoais: cirrose hepática por álcool, em acompanhamento há três anos. Exame físico: regular estado geral; emagrecido; descorado +/4+; FC=92bpm; PA=122x64mmHg; FR=16irpm; sinal de aranhas vasculares em tronco; distensão abdominal; sem sinais de ascite; fígado palpável 2cm abaixo do rebordo costal, com borda romba; baço percutível; toque retal: presença de melena. **APÓS ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO E PRESCRIÇÃO DE ANÁLOGO DA SOMATOSTATINA E DE INIBIDOR DE BOMBA DE PRÓTONS, A CONDUTA É:**

4000184425

Questão 21 Pneumologia Quilotórax

Mulher, 58a, queixa-se de dispneia e dor torácica à direita. Sem outras queixas. Está no nono dia de pós-operatório de ressecção de um tumor de mediastino posterior, sem intercorrências. Antecedentes: hipertensão arterial, tabagismo ativo. Exame físico: regular estado geral; corada; hidratada; PA=132x76mmHg; FC=68bpm; T=36,4°C; FR=16irpm; oximetria de pulso=96% (ar ambiente). Pulmões: murmúrio vesicular reduzido à direita, sem ruídos adventícios. Tomografia computadorizada de tórax: derrame pleural à direita, com atelectasias restritivas principalmente em lobo inferior, e leve espessamento parietal brônquico. Realizada toracocentese diagnóstica. Líquido pleural: coloração=esbranquiçada, aspecto=leitoso; hemácias=4.000/mm³; leucócitos=2.032/mm³(90% linfomonucleares e 10% polimorfonucleares); raras células mesoteliais e regular número de macrófagos; proteínas totais=1,5g/dL; glicose=102mg/dL; colesterol=66mg/dL; triglicérides=2.683mg/dL; desidrogenase láctica=77U/L. **A ANÁLISE DESTES LÍQUIDOS CAVITÁRIOS CLASSIFICA O DERRAME PLEURAL COMO:**

4000184424

Questão 22 Cirurgia Colecistite Aguda

Mulher, 38a, procurou Pronto Socorro com queixa de dor no lado direito do abdome, abaixo da última costela, em cólica, de forte intensidade, após churrasco. Sem comorbidades. Ultrassonografia de abdome: colecistite aguda litiásica. **O LOCAL ANATÔMICO ONDE OCORRE A OBSTRUÇÃO PARA DESENVOLVER ESSA DOENÇA É:**

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184423](https://www.4000184423.com.br)

Questão 23 Trauma Abdominal Fechado Cirurgia

Menino, 9a, é trazido à Unidade de Emergência após ter sofrido queda da bicicleta há duas horas. Exame físico: fácies dolorosa; palidez cutânea; FC=104bpm; FR=22irpm; PA=109x82mmHg; pulsos cheios. Abdome: doloroso à palpação, sem irritação peritoneal.



O MECANISMO DE TRAUMA E O EXAME FÍSICO ESTÃO RELACIONADOS À LESÃO DE QUAL ÓRGÃO?

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184422](https://www.4000184422.com.br)

Questão 24 Diagnóstico Cirurgia

Homem, 57a, vem ao Pronto Socorro com queixa de dor em membros inferiores ao deambular por cerca de 50 metros, sendo mais intensa no membro inferior esquerdo (MIE). Precisa parar a marcha por algum tempo até conseguir voltar a caminhar. Exame físico: FC=80bpm; PA=130x88mmHg; pressão em tornozelo direito=90mmHg; pressão em tornozelo esquerdo=45mmHg. **QUAL O VALOR DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAÇO (ITB) MEDIDO NESTE PACIENTE PARA O MIE?**

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184421](https://www.4000184421.com.br)

Questão 25 Dermatologia Manifestações clínicas

Adolescente, 15a, procura Unidade Básica de Saúde para avaliação de uma lesão que não cicatriza há dois meses. Exame físico: lesão em face anterior de região tibial esquerda, sem outras alterações.



A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184420](https://www.4000184420.com)

Questão 26 Coarctação de aorta

Menino, 5a, é trazido para consulta de puericultura sem queixas. Mãe refere bom desenvolvimento e nega doenças ou uso de medicamentos. Exame físico: bom estado geral; corado; IMC=percentil 30; FC=104bpm; FR=27irpm; PA membro superior direito=142x78mmHg; PA membro inferior direito=88x53mmHg; pulsos= radiais cheios e pediosos fracos; membros inferiores sem edema. A **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184419](https://www.4000184419.com)

Questão 27 Infectologia

Menina, 5a, é internada para investigação com história de febre (1 pico diário de até 38,2°C), hipoatividade, palidez progressiva, perda de 10% do peso e surgimento de massas cervicais e pápulas cutâneas não pruriginosas há seis meses. Exame físico: regular estado geral; descorada 3+/4+; hipoativa; emagrecida; T=38,2°C; FC=100bpm; FR=23irpm; linfonodos= aumentados em todas as cadeias, com drenagem de secreção de linfonodo cervical direito. Hb=7,2g/dL; plaquetas=256.000/mm³; leucócitos=34.000/mm³ (segmentados=35%, linfócitos típicos=15%, eosinófilos=40%, monócitos=10%); albumina=2,8g/dL, gamaglobulina=3,78g/dL.



A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA ETIOLÓGICA É:

4000184418

Questão 28 Contraindicações

Menina, 4m, em aleitamento materno exclusivo e residente em área onde ocorreu a confirmação de circulação do vírus da febre amarela (epizootias, casos humanos e vetores na área). Neste caso, sua mãe tem indicação de receber a vacina da febre amarela. **EM RELAÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO, A ORIENTAÇÃO É:**

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184417](https://www.4000184417.com)

Questão 29 Pediatria Taquicardia Supraventricular TSV

Menino, 10m, previamente hígido, é trazido à Emergência com história de palidez e sudorese durante a amamentação, há uma hora. Exame físico: mau estado geral; pálido; com cianose de extremidades e perioral; T=35,8°C; FC=214bpm; FR=56irpm; pulsos periféricos finos; tempo de enchimento capilar=6segundos. Coração: bulhas taquicárdicas e normofonéticas; pulmões: murmúrio vesicular presente e simétrico, estertores em bases; abdome: fígado a 4 cm do rebordo costal direito. Eletrocardiograma:



A CONDUTA É:

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184416

Questão 30 **Pediatria** **Diagnóstico**

Menino, 2m, é trazido ao Pronto Atendimento com história de tosse há oito dias. Hoje a mãe refere que a criança apresentou três episódios de perda de fôlego e cianose após tosse. Nega inapetência e febre. Antecedentes: mãe não realizou pré-natal, parto vaginal a termo, sem intercorrências, peso adequado e recebeu alta da maternidade com 48h de vida. Exame físico: bom estado geral; T=36,5°C; FC=148 bpm; FR=67irpm; pulmões: murmúrio vesicular presente e simétrico, sem ruídos adventícios; coração: bulhas rítmicas normofonéticas; abdome: fígado a 2 cm do rebordo costal direito, hepatimetria=4cm; pulsos simétricos. Durante o exame, apresentou um episódio de tosse seguido de cianose periférica, com duração de dois minutos, e melhora com a introdução de oxigênio em máscara não reinalante. Hb=9,7g/dL; Ht=30%; leucócitos=15.740/mm³ (78% linfócitos típicos, 13% neutrófilos, 1% eosinófilos, 8% monócitos). **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184415

Questão 31 **Gastroenterologia**

Menina, 13a, é internada para investigação de quadro de dor abdominal e evacuações líquidas com muco e sangue (12 a 15 episódios ao dia, inclusive durante o período noturno), associadas a tenesmo e à lesão perianal com drenagem intermitente de secreção purulenta, há seis meses. Apresenta perda de 24% do peso, amenorreia, embotamento afetivo e abandonou a escola durante o período. **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

4000184414

Questão 32 **Nefrologia**

Menina, 9a, previamente hígida, é trazida ao Pronto Atendimento com queixa de inchaço nas pernas, dor de cabeça e urina escura há dois dias. Sem outras queixas. Exame físico: T=36,2°C; PA=154x82mmHg; FC=96bpm; FR=23irpm; pulmões: murmúrio vesicular presente; membros inferiores: edema +/4+. Pele: máculas hipercrômicas, algumas com crostas melicéricas, em membros inferiores. Creatinina=0,42mg/dL; ureia=31mg/dL; exame de urina: hemácias=100/campo; leucócitos=60/campo; proteína +/4+; codócitos e acantócitos presentes, cilindros granulosos. **O DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO É:**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184413

Questão 33 **Classificação do paciente**

Menino, 2a, é trazido à Unidade Básica de Saúde com queixa de fezes líquidas (seis vezes ao dia), vômitos há dois dias, com piora há um dia. Exame físico: Regular estado geral; T=36,4°C; FC=145bpm; FR=26irpm; mucosas secas; turgor pastoso; perfusão periférica menor que 2 segundos; hipoativo e reativo. **QUAL É O GRAU DE DESIDRATAÇÃO DESTA CRIANÇA?**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184412

Questão 34 **Acesso Vascular**

Menina, 11m, foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva após reanimação cardiopulmonar na Sala de Emergência, onde foi realizado acesso intraósseo tibial à direita. O acesso permanece funcionando com infusão contínua de droga vasoativa. **O TEMPO MÁXIMO, EM HORAS, QUE SE PODE MANTER O ACESSO INTRAÓSSEO É DE:**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184411

Questão 35 **Exantema Súbito**

Menino, 14m, é trazido com queixa de vermelhidão pelo corpo há um dia. As lesões começaram na região do pescoço e progrediram rapidamente por todo o corpo, sem prurido, e pioram após o banho quente e com exposição ao sol. Mãe

relata febre, irritabilidade e diminuição do apetite há quatro dias. Nas últimas 24h está afebril e apresenta melhora da irritabilidade e da aceitação alimentar. Exame físico: bom estado geral; T=36,5°C; oroscopia sem alterações; linfonodos não palpáveis; pele= exantema maculopapular difuso. **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184410](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 36 Sinovite Transitória do Quadril

Menino, 3a, é trazido para consulta por estar mancando há um dia. Mãe acha que está com dor na perna. Nega trauma, febre ou outras queixas. Antecedentes: nega comorbidades ou uso de medicamentos, refere um resfriado comum há duas semanas. Carteira vacinal atualizada. Exame físico: bom estado geral; afebril; eupneico; hidratado; anictérico; boa perfusão periférica; IMC=+1z escore; marcha claudicante; quadris livres; articulações de membros inferiores sem edema, eritema ou bloqueio articular. **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184409](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 37 Obstetrícia Placenta prévia PP

Mulher, 38a, G3P2C2A0, idade gestacional de 28 semanas e 5 dias (E₈), refere sangramento vaginal vermelho vivo em pequena quantidade há dois dias. Nega contrações, relação sexual ou esforço físico. Refere boa movimentação fetal. Nega perda de líquido por via vaginal. Exame físico: altura=1,71m; peso=85,5Kg; PA=122x72mmHg; FC=88bpm; altura uterina=27cm; batimentos cardíacos fetais=148bpm; dinâmica uterina=ausente; movimentos fetais=presentes. Especular=presença de pequena quantidade de sangue coletada em fundo de saco vaginal, s e m sangramento ativo, colo aparentemente impérvio e sem lesões. Toque vaginal=não realizado. Solicitada ultrassonografia obstétrica, que apresenta a seguinte imagem.



A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184408](https://www.t.me/medicinalivre)

Questão 38 Ginecologia Herpes genital

Mulher, 28a, refere dor e prurido vulvar, além de disúria. Refere que já teve três episódios semelhantes. Ao exame ginecológico, observa-se.



A PRINCIPAL HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184407

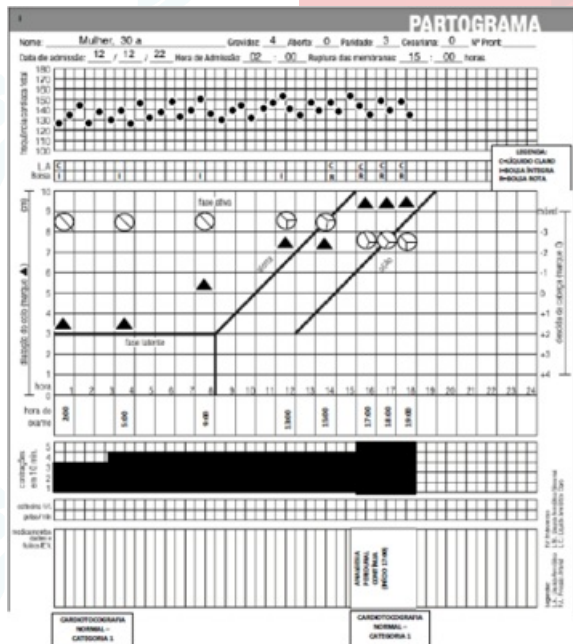
Questão 39 **Obstetrícia** **Infecção puerperal endometrite puerperal**

Mulher, 38a, primípara, comparece à Unidade Básica de Saúde no oitavo dia de puerpério, referindo febre e dor abdominal há dois dias. Está em amamentação exclusiva, sem queixas mamárias. Refere hábito intestinal e urinário sem alterações. Antecedentes: diabetes gestacional, tratada com dieta e atividade física; o parto foi cesárea por desproporção cefalopélvica. Exame físico: bom estado geral; descorada 2+/4+; hidratada; eupneica; T=38°C; PA=124x82mmHg; FC=124bpm; FR=18irpm. Mamas=lactantes, sem alterações; cardiopulmonar: sem alterações; abdome: flácido, ruídos hidroaéreos presentes, descompressão brusca negativa, ausência de massas palpáveis; presença de útero amolecido, palpável 1cm abaixo da cicatriz umbilical, dolorido à palpação. Cicatriz de cesárea seca, sem sinais flogísticos. Especular: presença de lóquio rubro em moderada quantidade. Toque vaginal: colo uterino pérvio para 1 polpa digital, com dor à mobilização. **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

4000184406

Questão 40 **Obstetrícia** **Partograma**

Mulher, 30a, G4P3C0A0, sem comorbidades e com último parto há três anos, apresenta trabalho de parto espontâneo às 39 semanas e 4 dias de gestação, representado pelo seguinte partograma:



A CONDUTA OBSTÉTRICA APÓS EXAME DAS 19:00 É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184405](#)

Questão 41 **Obstetrícia** **Indução de parto**

Primigesta, 21a, idade gestacional de 41 semanas (E₁₀), comparece ao Pronto Atendimento referindo perda de tampão mucoso, sem perda de líquidos, associada a endurecimento da barriga e dor moderada em baixo ventre, com piora há um dia. Antecedentes: nega comorbidades, gestação planejada e desejada. Exame físico: altura=1,67m; peso=67Kg; PA=116x75mmHg; altura uterina=37cm; feto cefálico; batimentos cardíacos fetais=137bpm; dinâmica uterina=ausente; movimentos fetais= presentes; toque vaginal= colo grosso, posterior, 1 polpa digital, feto cefálico em plano -3 de De Lee, bolsa íntegra. Amnioscopia=líquido opalescente, grumos grossos. Cardiotocografia=normal/classe I. **A**

CONDUTA OBSTÉTRICA É:

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184404

Questão 42 Diagnóstico Ginecologia

Mulher, 19a, G0P0, chega ao Pronto Atendimento com quadro de dor abdominal e febre há dois dias. Refere que faz uso de anticoncepcional oral combinado e que a última menstruação foi há sete dias. Sexualmente ativa, não apresenta comorbidades e não faz uso de outras medicações. Exame físico: bom estado geral; FC=82bpm; PA=116x74mmHg; afebril. Abdome: plano, flácido, indolor à palpação. Especular: presença de secreção mucopurulenta fétida coletada em vagina, pequeno sangramento vaginal. Toque vaginal: útero de tamanho e forma normais, sem massas palpáveis, dor à mobilização do colo. **O DIAGNÓSTICO É:**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184403

Questão 43 Interpretação e conduta frente as atipias citológicas

Mulher, 32a, G2P2A0, sem comorbidades, em acompanhamento ginecológico de rotina, apresentou os seguintes resultados de colpocitologia:

Junho/22: ASCUS- células escamosas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas.

Dezembro/22: Alterações celulares benignas.

QUANDO DEVERÁ SER REALIZADA A PRÓXIMA COLETA DE EXAME?

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184402

Questão 44 Nefrologia

Primigesta, 24a, idade gestacional de 28 semanas, comparece à consulta de pré-natal referindo dor em baixo ventre, associada à sensação de calafrio e mal-estar, há três dias. Refere inapetência e vômito há um dia. Nega disúria ou alteração de coloração da urina. Refere hábito urinário aumentado desde o início da gestação. Exame físico: bom estado geral; descorada +/4+; desidratada +/4+; anictérica; acianótica; T=38,3°C; PA=92x62mmHg; FC=125bpm; FR=18irpm. Cardiopulmonar: bulhas rítmicas normofonéticas; murmúrio vesicular presente e sem ruídos adventícios. Abdome: gravídico, tônus normal, batimentos cardíacos fetais=165bpm; altura uterina=28cm, dinâmica uterina= ausente, movimentos fetais=presentes. Sinal de Giordano presente à direita. **QUAL A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA?**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184401

Questão 45 Ginecologia

Casal comparece ao ambulatório referindo que deseja gestação. Mulher tem 30 anos, é nuligesta, refere ciclos regulares com duração de quatro dias, intervalo de 30 dias e não apresenta comorbidades. FSH=6,7mUI/mL (3º dia do ciclo), TSH=2,0μUI/mL e prolactina=15ng/mL. Marido tem 33 anos, não apresenta comorbidades e não tem filhos. Espermograma: volume=4 mL; concentração espermática=30milhões/mL; concentração total de espermatozoides = 60 milhões/mL; motilidade A+B=60%; vitalidade=70% vivos; morfologia >4% (critério estrito de Kruger); leucócitos=500/mL. O casal está sem métodos contraceptivos há dois anos. Mulher apresenta exame de imagem.

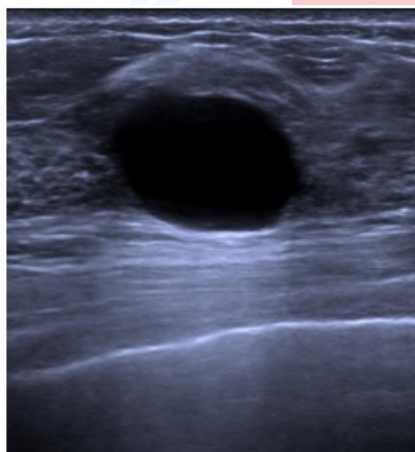


A CAUSA DA ESTERILIDADE É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184400](https://www.4000184400.com)

Questão 46 Cistos mamários

Mulher, 35a, procura atendimento por palpar nodulação indolor em mama esquerda há três meses. Nega outras queixas. Exame físico: mama sem abaulamentos ou retrações, ausência de descarga papilar; palpa-se área nodular de 1,5cm fibroelástica, móvel, não aderida a planos superficiais e profundos em quadrante superior lateral de mama esquerda, indolor à palpação; ausência de linfonodos axilares e em fossa supra clavicular. Ultrassonografia de mamas: imagem medindo 1,6cm em quadrante superior lateral de mama esquerda.



CONSIDERANDO A IMAGEM ANEXA, A CONDUTA É:

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184399](https://www.4000184399.com)

Questão 47 Quadro clínico Exames complementares Fatores de risco

Mulher, 72a, nulípara, procura atendimento com queixa de dor em baixo ventre há duas semanas, com piora progressiva e saída de corrimento fétido por via vaginal. Há dois dias apresenta febre e queda do estado geral. Exame físico: regular estado geral; emagrecida; descorada+/4+; anictérica; FC=86bpm; PA=112x74mmHg; T=37,5°C; FR=18irpm; perfusão periférica<2segundos. Abdome: doloroso à palpação de hipogastro. Exame ginecológico: vulva e vagina atroficas com conteúdo vaginal amarelo, espesso e de odor fétido. Colo uterino: aspecto normal com saída de secreção semelhante pelo orifício externo. Toque vaginal: útero aumentado para 10 semanas, doloroso à mobilização. Ultrassonografia pélvica: colo uterino normal, útero aumentado (volume=180cm³), com conteúdo heterogêneo, hipervascularizado, sem plano de clivagem com o miométrio, apresentando áreas hiperecogênicas e com sombras acústicas de permeio sugestivas de gás, linha endometrial de 12mm. Ovários não visibilizados. **ALÉM DO TRATAMENTO PARA O QUADRO INFECCIOSO, A PRINCIPAL DOENÇA ASSOCIADA A SER INVESTIGADA É:**

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184398](https://www.4000184398.com)

Questão 48 Obstetrícia Gestação ectópica

Mulher, 29a, gestante de nove semanas procura o Pronto Atendimento com dor em baixo ventre e pequeno sangramento via vaginal há um dia. Exame físico: bom estado geral; corada; PA=122x74mmHg; FC=88bpm. Abdome indolor à palpação, sem visceromegalias. Ginecológico: especular= presença de pequena quantidade de sangue escuro em saco vaginal, sem saída ativa de colo uterino; toque= útero em antroverso flexão, consistência amolecida, aumentado para oito semanas, colo impérveo, anexos palpáveis e indolores. Beta HCG=5.000UI/mL. Ultrassonografia transvaginal: útero em anteversoflexão, medindo 79x48x60mm (volume=118,31cm³); miométrio de textura homogênea; endométrio heterogêneo medindo 10mm; ovário direito medindo 23x22x11mm (volume=2,9cm³) e ovário esquerdo medindo 21x14x19mm (volume=2,9cm³). **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184397

Questão 49 Medicina Preventiva

Uma vacina foi avaliada em um estudo randomizado e apresentou o seguinte resultado:

	Doentes	Não doentes	Total
Vacina	50	4.950	5.000
Placebo	120	4.880	5.000
Total	170	9.830	10.000

A EFICÁCIA DA VACINA É:

4000184396

Questão 50 Medicina Preventiva

Uma vacina foi avaliada em um estudo randomizado e apresentou o seguinte resultado:

	Doentes	Não doentes	Total
Vacina	50	4.950	5.000
Placebo	120	4.880	5.000
Total	170	9.830	10.000

QUANTAS PESSOAS, APROXIMADAMENTE, PRECISARAM SER VACINADAS PARA QUE UMA DEIXASSE DE APRESENTAR A DOENÇA?

4000184395

Questão 51 Medicina Preventiva

Para estimar a velocidade com que a covid-19 se espalhou em Campinas durante o ano de 2020, **A MEDIDA DE FREQUÊNCIA MAIS INDICADA É:**

4000184394

Questão 52 Medicina Preventiva

Em um hospital foram registrados, na 32ª semana epidemiológica, dez casos de pacientes com síndrome serotoninérgica. Todos sobreviveram. O serviço de vigilância epidemiológica buscou identificar se algum fármaco poderia estar associado com essas manifestações. Os dez pacientes foram entrevistados e seus prontuários, avaliados. Os mesmos procedimentos foram feitos em um grupo de 40 pacientes internados, com características semelhantes, mas que não apresentaram a síndrome. O objetivo era comparar a proporção de indivíduos expostos àqueles fármacos nos dois grupos. **O TIPO DE ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO UTILIZADO FOI:**

4000184393

Questão 53 Medicina Preventiva

A população de uma cidade é de 100.000 habitantes. No início de 2019, havia nessa cidade 100 pessoas em tratamento para tuberculose. Durante esse mesmo ano, 60 desses pacientes receberam alta do tratamento e outras 50 pessoas foram diagnosticadas com tuberculose. **A PREVALÊNCIA DE TUBERCULOSE AO FINAL DE 2019 FOI DE:**

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184392](#)

Questão 54 Medicina Preventiva

Equipe de saúde da família diagnostica vários casos de onicomicose em pacientes que frequentam o mesmo salão de manicure. **A INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE ESTABELECIMENTO É ATRIBUIÇÃO DA VIGILÂNCIA:**

[4000184391](#)

Questão 55 Medicina Preventiva

Homem, 46a, procura Unidade Básica de Saúde queixando-se de surgimento de pontos pretos pruriginosos nos membros superiores, há cerca de quatro meses. Nega quadro semelhante anterior. É mecânico há 12 anos e nunca usou equipamento de proteção individual. Exame físico: pele=presença de pápulas foliculares com pontos centrais enegrecidos localizados no dorso das mãos e na face extensora das falanges, antebraços e braços, poupando a região palmar.



a Livre

Contra preços abusivos na medicina.

A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

[4000184390](#)

Questão 56 Medicina Preventiva

Homem, 38a, funcionário de linha de produção de aço inoxidável, procura Unidade Básica de Saúde com queixa de respiração ruidosa, rinorreia, epistaxe, obstrução, dor, ressecamento e formação de crostas nasais. Exame físico: rinoscopia anterior = presença de perfuração septal de cerca de 1,5cm de diâmetro. **O AGENTE OCUPACIONAL RELACIONADO A ESTE QUADRO CLÍNICO É:**

[4000184389](#)

Questão 57 Medicina Preventiva

Mulher, 90a, portadora de síndrome demencial avançada, foi trazida ao Pronto Socorro por episódio único de vômito e desidratação. Foi submetida a exames laboratoriais, tomografia de abdome, endoscopia e colonoscopia, que resultaram normais. Permaneceu internada durante uma semana, recebendo antibióticos. Após a internação, não foi mais capaz de deambular. **A PROTEÇÃO CONTRA NOVAS INTERVENÇÕES DESNECESSÁRIAS, EVITANDO DANOS IATROGÊNICOS, DENOMINA-SE:**

[4000184388](#)

Questão 58 Medicina Preventiva

No estudo de Framingham, iniciado na década de 1940 na cidade dos Estados Unidos que leva esse nome, mais de 5.000 pessoas foram acompanhadas durante vários anos para identificar a incidência de doenças cardiovasculares e os fatores

Questão 59 Medicina Preventiva

O avanço da biotecnologia, e suas aplicações na prática médica, tornou-se um novo paradigma na assistência à saúde. Tais avanços se concretizaram graças ao complexo médico-industrial, que se tornou uma área de negócios atrativa por sua alta lucratividade, porém geradora de conflitos de interesse. Nesse cenário, surgem conflitos éticos e legais que comprometem a organização e a gestão do sistema de saúde. **A SITUAÇÃO DESCRITA CAUSA IMPACTO EM QUAL PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DO SUS?**

4000184386

Questão 60 Etiologias Parkinsonismo Medicamentoso Neurologia

Homem, 54a, é encaminhado ao ambulatório de Saúde do Trabalhador com hipótese de parkinsonismo secundário e queixas de perda de memória, em uso de levodopa. Previamente hígido, trabalha como vigilante em um condomínio. Há dois anos, durante aplicação de herbicida no jardim do seu local de trabalho, derramou o produto sobre o corpo acidentalmente. Refere que o produto permaneceu em contato com a pele por cerca de uma hora. No mesmo dia, ao final da jornada de trabalho apresentou indisposição geral, ardência e vermelhidão nos olhos. Uma semana depois, notou aparecimento de vesículas nas áreas cutâneas expostas ao contato com o produto, que duraram quinze dias. Após um mês, apresentou parestesias de predomínio distal nos quatro membros com resolução espontânea em 45 dias, mantendo rigidez e lentificação motora. Exame neurológico atual: síndrome acinético-rígida, Mini Exame do Estado Mental=23/30 pontos. Eletroencefalograma dos quatro membros=normal. Ressonância magnética cerebral: hipersinal em T2 no globo pálido, na substância negra, na via nigro-estriatal e na substância cinzenta periaquedutal, bilateral e simétrica. **O DIAGNÓSTICO PROVÁVEL É DE PARKINSONISMO SECUNDÁRIO POR EXPOSIÇÃO A QUAL AGROTÓXICO HERBICIDA?**

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184385

Questão 61 Quadro Clínico Tratamento Neurologia

Homem, 87a, foi hospitalizado há quatro dias por sepse secundária à pneumonia, em uso de amoxicilina-clavulanato. No terceiro dia de tratamento, iniciou episódios de confusão e agitação, apesar das medidas para não interromper o seu sono à noite e do uso adequado dos óculos. Nega dor. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial em uso de propranolol, hidroclorotiazida e enalapril. Exame físico: PA=132x74mmHg; FC=76bpm; FR=16irpm; temperatura=36,7°C; oximetria de pulso=96% (ar ambiente). Neurológico: sem déficit focal; vígil e desorientado temporalmente. **A MEDIDA MAIS APROPRIADA PARA O TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO DELIRIUM NESTE PACIENTE É:**

- ☐ A Iniciar haloperidol.
- ☐ B Iniciar lorazepam.
- ☐ C Mobilizar precocemente.
- ☐ D Retirar a hidroclorotiazida.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184384

Questão 62 Classificação e fisiopatologia Cardiologia Tratamento

Mulher, 72a, foi avaliada por um episódio de síncope e alguns eventos de sensação de que ia desmaiar. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial e dislipidemia, em uso de hidroclorotiazida 25mg/dia, enalapril 20mg/dia e atorvastatina 40mg/dia. Exame físico: PA=122x78mmHg em posição supina, FC=70bpm. Após três minutos em pé, PA=100x66mmHg, FC=92bpm. Restante do exame físico: normal. **A CONDUTA É:**

- A Administrar fludrocortisona.
- B Ajustar a dose dos anti-hipertensivos.
- C Prescrever meia elástica compressiva.
- D Solicitar teste de inclinação ortostática (*tilt test table*).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184383](#)

Questão 63 Infectologia

Mulher, 37a, chegou ao Pronto Atendimento com história de dor na região lombar, sem irradiação, há duas semanas. Antecedentes pessoais: uso de cocaína injetável. Exame físico: T=38,2°C; PA=118x78mmHg; FC=92bpm; FR=20irpm. Dor à palpação sobre L4 e L5, com piora à hiperextensão e flexão do tronco. Presença de marcas de injeção nos antebraços, restante do exame físico normal. Teste para HIV, hemograma, hemocultura e urocultura em andamento. **A CONDUTA É:**

- A Prescrever antibioticoterapia, analgesia e liberar a paciente.
- B Realizar punção líquórica.
- C Solicitar ressonância magnética de coluna lombar.
- D Solicitar radiograma de coluna lombar.

Contra preços abusivos
na medicina.

4000184382

Questão 64 Doença de Menière

Mulher, 51a, procura Unidade Básica de Saúde para avaliação de tontura. Refere que há um ano teve episódio de perda auditiva esquerda, associado a zumbido. Nos últimos três meses, vem apresentado sensação de ambiente girando, com duração de 20 minutos a 5 horas, associada a náuseas e vômitos. Nega outras doenças ou uso de medicações. Traz exame de ressonância magnética de encéfalo, realizada há dois meses, sem anormalidades. Exame físico: T=36,5°C; PA=124x88mmHg; FC=82bpm; FR=16irpm. A manobra de Dix Hallpike no lado esquerdo induziu tontura, sem nistagmo. **A**

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:

- A Vertigem posicional paroxística benigna.
- B Neurite vestibular.
- C Acidente vascular vertebrobasilar.
- D Doença de Menière.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

4000184381

Questão 65 Clínica Médica

Homem, 72a, foi avaliado em consulta de rotina por dislipidemia. Ele refere comer frutas e legumes diariamente, carne vermelha duas vezes por semana e ingerir diariamente refrigerantes e uma lata de cerveja. Nega tabagismo. Mora sozinho e não tem relações sociais, descreve-se como uma pessoa solitária. O rastreio para depressão foi negativo. **PARA ESTE PACIENTE, O FATOR DE RISCO CARDIOVASCULAR MAIS IMPORTANTE É:**

- A Consumo de álcool.
- B Consumo de refrigerante.
- C Isolamento social.
- D Consumo de carne vermelha.

4000184380

Questão 66 Infectologia

Homem, 22a, foi diagnosticado com meningite por meningococo. Mora em uma casa com mais quatro estudantes. **EM RELAÇÃO À PROFILAXIA PARA MENINGITE NESTE CASO, É CORRETO AFIRMAR QUE:**

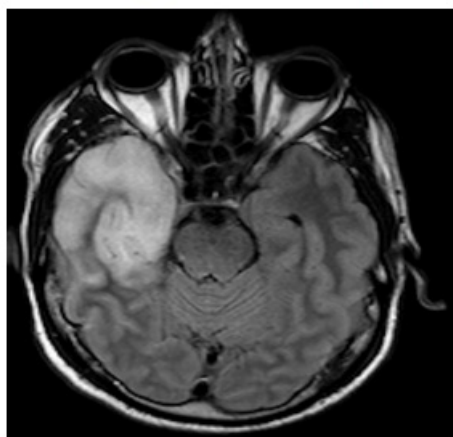
- A Todos os estudantes que moram na casa devem receber azitromicina, iniciada até 14 dias do diagnóstico do caso índice.
- B Os estudantes que dormem no mesmo quarto do paciente devem receber ceftriaxona, iniciada até 24h do diagnóstico do caso índice.
- C Todos os estudantes que moram na casa devem receber ceftriaxona, iniciada até 14 dias do diagnóstico do caso índice.
- D Os estudantes que dormem no mesmo quarto do paciente devem receber rifampicina, independente do tempo de diagnóstico do caso índice.

4000184379

Questão 67 Infectologia

Homem, 29a, é trazido por familiares para o Pronto Atendimento após ter apresentado crise tônico-clônica generalizada. Há dois dias iniciou quadro de febre, cefaleia e mudança comportamental. Previamente hígido. Exame físico: T=38,1°C; FC=98bpm; PA=128x84mmHg; Escala de coma de Glasgow=14, restante do exame físico normal. Ressonância magnética de crânio e coleta de líquido.

(Ressonância magnética de crânio- corte axial ponderado em FLAIR)



OS ACHADOS ESPERADOS PARA ESTE LÍQUOR SÃO:

- A** Pleocitose com predomínio de linfócitos, aumento discreto de proteínas, glicorraquia normal (superior a dois terços da glicemia), lactato normal, culturas e pesquisa de bactérias negativas. Pesquisa positiva para HSV-1 ou HSV-2.
- B** Pleocitose com predomínio de linfócitos, aumento discreto de proteínas, glicorraquia reduzida (inferior a dois terços da glicemia), lactato aumentado, culturas e pesquisa de bactérias negativas. Pesquisa positiva para HSV-1 ou HSV.
- C** Pleocitose com predomínio de linfócitos, aumento discreto de proteínas, glicorraquia normal (superior a dois terços da glicemia), lactato normal, culturas e pesquisa de bactérias negativas. Pesquisa positiva para Citomegalovírus.
- D** Pleocitose com predomínio de linfócitos, aumento discreto de proteínas, glicorraquia reduzida (inferior a dois terços da glicemia), lactato aumentado, culturas e pesquisa de bactérias negativas. Pesquisa positiva para Citomegalovírus.

4000184378

Questão 68 Tratamento Síndrome de GuillainBarré Neurologia

Mulher, 56a, previamente hígida, procura o Pronto Socorro com quadro de dormência e perda de força evoluindo há dois dias. Os sintomas se iniciaram nos pés e ascenderam até raiz de coxas. No momento, paciente deambulando apenas com apoio bilateral. Antecedentes pessoais: recebeu vacina antiviral há uma semana. Exame físico: bom estado geral; PA=138x87mmHg; FC=115bpm; FR=18irpm; oximetria de pulso=96% (ar ambiente); ausculta cardiopulmonar sem alterações. Neurológico: força muscular em membros inferiores- distal grau II e proximal grau III; e em membros superiores- distal grau III e proximal grau IV; reflexos osteotendinosos globalmente abolidos; reflexo cutâneo plantar em flexão; paralisia facial de padrão periférico à direita e à esquerda; exame de sensibilidade e função esfinteriana preservados. Exames laboratoriais: CPK=438UI/L; sódio=136mEq/L; potássio=4,2mEq/L; cálcio iônico=1,2mmol/L. **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA E O**

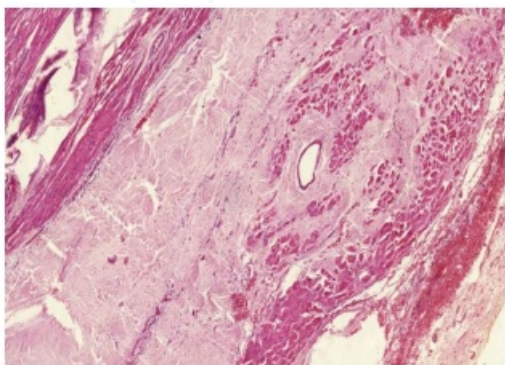
TRATAMENTO SÃO:

- A** Miosite pós-vacinal e pulsoterapia de corticosteroides.
- B** Mielite transversa pós-vacinal e imunoglobulina humana endovenosa.
- C** Síndrome de Guillain-Barré e pulsoterapia de corticosteroides.
- D** Síndrome de Guillain-Barré e imunoglobulina humana endovenosa.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184377

Questão 69 Infarto Agudo do miocárdio com supra de ST IAMCSST Cardiologia

Homem, 67a, no início da manhã apresentou fortes dores na região central do tórax, que irradiavam para o pescoço, mandíbula e braço esquerdo, e dificuldade para respirar. Foi imediatamente conduzido a uma Unidade de Emergência, chegando com sudorese acentuada e muito ansioso. Exame físico: PA=60x35mmHg; FC=120bpm; cianose de extremidades, pulsos fracos. Eletrocardiograma: sinais de extenso infarto do miocárdio anterolateral. Foram realizadas medidas iniciais de suporte de vida e indicado cateterismo cardíaco, mas antes disto evoluiu à óbito. Submetido à necropsia. A Figura mostra uma secção do coração.



SOBRE A IMAGEM, É CORRETO AFIRMAR QUE:

- A Há uma área de infarto do miocárdio antigo e o novo infarto é muito recente para ser identificado à histologia convencional.
- B Há uma área de necrose coagulativa do miocárdio, compatível com o infarto recente.
- C Existe uma hipertrofia dos cardiomiócitos decorrente de hipertensão arterial crônica.
- D O infarto do miocárdio produziu redução súbita da pressão arterial, com trombose vascular e sinais de recanalização.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184376](https://www.4000184376.com)

Questão 70 **Tabaco** **Dependência de Tabaco**

Homem, 20a, procura a Unidade Básica de Saúde para orientação sobre o uso de cigarro eletrônico. Após falecimento do avô por câncer de pulmão, e sabendo dos riscos da exposição ao tabaco, ele quer saber sobre a segurança desse novo dispositivo. **A ORIENTAÇÃO QUANTO AO USO DO CIGARRO ELETRÔNICO É:**

- A Pode ser usado com segurança em até 5mg de nicotina por dia.
- B Não existe tipo ou quantidade considerada segura.
- C Pode ser usado com segurança em até 2mg de nicotina por dia.
- D As unidades sem nicotina são consideradas seguras.

4000184376

Questão 71 **Diagnóstico e Classificação das Úlceras**

Homem, 48a, retorna assintomático à Unidade Básica de Saúde. Há três meses iniciou tratamento com omeprazol, após endoscopia digestiva alta (EDA) ter evidenciado úlcera em corpo gástrico de 1cm, bordas planas e nítidas, fundo com fibrina, sem sangramento ativo. Pesquisa para *Helicobacter pylori*=negativa. Exame físico: PA=114x76mmHg; FC=68bpm; FR=14irpm; restante sem alterações. **A CONDUTA É:**

- A Manter omeprazol até completar seis meses de tratamento.
- B Repetir a EDA, independente da melhora dos sintomas.
- C Repetir a EDA caso os sintomas persistam, após seis meses de tratamento.
- D Suspender omeprazol e dar alta ambulatorial.

4000184374

Questão 72 Heparina não fracionada

Homem, 32a, internado há três dias após fratura de tíbia por acidente automobilístico, apresentou quadro de dispneia súbita. Foi feito o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar e iniciada a anticoagulação plena com heparina não fracionada. No dia seguinte, após apresentar fraqueza em dimídio direito, foi suspensa a heparina e realizada tomografia computadorizada de crânio.



A CONDUTA É:

- ☐ A Prescrever vitamina K.
- ☐ B Retomar a heparina não fracionada.
- ☐ C Prescrever plasma fresco congelado.
- ☐ D Prescrever protamina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184373](#)

Questão 73 Tratamento de manutenção da asma Pneumologia

Homem, 37a, procura atendimento na Unidade Básica de Saúde com queixa de tosse seca e chiado no peito. Estes episódios ocorrem de quatro a cinco vezes por semana, nos últimos três meses, não relacionados aos exercícios. Durante as crises, tem melhora com o uso de salbutamol. Antecedentes pessoais: asma, em uso de budesonida inalatória diariamente. Exame físico: T=36,4°C; FR=16irpm; oximetria de pulso=96% (ar ambiente). Pulmões: murmúrio vesicular presente bilateralmente com sibilos expiratórios. **A CONDUTA É:**

- ☐ A Associar formoterol.
- ☐ B Prescrever azitromicina por 5 dias.
- ☐ C Substituir budesonida por prednisona.
- ☐ D Associar tiotrópio.

4000184372

Questão 74 Endocrinologia

Homem, 73a, retorna à consulta na Unidade Básica de Saúde referindo adinamia e ganho de peso nos últimos três meses. Antecedentes pessoais: doença arterial coronariana, hipertensão arterial e dislipidemia, em uso de losartana, carvedilol, ácido acetil salicílico, clopidogrel e atorvastatina. Exame físico: T=36,2°C; PA=128x72mmHg; FC=54bpm; FR=10irpm;

oximetria de pulso=97% (ar ambiente). Ausculta cardíaca e pulmonar normais. Reflexos osteotendinosos diminuídos globalmente. TSH=25μUI/mL; T4 livre=0,2ng/dL. **A CONDUTA É:**

- A Iniciar levotiroxina 50mcg.
- B Iniciar levotiroxina 25mcg.
- C Repetir o exame em 60 dias.
- D Repetir o exame em seis meses.

4000184371

Questão 75 Infectologia

Homem, 32a, assintomático, comparece à Unidade Básica de Saúde para repetir testagem de infecções sexualmente transmissíveis após oito meses do tratamento para sífilis secundária. Naquele momento, apresentou teste não treponêmico VDRL=1:32 e recebeu penicilina benzatina 2,4 milhões UI intramuscular. Exame físico: PA=122x84mmHg; FC=86bpm; FR=14irpm. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, ausência de lesões de pele, ausência de lesão genital. Exame neurológico sem alterações. Exames laboratoriais: sorologias de HIV e hepatites B e C não reagentes, VDRL=1:32. **A**

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA E A CONDUTA SÃO:

- A Cicatriz sorológica; repetir VDRL e em caso de aumento de título, indicar retratamento.
- B Reinfecção por sífilis; indicar retratamento em caso de aparecimento de lesões cutâneas e/ou genitais.
- C Sífilis persistente; indicar retratamento com doxiciclina, pela suspeita de falha da penicilina benzatina.
- D Reativação de sífilis; indicar retratamento com penicilina benzatina e realizar coleta de líquido.

4000184370

Questão 76 Pneumologia Intensiva Pneumologia

Mulher, 53a, internada para tratamento de pneumonia, evoluiu com necessidade de ventilação mecânica. Antecedentes pessoais: lúpus eritematoso sistêmico e diabetes melito. Medicamentos em uso: prednisona, ceftriaxona, azitromicina e insulina. Exame físico: peso atual=76Kg; peso predito=50Kg; T=36,9°C; PA=132x68mmHg; FC=88bpm; oximetria de pulso=95% (FiO₂=50%); ausculta pulmonar com crepitações em base esquerda; ausculta cardíaca normal. Ventilação mecânica: modo controlado a volume; fração inspirada de oxigênio (FiO₂)=50%; volume corrente=300mL; FR=16irpm; pressão positiva expiratória final (PEEP)=6mmHg; relação I:E=1:3. Gasometria arterial: pH=7,29; paO₂=120mmHg; paCO₂=72mmHg; HCO₃=27mmol/L; base excess (BE)=-1,5. **A CONDUTA É AUMENTAR:**

- A Frequência respiratória.
- B FiO₂.
- C PEEP.
- D Volume corrente.

4000184369

Questão 77 Protocolo de transfusão maciça Cirurgia

Homem, 21a, vítima de ferimento por projétil de arma de fogo em região toracoabdominal, é trazido ao hospital terciário por familiares. Exame físico: escala de coma de Glasgow=8; pupilas isofotorreagentes; PA=69x41mmHg; FC=142bpm; FR=24irpm; presença de orifício de entrada no 11º espaço intercostal na linha axilar anterior direita e orifício de

saída no mesmo nível na região paravertebral direita. Restante sem alterações. Foram realizados: obtenção de via aérea definitiva e administração de 1.000mL de solução de Ringer com lactato aquecido. **CONFORME O ATLS 10ª. EDIÇÃO A CONDUTA A SEGUIR É:**

- A Toracotomia de reanimação.
- B Laparotomia exploradora.
- C Protocolo de transfusão maciça.
- D Administrar droga vasoativa.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184368](https://www.4000184368.com.br)

Questão 78 Princípios da Anestesiologia Cirurgia

Durante a laringoscopia na intubação orotraqueal é solicitado, para um integrante da equipe, realizar uma pressão no sentido posterior, superior e para a direita na laringe. **A FINALIDADE PRINCIPAL DESTA MANOBRA É:**

- A Comprimir o esôfago contra a coluna.
- B Auxiliar na visualização das cordas vocais.
- C Determinar a classificação de Mallampati.
- D Evidenciar grau de obstrução da via aérea.

Contra preços abusivos na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184367](https://www.4000184367.com.br)

Questão 79 Choque Cirurgia Trauma Abdominal e Pélvico

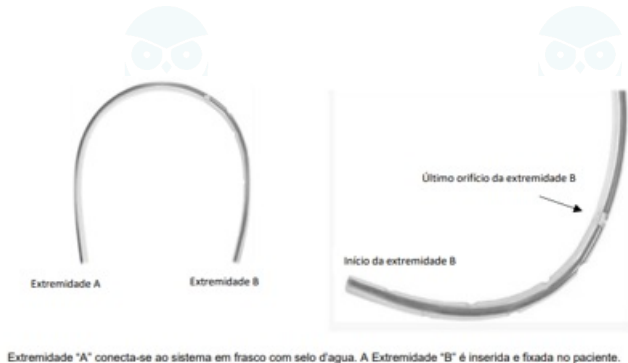
Homem, 19a, condutor de motocicleta, tem uma colisão frontal contra anteparo fixo. É trazido pelo atendimento pré-hospitalar para Unidade de Pronto Atendimento com colar cervical e imobilizado em prancha longa. Na admissão queixa-se de dor na região de abdome inferior. Exame físico: escala de coma de Glasgow=15; pupilas isofotorreagentes; PA=94x62mmHg; FC=122bpm; FR=18irpm; oximetria de pulso=95% (ar ambiente); pescoço/tórax sem alterações; abdome/pelve: palpação dolorosa da sínfise púbica com afastamento em torno de 3cm, dor à palpação e compressão laterais da pelve, presença de hematoma escrotal. Foram realizados: oferta de O₂=12L/min por máscara não reinalante; punção de dois acessos venosos periféricos com cateteres calibrosos; coleta de sangue e administração de 1.000mL de solução de Ringer com lactato aquecido e estabilização da pelve com lençol. **O POSICIONAMENTO DESTES LENÇOL DEVE SER NA TOPOGRAFIA:**

- A das cristas ilíacas anterior superior.
- B das regiões médias das coxas.
- C da região mediana entre púbis e cicatriz umbilical.
- D dos trocanteres maiores dos fêmures.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184366](https://www.4000184366.com.br)

Questão 80 Cirurgia Torácica Cirurgia

As imagens abaixo representam um dreno radiopaco utilizado em drenagem torácica.



Extremidade "A" conecta-se ao sistema em frasco com selo d'água. A Extremidade "B" é inserida e fixada no paciente.

NA REALIZAÇÃO DE UMA DRENAGEM TORÁCICA SOB SELO D'ÁGUA EM UM PACIENTE, O POSICIONAMENTO CORRETO DO ÚLTIMO ORIFÍCIO DA EXTREMIDADE "B" É:

- A No espaço intercostal, distante do feixe vâsculo-nervoso.
- B Entre as pleuras visceral e parietal.
- C No subcutâneo, sem exteriorização para o ambiente.
- D Entre a pleura visceral e o parênquima pulmonar.

Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184365](https://www.4000184365.com)

Questão 81 Pneumotórax Hipertensivo Cirurgia

Homem, vítima de acidente automobilístico, é trazido ao Pronto Socorro de referência. Na admissão, apresenta insuficiência respiratória aguda súbita. Exame físico: PA=82x54mmHg; FC=133bpm; FR=34irpm; oximetria de pulso=88% (ar ambiente); presença de enfisema subcutâneo; turgência jugular; desvio de traqueia para a esquerda e ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito. **A CONDUTA É:**

- A Solicitar radiograma de tórax.
- B Administrar 1.000mL de Ringer com lactato aquecido.
- C Solicitar tomografia computadorizada de tórax.
- D Realizar punção do espaço pleural.

Proibida Venda.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184364](https://www.4000184364.com)

Questão 82 Estadiamento anatômico

Homem, 58a, apresenta tosse e emagrecimento de 5Kg há dois meses. Radiograma de tórax: opacidade paracardíaca direita, com apagamento do bordo direito do coração e discreto alargamento do mediastino. Biopsia por broncoscopia: carcinoma não pequenas células. **O TUMOR ESTÁ LOCALIZADO NO BRÔNQUIO:**

- A principal direito.
- B intermediário.
- C do lobo inferior direito.
- D do lobo médio.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184363](https://www.4000184363.com)

Questão 83 Fimose Tratamento Tratamento

Menino, 3m, é trazido para puericultura e mãe nega queixas. O exame físico foi compatível com os diagnósticos de: fimose; hidrocele à esquerda; hemiescroto direito vazio e testículo palpável no canal inguinal direito. **A CONDUTA É:**

- A Expectante quanto à fimose; expectante quanto à hidrocele; realizar orquidopexia.
- B Indicar postectomia; corrigir a hidrocele; realizar orquidopexia.
- C Expectante quanto à fimose; expectante quanto à hidrocele; expectante quanto à orquidopexia.
- D Indicar postectomia; corrigir a hidrocele; expectante quanto à orquidopexia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184362](#)

Questão 84 **Score Meld**

O MELD (Model for End-stage Liver Disease) é um índice baseado em alguns dados clínicos do paciente adulto e é usado para definir a inscrição do paciente na fila de transplante hepático. **OS EXAMES NECESSÁRIOS PARA O CÁLCULO DO MELD SÃO:**

- A Bilirrubina indireta; transaminases; creatinina.
- B Bilirrubina total; RNI; creatinina.
- C Bilirrubina total; albumina; clearance de creatinina.
- D Bilirrubina indireta; RNI; clearance de creatinina.

4000184361

Questão 85 **Fases da Cicatrização** **Cirurgia**

NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS, AS FASES DOS EVENTOS ORGÂNICOS OCORREM NA SEGUINTE ORDEM DIDÁTICA:

- A Proliferativa (fibroplasia); reparativa (remodelação); exudativa (inflamatória).
- B Reparativa (remodelação); exudativa (inflamatória); proliferativa (fibroplasia).
- C Exsudativa (inflamatória); reparativa (remodelação) e proliferativa (fibroplasia).
- D Exudativa (inflamatória); proliferativa (fibroplasia); reparativa (remodelação).

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184360](#)

Questão 86 **Infectologia**

Homem, 32a, vítima de queda de moto em dia de chuva. Apresentou abdome agudo hemorrágico com choque refratário, sendo submetido à laparotomia exploradora com esplenectomia total. **ALÉM DAS VACINAS DE ROTINA, CONTRA QUAIS AGENTES INFECCIOSOS ESTE PACIENTE DEVE SER IMUNIZADO?**

- A Pneumococo, *Haemophilus influenzae* tipo B, meningococo.
- B Pneumococo, HPV e *Haemophilus influenzae* tipo B.
- C Meningococo, *Clostridium tetani* e HPV.
- D Meningococo, pneumococo e rotavírus.

Questão 87 Estimativa da Superfície Corpórea Queimada e Circulação **Cirurgia**

Homem, 26a, é trazido ao Pronto Socorro após queimadura na face anterior do corpo, por uso de álcool líquido em churrasqueira. Durante o atendimento inicial foi proposta reposição volêmica conforme o ATLS 10ª. edição.

CONSIDERANDO A REGRA DOS 9 PARA SER UTILIZADA NA FÓRMULA DE PARKLAND, A SUPERFÍCIE CORPÓREA QUEIMADA, CONFORME A ILUSTRAÇÃO ABAIXO, É:

Queimadura de segundo grau=coloração cinza sólida; queimadura de primeiro grau=listrado vertical.



- A 22,5%.
- B 20,5%.
- C 43%.
- D 45%.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184358

Questão 88 Cistos Renais **Cirurgia**

Homem, 75a, assintomático, retorna para consulta médica trazendo ultrassonografia de abdome que evidenciou um cisto de 3,2x2,8cm em rim esquerdo, sem conteúdo espesso e sem septações. **A CONDUTA É:**

- A Repetir ultrassonografia em seis meses.
- B Repetir ultrassonografia em um ano.
- C Orientar que não há necessidade de prosseguir a investigação.
- D Solicitar tomografia computadorizada de abdome com contraste.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184357

Questão 89 **Cirurgia**

No exame físico o sinal semiológico, quando presente, auxilia no raciocínio da hipótese diagnóstica. **OS SINAIS DE**

CULLEN, LENANDER E DE JOBERT, ESTÃO RELACIONADOS, RESPECTIVAMENTE, COM:

- A Pancreatite aguda, apendicite aguda e úlcera duodenal perfurada.
- B Neoplasia gástrica, pancreatite aguda e diverticulose.
- C Úlcera duodenal perfurada, apendicite aguda, diverticulose.
- D Pancreatite aguda, neoplasia gástrica e apendicite aguda.

4000184356

Questão 90 Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo SDRA Pneumologia

ASSINALE A VARIÁVEL E O VALOR QUE CARACTERIZAM A SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE:

- A Frequência respiratória > 30 irpm.
- B Pressão inspiratória máxima $< -25\text{cmH}_2\text{O}$.
- C Relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300\text{mmHg}$.
- D $\text{PaCO}_2 > 60\text{mmHg}$.

4000184355

Questão 91 Isquemia Mesentérica Crônica Cirurgia

Homem, 72a, procura Pronto Socorro queixando-se de dor abdominal em cólica há um mês, periumbilical, com piora há uma semana, principalmente após as refeições, sem melhora com analgésicos e necessitando permanecer em posição antálgica. Antecedente pessoal: infarto agudo do miocárdio há 12 anos, diabetes melito há 22 anos, tabagismo 40 anos/maço. Exame físico: FC=108bpm; PA=162x78mmHg; abdome: plano, normotenso, flácido, sem irritação peritoneal, sem tumor palpável; membros inferiores: pulsos pediosos ausentes, pulsos tibiais posteriores presentes. **A HIPÓTESE**

DIAGNOSTICA É:

- A Angina mesentérica.
- B Úlcera péptica.
- C Cólica biliar.
- D Aneurisma de aorta.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184354

Questão 92 Hematologia

Mulher, 32a, procura Pronto Socorro queixando-se de dor e inchaço em perna direita há dois dias. Ultrassonografia com Doppler: trombose venosa profunda. **O TRATAMENTO INICIAL E O ALVO TERAPÊUTICO SÃO:**

- A Warfarina; R=2,5 a 3,5.
- B Heparina não fracionada; RNI=2,0 a 3,0.
- C Heparina de baixo peso; RNI=2,5 a 3,5.
- D Heparina de baixo peso e warfarina; RNI=2,0 a 3,0.

Questão 93 Larva migrans Dermatologia

Menino, 8a, é trazido para atendimento médico por apresentar lesão pruriginosa em dorso de pé há uma semana, com aumento progressivo, conforme imagem.

**O AGENTE ETIOLÓGICO DESTA LESÃO É:**

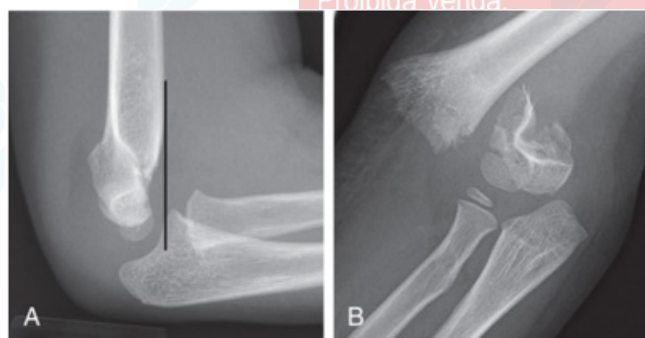
- A *Necator americanus*.
- B *Ancylostoma braziliensis*.
- C *Leishmania donovani*.
- D *Trypanosoma cruzi*.

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184352](https://www.4000184353.com)

Questão 94 Contratura Isquêmica de Volkmann

Adolescente, 12a, é trazido ao Pronto Socorro referindo dor em cotovelo direito após ter caído de uma árvore, há uma hora. Exame físico: corado; consciente; orientado; hidratado; fácies de dor. FC=112bpm, FR=21írpm, PA=126x82mmHg. Deformidade em cotovelo direito, doloroso à palpação, e pulsos radiais presentes. Restante sem alterações. Radiograma de cotovelo direito.



UMA COMPLICAÇÃO QUE PODE OCORRER NESTA SITUAÇÃO CLÍNICA É A SÍNDROME DE COMPARTIMENTO QUE, SE NÃO CONDUZIDA PRECOCEMENTE, PODE LEVAR À:

- A Choque neurogênico.
- B Lesão de Baumann.
- C Lesão dos nervos ulnar, mediano e braquial.
- D Contratura isquêmica de Volkmann.

4000184351

Questão 95 **Diarreia Crônica**

Criança, 3a, em acompanhamento ambulatorial por quadro de diarreia crônica, edema e baixo ganho pondero-estatural nos últimos sete meses. Exame físico: índice de massa corporal (IMC) percentil 3; descorado; hidratado; anictérico; fígado e baço não palpáveis; edema palpebral e de membros inferiores. hemoglobina=8,0g/dL; hematócrito=25%; VCM= 63fL; HCM=26pg; leucócitos=10.250/mm³(86% neutrófilos; 4% linfócitos; 5% monócitos e 5% eosinófilos); plaquetas=345.000/mm³; albumina=2,1g/dL; alfa1globulina=0,9g/dL; alfa2globulina=0,7g/dL; betaglobulina= 1,1g/dL; gamaglobulina=0,8g/dL; proteinúria 24 horas=0,15g. **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

- A Intolerância à lactose.
- B Enteropatia perdedora de proteína.
- C Infecção por *Ascaris lumbricoides*.
- D Deficiência de alfa1 antitripsina.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184350

Questão 96 **Tuberculose Latente** **Tuberculose**

Menino, 15 dias de vida, é trazido para consulta de puericultura em aleitamento materno exclusivo, assintomático. Antecedente pessoal: uma dose de vacina de hepatite B. Contactante domiciliar iniciou tratamento de tuberculose pulmonar há um dia. Exame físico sem alterações, com ganho ponderal de 30g/dia em relação à alta hospitalar. **A CONDUTA É:**

- A Prescrever rifampicina oral por 3 meses e, após, indicar teste tuberculínico.
- B Prescrever isoniazida oral por 3 meses e, após, indicar a vacina BCG.
- C Indicar a vacina BCG.
- D Indicar teste tuberculínico.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184349

Questão 97 **Refluxo Gastroesofágico RGE** **Pediatria**

Menina, 4m, é trazida para puericultura com história de vômitos após as mamadas desde o nascimento. Mãe refere sono agitado, irritabilidade e piora progressiva dos vômitos desde o início do quadro. Procurou serviço médico e foi orientado decúbito elevado e domperidona. Há dois meses o leite materno foi substituído por fórmula à base de aminoácidos 5 medidas fórmula em 150mL água a cada 2 horas, sem melhora. Antecedente pessoal: recém-nascido a termo, peso nascimento=3.130g. Exame físico: bom estado geral; anictérica; corada; peso=4,380Kg; fontanela plana e normotensa; exame neurológico normal; restante sem alterações. **A CONDUTA É:**

- A Substituir domperidona por omeprazol.
- B Indicar fundoplicatura total.
- C Solicitar radiograma contrastado de esôfago-estômago-duodeno.
- D Substituir a fórmula à base de aminoácidos por hidrolisado proteico.

4000184348

Questão 98 Diagnóstico Pediatria

Menino, 9a, previamente hígido, é trazido ao Pronto Atendimento com história de múltiplas lesões arroxeadas pelo corpo, sem prurido. Há dois dias iniciou quadro de dor abdominal intensa, difusa, com melhora parcial com uso de dipirona oral. Nega febre, vômitos, diarreia ou alterações urinárias. Exame físico: bom estado geral; corado; afebril; anictérico; hidratado; eupneico; pele: múltiplas lesões equimóticas indolores, sem hiperemia ou calor, em nádegas e membros inferiores; abdome indolor, sem visceromegalias ou massas; exame neurológico normal.



Contra preços abusivos
na medicina.

O DIAGNÓSTICO É:

- A Púrpura trombocitopênica idiopática.
- B Meningococcemia.
- C Púrpura *fulminans* de etiologia viral.
- D Vasculite por IgA.

Acesse t.me/medicinalivre

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184347

Questão 99 Dermatologia Molusco contagioso

Menina, 2a, é trazida para consulta de rotina, com lesões de pele há dois meses. Situação vacinal atualizada. Exame físico: bom estado geral; corada; hidratada; afebril; anictérica; pele



Restante do exame sem alterações. **O AGENTE ETIOLÓGICO É:**

- A *Herpes simplex.*
- B Poxvírus.
- C Papiloma vírus humano.
- D Vírus Varicella-zoster.

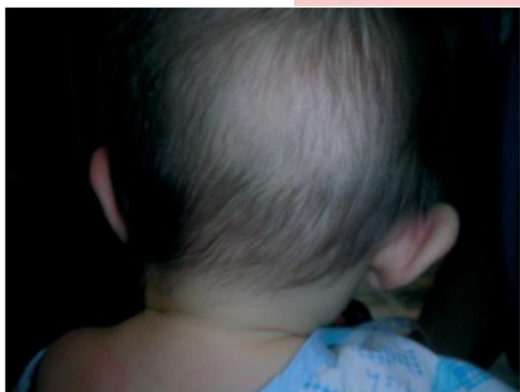
Medicina Livre

Contra preços abusivos
na medicina.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184346](https://www.4000184346.com)

Questão 100 Mastoidite

Menina, 15m, é trazida para avaliação médica com história de coriza e dor no ouvido direito há oito dias. Refere febre há três dias, prostração, inapetência, dor e aumento de volume retroauricular. Exame físico: bom estado geral; T=38,2oC; FR=42irpm; FC=137bpm. Cabeça:



Acesse t.me/medicinalivre

O TRATAMENTO É PRESCREVER:

- A Cefazolina e ampicilina intravenosa.
- B Ciprofloxacina tópica.
- C Azitromicina via oral.
- D Oxacilina e ceftriaxona intravenosa.

4000184345

Questão 101 Corpo EstranhoEngasgo

Menina, 10m, é trazida à Emergência por ter apresentado quadro súbito de acesso de tosse e cansaço. Nega febre e coriza. Exame físico: bom estado geral; T=36,5°C; FR=62irmp; FC=110bpm; pulsos cheios; perfusão periférica=2 segundos; oximetria de pulso= 91% (ar ambiente); batimento de asa nasal; retração intercostal; pulmões: murmúrio vesicular presente, com roncos disseminados bilateralmente; coração: bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros. **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

- A Aspiração de corpo estranho.
- B Bronquiolite viral aguda.
- C Laringite aguda.
- D Pneumotórax espontâneo.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184344](#)

Questão 102 Manejo da Via Aérea

Na condução da parada cardiorrespiratória em assistolia com via aérea definitiva de um lactente de três meses, **A FREQUÊNCIA DE COMPRESSÕES TORÁCICAS E DE VENTILAÇÃO É, RESPECTIVAMENTE:**

- A 100-120 compressões/min assíncronas e 1 ventilação a cada 2-3 segundos.
- B 100-110 compressões/min síncronas para cada ventilação.
- C 110-120 compressões/min assíncronas e 1 ventilação a cada 6 segundos.
- D 100-120 compressões/min síncronas para cada 4 ventilações.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184343](#)

Questão 103 Sepses neonatal

Recém-nascido a termo, filho de mãe colonizada por *Streptococcus agalactiae*, em trabalho de parto e que recebeu duas doses de penicilina cristalina antes do parto vaginal, sendo a última há três horas. Apgar 9/10, exame físico sem alterações.

A CONDUTA PARA O RECÉM-NASCIDO É:

- A Coletar hemograma, proteína C reativa e hemocultura; iniciar antibioticoterapia.
- B Coletar hemograma, proteína C reativa; aguardar exames para definir conduta.
- C Realizar exame físico seriado; sem coleta de exames ou tratamento.
- D Coletar hemocultura; iniciar antibioticoterapia.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184342](#)

Questão 104 Causas

Recém-nascido a termo com 3.450g apresenta-se hipotônico e com sucção débil com 12 horas de vida. Realizada dosagem de glicemia plasmática=22mg/dL. Antecedente gestacional: mãe com crise asmática e uso de terbutalina próximo ao parto. **O MECANISMO ASSOCIADO À OCORRÊNCIA DE HIPOGLICEMIA NESTE CASO É:**

- A Hiperinsulinismo.
- B Nesidioblastose.
- C Inibição da glicólise.
- D Bloqueio da glicogenólise.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184341](#)

Questão 105 Infectologia

Menino, 1a, é trazido à Emergência com história de choro intenso, agitação, sudorese fria e seis episódios de vômito há cerca de uma hora. Exame físico: regular estado geral; sonolento; choroso; T=36,8°C; FC=175bpm; FR=32irpm; pulsos cheios, enchimento capilar=2seg. Levado à Sala de Urgência. Eletrocardiograma: ritmo sinusal, onda T invertida em algumas derivações e presença de onda U. Glicemia capilar=204mg/dL. **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA É:**

- A Síndrome do QT longo.
- B Acidente escorpiónico.
- C Sepses criptogênica.
- D Cetoacidose diabética.

4000184340

Questão 106 Reanimação neonatal em maiores de 34 semanas

Recém-nascido, 40 semanas de gestação, gravidez sem intercorrências e parto cesárea por sofrimento fetal agudo com presença de líquido amniótico meconial. Foi recebido em campos aquecidos, posicionado em decúbito dorsal sob fonte de calor radiante, trocados os campos úmidos e asseguradas as vias aéreas pervias. Encontra-se hipotônico, com movimentos respiratórios irregulares e FC=60bpm. **A CONDUTA É:**

- A Intubação traqueal, administração de oxigênio a 100%, seguida de aspiração do conteúdo traqueal.
- B Intubação traqueal e ventilação com pressão positiva com oxigênio a 21%.
- C Compressão torácica coordenada com a ventilação com pressão positiva.
- D Ventilação com pressão positiva por máscara com oxigênio a 21%.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184339](#)

Questão 107 Hipotireoidismo Congênito

Menino, 23 dias de vida, foi convocado para consulta por apresentar TSH=25mUI/L em teste de triagem neonatal coletado em papel-filtro no quarto dia de vida. Mãe nega queixas. Está em aleitamento materno exclusivo com ganho ponderal de 28g/dia e o exame físico é normal. Antecedentes pessoais: gravidez e parto sem intercorrências (Capurro=39 semanas; peso ao nascimento=3.125g). **É CORRETO AFIRMAR QUE:**

- A Sugere hipotireoidismo subclínico; deve-se realizar dosagem sérica de T4L e TSH em oito semanas ou antes, se apresentar sintomas.
- B Sugere aumento fisiológico de TSH porque a coleta foi realizada no quarto dia de vida; não é necessária investigação.
- C Sugere hipotireoidismo; deve-se realizar dosagem sérica imediata de T4L e TSH.
- D Sugere hipertireoidismo; deve-se realizar dosagem sérica imediata de T3L, T4L e TSH.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184337](https://www.4000184337.com)

Questão 108 **Pneumonia afebril do lactente** **Pediatria** **Agentes etiológicos**

Menina, 3m, é internada em enfermaria com história de tosse seca, recusa das mamadas e cansaço há dois dias. Nega febre. Antecedentes pessoais: parto vaginal domiciliar a termo, com peso adequado; conjuntivite purulenta aos 15 dias de vida, em acompanhamento com oftalmologista. Exame físico: bom estado geral; corada; hidratada; T=36,2°C; FR=71irpm; FC=152bpm; pulsos cheios; enchimento capilar=2seg; pulmões: murmúrio vesicular presente, simétrico, com estertores subcrepitantes bilateralmente, tempo expiratório normal, com presença de retração de fúrcula, tiragem intercostal e subcostal. **O AGENTE ETIOLÓGICO RESPONSÁVEL PELO QUADRO É:**

- A *Streptococcus pneumoniae*.
- B *Staphylococcus aureus*.
- C *Chlamydia trachomatis*.
- D *Streptococcus agalactiae*.

Contra preços abusivos na medicina.

4000184337

Questão 109 **Tratamento**

Mulher, 41a, nuligesta, acompanhada por dismenorreia, que a incapacita de realizar atividades diárias, e dispareunia de profundidade há três anos. Tem ciclos menstruais regulares e usa *condom* como método contraceptivo. Antecedente pessoal: quadrantectomia por carcinoma *in situ* da mama; obesidade grau II. Ressonância magnética de pelve: lesão em fundo de saco posterior sugestiva de endometriose. **A CONDUTA É:**

- A Prescrever acetato de medroxiprogesterona trimestral.
- B Prescrever anticoncepcional oral combinado contínuo.
- C Indicar sistema intrauterino liberador de levonorgestrel.
- D Indicar tratamento cirúrgico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184337](https://www.4000184337.com)

Questão 110 **Obstetrícia** **Hepatites na gestação**

Mulher, 32a, gestante de 29 semanas, assintomática, foi encaminhada ao Pré-natal Especializado por apresentar os seguintes exames laboratoriais, coletados há sete dias: hemoglobina=12,1g/dL; hematócrito=36,4%; plaquetas=210.000/mm³; AST=15U/L; ALT=17U/L; HBsAg=positivo; anti-HBs=negativo; HBeAg=positivo; anti-HBe=negativo; anti-HBc=positivo. **A CONDUTA É:**

- A Solicitar carga viral do vírus da hepatite B, para definir tratamento materno; indicar vacina e imunoglobulina contra hepatite B para o recém-nascido.
- B Iniciar tratamento materno apenas no puerpério; indicar vacina e imunoglobulina contra hepatite B para o recém-nascido.
- C Realizar tratamento materno com tenofovir; indicar vacina e imunoglobulina contra hepatite B para o recém-nascido.
- D Realizar controle periódico de enzimas hepáticas maternas; indicar vacina contra hepatite B para o recém-nascido.

4000184335

Questão 111 Diabetes na gestação DMG Obstetrícia

Mulher, 30a, G1P0A0, idade gestacional de 26 semanas, é encaminhada com a seguinte curva glicêmica gestacional (CGG): Jejum=89mg/dL; 1h=182mg/dL; 2h=154mg/dL. Antecedentes: obesidade grau II, pai e avô diabéticos. **O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO SÃO:**

- A Euglicemia; orientar dieta, atividade física e repetir CGG com 28 semanas.
- B Diabetes gestacional; orientar dieta, atividade física e controle glicêmico.
- C Diabetes melito tipo 2; orientar dieta, atividade física e introduzir insulina.
- D Intolerância à glicose; orientar dieta e atividade física, não sendo necessário repetir o exame.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184334](#)

Questão 112 Rotura prematura de membranas ovulares RPM Obstetrícia

Mulher, 22a, G2P1A0, idade gestacional de 30 semanas, sem comorbidades, comparece ao Pronto Atendimento referindo dor em baixo ventre e sangramento vaginal discreto. Boa movimentação fetal. Exame físico: PA=102x62mmHg; FC=96bpm; altura uterina=28cm; BCF=152bpm; dinâmica uterina=ausente; especular=ausência de líquido ou sangue em vagina ou colo uterino; toque vaginal=colo dilatado 2cm, grosso, posterior. Após 30 minutos do exame, apresentou perda de líquido amniótico por via vaginal em grande quantidade. **ALÉM DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, AS MEDIDAS INDICADAS NESTE MOMENTO SÃO:**

- A Cardiotocografia, antibiótico de largo espectro para corioamnionite, sulfato de magnésio e indução do parto.
- B Triagem infecciosa, ultrassonografia com Doppler, sulfato de magnésio e parto cesárea.
- C Triagem infecciosa, corticoterapia, antibioticoprofilaxia para estreptococo do grupo B, sulfato de magnésio e tocolítico.
- D Cardiotocografia, triagem infecciosa, corticoterapia, antibioticoprofilaxia para estreptococo do grupo B.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184333](#)

Questão 113 Planejamento familiar

Mulher, 25a, vem para avaliação de planejamento familiar após encaminhamento pela reumatologia. Apresenta ciclos menstruais com fluxo aumentado e coágulos, com duração de 10 dias, nos últimos seis meses. Antecedentes: G0P0, menarca aos 15 anos, vida sexual ativa, parceiro único; tem diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico há três anos, em uso regular de hidroxiquina e metotrexato. hemoglobina=9g/dL, hematócrito=30%, leucócitos=2.000/mm³, plaquetas=60.000/mm³. Pesquisa de anticorpo anticardiolipina e de anticorpo anticélula (FAN) positivos.

Ultrassonografia pélvica: sem alterações em útero e ovários. **O MÉTODO CONTRACEPTIVO MAIS ADEQUADO É:**

- A Dispositivo intrauterino de cobre.
- B Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel.
- C Anticoncepcional oral combinado com 30µg de levonorgestrel.
- D Anticoncepcional oral combinado com 15µg de levonorgestrel.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184332

Questão 114 Endocrinologia

Mulher, 24a, nuligesta, queixa-se de secreção leitosa por ambas as mamas, há 18 meses. Refere ciclos menstruais longos, com atrasos de até 30 dias. Exame físico: IMC=22,2Kg/m²; mamas: expressão positiva de secreção láctea bilateralmente. Restante do exame físico normal. Prolactina=91ng/mL; TSH=2,5µUI/mL. Ressonância nuclear magnética cerebral: nódulo hipofisário de 6mm. A **CONDUTA É:**

- A Indicar tratamento cirúrgico, pois se trata de um tumor hipofisário e os agonistas dopaminérgicos não reduzem o volume do tumor.
- B Não utilizar contraceptivos hormonais combinados, pois o estrogênio vai aumentar a prolactina e o tumor.
- C Indicar tratamento com agonistas dopaminérgicos, para melhora do quadro clínico, da alteração hormonal e eventual redução do tumor.
- D Manter estadiamento de imagem anual. Por ser tumor pequeno, não há indicação de tratamento no momento.

4000184331

Questão 115 Exames laboratoriais Obstetrícia

Mulher, 18a, G2P0A1, idade gestacional de 21 semanas, sem queixas ou alterações ao exame físico. Exames laboratoriais de rotina pré-natal: hemoglobina=11,4g/dL; hematócrito=36%; glicemia de jejum=82 mg/dL; exame de urina: normal; urocultura=negativa. Sorologias: sífilis=negativa; toxoplasmose=IgG positivo e IgM negativo; HIV=negativa; hepatite C=negativa; Hepatite B=AntiHBs positivo, HBsAg e antiHBc negativos. Refere que desde a menarca apresenta fluxo menstrual intenso e com duração de sete dias. **É CORRETO AFIRMAR QUE:**

- A Os exames sugerem anemia na gestação; investigar com eletroforese de hemoglobina.
- B Os exames estão normais; orientar dieta e prescrever 40mg de ferro elementar ao dia, em uso contínuo.
- C Trata-se de anemia ferropriva; prescrever 200mg de ferro elementar ao dia, por três meses.
- D Trata-se de traço talassêmico; prescrever 40mg de ferro elementar e 5mg de ácido fólico ao dia, por três meses.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184330

Questão 116 Distúrbios hipertensivos na gestação DHEG Obstetrícia

Mulher, 35a, G3P2A0, idade gestacional de 37 semanas, refere que há dois dias vem apresentando edema de membros inferiores, dor de estômago e alguns episódios de cefaleia, principalmente nuchal. Antecedentes: hipertensão arterial há 10 anos, em uso regular de metildopa 750mg/dia. Exame físico: PA=152x92mmHg; FC=103bpm; altura uterina=32cm; dinâmica uterina=ausente; movimentos fetais=presentes; BCF=148bpm; edema em membros inferiores= 2+/4+. **A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA E A CONDUTA SÃO:**

- A Pré-eclâmpsia; solicitar hemograma, creatinina, proteinúria e enzimas hepáticas, realizar cardiotocografia e indicar cesárea.
- B Hipertensão arterial crônica não controlada; ajustar anti-hipertensivo, acompanhar em ambulatório de pré-natal e indicar parto com 38 semanas.
- C Hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia sobreposta; solicitar hemograma, creatinina, proteinúria e enzimas hepáticas, realizar cardiotocografia e avaliar indução de parto.
- D Hipertensão arterial crônica controlada e enxaqueca; prescrever analgésico, acompanhar em ambulatório de pré-natal e indicar parto com 39 semanas.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184329](#)

Questão 117 **Cardiotocografia CTB** **Obstetrícia**

Mulher, 37a, G4P3C0, sem comorbidades, com idade gestacional de 40 semanas e 4 dias, internada em Centro Obstétrico, em fase ativa de trabalho de parto (colo fino, 9cm, cefálico em plano -1 de De Lee, bolsa rota com líquido com mecônio fluido), apresenta a seguinte cardiotocografia:



Contra preços abusivos
na medicina.

A INTERPRETAÇÃO DA CARDIOTOCOGRAFIA E A CONDUTA OBSTÉTRICA NESTE MOMENTO SÃO:

- A Variabilidade normal com desacelerações precoces; manter assistência ao parto e cardiotocografia contínua.
- B Ausência de variabilidade com desacelerações tardias; indicar cesárea imediata.
- C Variabilidade diminuída com desacelerações variáveis; colocar em posição ginecológica e reduzir o colo uterino para parto vaginal imediato.
- D Variabilidade normal com desacelerações variáveis; corrigir taquissístolia e manter cardiotocografia contínua.

4000184328

Questão 118 **Diagnóstico e Exames Complementares**

Mulher, 52a, na menopausa há dois anos, em uso de terapia hormonal. Sem comorbidades. Antecedentes familiares negativos. **OS EXAMES RECOMENDADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DA TERAPIA HORMONAL SÃO:**

- A Dosagem de hormônios sexuais, mamografia e ultrassonografia pélvica.
- B Dosagem de hormônios sexuais, mamografia e cintilografia óssea.
- C Dosagem de lipoproteínas e frações, glicemia e mamografia.
- D Dosagem de lipoproteínas e frações, glicemia e ultrassonografia pélvica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184327](#)

Questão 119 **Ginecologia** **Farmacológicos**

Mulher, 70a, vem ao serviço com queixa de perda urinária durante orgasmo na relação sexual, há dois anos. Iniciou tratamento para perda urinária, mas interrompeu a medicação após três meses, por apresentar piora dos sintomas de demência. Antecedentes pessoais: G3C3, casada, com vida sexual ativa, menopausa aos 50 anos, sem terapia hormonal; demência leve em tratamento. Exame ginecológico: ausência de prolapsos, manobra de Valsalva negativa, sem outras alterações. **O DIAGNÓSTICO E A PROVÁVEL MEDICAÇÃO QUE A PACIENTE FEZ USO SÃO:**

- ☐ A Síndrome da bexiga hiperativa e oxibutinina.
- ☐ B Incontinência urinária de esforço e oxibutinina.
- ☐ C Síndrome da bexiga hiperativa e mirabegrona.
- ☐ D Incontinência urinária de esforço e mirabegrona.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184326](#)

Questão 120 **Interpretação e conduta frente as atipias citológicas**

Mulher, 47a, G2P2, retorna à Unidade Básica de Saúde para resultado de colpocitologia oncológica, coletada há um mês. Resultado: atipia de células glandulares sem outras especificações (ACG-SOE). Nega alteração de exame anteriores.

A ORIENTAÇÃO É:

- ☐ A O resultado é anormal; encaminhar para exame de colposcopia e biópsia.
- ☐ B O resultado é normal; deverá retornar para coleta de novo exame em três anos.
- ☐ C O resultado é anormal e indica infecção por HPV; encaminhar para tratamento com cirurgia de alta frequência.
- ☐ D O resultado é anormal, podendo estar associado à infecção por HPV ou processo inflamatório; retornar para coleta de novo exame em 12 meses.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184325](#)

Questão 121 **Exames complementares** **Quadro clínico**

Mulher, 56a, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de aparecimento de nódulo mamário à direita, indolor, há dois meses. Exame físico: mamas simétricas, sem abaulamentos ou retrações; alteração de textura da pele com hiperemia e edema em quadrante superior direito (QSD) de mama direita (D). Palpa-se nódulo endurecido e mal delimitado de 2cm em QSD de mama D, axila D com linfonodo palpável de 1cm endurecido e fossas supraclaviculares livres. **A CONDUTA É INDICAR:**

- ☐ A Mamografia, para rastreamento.
- ☐ B Ultrassonografia de mamas, para avaliação de axilas e fossas supraclaviculares.
- ☐ C Ressonância magnética de mamas, para avaliação de axilas e pele.
- ☐ D Mamografia, para orientação do diagnóstico.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184324](#)

Questão 122 **Diretrizes para o rastreamento**

Mulher, 66a, procura a Unidade Básica de Saúde para rotina de prevenção de câncer de colo uterino. Refere coleta de exames com intervalos trianuais desde os 25 anos, sem alterações. Último exame há um ano, normal. Sem queixas e exame

físico normal. **ALÉM DE ORIENTAR HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS, A CONDUTA É:**

- A Interromper rastreamento de câncer de colo uterino.
- B Coletar exame de colpocitologia oncológica e retorno para resultado. Se exame normal, interromper o rastreamento.
- C Retornar em dois anos para coleta exame de colpocitologia oncológica. Se exame normal, interromper o rastreamento.
- D Repetir colpocitologia oncológica em dois anos e solicitar ultrassonografia pélvica.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184323](#)

Questão 123 HIV na gestação Obstetrícia

Mulher, 29a, G1P0A0, 36 semanas de gestação, vem à consulta pré-natal e deseja parto normal. Exame físico e obstétrico normais para a idade gestacional, feto cefálico, com boa vitalidade. Antecedentes pessoais: HIV diagnosticado na décima semana de gestação, em uso regular de TARV potente. Carga viral realizada na 18ª e 35ª semanas de gestação: indetectável. Demais exames laboratoriais e ultrassonográficos normais. **DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA SOBRE ESTE PLANO DE PARTO:**

- A Via de parto obstétrica, preferencialmente vaginal; rotura artificial de membranas; evitar episiotomia; indicado AZT intravenoso durante todo o trabalho de parto.
- B Via de parto obstétrica, preferencialmente vaginal; rotura espontânea de membranas; evitar episiotomia; sem necessidade de AZT intravenoso.
- C Cesárea eletiva às 38 semanas; extração de feto empelcado; sem necessidade de AZT intravenoso.
- D Cesárea eletiva às 38 semanas; extração de feto empelcado; indicado AZT intravenoso três horas antes do parto.

4000184322

Questão 124 Neoplasia intraepitelial vulvar NIV

Mulher, 58a, com quadro de prurido vulvar crônico há 10 anos, comparece em consulta de retorno para avaliação de resultado de biopsia de lesão vulvar, cujo diagnóstico foi neoplasia intraepitelial diferenciada. Exame ginecológico: (**Figura 11**, anexo. Área biopsiada destacada). **O FATOR FREQUENTEMENTE ASSOCIADO A ESTE DIAGNÓSTICO É:**

FIGURA 11- referente à questão 64- área destacada no círculo corresponde ao local da biopsia.



- A Líquen escleroso da vulva.
- B Papilomavírus humano tipos 6 e 11.
- C Papilomavírus humano tipos 16 e 18.
- D Doença de Paget invasiva.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184321](#)

Questão 125 Medicina Preventiva

Estima-se que as lesões de Koplik estejam presentes em 60% das pessoas que estão incubando o sarampo. Alguns autores consideram que elas constituem um sinal patognomônico desta doença. **EM RELAÇÃO AO SINAL DE KOPLIK PARA O DIAGNÓSTICO DE SARAMPO, PODE-SE AFIRMAR QUE:**

- A A especificidade é elevada.
- B O valor preditivo positivo é 60%.
- C É falso positivo em 40% dos casos.
- D O valor preditivo negativo é 40%.

4000184320

Questão 126 Audiologia

Perda Auditiva induzida por Ruído PAIR ou Perda Auditiva induzida por níveis de Pressão Sonora Elevados PAINPSE

EM RELAÇÃO À PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO, É CORRETO AFIRMAR QUE É:

- A Do tipo misto, acometendo a orelha mais exposta, e irreversível.
- B Condutiva, unilateral e reversível quando cessada a exposição.
- C Do tipo misto, bilateral e reversível quando cessada a exposição.
- D Neurossensorial, geralmente bilateral, irreversível e progressiva.

4000184319

Questão 127 Medicina Preventiva

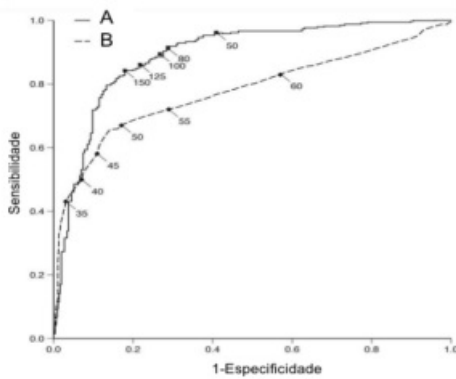
Um levantamento feito em uma amostra aleatória de estudantes dos cursos de graduação da Unicamp, para estudar o Índice de Massa Corporal (IMC) nesse grupo, identificou média=21Kg/m² com desvio-padrão=3Kg/m² e erro-padrão=0,5Kg/m², **PODEMOS DIZER, COM 95% DE CERTEZA (T-CRÍTICO=1,96), QUE A VERDADEIRA MÉDIA DO IMC NESSA POPULAÇÃO ESTÁ ENTRE:**

- A 15,12 e 26,88.
- B 18,00 e 24,00.
- C 20,02 e 21,98.
- D 20,50 e 22,15.

4000184318

Questão 128 Medicina Preventiva

A figura a seguir representa a curva ROC que compara o desempenho de dois métodos diagnósticos: A e B.



AO ANALISAR ESSA FIGURA, PODE-SE AFIRMAR QUE:

- ☐ A O método B é o melhor, pois a ascensão da sua curva tem o término mais agudo.
- ☐ B O método A é o melhor, pois as suas medidas estão mais próximas entre si.
- ☐ C O método A é o melhor, pois apresenta a maior área sob a curva.
- ☐ D Os dois métodos têm valor prognóstico positivo semelhante.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184317](#)

Questão 129 Medicina Preventiva

O número básico de reprodução R_0 (R zero) foi muito estudado durante a pandemia de COVID-19. A INFORMAÇÃO DADA POR ESSE CONCEITO É:

- ☐ A O número de pessoas que são contaminadas por um indivíduo, depois que ocorre uma estabilização no número de pessoas contaminadas.
- ☐ B O número de pessoas que são potencialmente contaminadas por um patógeno, após o início da vacinação.
- ☐ C O número mais alto de contaminação, que corresponde ao fim da fase de ascensão da curva epidêmica.
- ☐ D O número de pessoas que são contaminadas por um indivíduo infectado pelo patógeno, em um ambiente em que ninguém adquiriu imunidade.

[4000184316](#)

Questão 130 Medicina Preventiva

Homem, 55a, procura o Pronto Socorro por dor torácica em aperto, de forte intensidade. Antecedentes: hipertensão arterial e obesidade. Com a hipótese diagnóstica de infarto agudo do miocárdio (IAM), são solicitados exames complementares para confirmar ou afastar o diagnóstico. **CONSIDERANDO O RISCO DE MORTE DESTES DIAGNÓSTICO, A PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE VALIDAÇÃO DESTES EXAMES É QUE APRESENTEM:**

- A Sensibilidade próxima a 100%, para evitar deixar de diagnosticar pacientes com IAM.
- B Sensibilidade próxima a 100%, porque assim você vai evitar diagnosticar erradamente como infartados os pacientes sem IAM.
- C Especificidade próxima a 100%, para evitar deixar de diagnosticar pacientes com IAM.
- D Especificidade próxima a 100%, porque assim você vai evitar diagnosticar erradamente como infartados os pacientes sem IAM.

4 000184315

Questão 131 Medicina Preventiva

Schuch *et al.* realizaram uma revisão sistemática de estudos que avaliaram a associação entre atividade física e incidência de depressão. Os resultados foram sumarizados em uma metanálise que utilizou como medida o *Odds ratio*=0,83, com intervalo de confiança de 95%=0,79 a 0,88, representados na figura abaixo:



O RESULTADO APONTADO ACIMA PERMITE AFIRMAR QUE:

- A A probabilidade de uma pessoa que faz atividade física apresentar depressão é 0,83 vezes comparada à probabilidade de quem não pratica atividade física.
- B A chance de uma pessoa que faz atividade física apresentar depressão é 0,83 vezes comparada à chance de quem não pratica atividade física.
- C A chance de uma pessoa evoluir com depressão é de 0,83, sendo de 0,79 no grupo que faz atividade física e de 0,88 no grupo de não faz atividade física.
- D Realizar atividade física não apresentou redução significativa na associação com aumento na incidência de depressão.

Medicina Livre
Contra preços abusivos na medicina.
Proibida Venda. Acesse t.me/medicinalivre

4 000184314

Questão 132 Intoxicações Exógenas

Homem, 35a, procura Unidade Básica de Saúde com queixa de tontura, dor de cabeça, cansaço e náuseas. Trabalha diariamente na horta perto da sua casa. Colega de trabalho apresenta sintomas semelhantes. **A CONDUTA É:**

- A Realizar notificação de intoxicação crônica por hidrocarboneto e afastar do trabalho.
- B Receitar sintomáticos, afastar o paciente e encaminhar ao neurologista.
- C Solicitar dosagem de eletrólitos, prescrever hidratação endovenosa e medidas para tratamento de insolação.
- D Solicitar exames complementares, afastar o paciente e investigar condições de trabalho e produtos usados.

4 000184313

Questão 133 Medicina Preventiva

Homem, 52a, comparece a consulta ambulatorial com diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas sem proposta cirúrgica. Antecedentes: diabetes melito, amaurose bilateral. **EM RELAÇÃO À PROPOSTA DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA ESSE PACIENTE, É CORRETO AFIRMAR QUE:**

- A Deve ser iniciada na presença de falência multiorgânica.
- B Não deve ser introduzida de forma precoce, para não prejudicar a esfera psicossocial.
- C Pode promover o alívio da dor e de outros sintomas.
- D Não apresenta benefícios diante do tipo de neoplasia avançada e das comorbidades.

4000184312

Questão 134 Outros tumores ósseos

Adolescente, 15a, procura médico de família muito preocupada com aumento de volume localizado no terço proximal da região tibial direita há cerca de quatro anos. Nega dor no local e limitação de atividades físicas. Traz exames que confirmam o diagnóstico de osteocondroma. **A CONDUTA É:**

- A Encaminhar para ressecção do tumor, pelo risco elevado de degeneração sarcomatosa para condrossarcoma.
- B Realizar acompanhamento clínico e radiológico, sem necessidade de ressecção.
- C Solicitar cintilografia óssea, para diferenciar entre tumor ósseo benigno e maligno.
- D Encaminhar para radioterapia, pelo risco elevado de degeneração sarcomatosa para condrossarcoma.

Essa questão possui comentário do professor no site [4000184311](https://www.4000184311.com.br)

Questão 135 Medicina Preventiva

Os sistemas nacionais de saúde obedecem a diferentes lógicas, dependendo de contextos sociais, econômicos e políticos de cada país. **SOBRE O SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO, É CORRETO AFIRMAR QUE:**

- A É do tipo seguro social.
- B Mudou do tipo seguridade social para seguro social a partir da Constituição de 1988.
- C É do tipo seguridade social.
- D O tipo, seguridade ou seguro social, varia de acordo com a região do país.

4000184310

Questão 136 Medicina Preventiva

Para algumas condições de saúde, a atenção primária oportuna e de boa qualidade pode evitar a hospitalização ou reduzir sua frequência. **O INDICADOR “INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA”:**

- A Não se aplica a condições ou doenças agudas.
- B Avalia a resolubilidade e qualidade da atenção primária.
- C Avalia o acesso à atenção hospitalar.
- D Avalia o funcionamento da rede de atenção à saúde.

4000184309

Questão 137 Tratamento da Hipertensão arterial

Homem, 88a, assintomático, comparece à consulta em Unidade Básica de Saúde para reavaliação clínica com resultados de exames. Antecedentes: hipertensão arterial, intolerância à glicose, doença arterial periférica e osteoartrite de quadril. Medicamentos em uso: hidroclorotiazida 25mg/dia; losartana 50mg/dia; metformina 850mg2x/dia; carbonato de cálcio 1g/dia; paracetamol 2g/dia e sulfato de glucosamina 1,5mg/dia. Exame físico: bom estado geral, PA=136x82mmHg, FC=80bpm. Colesterol total=212mg/dL, HDL=56mg/dL, LDL=82mg/dL, triglicerídeos=257mg/dL, glicemia jejum=108mg/dL, creatinina=1,4mg/dL, ácido úrico=8,2mg/dL, hemoglobina glicada=7,6%. **A CONDUTA É:**

- A Prescrever estatina e estimular caminhada.
- B Substituir losartana por beta bloqueador.
- C Prescrever ácidos graxos ômega-3.
- D Suspender hidroclorotiazida.

4000184308

Questão 138 Medicina Preventiva

Homem, 82a, internado para tratamento de insuficiência cardíaca descompensada, está em programação de alta hospitalar. Antecedentes: hipertensão arterial, em uso de losartana 25mg/dia, carvedilol 25mg/dia e furosemida 40mg/dia. Exame físico: ausência de sinais de sobrecarga volêmica. Sua filha o acompanha e auxilia nas atividades diárias. **O FATOR MAIS IMPORTANTE PARA A ADEQUADA TRANSIÇÃO DE CUIDADOS DESTE PACIENTE É:**

- A Comunicação direta com o médico da atenção primária.
- B Planejamento da alta hospitalar pelo médico do hospital.
- C Ajuste medicamentoso e instrução da filha.
- D Agendamento de retorno para avaliação laboratorial.

4000184307

Questão 139 Medicina Preventiva

O modelo preventivista, baseado na concepção da história natural da doença, considera que existem três formas hierarquizadas de prevenção. **ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:**

- A A vacinação é a principal medida de proteção específica empregada na prevenção secundária.
- B Tanto o diagnóstico precoce como o tratamento oportuno fazem parte da prevenção secundária.
- C O tratamento adequado e integral é a principal estratégia de prevenção terciária.
- D A prevenção primária tem início imediatamente após o período pré-patogênico.

Essa questão possui comentário do professor no site 4000184306

Questão 140 Medicina Preventiva

O consentimento livre e esclarecido compõe um dos fundamentos éticos para a manifestação autônoma dos pacientes em relação aos procedimentos e intervenções em saúde. **A CAPACIDADE DE UM PACIENTE EM CONSENTIR INCLUI O SEGUINTE CRITÉRIO:**

- A** Compreender as informações relevantes sobre seu problema de saúde e alternativas de abordagens disponíveis, incluindo riscos e benefícios potenciais.
- B** Demonstrar ser capaz de repetir adequadamente as informações fornecidas, assim como as diferentes abordagens disponíveis.
- C** Compartilhar as informações que lhe foram prestadas com seu familiar ou representante legal.
- D** Ser capaz de opinar mesmo que seu raciocínio lógico, necessário para o processo de tomada de decisão, esteja comprometido.

4000184305

Respostas:

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	
34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44	
45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55	
56		57		58		59		60		61	C	62	B	63	C	64	D	65	C	66	C
67	A	68	D	69	A	70	B	71	B	72	D	73	A	74	B	75	D	76	A	77	C
78	B	79	D	80	B	81	D	82	D	83	C	84	B	85	D	86	A	87	B	88	C
89	A	90	C	91	A	92	D	93	B	94	D	95	B	96	A	97	C	98	D	99	B
100	D	101	A	102	A	103	C	104	A	105	B	106	D	107	C	108	C	109	D	110	C
111	B	112	D	113	B	114	C	115	B	116	C	117	D	118	C	119	A	120	A	121	D
122	A	123	B	124	A	125	A	126	D	127	C	128	C	129	D	130	A	131	B	132	D
133	C	134	B	135	C	136	B	137	D	138	A	139	B	140	A						